患者与家属的循证治疗科普

精神疾病确诊

从诊断标准到鉴别、误诊与就诊沟通

13 个模块 · 64 篇 · V1.0 / 2026-10

本资料库仅用于科普学习，不能替代精神科医生面诊、诊断与处方。

出现自杀念头、意识障碍、严重过敏、胸痛晕厥等情况，请立即拨打 120 或前往急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

使用边界与安全声明

这是一本写给患者和家属的诊断科普书。它把精神疾病确诊拆成 13 个模块，覆盖从主诉、病史、精神检查、诊断标准，到鉴别、共病、误诊和就诊沟通的完整路径。

它不能替代面诊、诊断和处方。所有具体用药、剂量、减量、住院与特殊人群决策，都必须由具备资质的精神科医生结合个体情况作出。

请先记住三件事

- 诊断不是对症状的简单计数；病程、功能损害、鉴别与排除，缺一不可。
- 不要自行突然停药、减量、换药或叠加药物；停药需要在医生指导下缓慢进行。
- 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐，立即拨打 120 或去急诊。

版本与引用

版本 V1.0，最后更新 2026-10。指南、药物适应证、医保政策与热线号码会变化；与面诊医生或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准。引用请注明《精神疾病确诊资料库》V1.0，并附具体篇目。

书中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。

总目录

按模块顺序排列。每篇正文都可独立阅读；书末附 60 个术语与主要指南来源。

使用说明

00 使用说明与免责声明

模块 1：诊断总论

1.1 精神疾病诊断是什么：分类、标准与边界
1.2 诊断流程：从主诉到结论
1.3 精神检查与症状学术语
1.4 DSM-5-TR 与 ICD-11 怎么用
1.5 鉴别诊断与共病的基本原则
1.6 误诊、过度诊断与诊断标签

模块 2：抑郁障碍确诊

2.1 抑郁障碍诊断要点
2.2 单相抑郁与双相抑郁的区分
2.3 抑郁的躯体原因与药物因素
2.4 抑郁严重度、功能损害与风险评估
2.5 抑郁诊断的常见误区与量表

模块 3：双相障碍确诊

3.1 躁狂、轻躁狂与双相 I 型 II 型
3.2 双相抑郁的识别
3.3 混合特征、快速循环与病程标注
3.4 双相与单相、边缘型人格、ADHD 的鉴别
3.5 双相诊断的常见误区与量表

模块 4：焦虑障碍确诊

4.1 焦虑障碍总论与分类
4.2 广泛性焦虑与惊恐障碍
4.3 社交焦虑、特定恐惧与广场恐惧
4.4 焦虑的躯体模仿者与物质药物因素
4.5 焦虑诊断的常见误区与量表

模块 5：精神分裂症谱系确诊

5.1 精神分裂症诊断要点

5.2 阳性、阴性与认知症状的检查

5.3 分裂情感、短暂精神病性与妄想障碍

5.4 精神病性症状的鉴别诊断

5.5 精神分裂症诊断的常见误区与量表

模块 6：强迫及相关障碍确诊

6.1 强迫症诊断要点

6.2 强迫思维与反刍、担忧、侵入性想法

6.3 躯体变形、囤积、拔毛与抠皮

6.4 强迫症与焦虑、抽动、ASD、精神分裂的鉴别

6.5 强迫症量表与诊断误区

模块 7：创伤及应激相关障碍确诊

7.1 创伤后应激障碍诊断要点

7.2 急性应激障碍与适应障碍

7.3 复杂性创伤与解离的识别

7.4 创伤相关障碍与焦虑、抑郁、人格的鉴别

7.5 创伤史询问与量表

模块 8：进食障碍确诊

8.1 神经性厌食

8.2 神经性贪食

8.3 暴食障碍

8.4 进食障碍的躯体评估与鉴别

模块 9：物质使用与成瘾确诊

9.1 物质使用障碍诊断框架

9.2 酒精使用障碍

9.3 镇静剂、兴奋剂、大麻与阿片

9.4 物质所致精神障碍与原发性障碍

模块 10：神经发育障碍确诊

10.1 ADHD 诊断

10.2 ASD 诊断

10.3 成人 ADHD 与 ASD 的识别

10.4 神经发育障碍与焦虑、抑郁、双相、人格的鉴别

模块 11：人格障碍确诊

11.1 人格障碍总论与分类

11.2 边缘型人格障碍

11.3 自恋、反社会、回避与依赖型人格
11.4 人格特质、人格障碍与心境发作

模块 12：躯体症状睡眠与器质性确诊

12.1 躯体症状障碍与疾病焦虑
12.2 失眠、嗜睡与昼夜节律障碍
12.3 谵妄与痴呆
12.4 器质性与药物所致精神障碍的排查

模块 13：特殊人群误诊与沟通

13.1 儿童青少年诊断
13.2 老年诊断
13.3 孕产期诊断
13.4 文化、性别与诊断偏差
13.5 共病与多重诊断
13.6 如何与医生沟通诊断与第二意见

附录：术语与诊断标准

A 术语表
B 诊断标准与指南版本

使用说明

00 使用说明与免责声明

> 这是一套讲“精神疾病怎么确诊”的科普资料，共 13 个模块、64 篇。它讲诊断标准、精神检查、鉴别诊断、常见误诊和就诊沟通，帮助患者与家属理解医生为什么这样判断。它**不能替代面诊、诊断和处方**，也不能拿来给自己或家人“对号入座”。

这套资料想解决什么问题

拿到精神科诊断时，人常有两种困惑：一种是“医生只聊了二十分钟，凭什么下结论”；另一种是“网上说这些症状就是某某病，我是不是也有”。前者不信任诊断，后者把诊断简化成症状清单。

这套资料想把“确诊”拆开：

- **诊断不是对症状**：需要病程、功能损害、排除躯体与物质原因、纵向观察。
- **诊断标准有边界**：DSM-5-TR、ICD-11 的条目、时间门槛、排除条件不完全一样。
- **鉴别诊断是关键**：抑郁与双相、焦虑与躯体病、强迫与焦虑、精神分裂与双相/物质/器质性，常常互相“长得像”。
- **诊断会修正**：早期信息不足时，医生给“考虑”“待观察”是正常的，不是水平差。
- **就诊可以准备**：把时间线、睡眠、功能、用药、家族史、风险讲清楚，能显著提高诊断质量。
- **标签有代价**：诊断能带来治疗和保障，也可能带来污名、保险和隐私问题，需要被认真对待。

它不是什麼

- 不是自诊工具。对照条目给自己“确诊”，最容易把正常波动、躯体疾病、药物反应、创伤反应误当成精神障碍。
- 不是诊断标准全文。本资料只做要点转述和临床解释，不能替代 DSM-5-TR、ICD-11 原文和医生的结构化访谈。
- 不是“量表诊断”。PHQ-9、GAD-7、MDQ、Y-BOS 等只是筛查或严重度工具，分数高不等于确诊。
- 不是治疗方案。本资料聚焦“怎么确诊”，治疗只在必要处简要提到下一步；具体用药、剂量、疗程不在本库范围。
- 不是法律或保险意见。诊断证明、病假、残疾、监护、隐私，以现行法律和当地政策为准。

三种读法

第一种：按诊断流程读。 先读模块 1，理解诊断的四个支点、精神检查和鉴别原则，再看具体障碍。

第二种：带着“我像不像”读。 先看对应障碍模块的“诊断要点”和“鉴别”，再读“常见误区”，最后看“就诊准备”。不要只看“我中了几条”。

第三种：家属/照护者读。 重点看模块 1 的“怎么提供病史”、模块 13 的“怎么和医生沟通”，以及各障碍的“家属能观察什么”。

五种内容标签

标签	含义	你该怎么用
【指南】	DSM-5-TR、ICD-11、NICE、中国指南等有明确标准或推荐	可以作为和医生讨论的依据
【研究】	随机对照试验、系统综述、流行病学研究支持	可以了解，别当成唯一答案
【临床经验】	临床常见做法，个体差异大	参考，不要照搬
【待验证】	机制推测、小样本研究、争议观点	保持开放，别当结论
【个人体验】	康复者或家属的主观感受	共情用，不代表普遍规律

安全声明（请先读）

诊断相关的内容，最怕“看完更不敢就医”或“看完自己乱下结论”。有些情况不能等：

- **出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划**：不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- **出现命令性幻听、坚信被迫害/被控制、明显激越或伤人风险**：先保证安全，拨打 120 或 110，尽快精神科急诊评估。
- **首次出现精神病性症状，伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识时清时浊**：先按躯体急症处理，立即急诊，警惕脑炎、感染、谵妄等。
- **木僵、缄默、拒食、违拗、蜡样屈曲**：可能是紧张症，需急诊精神科评估。
- **高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗**：可能是恶性综合征或严重药物反应，立即急诊。
- **严重皮疹、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
- **长期大量饮酒或镇静药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱**：立即急诊，不能自行硬戒。

如果你不确定“算不算严重”，按严重处理。**宁可白跑一趟，不要赌。**

关于诊断：三句最重要的话

1. **诊断是“最合理的解释”，不是关于你这个人的最终结论。** 它需要时间、信息和随访，也可能被修正。
2. **诊断必须由具备资质的精神科医生作出。** 量表、AI、网络测试、亲友判断，都不能替代面诊。
3. **诊断需要排除“不是精神科的原因”。** 甲状腺、贫血、低血糖、心律失常、脑炎、药物、酒精、睡眠呼吸暂停，都可能表现为精神症状。

关于隐私与案例

文中出现的“小 A”“一位来访者”等，都是合并、改写后的示意案例，不对应任何真实个人。诊断、用药、住院记录属于敏感信息，分享给医生之外的人之前，先想清楚边界。

如何纠错与更新

- 本资料版本：V1.0，最后更新 2026-10。
- 诊断标准会修订，指南会更新。看到与医生说法不一致时，**以面诊医生的个体化判断和最新标准为准**，并把差异告诉医生。
- 如果发现事实错误、失效链接、表述可能误导，请在资料库维护记录里标注“待核”，不要直接照用。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE 相关障碍指南（各模块分别标注）.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 1：诊断总论

先理解诊断是什么、不是什么，以及一次规范的诊断要经过哪些步骤。这个模块是后面所有障碍的“共同底座”。

1.1 精神疾病诊断是什么：分类、标准与边界

很多人第一次走进精神科，想问的其实只有一句话：“我到底是不是有病？”医生给出的却往往是一个拗口的名字，加上一句“先观察一段时间”。这一页讲清楚三件事：诊断在做什么、它靠什么成立、它的边界在哪里；以及一个名字写进病历之后，会给人带来什么。读完你大概能分清三层东西——正常的情绪波动、需要关注的症状、达到诊断标准的障碍。

诊断能做什么，不能做什么

诊断最直接的作用是**解释和安排**，不是给人下定义。它把一组同时出现、持续时间够长、已经影响生活的表现，归到一个相对稳定的名字下面，让医生知道往哪个方向找原因、先处理什么、大致会遇到什么走势，也让不同医院、不同医生之间能用同一套语言交流。

具体来说，诊断至少有五个用途。第一，**指向处理方向**：同样是失眠，抑郁相关的失眠和精神分裂症早期的不眠，处理重点完全不同。第二，**预测大致病程**：多数焦虑障碍在规范治疗下可以明显缓解，而精神分裂症更强调长期维持，这个预期会直接影响复诊频率和家庭安排。第三，**沟通**：一句“广泛性焦虑障碍”，能让接诊医生在几分钟内抓住大致轮廓。第四，**获得资源**：请假、病假、医保报销、残疾评定、学校的合理便利，通常需要写在纸上的诊断。第五，**研究**：没有统一的入组标准，就无法比较哪种治疗对哪类人更有效。

它做不到的事同样要说清楚。目前绝大多数精神障碍**没有可化验、可拍片的确诊指标**，DSM-5-TR 和 ICD-11 都是**描述性分类**：根据医生观察到的表现、患者讲述的经历、病程长短和功能受损程度来归类，而不是根据病因。【指南】这意味着诊断是“目前最合理的解释”，不是关于这个人的最终结论，也不是一张终身有效的判决书。

还有一层容易被忽略：诊断描述的是**一群人的共同点**，而坐在诊室里的永远是**一个具体的人**。同一个诊断下，有人主要是睡不好、有人主要是注意力散、有人主要是反复担心；有人三个月好转，有人反复多年。诊断给的是起点，个体化评估才是后面所有决定的依据。

分类系统是怎么来的

现代精神科诊断用的是“分类”思路：把表现相近的人放进同一个格子里。格子不是从天上掉下来的，而是几十年来一批医生根据临床观察、随访结果和跨地区一致性讨论逐步磨出来的。它有两个特点，值得每个读诊断的人知道。

第一个特点是**以症状组合为核心**。诊断标准通常由四类信息拼成：一组核心表现、一个最短持续时间、一条“造成明显痛苦或功能损害”的要求、一串需要先排除的情况。四项缺一不可，这也是为什么“我中了好几条症状”并不等于“我得了这个病”。

第二个特点是**阈值是人为约定的，而人群是连续的**。一个人的焦虑程度可以从零分排到一百分，标准只是在某处划了一条线。线放在哪里，取决于“到什么程度值得干预”“到什么程度治疗收益大于代价”这类现实考虑，而不是因为跨过这条线的瞬间人发生了质变。【临床经验】

把这两点放一起，就出现了两种理解方式，它们各有各的用处：

理解方式	它怎么看待“病”	好处	局限
类别模型	有或没有，界限清楚	便于沟通、决策、报销	会切掉灰色地带，边界附近的人很难归类
维度模型	程度高低，像血压一样连续	更贴近真实，能描述轻重	不便于快速沟通，也难直接对应指南

临床上常见的做法是两者混用：用类别下诊断，用维度描述严重度（比如“中度”“伴精神病性特征”“部分缓解”）。所以你会看到病历上写着“广泛性焦虑障碍，中度”，这不是矛盾，而是两个层面同时在说话。

分类还会受文化影响。什么算“过度担心孩子”、什么算“不尊重长辈”、什么算“情绪表达丰富”，在不同家庭、不同地区、不同代际之间差别很大。同样的行为，在一个文化里是性格，在另一个文化里可能被写成症状。【指南】这就是为什么规范的精神检查一定会问“你自己怎么看”“家里人和同事怎么看”，而不是只对着条目打分。

正常波动、症状、障碍：三条边界

这是全篇最需要慢慢看的一段。很多人卡在“我这样算不算病”，其实问的是三条边界：**这是人之常情，还是需要留意的信号，还是已经达到障碍的程度。**

层面	常见样子	判断的关键
正常波动	考前失眠、失恋后难过两三周、上台前心慌手抖、换季时情绪低一点	有明确诱因，随环境变化起伏，睡眠和吃饭大体还行，工作学习能维持
症状	连续几周提不起劲、反复检查门锁、偶尔听到有人叫自己名字	已经带来痛苦或效率下降，但可能还不足以构成某个障碍
障碍	症状成组出现、持续够久、明显影响生活、且排除了其他原因	需要医生按诊断标准逐条核对，并结合纵向观察

从“波动”走到“障碍”，中间通常要过四道关。

第一道是痛苦。当事人自己觉得难受，或者周围人明显看出不对劲。这一条最主观，也最容易被低估——有些人习惯忍耐，量表分数不高，但已经很难受；有些人表达强烈，实际功能尚可。

第二道是功能损害。这是诊断里分量最重的一条。能不能上班上学、能不能照顾自己和孩子、有没有中断社交、有没有因为症状做出危险的事（比如不敢开车、不敢独自在家、反复请假）。功能损害不是“有点影响心情”，而是生活轨道被改变了。

第三道是持续时间。几乎所有精神障碍都有最短病程要求，只是长短不同：有的以两周计，有的以一个月计，有的以六个月计。【指南】时间门槛的意义在于把“一过性的反应”排除掉——人遇到大事都会有反应，反应本身不是病。

第四道是排除。甲状腺功能异常、贫血、低血糖、心律失常、睡眠呼吸暂停、脑部病变、药物副作用、酒精和毒品，都可能造出一模一样的表现。不先排除这些，任何精神科诊断都不算完成。

四道关都过了，才谈得上“符合诊断标准”。注意措辞：是“符合标准”，不是“就是这个人”。前者说的是这次评估的结论，后者说的是一个人的全部。

为什么“有症状”不等于“有病”

普通人也会经历短暂的幻觉、奇怪的念头、强烈的被害感。大型人群调查里，有相当比例的人报告过“听到不存在的声音”或“觉得有人在针对自己”，但其中大多数并不发展成障碍，也不需要治疗。【研究】这些体验更像是一种心理上的“杂音”，在压力大、睡眠不足、发烧、刚醒来或刚入睡时尤其容易出现。

所以临床上真正在意的不是“有没有这个体验”，而是它**出现的频率、持续时间、当事人信不信、有没有影响判断、有没有让人做出危险的事**。一个在极度疲惫时听见有人喊自己名字、回头发现没人、笑笑就过去的人，和一个坚信邻居在用仪器害自己、因此不敢开窗的人，体验的“内容”可能相似，临床意义却完全不同。

功能的保留程度往往比症状本身更能说明问题。有的人症状不轻，但工作、关系、自我照顾都还维持着；有的人症状看起来不重，却已经完全无法出门。诊断标准里强调功能损害，正是因为这个原因。

这里还要提一句特殊人群。儿童表达痛苦的方式常常是行为问题（拒绝上学、发脾气、肚子疼），老年人可能表现为身体不适、记忆力下降或“不想活了”，孕产妇的失眠和情绪波动容易被当成“带孩子的正常辛苦”，少数群体面临的现实压力也常被误读为个人脆弱。同样的表现，放在不同年龄、性别、文化处境里，权重是不一样的。漏掉这一层，最容易把“处境问题”写成“个人有病”。

标签的代价

诊断是有用的，但标签是有重量的。把这两件事分开看，人才不会被一个名字困住。

先说好处。一个准确的诊断能让人**终于说清楚自己怎么了**，这种“原来我不是懒、不是矫情”的确认感本身就有治疗作用；也能让人找到同类、找到对应的治疗方法、在制度上获得保护（病假、报销、合理便利）。很多人是在拿到诊断之后，才第一次被认真对待。

再说代价，通常有四层。

污名。 社会对精神障碍的想象仍然粗糙，“精神病”三个字常被当成骂人的话。一旦这个标签落到自己或家人身上，求职、婚恋、邻里关系都可能受影响。

自我认同窄化。 有些人会把诊断当成解释一切的总钥匙：一次心情不好是“因为我抑郁”，一次争执是“因为我边界感有问题”，一个优点也要归功于“病给我的敏感”。诊断从“我有的一个状况”变成了“我就是这个状况”。

隐私与制度风险。 病历属于敏感个人信息。诊断记录可能出现在保险核保、某些岗位的体检、学校档案、司法程序中，具体规则各地不同，但“写下来就可能被看到”这一点是真实的。

过度关注与反向伤害。 家人知道诊断后，可能过度保护、过度监控，或者把所有矛盾都归因于病，反而让当事人失去练习和成长的空间。

降低代价的办法不是拒绝诊断，而是**把诊断放回它该在的位置**：它是工作假设，不是身份；它需要定期复核，不是一次定终身；它只对必要的对象披露，不必向所有人交代。病历里可以写“考虑某障碍，建议随访”，不必急着写成一个钉死的结论——这也是规范的做法。

可以照着做的观察清单

如果你正在犹豫“要不要去看医生”，下面这份清单比在网上对条目更有用。把它写下来，带去门诊。

- ☐ 最近一个月，我最难受的是哪几件事？分别从什么时候开始？
- ☐ 这些情况一周出现几天？一天里什么时候最重？
- ☐ 睡眠（入睡、易醒、早醒、总时长）和食欲、体重有没有变化？
- ☐ 工作、学习、家务、社交，哪一项最先撑不住？掉了多少？
- ☐ 有没有一段时间完全不像平时的自己（特别兴奋、话多、睡得少也不累，或者完全动不了）？
- ☐ 最近有没有换药、加药、停药，或者开始喝酒、喝咖啡、用其他东西？
- ☐ 有没有查过甲状腺、血常规、血糖、心电图？结果是什么？
- ☐ 家里有没有人有过类似情况、住过院、用过精神科药物？
- ☐ 有没有出现过“活着没意思”“不如消失”的念头？有没有做过准备？
- ☐ 我最希望医生帮我解决的，具体是哪一件事？

什么时候需要联系医生或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法、告别、送东西：不要独处，让信任的人陪着，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听（声音命令你去做危险的事）、坚信被迫害或被控制、明显激越、有伤人风险：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
- 首次出现幻觉、妄想，同时伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识时清时浊：按躯体急症处理，立即急诊。
- 木僵、缄默、拒食、保持一个姿势不动：需急诊精神科评估。
- 高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变：立即急诊。
- 长期大量饮酒或镇静催眠药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊，不要自行硬戒。

常见误区

“症状对上了，就是确诊了。” 网上流传的条目大多是删节版，缺了病程、功能损害和排除条件这三样最关键的部件。对着条目数数，等于只看考试题干不看评分标准。

“医生说‘考虑’，说明他水平不行。” 恰恰相反。信息不足时给出“考虑某障碍、建议随访”，是规范且诚实的做法。精神科诊断需要纵向观察，很多问题在一次门诊里本来就看不清楚。

“诊断一变，说明之前看错了。” 诊断修正在精神科很常见，原因可能是补充了病史、观察到了新的发作形式、发现了躯体或药物因素，也可能是标准本身更新了。修正不等于前面的医生不负责任。

“有了诊断，就不用再解释自己了。” 诊断是简写，不是全部。它无法说明你的成长经历、你的应对方式、你现在最在意什么，而这些恰恰决定了治疗怎么配合才有效。

“轻度的就不用管。” 严重度分级影响的是治疗强度，不是“要不要重视”。轻度但持续多年、逐渐侵蚀生活的状况，同样值得评估。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health
- NIMH. Mental Health Information. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

1.2 诊断流程：从主诉到结论

很多人形容第一次看精神科：“我讲了二十分钟，医生就写了个诊断。”也有人相反：“去了三次，医生还是说再观察。”这两种体验背后，其实是同一套流程——只是有的人走完了，有的人还在路上。这一页把一个规范的精神科评估拆成看得见的步骤，告诉你每一步医生在找什么、你能提供什么，以及为什么“一次门诊就下结论”本身并不可靠。

一次评估大致经过哪些环节

精神科没有“一管血定乾坤”的检查，诊断靠的是**多来源信息的交叉印证**。规范的评估通常包含下面这些环节，顺序会因人而异，但很少有哪一环可以被真正跳过。

环节	医生在找什么	你能提供什么
主诉	最困扰的一件事，以及它持续多久	用一句话说清“最难受的是什么、多久了”
现病史	起病时间、诱因、症状组合、波动、功能变化	时间线：什么时候开始、什么时候变重、什么情况下好转
既往史	以前有没有类似发作、诊断、用药、住院	旧病历、药盒、检查单
个人史与发育史	成长、学业、工作、婚恋、重大转折	童年是否就有注意力、社交、情绪上的困难
家族史	亲属中有无精神障碍、自杀、住院	知道多少说多少，不必羞于提
精神检查	当下的外观、言语、情绪、思维、知觉、认知、自知力	如实回答，不必“表现得正常一点”
量表	严重度基线、筛查漏项、随访对比	按最近两周的真实情况填，不要揣测“医生想听什么”
躯体与实验室检查	排除甲状腺、贫血、电解质、感染、药物等	近期体检、用药清单、月经史、饮酒史
风险评估	自伤、自杀、伤人、走失、拒食、物质使用	直接说，不要怕“说了会被抓起来”
形成假设与随访	最可能的解释、需要排除什么、观察多久	问清楚“下次复诊要看什么变化”

问诊：主诉、现病史与家属的作用

主诉与现病史：把一团乱麻讲成一条线

主诉是整份病历的第一句话，通常只有一行：**最主要的问题 + 持续时间**。比如“情绪低落、兴趣减退三个月”“反复担心半年，加重两周”“听见有人议论自己一个月”。这一行看似简单，却决定了后面所有提问的方向。

现病史是主体，医生会按一条隐含的时间线来问：

- **什么时候开始的？** 是突然几天之内，还是慢慢几个月？有没有明确的诱因（失业、分手、生育、生病、搬迁、亲人去世）？
- **一开始是什么样？** 很多人只记得“最严重的时候”，而最早的信号往往更有诊断价值。
- **怎么变化的？** 是一直差不多，还是一阵好一阵坏？有没有完全不难受的时期？这一点对区分“发作性”和“持续性”的障碍特别关键。
- **有没有伴随的东西？** 睡眠、食欲、体重、精力、性欲、注意力、疼痛、身体不适。
- **有没有反过来影响生活？** 请假了没有、成绩掉了没有、关系出问题了没有、有没有不敢出门。

- **有没有自己想过办法？** 喝过酒、用过助眠药、找过咨询、去过别的医院、吃过什么药、效果如何、有没有副作用。

家属在这里的作用很大。当事人处在抑郁或焦虑中时，记忆常偏向负面，容易低估自己以前的好状态；而家属能提供“他以前不是这样”的对照。反过来，家属也容易只看到行为问题（不出门、发脾气、不吃饭），看不到当事人内部正在经历什么。**最好的病史是两个人分开讲，再由医生拼起来。**

精神检查：医生在看什么、问什么

精神检查不是“聊聊天”，而是一次有结构的观察。医生同时在做两件事：听你说什么（内容），看你怎么说（形式、速度、表情、坐姿、眼神）。它通常包括外观与行为、言语、情绪与情感、思维形式与内容、知觉、认知功能、自知力几个方面，具体内容在 1.3 精神检查与症状学术语 里有逐项解释。

这里只说三个容易被误解的点。

第一，医生会问一些“听起来很奇怪”的问题。 比如“有没有人跟踪你”“有没有听到别人听不到的声音”“有没有觉得电视在说你”“有没有觉得自己的想法被别人拿走”。这些不是暗示，也不是诱导，而是常规筛查。被问到不代表医生觉得你有，很多人回答了“没有”，这段就过去了。

第二，医生会观察你的“不一致”。 嘴上说“我没事”，眼睛却一直看着地面、手指不停搓；说“我很开心”，脸上没有表情；描述痛苦的事情时语气像在讲别人的故事。这些不一致不是“装”，而是症状的一部分，也是判断的重要线索。

第三，医生会评估自知力。 也就是你如何看待自己现在的状态：觉得是生病了、需要帮助，还是觉得都是别人的问题、自己没病。自知力不是“听话程度”，也不影响你作为人的价值，但它直接影响治疗能不能配合、需不需要家属参与、要不要考虑住院评估。

量表与躯体排查：各自管什么

量表在评估里是有用的，但它的作用和很多人想的不一样。

用途	说明	不能做什么
筛查	用几个问题快速找出可能被漏掉的方向	不能凭分数下诊断
量化严重度	给“轻、中、重”一个可比较的基线	不能替代医生的整体判断
随访对比	两次分数变化，帮助看治疗有没有起效	不能反映全部功能与风险
科研与质控	让不同研究、不同医院的数据可比	不能说明病因

量表分数受很多因素影响：最近两周的状态、填表时的情绪、对题目的理解、是否想让医生重视、文化程度、躯体疾病。同一个分数，放在不同人身上含义不同。所以规范的做法是：**量表提示方向，医生面谈确认，纵向观察定案**。看到“PHQ-9 18 分”就认定“重度抑郁”，是把尺子当成了医生。

躯体排查：什么时候必须查

精神科诊断有一条基本原则：**先排除“不是精神科的原因”**。这不是过度检查，而是因为漏掉躯体病的代价太大。

- **首次发作、年龄偏大、症状不典型**：通常需要血常规、甲状腺功能、血糖、电解质、肝肾功能，必要时心电图、脑电图或影像。
- **伴发热、头痛、抽搐、意识波动、视力改变、步态异常**：优先按神经系统急症处理。
- **长期饮酒、营养不良、进食障碍**：需要关注维生素缺乏、电解质紊乱。
- **正在服用其他科药物**（激素、抗过敏药、降压药、抗病毒药、避孕药等）：需要核对说明书与用药时间关系。
- **老年人首次出现精神症状**：尤其要排查感染、药物相互作用、谵妄和认知下降。

检查正常，不代表“病是装的”；检查异常，也不代表精神症状就是它引起的。两者需要医生结合时间关系判断。

为什么一次门诊不够

这是最值得理解的一点。一次门诊通常只有十几到几十分钟，而诊断需要的信息量远不止这些。

第一，门诊看到的是横断面。 你走进诊室的那几十分钟，可能正好是这周状态最好的一天，也可能正好是最差的一天。而诊断标准里的病程要求，靠的是纵向信息。

第二，状态会影响表达。 极度焦虑的人讲不清时间线，抑郁的人容易只讲负面，躁狂的人可能觉得自己完全正常、是家人多事，精神病性症状的人可能因为不信任而隐瞒。同一个人，在不同状态下给出的病史可以差别很大。

第三，诊断需要“排除”，而排除需要时间。 停药观察、戒酒观察、治疗甲状腺、改善睡眠呼吸暂停，这些都需要几周才能看出精神症状是否随之改变。

第四，有些障碍本身就要求“观察一段时间”。 比如儿童的情绪和行为问题要看跨场景表现，人格相关的问题要看长期模式，短暂的精神病性症状要看会不会持续。急着下结论，反而容易误判。

第五，治疗反应也是诊断信息。 抗抑郁药无效、情绪稳定剂有效，这些反馈会反过来修正最初的判断。所以医生常说“先按这个方向治，两周后复诊再说”，这不是敷衍，而是诊断流程的一部分。

诊断不是“对症状”

很多人以为诊断就是“症状清单打勾”，其实医生做的是**假设—验证**：先形成几个可能的解释，再用病史、检查、随访逐一排除，最后留下最能解释全部信息的那一个。

举个例子。一个人说“我最近什么都不想干、睡不着、注意力很差”。可能的解释至少有五种：抑郁发作、双相抑郁、甲状腺功能减退、睡眠呼吸暂停、酒精或药物影响。它们的症状高度重叠，但处理方向完全不同。医生要问的不是“你有几条症状”，而是：有没有过一段时间睡得少却精力特别好？体重和怕冷有没有变化？打不打呼噜？最近喝不喝酒？这些问题的答案，才决定了诊断往哪边走。

所以，**诊断的质量很大程度上取决于“问了什么”，而不是“看了多久”**。同一位医生，问得细、愿意等、会主动追问轻躁狂史和物质使用，和只对着量表打分的医生，给出的结论可能完全不同。

去就诊之前：准备清单与常见误区

把下面这份清单写在一张纸上，比临场回忆有效得多。

- ☐ 一句话主诉：最难受的是什么，从什么时候开始。
- ☐ 一条时间线：起病、加重、好转的关键节点，尽量写月份。
- ☐ 症状清单：睡眠、食欲、体重、精力、注意力、情绪、焦虑、幻觉或奇怪想法、自伤念头。
- ☐ 功能变化：工作/学习/家务/社交，具体掉了多少，有没有请假或休学。
- ☐ 用药记录：药名、开始与停用时间、效果、副作用（不必写剂量，带着药盒即可）。
- ☐ 物质使用：酒、烟、咖啡、助眠药、其他物质，频率和量。
- ☐ 躯体情况：慢性病、近期检查结果、是否怀孕或备孕、月经情况。
- ☐ 家族史：亲属中有无精神障碍、住院、自杀。
- ☐ 风险情况：有没有自伤自杀念头、计划、过往尝试。
- ☐ 三个问题：最可能的诊断是什么？还需要排除什么？下次复诊看什么变化？

> **什么时候需要联系医生或去急诊**
>
> 评估过程中如果出现下列情况，不要等到预约日：
>
> - 自杀念头变得频繁、具体，或已经开始准备：不要独处，拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
> - 出现命令性幻听、坚信被迫害、明显激越或有伤人风险：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
> - 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：立即急诊。
> - 服药后出现大面积皮疹、起疱、面唇肿胀、呼吸困难：立即停药并急诊。
> - 突然停用酒精或镇静催眠药后出现抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊。
> - 出现木僵、拒食、缄默、长时间保持一个姿势：急诊精神科评估。

常见误区

“医生问得太少，肯定不靠谱。” 问得少确实可能是问题，但也要看问的是什么。有的医生用结构化访谈，问题密集而短；有的医生让你先讲十分钟再追问。判断标准不是时长，而是有没有问到病程、功能、躯体、物质、风险和家族史。

“量表分数高，诊断就重。” 量表测的是这周的痛苦程度，不是障碍的严重度分级。诊断里的“重度”还看功能损害、精神病性症状和风险。

“医生说观察，就是没本事。” 观察是诊断工具之一。尤其是首次发作、青少年、老年人、症状不典型的情况，仓促定论的风险更大。

“换个医院就能马上确诊。” 换医生可能带来新的视角，但如果每次只提供碎片信息，结果往往还是“建议随访”。带着完整的时间线和旧病历去，比换多少家都有效。

“检查都正常，说明我是装的。” 精神障碍目前本来就没有确诊性的化验指标。检查正常排除的是“别的病”，不是排除你的痛苦。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022.
- 国家卫生健康委. 《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

1.3 精神检查与症状学术语

病历上那些“思维散漫”“情感平淡”“自知力不全”，到底在说什么？很多人拿到出院小结，像在读一份外语文件。这一页把精神检查的七个维度拆开，把最常出现的术语翻译成大白话，并说明医生为什么在意这些细节。读完你会发现：精神检查不是随便聊天，而是一次有结构的观察；术语也不是玄学，它们描述的是可以被看见、被追问的东西。

精神检查不是“聊天”

精神科门诊里，医生和你说话的时间可能只有二十分钟，但这段对话同时在做四件事：**建立关系、收集信息、观察状态、评估风险**。聊天是随意的，精神检查是有结构的——医生心里有一张表，从你进门那一刻就开始填。

他看什么？看你走进来的姿态、坐下后离他多远、有没有眼神接触、手放在哪里、说话时表情和内容是否一致、回答是简洁还是绕圈、有没有突然停住、提到某个话题时是否明显紧张。他问什么？除了“哪里不舒服”，还会问睡眠、食欲、精力、注意力、有没有听到别人听不到的声音、有没有觉得被针对、有没有想过结束生命。这些问题不是随口闲聊，每一条都对应诊断标准里的某个位置。

所以精神检查有几个特点，值得患者和家属知道。

它同时看“内容”和“形式”。 你说“我最近很累”，这是内容；你说这句话时语速很慢、停顿很久、眼睛不看人，这是形式。两者都是信息。有时候形式比内容更能说明问题，比如一个人反复说“我没事”，但坐立不安、反复起身、手心出汗。

它会交叉验证。 医生说“家里人说你这两个月几乎不出门”，不是要拆穿你，而是在比对不同来源的信息。说法不一致很常见，本身也是信息，医生会追问“为什么你觉得还好，家人觉得严重”。

它包含风险询问。 问自杀、自伤、伤人，是每一次规范评估的固定动作，不是因为你“看起来危险”。直接回答反而更安全——隐瞒风险不会让风险消失，只会让帮助来得更晚。

它不需要你“表现正常”。 有些人进诊室前会特意整理情绪、挑好听的说，结果医生看到的是一个“状态不错”的人，回家后却完全另一副样子。如实呈现，包括难堪的部分，才对诊断有帮助。

七个维度：一项一项看

规范的精神检查通常覆盖下面七个方面。不同医院格式略有差异，但核心内容相近。

维度	具体看什么	常见术语
外观与行为	衣着、卫生、姿势、步态、眼神接触、动作多少、有无怪异动作	精神运动性迟滞、激越、刻板动作、紧张症行为
言语	语速、音量、话量、流畅度、能否被打断	思维奔逸、思维迟缓、思维中断、病理性赘述
情绪与情感	当下心境、表情是否与内容相称、情绪波动	情感平淡、情感不协调、情感倒错、易激惹
思维形式	话与话之间有没有逻辑、是否跑题、是否空洞	思维散漫、破裂性思维、思维贫乏、思维被插入
思维内容	有没有固定、难以纠正的错误信念	妄想、牵连观念、超价观念、强迫观念
知觉	有没有看到、听到、闻到不存在的东西	幻觉、错觉、命令性幻听、假性幻觉

维度	具体看什么	常见术语
认知与自知力	注意力、记忆、定向力；如何看待自己的病	注意力涣散、记忆减退、自知力缺乏

下面挑最常被误解的几组词，逐个翻译。

情绪与情感：容易混淆的几个词

日常语言里“情绪”和“情感”是一个词，临床上要分开。**心境（mood）**指一段时间里持续的背景情绪，比如“这两个月一直低落”；**情感（affect）**指当下这一刻表现出来的情绪反应，比如说话时的表情、语调、眼泪。一个人可以心境低落，但当下情感表达还算丰富；也可以心境描述不清，而当下情感明显迟钝。

情感平淡是最常被误读的一个。它不是“没感情”“冷血”，而是**情感表达的范围和强度明显收窄**：说话语调平、脸上变化少、讲到高兴或难过的事都没有相应反应。它常见于精神分裂症谱系，也可见于重度抑郁、帕金森病、长期使用某些药物、创伤后麻木。【指南】重要的是，情感平淡描述的是“外在表达变少”，不等于内心没有感受——很多当事人事后会说“我心里其实很难受，但脸上做不出来”。

情感不协调指情感表达与谈话内容、或与当下情境明显不匹配。比如讲亲人去世时笑，或讲一件小事时突然痛哭。它在精神分裂症中较常见，但不是专属，严重解离、脑器质性损害、文化表达差异都可能出现。

情感倒错比不协调更进一步：表达出的情感方向与内容相反。

易激惹指小事就能引发明显愤怒或争吵，常见于抑郁、躁狂、焦虑、创伤后反应、慢性疼痛、失眠和物质戒断。它容易被家人描述成“脾气变差”，但背后可能是抑郁、也可能是躁狂期的开始，需要结合睡眠需求和整体状态判断。

情感脆弱（情绪失禁）指轻微刺激就控制不住地哭或笑，常见于脑卒中后、多发性硬化等神经系统疾病，也可能是极度疲惫下的正常反应。

思维：形式与内容的区别

这是术语最密集的地方，也是最容易被网上文章断章取义的地方。先记住一个区分：**思维形式**说的是“怎么想、怎么讲”，**思维内容**说的是“想了什么”。

思维形式

思维奔逸：话明显变多、变快，一个念头接一个念头，话题不断跳，别人很难插话，常伴“脑子转得飞快”的主观感受。常见于躁狂或轻躁狂发作，也可见于焦虑激动、甲亢、某些药物作用。

思维迟缓：思考变慢、反应变慢、说话少而慢、停顿多，本人常觉得“脑子像生锈”。常见于抑郁发作，也可见于甲状腺功能减退、药物镇静、睡眠严重不足。

思维中断：说话说到一半突然停住，片刻后换一个话题，本人可能说“脑子突然空了”。**思维阻滞**类似，但更强调“被外力挡住”的体验。这类描述在精神分裂症中较常见，但一次出现说明不了什么，疲劳、焦虑、注意力涣散也会有类似表现。

思维散漫：句子之间缺乏逻辑联系，听的人抓不住重点，问东答西，但单个句子还算通顺。**破裂性思维**更严重，句子之间也失去联系，变成词的堆砌。

病理性赘述：讲话绕来绕去、细节过多、抓不住重点，但方向大体还在。常见于癫痫相关障碍、老年认知下降、部分人格特点。

思维贫乏：不是“不想说”，而是“没什么可说”，回答简短空洞，缺乏内容。常与情感平淡、意志缺乏一起出现。

持续言语：反复重复同一个词或同一句话，常见于痴呆、脑器质性损害。

思维内容

妄想是核心概念。它指一种**固定的、与事实不符的信念**，即使有相反证据、即使周围人都不同意，当事人仍然坚信，而且这种信念通常与他的文化背景不相符。常见主题有被害（有人害我）、关系（别人的话都在说我）、夸大（我有特殊能力）、嫉妒（伴侣不忠）、罪恶（我罪不可赦）、被控制（我的身体被别人操纵）、被洞悉（别人能知道我在想什么）。

需要注意两点。第一，妄想不是“想法奇怪”，很多人有奇怪的爱好和观点，但能接受讨论、会随证据调整，那叫超价观念或普通信念，不叫妄想。第二，妄想的内容受文化影响，某些在特定宗教或民俗语境中常见的说法，不能简单判为妄想——这正是精神检查要问“你们那里的人怎么看”的原因。

牵连观念指把外界无关的事认为与自己有关，比如觉得路人咳嗽是在暗示自己、电视里的台词在说自己。轻微的牵连观念在焦虑、疲惫、社交敏感的人身上也会短暂出现；只有当它固定、泛化、影响行为时，才更有临床意义。

超价观念指一种强烈但尚未达到妄想程度的信念，通常与个人经历、价值观紧密相关，能被部分说服。**强迫观念**则是反复闯入的、本人认为不合理却无法摆脱的想法，通常伴随强烈的抵抗和痛苦，与妄想的“坚信”不同。

知觉、认知与自知力

幻觉指没有相应外界刺激时产生的真实知觉体验——真的“听到”“看到”，不是想象，也不是“觉得好像”。最常见的是**幻听**，包括**命令性幻听**（声音命令去做某事，这一项必须高度重视）、**评论性幻听**（声音评论自己的一举一动）、**争论性幻听**（两个声音争吵）。幻视在成人中相对少见，出现时要更多考虑躯体或药物因素；**幻触**（虫爬感）常见于物质戒断或躯体疾病；**嗅幻觉**（闻到别人闻不到的味道）尤其要警惕神经系统问题。

错觉与幻觉不同：错觉是**有外界刺激但感知错了**，比如把衣架看成一个人、把风声听成哭声。健康人在昏暗、疲劳、发烧、刚睡醒时都可能出现，本身不代表障碍。

假性幻觉指“听到”的声音不在外界空间，而在脑子里，本人知道它不是通过耳朵来的。这个概念在中文教材里常见，但不同学派的界定有差异，实际诊断中更看重体验的整体结构而不是单个标签。

认知在精神检查里主要指注意力、记忆力、执行功能和定向力。抑郁和焦虑会造成明显的注意力下降（“看书看不进去”），容易被误认为“变笨了”；老年人出现记忆下降，需要区分抑郁相关的假性痴呆、谵妄和真正的认知障碍。

自知力指一个人如何看待自己的状态：是否认为这些体验不正常、是否认为自己需要帮助、是否愿意配合评估和处理。自知力不是“听话”，也不是道德评价。它常常随病情波动——急性期坚信自己没病，好转后才发现“当时确实不对”。医生评估自知力，是为了判断需不需要家属参与、要不要更严密的安全安排，而不是给你打分。

家属能观察和记录什么

家属的描述常常比当事人更完整，但也容易只看到“行为”，漏掉“体验”。下面这份清单可以直接照着记，复诊时带给医生。

- ☐ 睡眠：几点上床、几点睡着、夜里醒几次、几点起、白天睡不睡。
- ☐ 吃饭与体重：吃得多少、有没有明显变化、有没有躲着吃或催吐。
- ☐ 说话：话变多还是变少、语速、能不能被打断、有没有突然停住。
- ☐ 情绪：一天里什么时候最差、有没有毫无原因的哭泣或大笑、有没有明显易怒。
- ☐ 行为：出门次数、洗漱、房间状态、有没有重复动作、有没有长时间不动。
- ☐ 知觉与想法：有没有自言自语、侧耳倾听、突然紧张、说“有人针对我”。
- ☐ 功能：上班上学是否中断、家务是否还能做、社交是否明显减少。
- ☐ 风险：有没有说“活着没意思”、有没有自伤、有没有把东西送人。
- ☐ 用药与物质：吃了什么、什么时候停的、有没有喝酒。
- ☐ 记录方式：用手机备忘录按日期写一两行，比事后回忆准确得多。

什么时候需要联系医生或去急诊

- 听到命令自己做危险事情的声音，或坚信有人要害自己、因此准备“反击”：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备：不要独处，立即 120 或急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 长时间保持一个姿势、不说话、不吃不喝、对外界刺激没有反应：可能是紧张症或木僵，立即急诊。
- 意识时清时浊、注意力飘忽、看到虫或人影、伴发热或感染：警惕谵妄，立即急诊。
- 服药后高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变：立即急诊。
- 首次出现幻觉或妄想，伴头痛、抽搐、视物异常：按神经系统急症处理，立即急诊。

常见误区

“病历写我‘情感平淡’，是不是说我冷血？” 不是。它描述的是情绪的外在表达变少，是症状描述，不是人格评价。很多人在恢复后会说，当时心里有感受，只是表达不出来。

“思维散漫是不是就是说话没逻辑？” 日常的“跳跃”通常还能听懂大意，思维散漫是听的人完全抓不住主线，本人也说不清自己要表达什么。两者程度不同，需要医生判断。

“有幻觉就是精神分裂症。” 幻觉可见于双相、抑郁伴精神病性特征、物质中毒或戒断、癫痫、脑炎、谵妄、听力障碍、极度睡眠剥夺。只凭幻觉这一条，无法确定是哪种。

“自知力差就是不讲理。” 自知力受损是症状的一部分，尤其在急性期。这时候争论“你有没有病”通常没有帮助，先处理状态、保证安全更重要。

“术语越专业，诊断越可靠。” 术语只是描述工具。同一个词在不同医生那里可能有细微差别，真正可靠的是完整的病史、纵向观察和排除过程。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- 国家卫生健康委. 《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

1.4 DSM-5-TR 与 ICD-11 怎么用

同一段经历，在两家医院拿到两个不同的诊断名称，是不是有人搞错了？不一定。精神科目前有两套主流的国际分类系统：美国的 DSM-5-TR 和世界卫生组织的 ICD-11。它们对同一群人的描述大同小异，但在时间门槛、分组方式和一些具体障碍的界定上确实不同。这一页讲两套系统各自是什么、差异在哪里、为什么会出现两个名称，以及为什么不能拿着条文给自己下诊断。

两套系统是什么关系

DSM 由美国精神医学学会编写，1952 年出第一版，现在用的是 2013 年 DSM-5 的修订版 DSM-5-TR（2022 年）。它在美国的临床、教学、研究和保险赔付中用得最多，也是很多国际研究约定俗成的“共同语言”。ICD 由世界卫生组织编写，覆盖全部疾病，精神障碍在其中是第 06 章“精神、行为与神经发育障碍”；ICD-11 于 2019 年由世界卫生大会通过，2022 年 1 月 1 日生效，各国陆续本地化采用。

维度	DSM-5-TR	ICD-11
编写机构	美国精神医学学会	世界卫生组织
主要用途	美国临床、研究、保险；国际研究常借用	全球疾病统计、公共卫生、各国医保与法律
结构	按障碍类别分章，双相与抑郁分列	第 06 章内分组，双相与抑郁合为“心境障碍”
人格障碍	第十类类型 + 第三节维度模型	采用维度模型（严重度 + 特质），不设类型
配套工具	结构化访谈 SCID-5、量表、文化访谈	临床描述与诊断指南（CDDR）、各地翻译版

两者不是“谁更权威”的关系，而是**服务对象不同**：DSM 更像临床医生的操作手册，条目写得细、边界划得清；ICD 更像全球通用的统计与公共卫生框架，强调跨文化适用和与各国卫生系统的衔接。中国临床实践中两者都在用，医院病历和科研入组常参考 DSM-5-TR，疾病分类与统计上报则对接 ICD。

三个“门槛”：时间、功能、排除

无论用哪套标准，一个诊断要成立，通常都要过三道门槛。这三道门槛比“有几条症状”重要得多，也是最容易被网上文章删掉的部分。

门槛	它在问什么	常见处理方式
时间	这些表现持续了多久？是持续存在还是阵发？	不同障碍要求不同：两周、一个月、六个月不等【指南】
功能	有没有造成明显痛苦或生活功能下降？	看工作、学习、社交、自我照顾，而不是只看感受
排除	有没有躯体疾病、物质、药物、其他精神障碍能更好解释？	化验、用药核对、停药观察、纵向随访

时间门槛最容易引起误解。以精神分裂症为例，DSM-5-TR 要求总的病程至少六个月，其中至少一个月是活跃期症状；ICD-11 的时间要求更短，症状持续约一个月即可。【指南】这意味着同一个人，在发病第六周去看两位分别使用两套标准的医生，可能一个被写成“精神分裂症”，另一个被写成“其他原发性精神病性障碍”或“待观察”。不是谁错了，而是标准划的线不同。

再比如广泛性焦虑：DSM-5-TR 要求担忧持续至少六个月，ICD-11 的表述是“至少数月”，没有写死六个月。对于刚好难受了四个月的人，这个差别可能直接影响有没有一个诊断名称。

功能门槛是诊断的实质。诊断标准里几乎都有“造成临床显著痛苦或功能损害”这一条，但“显著”没有刻度。同样是每天担心，一个人还能正常上班、照顾孩子，一个人已经请假三个月、不敢出门，临床意义完全不同。医生判断功能，通常问得很具体：这个月请了几天假？孩子的作业还管不管？多久没和朋友见面？能不能独自坐地铁？

排除门槛最费时间，也最容易被跳过。甲状腺功能亢进可以表现得像焦虑障碍，甲状腺功能减退可以表现得像抑郁，睡眠呼吸暂停可以造成注意力差和情绪不稳，酒精和镇静药物可以造出几乎任何精神症状，脑炎早期可能只表现为“行为古怪”。不做排除就下诊断，是把风险留给了患者。

两套标准的差异在哪里

除了时间门槛，还有几处差异在日常就诊中会碰到。

分组逻辑不同。 DSM-5-TR 把双相障碍和抑郁障碍分成两章，强调两者的区别；ICD-11 把它们放在同一个“心境障碍”组里，更强调连续性和共同机制。这不只是排版问题，它会影响医生思考的顺序：一个以抑郁为主诉的人，在 ICD 框架下更容易被追问“有没有过高涨期”，在 DSM 框架下则要先判断当前是抑郁章还是双相章。

人格障碍的模型不同。 DSM-5-TR 保留了十种人格障碍类型（边缘型、回避型等），同时在第三节给出一套维度模型供研究使用；ICD-11 直接取消了类型，改为评估“人格障碍的严重程度”加上几个特质维度（如负性情绪、疏离、去抑制、强迫性）。【指南】所以同一个人可能在一份报告里被写成“边缘型人格障碍”，在另一份里被写成“中度人格障碍，伴负性情绪与冲动特质”。描述的是相近的东西，语言体系不同。

躯体症状相关障碍的命名不同。 DSM-5-TR 用“躯体症状障碍”，核心是“对身体症状的过度想法、感受和行为”；ICD-11 用“身体不适障碍”，核心是“反复多系统躯体不适及对健康的过度关注”。两者都强调“不是装病”，但切入角度有差别。

新增与删除的条目不同步。 比如延长哀伤障碍，ICD-11 先纳入，DSM-5-TR 在 2022 年也纳入，但两边的病程门槛和症状要求不完全一致。再比如游戏障碍，ICD-11 把它列为一种障碍，DSM-5-TR 只在“需要进一步研究的情况”里提到。反过来，DSM 里有的一些标注（如“伴混合特征”“伴焦虑痛苦”）在 ICD-11 里没有完全对应的写法。

文化相关的内容位置不同。 DSM-5-TR 有专门的文化概念化访谈提纲，提醒医生评估文化解释、文化压力和支持；ICD-11 也在指南中强调文化适用性。这一点对移民、少数民族、宗教家庭尤其重要——某些表达在特定文化中是正常的，不应该被直接翻译成症状。

为什么同一个人可能有两个名称

理解了上面的差异，就很容易明白为什么会出现“两个名称”。

第一，标准不同。 如上所述，时间门槛、分组方式、条目取舍都会改变结论。

第二，医生不同。 有的医生习惯用 DSM 的细条目，有的习惯用 ICD 的临床描述；有的偏向“早一点给名字好沟通”，有的偏向“证据不足就先观察”。这属于临床判断的差异，不一定是错误。

第三，时间不同。 半年前的评估和今天的评估看到的是不同片段。轻躁狂期没被问到、物质使用后来才承认、躯体检查后来才做，都会改变结论。

第四，目的不同。 临床诊断是为了治疗，统计编码是为了上报，保险审核看的是另一套规则，司法鉴定又有自己的标准。同一份病情，在不同文书里写成不同名称，有时是正常的。

第五，翻译与本地化。 中文版术语在各地译法不完全统一，比如同一个英文概念，大陆、香港、台湾的译名可能不同；ICD-11 的本地化版本也在陆续推出。看到陌生译名时，先确认它对应的是哪个概念。

需要提醒的是，**诊断名称不同，不等于病情不同**。对治疗真正重要的是：症状的组合与严重度、功能受损在哪、有没有风险、有没有躯体或物质因素、对什么治疗有反应。名称是这些内容的简写，简写可以不一样，内容才是根本。

为什么不能照条文自诊

网上流传的“DSM-5 诊断标准”大多是删节版，常见的问题有四类。

第一，删掉了门槛。 只列症状条目，不写持续时间、功能损害和排除条件。于是“最近两周情绪低落、睡不好、没兴趣”就被读成“抑郁症”，而实际上还需要排除躯体疾病、物质影响、双相史，也需要评估功能损害程度。

第二，删掉了限定词。 原文里大量的“大多数日子”“几乎每天”“明显超出正常范围”“与文化背景不符”，在转述中常常消失。这些限定词正是判断的关键，去掉之后，任何普通情绪波动都能被套进去。

第三，需要临床判断的条目无法自评。 比如“言语增多或主观感到话多”“思维奔逸”“注意力随境转移”，需要有人观察你的语速、能否被打断、话题是否跳跃，自己很难客观评估。再比如“功能损害”，自己觉得“还行”和实际请假三个月，往往是两回事。

第四，版本会过时。 网上很多内容来自 DSM-IV 或更早的版本，条目数量、时间门槛都已经改了。用二十年前的标准对照今天的自己，结论没有意义。

条文是给受过训练的人用的工具，不是给大众用的自测表。它的每一条都预设了“由医生来判断这个描述是否成立”，去掉这个前提，条文就变成了暗示。

就诊时怎么问、怎么核对

如果你想知道医生用的是哪套标准、依据是什么，可以这样问。这些问题不会冒犯医生，反而常常被欢迎。

- ☐ 您这次考虑的诊断，用的是 DSM-5-TR 还是 ICD-11？

- ☐ 支持这个诊断的关键证据是哪几条？分别对应多长时间？
- ☐ 目前还需要排除什么？需要做哪些检查或观察多久？
- ☐ 我的功能损害主要体现在哪方面？严重度大概在什么程度？
- ☐ 有没有可能同时存在另一个诊断？两个诊断的先后顺序是什么？
- ☐ 如果之后出现哪些变化，诊断可能需要修正？
- ☐ 下次复诊时，您希望我记录哪些内容？
- ☐ 这个诊断会不会写进病历？对请假、保险、就业可能有什么影响？

什么时候需要联系医生或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被迫害并准备采取行动、明显激越：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
- 首次出现精神病性症状，伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识波动：立即急诊，警惕脑炎、感染、谵妄。
- 木僵、拒食、缄默、长时间维持一个姿势：急诊精神科评估。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变：立即急诊。
- 长期大量饮酒或镇静药突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊。

常见误区

“DSM 是美国的，跟中国没关系。” 中国临床和研究大量参考 DSM-5-TR，疾病分类与统计则对接 ICD。两套都在用，只是场景不同。

“两个医生给的诊断不一样，肯定有一个是误诊。” 名称不同可能来自标准、时间点、信息量或表述习惯的差异。真正要问的是：两个诊断对治疗方案的指向是否一致，有没有哪一方漏掉了重要的排除。

“ICD-11 更新，所以 DSM 过时了。” 两套系统各自修订，节奏不同，不存在谁替代谁。DSM-5-TR 是 2022 年的文本修订版，ICD-11 于 2022 年生效，都在使用中。

“诊断名称越细越好。” 细名称有助于沟通，但对治疗决策的帮助有限。严重度、功能损害、风险、共病，往往比名称本身更重要。

“查了标准，我全中。” 这是最需要警惕的一句。标准里的限定词、时间门槛和排除条件，恰恰是自诊时最容易忽略的部分；而“全中”本身也可能是焦虑的表现。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults (CG113), 2011（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

1.5 鉴别诊断与共病的基本原则

“医生说我既是抑郁又是焦虑，还有边缘型人格，到底是几个病？”这是门诊里很常见的问题。另一头，也常有人问：“我查了甲状腺、做了核磁，都正常，为什么医生还不肯下结论？”这两个问题指向同一件事：精神科诊断不是把症状往格子里塞，而是一个不断排除、排序、验证的过程。这一页讲三条基本原则——先排除、再辨析、后排序；也讲共病到底意味着什么，以及为什么“多贴几个标签”往往不是好事。

为什么“先排除”是铁律

精神科有一条几乎不容妥协的原则：**在把症状归因于精神障碍之前，先排除躯体疾病、物质使用和药物影响。** 这条原则的道理很朴素——漏掉一个甲状腺功能亢进，代价是持续几个月甚至几年的错误治疗；漏掉一个脑炎，代价可能是不可逆的损伤。

【指南】DSM-5-TR 和 ICD-11 在多数障碍的诊断标准里都写有排除条件，例如“症状不能由某种物质的生理效应或另一种躯体疾病更好地解释”。这不是客套话，而是诊断成立的必要条件。也就是说，一个诊断即使症状条目全都符合，只要存在更能解释全部表现的躯体或物质原因，这个诊断就不成立。

为什么精神症状这么容易被躯体病“冒充”？因为大脑是全身的一部分。甲状腺激素、血糖、电解质、氧饱和度、炎症因子、肝肾功能、药物浓度，任何一项异常都可能改变注意力、情绪、睡眠、思维速度和行为。表现上，它们和“原发性”精神障碍可以几乎一模一样。

反过来也要提醒一句：**检查正常，不等于症状是“想出来的”。** 目前多数精神障碍没有确诊性的化验指标，检查正常排除的是“别的病”，不是排除你的痛苦。这两件事经常被混为一谈，结果要么是患者觉得“医生在说我装病”，要么是家属觉得“查不出毛病就是矫情”。

三类“模仿者”

鉴别诊断的对手主要来自三个方向。下面这张表不是完整清单，但覆盖了门诊最常遇到的几类。

方向	常见例子	医生会问/查什么
躯体疾病	甲亢、甲减、贫血、维生素 B12 缺乏、低血糖、电解质紊乱、睡眠呼吸暂停、颞叶癫痫、脑血管病、自身免疫性脑炎、慢性感染、激素异常	起病快慢、发热、体重变化、心悸、打鼾、抽搐、视物异常；血常规、甲功、血糖、电解质、肝肾功能、心电图，必要时脑电图或影像
物质使用	酒精（醉酒与戒断）、大麻、苯丙胺类、阿片、镇静催眠药、咖啡因、尼古丁、致幻剂	使用种类、频率、最后一次使用时间、停用后有没有抖动/出汗/幻觉；必要时尿检
药物与其他	糖皮质激素、干扰素、异烟肼、左旋多巴、抗胆碱能药、部分抗生素、抗癫痫药、口服避孕药、化疗与免疫抑制药、含激素或重金属的保健品	用药清单、开始与加量时间、减量后是否好转、说明书副作用

这三类之所以重要，是因为它们**通常可以纠正**。把甲减当抑郁治，抗抑郁药效果往往有限；把酒精戒断当焦虑治，可能错过抽搐和谵妄的风险；把激素引起的躁狂当双相治，停药才是关键一步。

除了这三类，还有一类常被忽略：**其他精神障碍**。强迫症和广泛性焦虑都表现为反复思考，双相抑郁和单相抑郁都表现为情绪低落，创伤后应激和边缘型人格都表现为情绪不稳与自伤，孤独症谱系和社交焦虑都表现为回避社交。这些“精神科内部的模仿者”，靠的不是化验，而是时间线、起病年龄、症状结构和对治疗的反应来区分。

时间关系：判断“谁引起谁”的实用线索

发现一个人既有躯体病又有精神症状，不等于两者有因果关系。判断因果，最实用的工具是**时间关系**。

时间线索	提示
精神症状在用药加量或物质使用后数天内出现	更支持物质/药物所致
减量、停药或戒断后症状明显减轻	更支持物质/药物所致
再次使用后症状重现	因果关系更强
躯体病确诊在前，精神症状随后出现并随躯体病波动	更支持躯体疾病所致
精神症状先出现多年，躯体病后来才有	更可能是两个独立问题
症状与月经周期、季节、轮班、时差稳定相关	提示内分泌、昼夜节律因素

还有几个实用做法：**停药观察**（在医生指导下，评估症状是否随停药改善）、**治疗躯体病后再评估**（比如先把甲状腺功能调到正常，再看情绪）、**尿检或血药浓度**（在知情同意下）、**向家属核对使用情况**（很多人不会主动提饮酒或助眠药）。

需要强调的是，时间关系只是线索，不是判决。有些躯体病早期症状很轻，有些物质使用的隐瞒很常见，有些“原发性”精神障碍也会在躯体病之后首次发作。所以规范的做法是：**保留两种可能，边治边看，定期复核**。

共病不是“多贴几个标签”

共病（comorbidity）指一个人同时符合两个或以上障碍的诊断标准。它在精神科非常常见：抑郁与焦虑共病、创伤后应激与抑郁共病、物质使用与几乎任何精神障碍共病、孤独症谱系与注意力问题共病。共病不是诊断水平不够的表现，而是真实存在的现象。

但“共病”这个词经常被误用。下面几种情况，看起来像共病，其实不是。

第一种，把一个病的不同症状拆成几个病。 抑郁的人本来就会注意力差、担心、睡不好、容易发脾气。如果把这些分别写成“注意力障碍”“广泛性焦虑”“失眠障碍”“间歇性暴怒”，就变成了四个标签，但实际上可能只是一个抑郁发作的不同侧面。

第二种，把因果关系当成并列关系。 长期失眠可以引起情绪低落，长期焦虑可以引起抑郁，创伤可以同时引起闪回、回避和抑郁。这些情况下，写两个诊断不算错，但治疗的重点不一样——先处理哪个，取决于哪个是“上游”。

第三种，把人格特质和发作混在一起。 一个人平时就敏感、容易紧张，抑郁发作时更明显。如果只写“人格障碍”，可能漏掉可治疗的发作；如果只写“抑郁”，可能忽略长期模式对治疗关系的影响。

第四种，诊断遮蔽（diagnostic overshadowing）。 一个人已经有精神科诊断，后来出现新的躯体症状（头痛、腹痛、乏力、体重下降），容易被一句“这是你的焦虑/抑郁躯体化”带过去，从而漏掉真正的躯体病。这是临床上真实存在、且后果严重的偏差，尤其容易发生在老年人、慢性精神障碍患者和有物质使用史的人身上。

判断共病是否成立，通常要看三件事：**每一组症状是否各自达到诊断门槛**（而不是勉强凑数）、**它们的时间关系是什么**（同时起病、先后起病、还是一个引起另一个）、**分开处理后是否各自有独立反应**（比如抑郁改善后焦虑仍持续，才更像两个问题）。

诊断顺序与优先级

当一个人同时存在多个问题时，医生不会平等对待所有诊断，而是按优先级排序。排序的依据通常有四条。

第一，先处理危及生命的。 自杀风险、拒食导致的电解质紊乱、谵妄、恶性综合征、酒精或镇静药戒断、严重激越，这些优先于任何“定性”问题。这时候诊断的作用是快速指向处理，而不是求全。

第二，先处理可逆的。 药物引起的、感染引起的、甲状腺引起的、睡眠呼吸暂停引起的、维生素缺乏引起的，只要能纠正病因，症状往往随之改善。这类问题排在“原发性精神障碍”之前。

第三，先处理“上游”。 如果焦虑是失眠的结果，先治失眠；如果抑郁是长期创伤反应的一部分，创伤相关的工作不能一直往后拖；如果物质使用是维持失眠和情绪不稳的原因，戒断与减量是绕不开的一步。

第四，先处理对治疗影响最大的。 双相障碍被误当单相抑郁治疗，可能诱发转躁；强迫症合并抽动，用药选择不同；孤独症谱系合并焦虑，治疗方式需要调整。这些“会影响方案”的诊断，需要在早期就辨明。

排序不是一次完成的。常见的做法是：**先给一个工作诊断，按最可能的方向处理，同时把“待排除”写在病历里，四周到八周后复核。** 随着信息增加，顺序可能调整，甚至主诊断会换人。这不是摇摆，而是规范。

这里还有一个常被忽略的排序问题：**病因性诊断优先于症状性诊断**。比如“甲状腺功能减退所致精神障碍”比“抑郁障碍”更具体，只要证据支持，就应该写前者；只有在排除之后，才写“原发性”。同理，“酒精所致精神病性障碍”与“精神分裂症”在时间关系明确时，前者优先。

就诊前可以做的准备

鉴别和共病靠的是信息，而信息很大一部分掌握在患者和家属手里。

- ☐ 把最近一年的用药列全：药名、开始时间、加量时间、停药时间（不必写剂量，带药盒即可）。

- ☐ 记下饮酒、吸烟、咖啡、助眠药、止痛药的使用频率和最近一次时间。
- ☐ 整理近期的化验与检查报告，特别是甲功、血常规、血糖、电解质、心电图。
- ☐ 写下慢性病清单：高血压、糖尿病、甲状腺病、肝病、肾病、癫痫、自身免疫病。
- ☐ 记录症状出现的顺序：哪个先来，哪个后来，间隔多久。
- ☐ 注意有没有“周期性”：与月经、季节、轮班、熬夜的关系。
- ☐ 回忆有没有发热、头痛、抽搐、视物异常、体重明显变化、打鼾憋醒。
- ☐ 写下家族史：精神障碍、自杀、住院、酒精问题。
- ☐ 准备一个问题清单：还需要排除什么？先治哪个？多久复核一次？

什么时候需要联系医生或去急诊

- 意识时清时浊、注意力飘忽、看到虫或人影、伴发热或感染：警惕谵妄，立即急诊。
- 高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变、肌酸激酶升高：警惕恶性综合征或严重药物反应，立即急诊。
- 开始新药或加量后出现高热、震颤、躁动、腹泻、反射亢进：警惕严重药物反应，立即急诊。
- 长期大量饮酒或镇静催眠药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊，不要自行硬戒。
- 严重皮疹、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难：立即停药并急诊。
- 自杀念头、自伤行为、拒食超过一天、木僵：立即 120 或急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

常见误区

“检查都正常，就不用再查了。” 有些问题需要动态观察（如自身免疫性脑炎、间歇性卟啉病、睡眠呼吸暂停），一次正常不能排除全部。症状变化时，医生可能会重复或补充检查。

“有两个诊断，说明医生没本事。” 共病是真实存在的。真正需要警惕的是“标签越贴越多、却没有一个能解释主要功能损害”的情况。

“先治哪个都一样。” 顺序会影响效果和安全。双相被当单相抑郁治、谵妄被当焦虑治、戒断被当失眠治，都是有代价的。

“既然是焦虑引起的，躯体症状就不用管。” 诊断遮蔽是明确的临床风险。新出现的躯体症状，尤其伴体重下降、发热、疼痛性质改变时，需要重新评估。

“共病就是病得更重。” 共病通常提示需要更综合的方案，但不等于预后一定差。很多人在规范处理后，两三个问题会一起改善。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.

- 国家卫生健康委. 《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

1.6 误诊、过度诊断与诊断标签

精神科的诊断没有化验单可以对照，因此它比很多专科更容易出错，也更容易被争论。有人被误诊多年，有人被过度诊断吃了不必要的药，也有人因为一个标签失去了工作机会。这一页讲误诊通常怎么发生、过度诊断与漏诊为什么是一枚硬币的两面、诊断为什么会改变，以及一个标签落到身上之后，隐私、保险、自我认同会发生什么。读完你大概能判断：什么时候该接受一个诊断，什么时候该去要一个第二意见。

误诊是怎么发生的：四条常见路径

误诊很少是“医生故意乱写”，更多是信息、时间和认知偏差共同作用的结果。门诊最常见的路径有四条。

第一条，信息不足。 一次门诊十几分钟，患者可能只讲了最近两周的失眠，没提三年前那次“连着几天不睡也不累”的时期；可能只说了胃不舒服，没提每天半斤白酒；可能只说了注意力差，没提从小就这样。双相障碍被当成单相抑郁治疗，最常见的原因就是没人问过轻躁狂史。

第二条，锚定与惯性。 一个人第一次被写成“抑郁”，之后的医生容易沿用这个标签，只在上面加药、加量，很少重新问“这个诊断还站得住吗”。学术上把这种现象叫诊断锚定和诊断惯性。它在慢性病、反复就诊、跨医院转诊的人身上尤其常见。

第三条，诊断遮蔽。 已经有精神科诊断的人，后来出现新的躯体症状时，容易被一句“这是焦虑的躯体化”带过去。体重下降、持续头痛、夜间盗汗、新发的抽搐，这些信号如果被标签挡住，可能延误肿瘤、感染、自身免疫病的发现。老年人、长期精神障碍患者、有物质使用史的人，是诊断遮蔽的高危人群。

第四条，偏差。 同样的表现，落在不同人身上会被读成不同的东西。女性更容易被写成“情绪化”“边缘型”“焦虑”，男性更容易被写成“物质问题”“冲动控制差”；儿童的社交困难可能被写成“内向”，成年后才被发现是孤独症谱系；老年人的抑郁可能被当成“正常衰老”，而谵妄可能被当成“痴呆加重”；少数群体面对的现实压力，可能被简化成个人脆弱。这些偏差不是个别医生的恶意，而是整个诊断体系需要持续校准的地方。

还有两条也值得记：**量表驱动**（只看分数不看人）和**治疗反应误导**（吃了某药有效就反推诊断，实际上很多药对不同障碍都有效）。

过度诊断与漏诊：同一枚硬币的两面

过度诊断指的是：一个人被贴上了某个诊断，但这个诊断在他身上并不会带来实际好处，甚至带来伤害——可能是因为症状本来轻微、会自行缓解，可能是因为标准被放宽到把正常波动也纳入，也可能是因为这个标签导致了不必要的治疗。

它和漏诊看起来相反，成因却常常相同：**评估不够细、时间不够长、信息不够全**。

现象	常见原因	可能后果

现象	常见原因	可能后果
过度诊断	筛查普及、公众意识提高、门诊时间短、标准放宽、报销与资源导向、社交媒体自我标签	不必要的用药与副作用、标签污名、资源挤占、把正常波动病理化
漏诊	表现不典型、患者只报躯体症状、隐瞒物质使用或创伤、语言与文化障碍、医生只问一个方向、诊断遮蔽	延误治疗、病情慢性化、反复急诊、家庭负担加重

需要区分两件事：**识别率提高**和**过度诊断**。过去很多抑郁、孤独症、成人注意力问题确实被漏掉了，现在被认出来，是进步。判断是不是过度诊断，关键不在于“诊断数量变多”，而在于“这些被诊断的人，是否因此获得了更好的结果”。如果一个人被诊断为轻度抑郁，随后接受了规范的心理治疗并明显好转，这是识别；如果一个人只是考试前焦虑两周，被贴上“焦虑症”并长期服药，却没人评估他的睡眠、咖啡因和压力源，这更接近过度诊断。

漏诊同样普遍，而且更隐蔽。它的代价是时间：抑郁被当成“性格问题”拖了五年，孤独症被当成“不合群”拖到成年，睡眠呼吸暂停被当成“抑郁的疲劳”治了三年。漏诊不会上新闻，但它每天都在发生。

对中国读者还要加一句现实提醒：**不同地区、不同级别医院的精神科资源差别很大**。基层医院可能没有条件做完整评估，专科医院可能一号难求。这不意味着基层诊断一定不可靠，而意味着你需要更主动地提供信息，并在效果不理想时考虑转诊或第二意见。

诊断改变：什么时候该改，什么时候是漂移

诊断改变在精神科是常态，但“改变”有两种性质，值得分开看。

一种是正常的修正。 补充了病史（原来有过躁狂期）、完成了排除（甲状腺问题被纠正、酒精戒断被处理）、观察到了新发作（从单次抑郁变成反复发作）、治疗反应提供了新信息（抗抑郁药后出现转躁）。这种情况下，改诊断说明评估在推进，是好事。

另一种是诊断漂移。 指某个诊断的使用率在几年内、或在地区之间出现系统性变化，而人群的实际患病情况未必同步变化。比如某些国家精神分裂症的诊断率长期下降、双相和成人注意力障碍的诊断率上升、孤独症谱系诊断明显增加。漂移的原因包括标准修订、疾病认知变化、医保编码、药物市场、医生训练风格，也包括社会对某些标签的接受度不同。【研究】

漂移本身不是错误，但它提醒我们：**诊断名称里有一部分是时代和环境的产物。** 同一个人，在 1990 年、2010 年和 2026 年去看病，可能拿到三个不同的名字。这不代表他变了三次，而代表命名的框架在变。

对个人来说，实用的判断是：

- **该改的时候**：出现了新的事实（新的发作形式、新的躯体病、新的物质使用信息）；现有治疗长期无效且副作用明显；症状组合与当前诊断的核心特征明显不符。
- **不必急着改的时候**：只是换了一个医生、换了一套分类系统、或者名称翻译不同，而描述的内容其实一致。

标签会跟着你走

诊断一旦写进病历，就不只是一个医学判断，它还会进入制度。下面几件事，很多人是事后才知道的。

隐私。 门诊病历、住院记录、电子健康档案都属于敏感个人信息。它们在医院内部共享、在转诊时流转、在医保结算中被调取。不同地区对访问权限、保存年限、第三方调阅的规定不同，但“写下来就可能被看到”是基本事实。合法授权范围内的调阅，通常不需要你每次签字。

保险。 商业健康保险、重疾险、寿险在核保时可能询问精神障碍史，已承保的保单也可能涉及如实告知义务。具体规则各地差异很大，且随产品变化。比较稳妥的做法是：在投保前看清健康告知问卷，不要凭印象回答；已有保单的，保留好投保时的材料。

就业与职业资格。 多数岗位受反歧视法律保护，用人单位不能仅因精神障碍史拒绝录用或辞退。但部分职业（飞行、航海、军警、部分公职与安全岗位）有明确的健康标准，可能限制或需要定期评估。现实中还有一层隐形的：同事的看法、领导的顾虑、晋升时的印象。这一层没有法条可以解决，只能靠选择披露的范围。

自我认同。 这是最容易被低估的一层。标签会改变一个人解释自己的方式：一次普通的情绪低落被读成“复发了”，一次正常的紧张被读成“焦虑又来了”，一个优点被归因于“病给我的敏感”。有些人会把诊断当成免于责任的理由，也有些人会把它当成不敢尝试的理由。两种都让生活变窄。

家庭关系。 家人知道诊断后，可能过度保护、过度监控，也可能把所有冲突都归因于病。对青少年来说，这尤其影响自主性；对伴侣来说，可能变成长期的不对等。

这些代价不意味着“不要诊断”。它意味着：**诊断要写得准，范围要写得窄，披露要看对象，解释权要留在自己手里。** 病历上写“考虑某障碍，建议随访”比写一个钉死的结论更留有余地；向单位说明时，说“我需要定期复诊”比贴一个病名更必要；在社交场合，你有权不说。

怀疑诊断不对时，可以做什么

怀疑是正常的，行动要有章法。下面这份清单可以直接照着做。

- ☐ 先确认自己掌握了完整信息：起病时间、症状变化、用药与物质使用、躯体检查、家族史。
- ☐ 把旧病历、出院小结、化验单、药盒整理成一个文件夹，复诊时带上。
- ☐ 记录最近四周的症状与功能变化，按日期写，每次一两行。
- ☐ 问清楚当前诊断的依据：支持哪几条、排除了什么、还需要观察多久。
- ☐ 如果治疗方案长期无效或副作用明显，明确提出“是否需要重新评估诊断”。
- ☐ 考虑第二意见：可以带齐材料去另一家医院的精神科，而不是从头再讲一遍。
- ☐ 第二意见不等于否定前一位医生；把两份意见的差异告诉双方，往往比选边更有用。
- ☐ 不要在医生不知情的情况下自行停药、减药或换药，尤其是抗精神病药、心境稳定剂和苯二氮䓬类。
- ☐ 如果诊断涉及儿童、老人、孕产期，主动要求评估发育史、用药相互作用和躯体因素。

☐ 保留自己的记录：什么时候被诊断、依据是什么、什么时候改过、为什么改。

什么时候需要联系医生或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法、告别、送东西：不要独处，立即拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被迫害并准备采取行动、明显激越或有伤人风险：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：立即急诊。
- 服药后出现大面积皮疹、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难：立即停药并急诊。
- 长期大量饮酒或镇静药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊。
- 木僵、拒食、缄默、长时间维持一个姿势：急诊精神科评估。
- 已有精神科诊断的人新出现持续头痛、体重明显下降、发热、抽搐、视物异常：不要默认是“老毛病”，尽快就诊排查。

常见误区

“诊断改了，说明之前的医生是庸医。” 诊断修正常常是因为信息增加了。真正需要追问的是：改的依据是什么，新诊断是否更好地解释了全部表现。

“过度诊断的说法，是在说这些病根本不存在。” 不是。抑郁、焦虑、孤独症、注意力障碍都是真实存在的，且长期被低估。过度诊断说的是“在某些人身上，这个标签带来的害处大于好处”。

“有了标签，人生就毁了。” 标签会带来现实限制，但不决定全部。很多人带着诊断完成了学业、工作、亲密关系。关键在于诊断是否准确、支持是否到位、披露范围是否可控。

“量表分数高就是重度，分数低就不用管。” 量表测的是近期痛苦程度，不测功能、不测风险、不测病程。低分但功能持续下降的人，同样需要评估。

“第二意见就是不信任。” 在诊断分歧大、治疗方案效果不佳、涉及重大决定（住院、长期用药、手术）时，第二意见是常规做法，不是冒犯。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022.
- 全国人民代表大会常务委员会. 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 2：抑郁障碍确诊

抑郁最常见，也最容易被“只看到抑郁”而漏掉双相、躯体病和药物因素。

2.1 抑郁障碍诊断要点

“情绪低落”几乎每个人都经历过，但抑郁障碍的诊断并不是把“难过”换一个说法。这一页讲医生判断抑郁障碍时真正会看的几件事：核心症状、附加症状、两周门槛、功能损害，以及重性抑郁、持续性抑郁、破坏性情绪失调三种常见类型怎么分。适合第一次因情绪问题就诊的人，也适合想理解诊断依据的家属。读完后，你至少能准备出一份有用的时间线，并知道哪些情况不能等。

一、两个核心症状，和“两周”这道门槛

医生不会只问“你开心吗”。在抑郁发作的评估里，有两个症状被视为支点：一是**几乎每天、大部分时间都情绪低落**——有的人是难过、想哭，有的人是空虚、麻木，青少年更常见的是易激惹；二是**兴趣和愉悦感明显减少**，原来喜欢的事变得没意思，连刷牙洗脸都觉得费劲。这两条里至少要有一条，才谈得上抑郁发作。

在此之上，医生还会看一组附加症状：

- 食欲或体重明显变化，没刻意减肥却掉秤，或者靠吃东西缓解情绪；
- 失眠、早醒、夜里反复醒，或者相反，睡得过多仍不解乏；
- 坐不住、来回走动，或者动作和说话明显变慢，别人能看出来；
- 疲劳、没力气，一件小事也要下很大决心；
- 觉得自己没用、过度自责，甚至为不该负责的事反复道歉；
- 注意力下降、犹豫不决，看书看几行就走神；
- 反复想到死亡、自杀，或觉得“没有我大家会更好”。

【指南】DSM-5-TR 通常要求这些症状合起来至少五项，持续至少两周，几乎每天、占据大部分时间，并造成明显痛苦或功能损害；同时排除物质、药物和躯体疾病所致，也不能用其他精神障碍更好地解释。ICD-11 同样以两周为基本门槛，把抑郁发作分为轻、中、重。两套系统的条目和措辞略有差异，以原文和医生的结构化访谈为准。

这里要强调：**诊断不是打勾计数**。同样是“五条”，一个人失恋后两周逐渐缓解，另一个人三个月内越来越重、工作停摆、每天凌晨四点醒、体重掉了好几斤，诊断意义完全不同。医生还会看起病方式、变化轨迹、既往发作、发作间期是否完全缓解、家族史、躯体病和用药。

医生会看	具体问什么	为什么重要
核心症状	低落或兴趣丧失，是否几乎每天、大部分时间	决定“是不是抑郁综合征”
附加症状	睡眠、食欲、精力、注意力、自责、死亡念头	决定症状群是否完整、严重度

医生会看	具体问什么	为什么重要
时间	持续多久、是否几乎每天、有没有缓解期	区分正常波动、适应反应与发作
功能	工作学习、自理、人际、健康行为	判断“障碍”，而不只是“难受”

二、病程与功能损害：诊断的另一半

两周是下限，不是“熬满两周就确诊”，也不是“不到两周就一定没事”。很多人来就诊时已经难受了几个月，只是最近两周明显加重；也有人反复发作，每次两三周、间隔几个月，这时整体病程比单次发作更重要。

持续性抑郁障碍（过去常叫心境恶劣）看的是“长期低烧”式的抑郁：大多数日子情绪低落，持续两年以上，儿童青少年一年以上；同时有食欲、睡眠、精力、自尊、注意力、无望感中的若干项；在这段时间里，几乎没有连续两个月完全无症状。它常和重性抑郁发作叠加，形成“双重抑郁”——平时是低落的底色，某段时间又明显加重。

功能损害是诊断里最容易被忽略、也最能说明问题的一块。医生通常会问四个场景：

功能领域	可以怎么描述	轻度与重度的差别
工作与学习	能不能完成基本任务、有没有请假、成绩变化	效率下降，与无法上学上班
自理与家务	洗澡、做饭、收拾、按时吃饭	做得费劲，与长期不洗不收拾
人际关系	是否回避联系、易怒、争吵增多	有点退缩，与断绝往来
健康行为	睡眠、饮食、运动、复诊、是否酗酒	紊乱，与明显自伤性行为

功能损害还要放回人的生活背景里看：一个退休老人“不上班”不等于没损害，要看他还能不能独立买菜、服药、管理钱财；一个学生“成绩还行”也不等于没损害，可能是在透支大量时间硬撑。**诊断看的是“和他自己比、和他这个阶段应该能做到的比”，不是和别人比。**

不同人群的表现会让功能损害变得隐蔽。**青少年**不一定说“我抑郁”，更常见的是易激惹、顶撞、成绩下滑、拒绝上学、沉迷手机；易激惹本身不等于抑郁，也不等于双相。**老年人**常以乏力、疼痛、食欲差、便秘、失眠为主诉，被当成“老了正常”，也可能表现为记忆力下降而被误认为痴呆。**孕产期**的产后情绪低落通常在几天内出现、两周内缓解；持续两周以上、影响照顾自己和婴儿，才需要进一步评估。还有些人更习惯说“胸口堵、浑身没劲”，而不是“我心情不好”，医生需要把躯体主诉翻译成情绪和功能问题，而不是简单归为“想太多”。

三、三种常被混在一起的抑郁障碍

维度	重性抑郁障碍	持续性抑郁障碍	破坏性情绪失调障碍
核心	一次或多次抑郁发作	长期、几乎天天的低落	反复、严重的发脾气
时间	单次至少两周	成人两年以上，儿童青少年一年以上	症状持续一年以上，起病多在十岁前
功能	发作期明显受损	长期轻度到中度受损	家庭、学校、同伴至少两个场景受损
注意	需排除双相、躯体、物质	常与重性抑郁叠加	诊断年龄六至十八岁，需与双相、ADHD、对立违抗鉴别

重性抑郁障碍是最常被提到的类型，核心是“发作”：一段时间内症状群完整、功能改变明显，之后可能缓解，也可能复发。诊断时最关键的排除之一，是**有没有过躁狂或轻躁狂发作**。如果有，诊断方向可能从单相抑郁转为双相障碍，治疗策略也不同。这一点在 2.2 会展开。

持续性抑郁障碍的关键词是“长期”。它不一定很重，但拖得久，容易被人格化成“我就是这种性格”。如果一个人从青春期起就一直低自尊、疲惫、睡不好、觉得没希望，医生会考虑这个诊断，而不是只给一句“抑郁状态”。

破坏性情绪失调障碍是针对儿童的诊断，核心不是“情绪低落”，而是**反复、严重、与发育水平不相称的脾气爆发**，例如每周多次、持续一年以上，爆发之间仍大部分时间易激惹或愤怒；症状要出现在多个场景，首次诊断年龄六至十八岁、起病在十岁前。DSM-5-TR 规定它不能与对立违抗障碍同时诊断，如符合双相应优先考虑双相。这个诊断提醒医生：**长期易激惹的儿童不一定是双相**，不要因为“发脾气”就贴双相标签，也不要因为“只是孩子”就忽略功能损害。

四、先排除：三类“看起来像抑郁”的情况

抑郁症状没有特异性。甲状腺功能减退、贫血、维生素 B12 缺乏、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、糖尿病、脑卒中后、帕金森病、多发性硬化、库欣综合征、高钙血症、慢性感染都可能表现为乏力、兴趣下降、注意力差、睡眠紊乱。**不是每个抑郁患者都要做全套检查**，但首次发作、症状不典型、治疗反应差、年龄偏大、有明显躯体症状或体重变化时，医生通常会安排针对性检查。

类别	常见例子	值得警惕的线索
躯体疾病	甲减或甲亢、贫血、B12 缺乏、睡眠呼吸暂停、脑卒中、帕金森、慢性感染	怕冷、心悸、打鼾憋醒、局灶神经症状、体重明显变化
物质与药物	酒精、镇静催眠药、类固醇、干扰素、异维 A 酸、某些降压药和激素、戒断	饮酒量增加、近期换药、停药后出现症状
其他精神障碍	双相、分裂情感性障碍、精神分裂症、焦虑或强迫或创伤相关障碍、人格障碍、进食障碍、痴呆或谵妄（急性意识混乱）	有躁狂或轻躁狂史、幻听妄想、强迫行为、创伤史、认知波动

还有两类容易被忽略：

- **悲伤与丧亲**：失去亲人后出现难过、哭泣、睡不好、不想社交，是正常反应。DSM-5-TR 不再把丧亲排除在抑郁诊断之外，但是否构成障碍，仍要看症状持续时间、功能损害、有没有自伤念头、有没有与丧失无关的全面负性自我评价。**不要把正常悲伤病理化，也不要用“这是丧亲”掩盖需要治疗的抑郁。**
- **适应障碍**：有明显应激源，比如失业、离婚、移民、考试失败，情绪反应在应激后一段时间内出现，但达不到抑郁发作的完整标准。它和抑郁发作的边界，有时需要随访才能分清。

五、就诊准备与需要立即处理的情况

门诊时间有限，带一份“时间线”比临场回忆有效得多。可以按下面清单准备：

- ☐ 症状从什么时候开始，最近两周和之前比是加重、减轻还是波动；

- ☐ 情绪低落或兴趣丧失是否几乎每天，一天中什么时候最重；
- ☐ 睡眠：入睡、早醒、夜醒、总时长、白天补觉；
- ☐ 食欲和体重：最近一个月变化多少；
- ☐ 精力、注意力、做事速度，能不能完成工作、学业或家务；
- ☐ 自责、无望、死亡念头：有没有计划、准备、告别行为；
- ☐ 既往有没有类似发作，持续多久，是否完全缓解；
- ☐ 有没有过“睡得很少但很精神、话多、花钱多、觉得自己特别行”的时期；
- ☐ 目前在吃什么药、保健品，饮酒、咖啡因或其他物质使用情况；
- ☐ 甲状腺、贫血、B12、睡眠呼吸暂停等躯体病史；
- ☐ 家族中抑郁、双相、自杀、酒精使用的情况；
- ☐ 月经周期、孕期或产后、更年期等激素相关时间点。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划、准备**，比如写遗书、告别、赠送物品、囤药、查方法，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**命令性幻听**、坚信自己被害或被控制、明显激越或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110，尽快精神科急诊评估。
- **木僵、缄默、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，需急诊精神科评估。
- **产后两周内出现幻觉、被害感、行为混乱**：警惕产后精神病，立即急诊。
- **意识时清时浊、发热、剧烈头痛、抽搐**：先按躯体急症处理，立即急诊，警惕脑炎、感染、谵妄。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“心情不好就是抑郁。”** 抑郁障碍要求症状群、持续时间、功能损害，并排除其他原因；正常悲伤、压力反应、躯体病都可以让人心情差。
- **“不到两周就不算。”** 两周是发作门槛，但医生会看既往发作、整体病程和功能；持续性抑郁障碍看的是两年。
- **“量表高分就是确诊。”** PHQ-9 等只用于筛查和随访，不能替代面诊；分数高也可能是焦虑、躯体病、失眠或药物所致，详见 2.5。
- **“抑郁是矫情、意志薄弱。”** 抑郁障碍有生物学、心理和社会因素，不是“想开点”能解决的；把责任推给患者，会让人更不敢就医。
- **“抑郁一定得吃药”，或者“吃药会成瘾、会变傻”。** 治疗选择要看严重度、既往史、共病和患者意愿；抗抑郁药不是成瘾物质，但需要在医生指导下使用和停用。
- **“好了就可以自己停药。”** 减停需要医生评估，自行停药可能引起撤药反应或复发。
- **“只查心理，不查身体”，或者反过来“只查身体，不看心理”。** 两边都可能漏；首次发作、非典型表现、治疗反应差时，尤其要把躯体因素纳入。

- **“把双相当成单相。”** 只问抑郁、不问轻躁狂，是常见的误诊路径；抗抑郁药后“像变了一个人”，要尽快告诉医生，详见 2.2。

确诊后下一步通常是什么。 如果医生考虑抑郁障碍，接下来通常会做三件事：一是补齐信息，包括躯体检查、用药回顾、既往史、家族史和风险询问；二是判断严重度和是否需要联合治疗；三是安排随访，看症状和功能的变化。诊断不是一次定终身，尤其在信息不足时，医生写“抑郁状态”“考虑抑郁发作”并继续观察，是规范做法。**你能做的，是把时间线和功能变化讲清楚，并在出现风险信号时立即求助。**

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- NICE. *Depression in adults: treatment and management* (NG222). 2022.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

2.2 单相抑郁与双相抑郁的区分

很多人被诊断为抑郁后，会听到医生反复问一些“奇怪”的问题：有没有一段时间睡得很少却很精神？有没有花钱特别大手大脚？有没有觉得自己特别有能力？这些问题的目标只有一个——把单相抑郁和双相抑郁分开。这一页讲为什么要追问轻躁狂史、抗抑郁药后“像变了一个人”可能意味着什么、双相抑郁有哪些容易被忽略的特征。适合已经确诊抑郁但疗效不理想、家族里有双相、或正在用抗抑郁药的人。

一、医生为什么总要追问“轻躁狂”

“单相抑郁”不是 DSM-5-TR 里的正式名称，而是临床上的简称：只有抑郁发作，没有躁狂或轻躁狂发作。双相障碍则至少要有过一次躁狂或轻躁狂，抑郁并不是必需条件。两者在抑郁期的表现可以非常像，但治疗方向不同：双相抑郁通常需要以心境稳定剂（俗称情绪稳定剂）为骨架，单用抗抑郁药可能带来转躁、混合状态或循环加速的风险【指南】。

难点在于，轻躁狂常常不被当成病。处在轻躁狂里的人，往往觉得自己“终于正常了”“状态最好”，不会主动告诉医生；家人也可能觉得“那段时间挺有活力”。于是，患者带着抑郁来就诊，医生只看到抑郁，诊断就停在单相。

线索	更支持单相抑郁	更支持双相抑郁	需要核对什么
既往高涨期	从没有过持续几天的高涨或易激惹	有过四天以上的轻躁狂，或一周以上的躁狂	睡眠需求、话量、花钱、计划性
家族史	抑郁为主	双相、精神病性抑郁、自杀或严重药物反应	尽量问到两级亲属
起病年龄	各年龄段均可	青少年期、产后或季节相关起病更常见	第一次发作的时间点
治疗反应	抗抑郁药逐渐起效	抗抑郁药无效、越用越烦躁，或一用就“变了一个人”	用药与症状变化的时间关系

单靠一条线索不能定方向。医生会把起病年龄、发作次数、发作间期、产后或季节规律、精神病性症状、家族史、药物反应拼在一起看，再决定要不要按双相重新评估。**不要因为自己“对上了两条”就自行改诊断或停药。**

需要排除的至少有三类：单相抑郁（从来没有轻躁狂或躁狂）、物质或药物所致的心境改变（兴奋剂、类固醇、甲状腺素、抗抑郁药等）、以及其他精神障碍（边缘型人格、ADHD、创伤后应激、分裂情感）。三类的线索不同，处理方向也不同。

二、双相抑郁常见的“非典型”特征

抑郁的“非典型特征”是一个术语，指与“典型”抑郁（失眠、食欲下降、体重减轻）相反的一组表现：睡得过多、食欲增加、体重增加、四肢像灌了铅一样沉重、对好消息仍有短暂的情绪反应、对被拒绝特别敏感。这些特征在双相抑郁中更常见，但在单相抑郁里也不少见，所以只能当线索，不能当证据。

临床上，以下情况会让医生更警惕双相：

- 抑郁发作来得早，青少年期或二十岁前后首次发作；
- 产后或季节性发作明显，每年同一时段复发；
- 抑郁反复发作、次数多，但每次持续时间相对短；
- 抑郁伴精神病性症状，尤其是罪恶、贫穷、虚无等与心境一致的妄想；
- 家族中有双相、精神病性抑郁或抗抑郁药诱发的躁狂；
- 抗抑郁药治疗效果差，或一加量就出现激越、失眠、话多；
- 抑郁中混着思维奔逸、冲动、易激惹等“往上走”的症状。

反过来，单相抑郁也有它的典型样子：入睡困难、早醒、食欲下降、体重减轻、情绪持续低落、对什么都提不起兴趣。但**这些只是统计倾向，不是诊断公式**。有的人双相抑郁表现得很“典型”，有的人单相抑郁也会睡得多、吃得多。

三、抗抑郁药后“像变了一个人”

这是门诊里最值得重视的信号之一。用药后出现明显变化，可能有几种完全不同的解释，处理方式也不同：

观察到的变化	更像转躁或混合	更像其他情况
睡眠需求明显减少，只睡三四小时仍精力旺盛	是	也可能是失眠，但失眠通常伴疲惫
话明显变多、语速快、想法一个接一个	是	焦虑时也会话多，但通常伴担心
花钱、投资、赌博、性行为明显失控	是	冲动控制问题也可能，但多有既往史
坐立不安、来回走动、心里烦躁	可能是混合或激越	也可能是药物激活或静坐不能（坐不住、总想走动）
情绪突然轻松、愿意出门	不一定	可能只是抑郁好转

真正的转躁或轻躁狂，通常是**一组症状一起出现、持续几天**，而不是某一晚睡不好。混合状态更危险：人一边绝望、一边停不下来，冲动和自杀风险都会升高。发现这些变化，正确的做法是**尽快联系开药医生，不要自行停药或加药**。突然停药可能引起撤药反应，也可能让情绪更快地摆向另一头。

还要说明：抗抑郁药诱发的躁狂或轻躁狂，在 DSM-5-TR 里可以归为“物质或药物所致双相障碍”，不等于这个人“一定终身是双相”。但它是一个需要认真对待的信号，医生会重新询问既往史、家族史，并调整随访频率。

四、怎么把轻躁狂史问出来

直接问“你有没有躁狂过”，多数人会回答“没有”，因为这个词太吓人，而且轻躁狂的主观体验并不痛苦。换一种问法，信息会多很多：

- ☐ 有没有一段时间，睡得比平时少很多，却不觉得困、白天照样有劲；
- ☐ 有没有一段时间，话比平时多，别人插不上嘴，或者电话打个不停；

- ☐ 有没有一段时间，觉得自己特别有本事、计划特别多，同时开好几件事；
- ☐ 有没有一段时间，花钱明显超过平时，事后后悔；
- ☐ 有没有一段时间，特别容易发火、看谁都不顺眼，持续几天；
- ☐ 有没有一段时间，性欲明显增强，或做出平时不会做的冒险决定；
- ☐ 那段时间持续了几天，是一天里的几小时，还是连续几天大部分时间；
- ☐ 那段时间之后，是不是“跌”回抑郁，或者需要很久才恢复；
- ☐ 家人、伴侣、老同学有没有说过“你那阵子像变了个人”；
- ☐ 当时有没有喝酒、用兴奋剂、吃类固醇或其他药。

问的时候尽量带着具体时间段，比如“去年春天”“生完孩子那半年”，再找一位知情者核对。病历、旧照片、消费记录、工作考勤都能帮忙还原。MDQ 等筛查工具可以提示方向，但不能确诊，详见 3.5。

五、误诊的代价与常见误区

把双相抑郁当单相抑郁治，代价不只是“药不对”。抗抑郁药单用可能诱发躁狂、混合状态，让情绪波动更快；也可能让抑郁反复发作、治疗效果越来越差。对患者来说，这意味着更长的病程、更多的请假和住院、更重的经济负担，以及更高的自杀风险。反过来，把单相抑郁误当双相、长期按双相治疗，也会带来不必要的药物负担和标签压力。**区分的目的不是贴一个更“重”的标签，而是找到更匹配的治疗方向。**

- **“我从来没有兴奋过，所以不可能是双相。”** 轻躁狂不一定表现为兴奋，也可能是易激惹、思维快、活动多、睡得少。而且双相 II 型只有轻躁狂，没有躁狂。
- **“抗抑郁药吃完变开心了，说明药对症。”** 要看他是不是“好过头”了：睡眠需求减少、话多、冲动、花钱失控，这些不是单纯的好转。
- **“双相就是抑郁加兴奋，情绪起伏大就是双相。”** 双相的核心是**发作性**的心境和精力改变，持续几天到几周，而不是一天之内随事情起伏。
- **“一次转躁就说明我是双相。”** 需要排除物质、药物、躯体原因，也需要看后续病程；一次药物诱发事件不等于终身诊断。
- **“既然是双相，就绝对不能碰抗抑郁药。”** 双相抑郁有时仍会在心境稳定剂基础上短期联合抗抑郁药，是否使用、用多久，要由医生权衡，不能自行决定。
- **“我怕转躁，所以干脆不吃药。”** 不治疗的双相抑郁同样有自杀和功能损害风险，正确做法是让医生知道你的顾虑，一起定方案。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望或想死，风险很高，需尽快精神科急诊评估。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。

- 用药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
- **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，需急诊精神科评估。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

2.3 抑郁的躯体原因与药物因素

有些“抑郁”背后是甲状腺、贫血、睡眠呼吸暂停，或者某种正在吃的药；也有些抑郁与躯体病同时存在，互相加重。这一页讲医生在什么情况下会怀疑“不是单纯抑郁”、常见的躯体与药物因素有哪些、什么时候必须查。适合首次出现抑郁、治疗效果不好、或正在长期服药的人，也适合想理解“为什么要抽血、为什么要问喝酒”的家属。

一、为什么抑郁要先想“不是抑郁”

抑郁症状没有特异性。乏力、兴趣下降、注意力差、睡不好、食欲改变，既可以是抑郁障碍，也可以是甲减、贫血、感染、疼痛、药物副作用。**“排除躯体原因”不是否定你的痛苦，而是避免把可治疗的病当成精神病，也避免把精神病拖成慢性。**

需要同时排除的至少有三类：

类别	例子	为什么容易混
躯体疾病	甲减、贫血、B12 缺乏、睡眠呼吸暂停、脑卒中、帕金森病	直接造成乏力、迟钝、情绪低落
物质与药物	酒精、镇静药、类固醇、干扰素、某些降压药	用药后出现，或停药后加重
其他精神障碍	双相、焦虑、创伤、人格、痴呆或谵妄	症状重叠，需要看病程和发作性

躯体病和抑郁常常是双向的：慢性病会增加抑郁风险，抑郁也会影响服药、饮食、睡眠和复诊，让躯体病更难控制。所以医生不会简单地二选一，而是看时间关系、严重度、能不能用躯体病解释全部症状。**无论原因是什么，抑郁障碍的诊断仍要求症状持续两周以上并造成功能损害**；排查躯体因素不是为了否定诊断，而是为了让诊断更准确。

二、常见躯体原因

问题	可能表现	一般怎么查
甲状腺功能异常	甲减：怕冷、便秘、体重增加、反应慢；甲亢：心悸、手抖、消瘦、易怒、失眠	促甲状腺激素、游离甲状腺激素
贫血与营养缺乏	乏力、气短、头晕、面色差；B12 缺乏可伴手脚麻、走路不稳、记忆力下降	血常规、铁蛋白、维生素 B12、叶酸
睡眠呼吸暂停	打鼾、憋醒、白天嗜睡、晨起头痛、注意力差	睡眠监测，必要时耳鼻喉评估
神经系统疾病	脑卒中后、帕金森病、多发性硬化、癫痫	神经系统查体、影像，按线索选择
内分泌与代谢	库欣综合征、高钙血症、糖尿病、肝肾疾病	电解质、血糖、肝肾功能、激素检查

甲状腺是最常被想到的一个。甲减可以表现得像“抑郁”：没劲、怕冷、便秘、体重增加、反应慢、情绪低；甲亢则更像焦虑：心慌、手抖、出汗、失眠、易怒。一次促甲状腺激素检查就能提供重要线索，但甲状腺抗体、影像等要根据情况加做。

贫血和 B12 缺乏也常被漏。缺铁性贫血会让人乏力、气短、注意力下降；B12 缺乏除了贫血，还可能引起手脚麻木、走路不稳、记忆力下降、舌头疼，老年人尤其要留意。长期素食、胃手术后、长期服用某些抑酸药的人风险更高。

睡眠呼吸暂停是“睡多久都不解乏”的常见原因。典型表现是打鼾、被憋醒、白天困得厉害、晨起头痛、注意力差。它既可以直接造成抑郁样表现，也会加重原有抑郁。体重偏高、颈围粗、下颌后缩的人风险更高，但瘦人也会有。

此外，脑卒中后抑郁、帕金森病伴抑郁、多发性硬化、慢性疼痛、糖尿病、肿瘤、慢性感染都可能表现为抑郁。**不是每个抑郁患者都要做全套检查**，但首次发作、症状不典型、治疗反应差、年龄偏大、有明显躯体症状或体重变化时，医生通常会安排针对性检查。

三、药物、酒精与其他物质

类别	常见例子	线索
激素与免疫药物	糖皮质激素、干扰素、某些激素类药物	用药后情绪波动、失眠、易怒，减量后变化
皮肤科与神经系统用药	异维 A 酸、部分抗癫痫药、部分降压药	说明书有情绪相关警示，换药后出现
镇静催眠与止痛药	苯二氮䓬类、阿片类	白天嗜睡、反应慢、情绪低、依赖
酒精与其他物质	长期大量饮酒、大麻、兴奋剂	饮酒量增加、停用后难受、社会功能下降

药物与抑郁的关系，不能只靠说明书“对号入座”。同一种药，有人吃了没事，有人会出现明显情绪变化；时间关系、剂量变化、是否合并其他药，都要由医生判断。**不要因为看到“可能引起抑郁”就自行停药**，尤其是激素、抗癫痫药、抗凝药、降压药，突然停用可能带来更严重的后果。

酒精值得单独说。长期大量饮酒会破坏睡眠、消耗营养、加重绝望感，也可能直接诱发抑郁；抑郁的人又常借酒缓解情绪，形成恶性循环。酒精戒断还会引起焦虑、失眠、手抖、出汗，严重时抽搐、幻觉、意识混乱，**不能自行硬戒**。大麻、兴奋剂、镇静药的使用和戒断，也可能模仿或加重抑郁。

四、什么时候必须查、查什么

以下情况提示需要更积极地排查躯体与药物因素：

- ☐ 第一次出现抑郁发作，尤其是中老年首次发作；
- ☐ 体重在短期内明显下降，或伴有发热、盗汗、疼痛；
- ☐ 有怕冷、心悸、手抖、便秘、脱发、月经紊乱等躯体症状；
- ☐ 打鼾、憋醒、白天嗜睡明显；
- ☐ 手脚麻木、走路不稳、记忆力下降、性格改变；
- ☐ 有局灶神经症状、头痛、抽搐、意识波动；
- ☐ 抑郁治疗效果差，或反复发作、剂量越用越大；
- ☐ 长期饮酒、使用镇静药或其他物质；
- ☐ 正在使用激素、干扰素、异维 A 酸等药物；
- ☐ 孕期或产后、围绝经期、甲状腺病或贫血史；

- ☐ 免疫功能低下、静脉用药、多个性伴侣等感染风险；
- ☐ 家族中有甲状腺病、贫血、神经系统疾病。

常见的基础检查包括血常规、促甲状腺激素、电解质、血糖、肝肾功能、钙、维生素 B12、叶酸、铁蛋白；根据情况加做妊娠试验、尿药筛查、HIV 或梅毒检测、睡眠监测、心电图、脑影像。**检查不是越多越好**，而是围绕线索选择。查得过多可能带来假阳性、额外焦虑和费用，查得太少则可能漏掉可治疗的原因。

五、查出来之后：别走两个极端

一个极端是“查出了甲状腺问题，就认为抑郁全是甲状腺引起的”，自己把精神科药停了。甲状腺病可以引起抑郁样症状，但抑郁也可能同时存在；甲状腺功能恢复正常后，情绪不一定立刻好转。另一个极端是“检查都正常，就说明我是装病”。**躯体检查正常，恰恰支持抑郁障碍的诊断，而不是否定它。**

比较稳妥的做法是：

- 把最近半年的用药、保健品、饮酒、体重、睡眠、月经情况整理给药医生；
- 躯体科医生和精神科医生之间互通信息，不要各看各的；
- 不自行停用任何处方药，尤其是激素、抗癫痫药、抗凝药；
- 不因为“查不出原因”就拒绝精神科随访，也不因为“查出一点问题”就拒绝心理和药物治疗；
- 复诊时主动报告新出现的症状，尤其是发热、皮疹、意识变化。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- **意识时清时浊、发热、剧烈头痛、抽搐**：先按躯体急症处理，警惕脑炎、感染、代谢紊乱、谵妄（急性意识混乱、注意力忽清忽浊）。
- **长期大量饮酒或镇静药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱**：立即急诊，不能自行硬戒。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
- **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，需急诊精神科评估。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“抑郁就是心理问题，不用查身体。”** 首次发作、非典型表现、治疗反应差时，躯体排查是诊断的一部分。
- **“查了甲状腺正常，就说明医生在乱开检查。”** 排查是排除法，正常结果同样有诊断价值。
- **“查出贫血，补铁就能治好抑郁。”** 贫血可能加重抑郁，但抑郁障碍有自己的病程和治疗，需要分别评估。

- **“喝酒能助眠、能解愁。”** 酒精破坏睡眠结构，加重抑郁和焦虑，长期还会造成依赖和戒断风险。
- **“药物说明书上写了抑郁，就必须马上停。”** 要看时间关系、发生率和医生评估，擅自停药可能更危险。
- **“老年人没劲、睡不好是正常衰老。”** 老年抑郁常以躯体症状出现，也可能是甲减、贫血、睡眠呼吸暂停或药物所致。
- **“产后情绪差是矫情。”** 产后激素、睡眠剥夺、贫血、甲状腺炎都可能参与，持续两周以上或影响照顾婴儿要就医。
- **“只要查出躯体病，就不用看精神科。”** 两者常并存，分别治疗并不矛盾。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- NICE. *Depression in adults: treatment and management* (NG222). 2022.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

2.4 抑郁严重度、功能损害与风险评估

同样叫“抑郁”，有人还能勉强上班，有人已经躺在床上几天不吃饭，有人出现了“自己罪该万死”的念头。严重度不是为了分等级、贴标签，而是决定治疗强度、随访频率和要不要住院。这一页讲轻、中、重怎么分，功能损害怎么评估，自杀风险和精神病性症状怎么识别。适合刚被诊断抑郁的人、需要判断家人状况的照护者，也适合想理解“医生为什么建议住院”的人。

一、轻、中、重：不是靠“有多难受”

严重度不是一个感觉分，而是几条线一起看：症状数量和强度、功能损害程度、有没有精神病性症状、有没有自杀或伤人风险、病程和既往发作情况。DSM-5-TR 把抑郁发作分为轻度、中度、重度，并标注有无精神病性特征、是否部分或完全缓解；ICD-11 同样分轻、中、重，并区分是否伴精神病性症状。两套系统的措辞不同，但都强调**功能**，而不是只看“心情有多差”。

分层	症状与功能	常见表现	处理方向
轻度	超过诊断所需的症状不多，功能损害轻微	能维持工作学习，但效率下降、社交减少	心理治疗、密切随访，视情况考虑药物
中度	症状数量和功能损害介于轻重之间	工作学习明显吃力，常请假，家务堆积	心理治疗联合药物，定期评估
重度	多数症状存在，功能严重受损	无法工作、卧床、生活难以自理，或伴精神病性症状	积极药物治疗，必要时住院或物理治疗

要提醒两点。第一，**轻度不等于没有风险**。有些轻度抑郁的人仍有明确的自杀念头，尤其是有过尝试、伴焦虑激越或物质使用的人。第二，**重度也不等于一定要住院**，如果有人全天陪护、能配合治疗、风险可控，也可以在门诊密集随访。住不住院，看的是风险和能不能保证安全，不是单看“重度”两个字。

严重度不能替代鉴别。评估之前，医生仍要排除双相抑郁、物质或药物所致的心境改变、躯体病所致抑郁，以及精神分裂症或分裂情感等伴精神病性症状的障碍。**同样是“重度”，治疗方向可能完全不同。**

病程同样影响判断：第一次发作、反复发作、部分缓解、完全缓解，处理不一样。两次发作之间能不能回到病前状态，是评估“好没好”的关键，而不是“这几天心情还行”。

二、功能损害：把“能不能生活”问具体

“功能损害”听起来抽象，其实就是一个人在日常生活里还能做多少事。医生通常会从几个场景问：

场景	具体问题	损害的表现
工作与学习	能不能完成基本任务、有没有请假、成绩或业绩变化	效率下降、频繁出错、无法出门
自理与家务	洗澡、换衣、做饭、收拾、按时吃药	几天不洗澡、家里堆满垃圾、漏服药
人际与角色	能不能和家人朋友联系、照顾孩子或老人	回避联系、易怒、无法履行照护责任
健康与安全	睡眠、饮食、是否酗酒、有没有危险行为	长期失眠、体重骤降、酒驾、自伤

评估功能时，要拿“病前”做参照。一个原本每天跑步、做饭、上班的人，现在连起床都困难，这是明显损害；一个长期独居、本来就不爱社交的人，不能只用“他不出门”判断。家属能提供的具体例子最有价值：这周洗了几次澡、有没有吃饭、有没有去上班、有没有接电话、钱有没有乱花。

老年人、儿童青少年、孕产妇的功能评估要特别小心。老人可能把“吃不下、走不动”归为衰老，实际是抑郁；孩子可能表现为成绩下滑、拒学、易怒，而不是说“我难过”；孕产妇的功能要连“能不能照顾婴儿”一起看。**文化背景也会影响表达**，有人只说躯体不适，不承认情绪问题，这不代表损害轻。

三、自杀风险：直接问，具体问

很多人担心“问自杀会不会把人问出问题”。研究并不支持这种担心：温和、直接地询问，不会增加自杀风险，反而能让对方说出计划、获得帮助【研究】。真正危险的是不问、假设“他只是说说”、或者答应替对方保密。

维度	要问什么	高风险信号
想法	有没有想过不如死了、频率多高、什么时候最重	几乎每天想、持续时间长
计划	有没有具体方法、地点、时间	方法明确、已经踩点或准备工具
意图	想不想真的去做、有没有“必须死”的念头	明确说“这次一定要死”
既往	以前有没有尝试、有没有自伤	有过尝试，尤其近期
保护因素	有什么让你还愿意撑下去	保护因素少、社会隔离
环境	家里有没有药、农药、刀具、枪支	手段容易获得、独居

高风险不只来自“说想死”。**激越、严重失眠、混合状态、精神病性症状、产后、酗酒或滥用药物、近期丧失、慢性疼痛、刚出院**，都会抬高风险。反过来，一个人说“为了孩子我不会死”，是重要的保护因素，但不能因此就不做安全计划。

安全计划不是一句“想开点”，而是具体的：把药和危险物品交给家人保管、列出可以立刻联系的人、写下求助电话、约定出现念头时先做什么。**“保证不自杀”的口头承诺没有可靠保护作用**，不要用它代替陪护和随访。

四、精神病性症状与紧张症

抑郁可以伴精神病性症状，通常与心境一致：坚信自己犯了不可饶恕的罪、穷得拖累家人、身体已经烂掉或不存在、被人迫害。也可能出现幻听，比如听到声音说“你不配活着”。这类抑郁往往更重，自杀风险更高，思维和动作明显变慢，常常需要住院评估，部分人需要物理治疗【指南】。

紧张症是另一个急症。表现为木僵、缄默、拒食拒水、违拗、保持奇怪姿势、蜡样屈曲，或者相反的明显激越。它可能出现在抑郁、双相、精神分裂症，也可能由躯体病或药物引起。**拒食拒水超过一天、长时间不动、意识改变**，不要在家观察，直接急诊。

混合状态也要识别：抑郁的同时出现思维奔逸、话多、活动增多、冲动、整夜不睡。这种状态比单纯抑郁更危险，因为人既有绝望，又有行动力。

五、什么时候需要住院评估

住院不是“严重到没救了”，而是为了安全、为了完成门诊做不到的治疗。以下情况通常需要精神科急诊或住院评估：

- ☐ 有明确自杀计划、手段，或近期有自杀尝试；
- ☐ 有伤人风险，或命令性幻听让患者伤害自己或别人；
- ☐ 出现精神病性症状，且自知力差、无法配合门诊治疗；
- ☐ 木僵、拒食拒水、严重脱水或营养不良；
- ☐ 生活完全不能自理，或家人无法提供安全陪护；
- ☐ 需要物理治疗（如电休克治疗，在麻醉下进行）而门诊条件不足；
- ☐ 诊断不明确，需要连续观察；
- ☐ 伴严重躯体病、产后精神病、物质戒断等高风险情况；
- ☐ 门诊治疗无效，症状持续加重。

就诊时，家属可以准备一份“风险清单”：最近有没有说想死、有没有查方法、有没有囤药、有没有告别、有没有自伤、晚上睡多久、有没有幻觉、有没有喝酒。**不要替患者隐瞒**，这些信息直接决定医生敢不敢让患者回家。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 出现**自杀念头、计划、准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
> - 出现**命令性幻听**、坚信自己被害或被控制、明显激越或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
> - 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
> - **木僵、缄默、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
> - **产后两周内出现幻觉、被害感、行为混乱**：警惕产后精神病，立即急诊。
> - 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
>
> 如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“轻度抑郁不用管。”** 轻度也可能有自杀风险，也会拖成慢性；是否需要治疗看功能、病程和风险。
- **“能上班就说明不严重。”** 有人靠透支硬撑，回家就崩溃；功能评估要看全部场景，不只是出勤。

- **“问自杀会教坏他。”** 直接、温和地询问不会增加风险，反而能发现计划、争取时间。
- **“他说不会自杀，就可以放心。”** 口头保证不可靠，要看计划、手段、既往尝试和当下状态。
- **“住院就是关起来，越住越严重。”** 住院的目的是安全保护和集中治疗，是否住院要看风险，不由患者“意志强不强”决定。
- **“有精神病性症状就是精神分裂症。”** 抑郁也可以伴精神病性症状，关键看心境发作与精神病性症状的时间关系。
- **“老年人和孩子不会自杀。”** 两个群体都可能自杀，且常被低估，需要直接询问。
- **“出院就说明彻底好了。”** 出院后一段时间仍是高风险期，需要按时复诊、服药和陪护。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Depression in adults: treatment and management* (NG222). 2022.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

2.5 抑郁诊断的常见误区与量表

PHQ-9 打了 18 分，是不是就“确诊抑郁”了？HAMD 分数降了，是不是就“好了”？量表在抑郁诊断里很有用，但它负责的是筛查、量化严重度和追踪变化，不负责下诊断。这一页讲 PHQ-9、HAMD 等工具能做什么、不能做什么，以及“心情不好就是抑郁”“量表高分就是确诊”这些常见误区。适合刚做过量表、被分数吓到、或想更有效使用复诊时间的人。

一、量表能做什么，不能做什么

量表本质上是“把主观感受变成可比较的数字”。它的价值在于：帮助医生快速筛查、判断严重度、比较治疗前后的变化、在科研中统一标准。但它没有能力完成诊断，因为诊断还要看病程、功能损害、排除躯体与物质原因、纵向观察，以及医生面对面的精神检查。

量表能做的	量表不能做的
提示“可能需要进一步评估”	确认或排除某个诊断
粗略量化症状严重度	判断症状是不是躯体病或药物引起
追踪同一患者治疗前后的变化	替代医生的结构化访谈
帮助患者把问题说清楚	区分单相抑郁与双相抑郁
在群体中做筛查	预测个体的自杀风险

量表分数还会受很多因素影响：最近睡不好、刚吵完架、慢性疼痛、贫血、甲状腺问题、酒精、文化对情绪表达的抑制，都会让分数偏高或偏低。**分数是一个线索，不是判决。** 量表阳性之后，医生仍要排除双相、躯体病和药物因素，以及创伤、人格、痴呆等其他解释。

二、PHQ-9：九个问题，不是诊断书

PHQ-9 是自评量表，九个条目对应抑郁的核心和附加症状，回忆期是“最近两周”，每条按发生频率从“完全没有”到“几乎每天”计分，总分越高提示症状越重。常用的分段大致是：0–4 分无明显抑郁症状，5–9 分轻度，10–14 分中度，15–19 分中重度，20–27 分重度。不同研究、不同人群的切分点会略有差异。

在最初的验证研究里，以 10 分为切分点时，PHQ-9 的敏感度和特异度大约都在 88% 左右【研究】。这个数字听起来很高，但要理解它的含义：它说明这个工具“筛得比较准”，不等于“10 分以上的人都是抑郁障碍”。在基层或普通人群里，即使特异度很高，假阳性也会因为患病率低而变得不可忽略。

PHQ-9 有几个具体局限：

- **它只覆盖最近两周**。持续性抑郁障碍需要两年以上的病程，单靠一次 PHQ-9 看不出来。
- **躯体条目会“串味”**。睡眠、食欲、疲劳、注意力这几项，在贫血、甲减、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛里也会高分。
- **第 9 条不是风险评估**。它问的是“觉得自己死了更好，或想伤害自己”的频率，回答“有”只说明需要进一步询问，不能代替自杀风险评估。

- **它不区分双相**。PHQ-9 没有轻躁狂条目，双相抑郁在抑郁期同样可以得高分。
- **它会受“求关注”或“否认”影响**。有人习惯轻描淡写，有人习惯把问题说重，分数和真实状态可能不一致。

PHQ-2 是更短的两条筛查，适合门诊快速初筛；阳性后仍需进一步评估。无论 PHQ-9 还是 PHQ-2，都只是“筛查工具”。

三、HAMD 与其他量表

HAMD（汉密尔顿抑郁量表）是他评量表，由受过训练的医生或评估者根据访谈打分，常用 17 项版本，也有 21 项等版本。它历史长、在临床试验里用得多，能比较细致地记录症状变化。但它的条目设计早于 DSM-5，和现行诊断标准的对应并不完美，而且偏重躯体症状和失眠，在躯体病老人身上可能“虚高”。

量表	谁来评	主要用途	主要局限
PHQ-9	患者自评	初筛、严重度、随访	受躯体症状影响，不覆盖双相
HAMD	医生他评	临床试验、严重度追踪	需培训，偏重躯体条目，与 DSM 不完全对应
MADRS	医生他评	严重度、治疗变化	同样不能单独诊断
BDI-II	患者自评	自评严重度、认知症状	受文化、躯体病影响

MADRS（蒙哥马利抑郁评定量表）也是常用的他评工具，条目更聚焦核心抑郁症状，对治疗变化较敏感；BDI-II 是自评工具，覆盖认知和躯体症状。它们各有侧重，但共同点是：**都不能单独确诊抑郁障碍，也不能凭一次分数决定用药。**

四、常见误区

- **“心情不好就是抑郁。”** 正常悲伤、失恋、丧亲、失业后的反应，和抑郁障碍之间隔着病程、功能损害和排除条件。难过是正常情绪，不一定要治；持续两周以上、几乎每天、功能明显受影响，才需要评估。
- **“量表高分就是确诊。”** 分数高只说明“值得进一步看”，诊断要靠医生访谈、病史、功能评估和排除。
- **“量表正常就没有抑郁。”** 有人习惯否认或轻描淡写，有人以躯体症状为主，有人是双相抑郁，量表可能漏掉。
- **“PHQ-9 第 9 条有分，就是一定会自杀。”** 第 9 条阳性需要进一步问计划、手段、既往尝试，但它本身不是风险分级。
- **“HAMD 分数降了，病就好了。”** 分数下降可能只是睡眠或食欲改善，功能、兴趣、绝望感、复发风险还要看。
- **“网上测试说我是重度抑郁。”** 网络测试没有临床访谈、没有排除，不能作为诊断依据，也不能据此买药。
- **“抑郁是性格软弱、想不开。”** 抑郁障碍有生物学、心理、社会多因素，不是意志力问题；这样说会让患者更不敢求助。

- **“抑郁一定会自杀。”** 大多数抑郁患者不会死于自杀，但风险确实升高，需要认真评估，不能用“不会”来安慰自己。
- **“吃药会成瘾、会把人吃傻。”** 抗抑郁药不是成瘾物质，也不会把人吃傻；具体用不用、用多久，要由医生根据严重度、既往史和患者意愿决定。
- **“症状好了就可以自己停药。”** 自行减停可能引起撤药反应或复发，停药方案要医生评估。
- **“抑郁是女人的病，男人不会得。”** 男性也会抑郁，只是更常表现为易怒、酗酒、工作过度、躯体不适，容易被漏诊。
- **“老年人健忘就是痴呆，不可能是抑郁。”** 老年抑郁可以表现为记忆力下降，俗称“假性痴呆”，需要和痴呆、谵妄鉴别。

五、怎么用量表而不被量表绑架

量表最好的用法，是把它当成“复诊前的准备工具”，而不是“自我诊断的判决书”。可以这样做：

- ☐ 固定时间填写，比如每次复诊前一周，按最近两周的真实情况填；
- ☐ 不查“标准答案”，不为了让医生重视而故意填高，也不为了“看起来没事”而填低；
- ☐ 把总分和具体条目一起看，尤其是睡眠、食欲、注意力、第 9 条；
- ☐ 记录分数变化和当时的生活事件、用药变化、月经周期；
- ☐ 复诊时问医生：“这个分数说明什么？还需要排除哪些原因？”；
- ☐ 不因为一次分数高就自行加药，也不因为分数低就自行停药；
- ☐ 如果分数持续升高，或出现自杀念头，不要等下次复诊，直接联系医生或急诊；
- ☐ 把量表结果和功能变化一起讲，比如“分数降了，但我还是没法上班”。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，尽快精神科急诊评估。
- **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

参考来源

- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*. 2001.
- Hamilton M. A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*. 1960.

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Depression in adults: treatment and management* (NG222). 2022.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 3：双相障碍确诊

双相最容易在“抑郁期”被误诊为单相抑郁。确诊的关键是主动追问“有没有过高涨/轻躁狂的时期”。

3.1 躁狂、轻躁狂与双相 I 型 II 型

双相障碍的名字容易让人以为就是“抑郁加高兴”，但诊断的关键在“发作”：一段持续几天到几周、明显不同于平时的情绪和精力改变。这一页讲躁狂与轻躁狂的时间门槛、功能影响和精神病性症状，以及双相 I 型与 II 型怎么分。适合被诊断为抑郁但怀疑自己有过“高涨期”的人，也适合想理解“轻躁狂为什么算病”的家属。

一、躁狂与轻躁狂：同一条线上的两个刻度

躁狂和轻躁狂共享同一组症状，区别在**持续时间、功能影响和有没有精神病性症状**。

维度	轻躁狂	躁狂
持续时间	连续至少四天，大部分时间	至少一周，或短于一周但因病情严重需住院
变化程度	明显不同于平时，别人能看出来	明显异常，常导致功能严重受损
功能	通常不造成严重损害，不需要住院	工作社交严重受损，或需住院
精神病性症状	没有	可以有，如夸大、被害妄想
自知力	常觉得“我很好”，不认为有病	常明显受损

【指南】DSM-5-TR 对躁狂要求持续至少一周、几乎每天大部分时间，并且造成明显功能损害、需要住院，或伴精神病性症状；轻躁狂则要求连续至少四天，变化能被他人观察到，但没有明显功能损害、不需要住院、没有精神病性症状。ICD-11 的表述略有差异，实际判断以原文和医生访谈为准。

时间门槛只是入口，不是全部。有的人症状只持续三天，但严重到需要住院，仍可能按躁狂处理；有的人持续一周，但功能基本维持，医生会仔细区分。**不要用“有没有满七天”自行判断。**

二、不只是“高兴”：症状群怎么组合

躁狂的核心不只是情绪高涨，还包括**精力或目标性活动明显增加**。情绪可以是高兴、过度自信，也可以是易怒、一点就着。很多患者并不觉得“快乐”，而是烦躁、停不下来、睡不好。

常见的症状群包括：

- **自我评价膨胀**：觉得自己能力超群、有特殊使命，别人都不懂；
- **睡眠需求减少**：只睡三四个小时也不困，不是失眠后疲惫，而是“睡够了”；
- **话多、语速快**：停不下来，别人插不上嘴，电话打很久；
- **思维奔逸**：想法一个接一个，自己觉得“脑子转得特别快”；
- **注意力易转移**：说到一半就换话题，容易被外界小事带走；
- **活动增多**：同时开很多项目，走路快、动作多，静不下来；

- **冒险行为**：大手笔花钱、投资、赌博、危险驾驶、性行为失控。

这些症状要一起看，不能单凭“话多”或“睡得少”下结论。一个人平时就外向、话多，和“明显不同于平时”是两回事；一个人熬夜赶工，第二天累得不行，也不等于睡眠需求减少。**判断的参照系是“他平时的样子”和“别人有没有觉得他变了”。**

三、双相 I 型与 II 型

维度	双相 I 型	双相 II 型
必要条件	至少一次躁狂发作	至少一次轻躁狂发作，加至少一次重性抑郁发作
是否有躁狂	有	从来没有
抑郁发作	可有可无	必须有
常见误解	“I 型更轻”	“II 型更轻”
功能影响	躁狂期可能严重受损、住院	轻躁狂期功能相对保留，但抑郁期损害常很重

双相 I 型的诊断门槛是“至少一次躁狂发作”，不要求一定有抑郁发作。也就是说，一个人可能只出现过躁狂，没有明显的抑郁期，仍然可以诊断为双相 I 型。躁狂可以伴精神病性症状，也可能需要住院。

双相 II 型要求至少一次轻躁狂发作和至少一次重性抑郁发作，并且从来没有过躁狂发作。它常被误认为“比较轻的双相”，这是不准确的：II 型的轻躁狂确实不造成严重功能损害，但抑郁发作往往频繁、功能负担重，自杀风险并不低，功能损害也可能很重【指南】。**不要因为“只是 II 型”就掉以轻心。**

还有一种情况是“环性心境”：长期在轻躁狂样和抑郁样之间波动，但达不到发作标准，持续两年以上（儿童青少年一年以上）。它不属于 I 型或 II 型，但同样会带来功能损害，详见 3.3。

四、病程、功能与需要排除的情况

双相障碍通常是发作性的：一段时间明显偏离基线，之后回到接近平时的状态，也可能留下一些残留症状。发作频率、发作间期能不能完全恢复、有没有快速循环（一年四次以上）、有没有混合特征，都会影响诊断标注和治疗方向。

功能损害要看具体场景：躁狂期可能把积蓄花光、丢掉工作、破坏关系；轻躁狂期可能“看起来效率很高”，但事后发现决定草率；抑郁期则可能无法工作、卧床、回避社交。**“发作间期完全正常”不是诊断的必要条件**，很多人会有残留的睡眠、注意力或情绪问题。

需要排除的情况至少有三类：

看起来像双相	可能是	线索
话多、精力旺、睡得少	物质或药物所致	近期用兴奋剂、类固醇、甲状腺素、抗抑郁药，或停药
兴奋、易怒、思维乱	躯体疾病所致	甲亢、库欣综合征、谵妄（急性意识混乱）、脑卒中、多发性硬化、神经梅毒
情绪不稳、冲动	其他精神障碍	边缘型人格、ADHD、创伤后应激、精神分裂症或分裂情感性障碍

物质和药物是最常被漏掉的一类。咖啡因、可卡因、冰毒、大麻、类固醇、甲状腺素、某些抗抑郁药都可能引起类似躁狂的表现；酒精戒断也会引起激越、失眠、幻觉。**躯体病**方面，甲亢、库欣综合征、高钙血症、谵妄、脑部病变都可能模仿躁狂，首次发作、年龄偏大或有神经症状时尤其要查。**其他精神障碍**方面，精神分裂症和分裂情感障碍以精神病性症状为主，边缘型人格的情绪波动多在几小时内、由人际事件触发，ADHD 则是从童年起持续存在的注意力与冲动问题，详见 3.4。

五、就诊准备与需要立即处理的情况

- ☐ 第一次出现“明显不同于平时”的高涨或易激惹是什么时候，持续了几天；
- ☐ 那段时间睡多久，是不困还是睡不着；
- ☐ 话量、语速、活动量、花钱、性行为、冒险行为有什么变化；
- ☐ 别人有没有说过“你像变了个人”，事后自己怎么评价；
- ☐ 有没有出现夸大、被害、被控制等想法，或听到别人听不到的声音；
- ☐ 高涨期之后有没有“跌下来”，抑郁持续多久；
- ☐ 既往发作次数、间隔、有没有一年四次以上；
- ☐ 当时有没有喝酒、用兴奋剂、吃类固醇或其他药；
- ☐ 有没有甲状腺病、脑部疾病、癫痫等躯体病史；
- ☐ 家族中有没有双相、精神病性症状、自杀或药物诱发躁狂；
- ☐ 目前用药、剂量变化和停药情况；
- ☐ 工作、学习、财务、人际关系受了多大影响。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- 躁狂期出现**完全不吃不喝、几天不睡、行为失控、暴力风险**：需急诊精神科评估。
- **木僵、缄默、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“双相就是抑郁加兴奋。”** 双相的核心是发作性的情绪和精力改变，可以只有躁狂，也可以以抑郁为主；轻躁狂不一定表现为“兴奋”。

- **“轻躁狂不算病，不用治。”** 轻躁狂可能带来冲动决定、关系破裂和财务损失，也常是双相 II 型的入口，需要评估和随访。
- **“双相 II 型比 I 型轻。”** II 型的抑郁负担和自杀风险并不低，不能按“轻重”排序。
- **“一次高兴就是躁狂。”** 要看持续时间、是否明显不同于平时、功能影响和别人的观察。
- **“躁狂就是创造力爆发。”** 轻躁狂时确实可能效率高、点子多，但判断力下降、冲动和随后的崩溃同样真实，不能浪漫化。
- **“情绪波动大就是双相。”** 边缘型人格、ADHD、创伤反应、甲亢、物质使用都可能表现为情绪不稳，需要纵向史和排除。
- **“吃药会失去自我。”** 治疗目标是减少发作、恢复功能，不是把人变得平淡；具体方案要和医生讨论，不要自行停药。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

3.2 双相抑郁的识别

双相障碍患者最常见的就诊状态不是躁狂，而是抑郁。很多人因为抑郁去看医生，拿了几年抗抑郁药，直到某次“用药后像变了个人”或“怎么治都不好”，才被重新考虑双相。这一页讲双相抑郁和单相抑郁的差别、哪些线索值得警惕、抗抑郁药转躁怎么识别，以及误诊的代价。适合被诊断为抑郁但反复发作、疗效不佳，或家族中有双相的人。

一、为什么双相抑郁总被漏掉

原因不神秘，主要有三个。第一，**抑郁期更长、更常求助**，躁狂或轻躁狂期往往不觉得自己有病，甚至觉得“状态最好”。第二，**轻躁狂的主观体验不痛苦**，患者不会主动报告，家人也可能把它当成“有活力”。第三，**多数抑郁筛查工具不查轻躁狂**，PHQ-9 得分再高，也不会提示双相。

还有一个容易被忽略的点：双相抑郁的首次发作常常就是抑郁，躁狂可能几年后才出现。医生在第一次就诊时只能根据现有信息判断，写“抑郁发作”并继续随访，是合理的；但如果多次复诊都没有主动追问轻躁狂史，就可能一直停在单相诊断上。需要排除的至少有三类：单相抑郁、物质或药物或躯体病所致的心境改变、以及边缘型人格、ADHD、创伤后应激等以情绪不稳为主的精神障碍。

漏诊原因	具体表现	可以怎么补
轻躁狂不痛苦	觉得“那阵子效率高、心情好”	换问法，问睡眠、话量、花钱、冲动
只关注当下抑郁	医生问情绪、睡眠、食欲，不问高涨期	主动提供既往“状态特别好”的时段
量表不覆盖	PHQ-9、HAMD 都没有轻躁狂条目	加用 MDQ 等筛查，但仍需访谈
家属不知情	高涨期可能被视为“正常”或“性格外向”	找伴侣、父母、老同学核对

二、双相抑郁的线索：和单相抑郁比

双相抑郁和单相抑郁在抑郁期可以非常像，但有一些统计上的倾向。下面这些线索不是“确诊条件”，只是提示医生“需要更仔细地问”。

线索	更偏单相抑郁	更需要考虑双相
睡眠	入睡困难、早醒	睡得过多、白天嗜睡
食欲	下降、体重减轻	增加、体重上升、渴望甜食
动作	焦虑、坐立不安	明显迟缓、木僵样
发作特点	持续时间较长	发作频繁、间歇期较短
起病	各年龄段	青少年期、产后、季节相关
家族史	抑郁为主	双相、精神病性抑郁、药物诱发躁狂
治疗反应	抗抑郁药逐渐起效	无效、越用越烦躁，或一用就转躁

“非典型特征”是双相抑郁常被提到的一组表现：睡得过多、吃得过多、体重增加、四肢沉重像灌了铅、对好消息仍有短暂反应、对被拒绝特别敏感。这些特征在单相抑郁里也不少见，所以不能单凭“我睡得多”就判断双相。真正有价值的是**组合**：早发、反复、产后或季节性、伴精神病性症状、家族史、抗抑郁药反应差，这些加在一起，才值得高度警惕。

双相抑郁也可能伴**混合特征**：抑郁的同时思维奔逸、话多、活动增多、冲动、整夜不睡。这种状态自杀风险高，也更容易被误认为“焦虑”或“抑郁加重”。

三、抗抑郁药转躁：识别与处理

抗抑郁药可能诱发躁狂、轻躁狂或混合状态，这是双相诊断里最重要的线索之一，也是治疗中最需要警惕的风险【指南】。它通常发生在用药后数天到数周，加量后更明显；表现不是“心情变好”，而是**睡眠需求减少、话多、思维快、活动多、花钱或冒险行为增加、易怒**，持续几天，而不是一两个小时。

要和几种情况区分：

- **药物激活**：坐立不安、心慌、失眠、烦躁，但没有情绪高涨、夸大或活动增多；
- **抑郁好转**：愿意出门、能做事，但睡眠、判断力、消费都在正常范围；
- **混合状态**：抑郁没走，又出现思维快、冲动、整夜不睡，风险最高；
- **物质或躯体因素**：同时喝酒、用兴奋剂，或甲亢、感染等。

发现可疑变化，正确的做法是**尽快联系开药医生**，把用药时间、剂量变化、症状出现的时间线说清楚。**不要自行停药或加药**：突然停抗抑郁药可能引起撤药反应，也可能让情绪更快摆向另一头。如果出现精神病性症状、明显冲动或自杀念头，按急症处理。

还要说明：一次药物诱发的躁狂或轻躁狂，不等于“终身双相”。DSM-5-TR 有“物质或药物所致双相障碍”这一类别，医生会结合既往史、家族史和后续病程重新评估。**不要自己给自己改诊断，也不要因为怕转躁就拒绝所有药物治疗。**

四、误诊的代价

把双相抑郁当单相抑郁治，最直接的代价是**治疗方向不对**：单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合状态，让发作更频繁；也可能出现“药越换越多、效果越来越差”。对患者来说，这意味着更长的病程、更多的请假和住院、更重的经济负担，以及更高的自杀风险。

反过来，把单相抑郁误当双相、长期按双相治疗，也会带来不必要的药物负担、体重和代谢问题，以及“我是不是疯了”的标签压力。**区分的目的不是选一个更重的标签，而是找到更匹配的治疗。**

误诊还会影响人生决定：有人因为“抑郁”反复请假、辞职，后来才发现是双相；有人被当成“性格不稳定”，其实是未被识别的发作。**准确的纵向病史，比一次量表分数更能改变结局。**

五、怎么问、怎么记、什么时候就医

- ☐ 第一次抑郁发作是什么时候，当时有没有“状态特别好”的时期；
- ☐ 高涨期持续几天，睡眠需求减少到什么程度；
- ☐ 那段时间有没有话多、思维快、花钱多、冲动、易怒；
- ☐ 有没有人说过“你像变了个人”，事后自己怎么评价；
- ☐ 抑郁期有没有睡得过多、吃得过多、四肢沉重；

- ☐ 有没有产后、季节性、青春期起病的规律；
- ☐ 抗抑郁药使用后有没有出现转躁、混合或“越治越糟”；
- ☐ 家族中有没有双相、精神病性抑郁、自杀或药物诱发躁狂；
- ☐ 有没有甲状腺病、脑部疾病、物质使用；
- ☐ 发作频率、间隔、一年有没有四次以上；
- ☐ 工作、学习、财务、关系受了多大影响；
- ☐ 目前所有药物、保健品、酒精和咖啡因使用情况。

记录时尽量用时间线：哪年哪月、什么状态、持续多久、有没有用药、什么时候恢复。旧照片、消费记录、工作考勤、家人回忆都能帮忙。MDQ 等工具可以筛查，但不能确诊，详见 3.5。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
> - 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
> - 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
> - 用药后出现**转躁、行为失控、几天不睡**：尽快联系开药医生，不要自行停药或加药。
> - **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
> - 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
>
> 如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“我只是抑郁，不可能是双相。”** 双相抑郁比躁狂更常见，很多人第一次就诊就是抑郁；关键是有没有轻躁狂史。
- **“我从来没有兴奋过。”** 轻躁狂也可能是易激惹、思维快、活动多、睡得少，不一定表现为“开心”。
- **“抗抑郁药吃完心情好了，说明对症。”** 要看好到什么程度：睡眠需求减少、话多、冲动、花钱失控，不是单纯好转。
- **“一次转躁就一定是双相。”** 需要排除物质、药物、躯体原因，也要看后续病程。
- **“双相抑郁不能吃抗抑郁药。”** 有时会在心境稳定剂基础上短期联合，是否使用由医生权衡，不要自行决定。
- **“双相 II 型比较轻，不用认真治。”** II 型的抑郁负担和自杀风险并不低。
- **“情绪波动大就是双相。”** 边缘型人格、ADHD、创伤反应、甲亢都可能，需要纵向史和排除。
- **“确诊双相就完了。”** 双相是可以管理的慢性病，规律治疗和随访能显著减少发作；诊断是起点，不是终点。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

3.3 混合特征、快速循环与病程标注

同样是双相，有的人一年只发作一次，有的人一年四次以上；有的人躁狂期纯粹“往上走”，有的人却在高涨的同时绝望、想死。这些差别会写进诊断的“标注”里，直接影响治疗和随访。这一页讲混合特征、快速循环、环性心境，以及医生写在诊断后面的那些标注是什么意思。适合病程反复、情绪变化复杂，或想看懂自己诊断书的人。

一、混合特征：不是“又高兴又难过”那么简单

混合特征指的是：在一次发作里，同时出现相反极性的症状。DSM-5-TR 的做法是加标注：躁狂或轻躁狂发作中，如果同时有至少三项抑郁症状；或抑郁发作中，如果同时有至少三项躁狂/轻躁狂症状，并且这些症状几乎每天出现、占据发作的大部分时间，就可以标“伴混合特征”。容易重叠的症状（比如易激惹、注意力分散）不能重复计算。

发作类型	混合时的常见表现	主要风险
躁狂伴混合	情绪高涨或易怒，同时绝望、自责、想死	冲动、自杀、伤人
抑郁伴混合	情绪低落，同时思维奔逸、话多、活动增多、整夜不睡	自杀、冲动、治疗复杂
轻躁狂伴混合	精力旺、点子多，同时焦虑、抑郁、烦躁	易被误认为“焦虑”或“性格问题”

混合状态最危险的地方，是**绝望和行动力同时存在**。单纯抑郁的人可能没有力气实施自杀，单纯躁狂的人可能不觉得绝望；混合状态的人既有想死的念头，又有冲动、失眠、精力，风险明显升高。**混合状态属于急症边界，不要在家观察。**

混合特征也容易被误诊。抑郁伴混合的人，可能因为“话多、坐不住、睡不着”被当成焦虑，加了镇静药或抗抑郁药，反而更糟；躁狂伴混合的人，可能因为“说想死”被当成单纯抑郁。**纵向了解发作的全貌，比只看当下几分钟重要。** 同时还要排除物质或药物所致、甲状腺等躯体因素，以及边缘型人格的应激性情绪波动。

二、快速循环：一年四次以上

快速循环不是一种独立的病，而是病程标注：在过去十二个月里，至少有四次心境发作，可以是躁狂、轻躁狂或重性抑郁；发作之间要有明显缓解（至少两个月）或直接转换为相反极性。也就是说，四次“情绪不好”不一定是快速循环，必须是达到发作标准的心境发作。

概念	定义要点	常见诱因或关联
快速循环	十二个月内四次以上心境发作	抗抑郁药、甲状腺功能减退、物质使用、月经周期
超快速循环	几天到几周内反复切换	争议较大，需仔细排除物质和躯体因素
环性心境	两年以上轻躁狂样与抑郁样波动，达不到发作标准	常被当性格，功能损害持续

快速循环在临床上女性更常被报告，但原因可能包括就诊行为、诊断习惯和共病差异，不能简单归因于“女性体质”。**抗抑郁药是重要的可逆因素：**有些人单用或反复加用抗抑郁药后，发作越来越频

繁；甲状腺功能减退、酒精或其他物质、睡眠剥夺也可能推波助澜。治疗上，医生通常会重新审视抗抑郁药、评估甲状腺、优化心境稳定剂，而不是继续“加一种药压症状”。

三、环性心境：长期的“小波浪”

环性心境（cyclothymia）是双相谱系里更长期、更轻的一种模式：至少两年（儿童青少年一年）反复出现轻躁狂样和抑郁样的症状，但达不到躁狂、轻躁狂或重性抑郁发作的完整标准；在这两年里，几乎没有连续两个月完全无症状；并且造成功能损害，不能用其他精神障碍更好地解释。

它和“性格起伏大”的区别在于**持续时间、功能损害和不可控性**。一个人平时情绪丰富、遇到好事开心、遇到坏事难过，是正常波动；环性心境的人则在几年里反复出现精力、睡眠、自信、兴趣的明显起落，工作、关系、财务反复受影响，自己也觉得“控制不住”。

环性心境也容易和边缘型人格障碍混。后者的人际关系、自我认同、冲动和自伤模式更突出，情绪波动常由被抛弃、被批评等事件在几小时内触发；环性心境更偏向自发的、持续数天的轻躁狂样或抑郁样状态。两者可以共病，诊断要谨慎。

四、病程标注：医生写在诊断后面的那几行

双相障碍的诊断不只是一个名字，后面常跟着一串标注。它们不是“附加标签”，而是对治疗和预后有实际意义的信息。

标注	含义	为什么重要
当前发作类型	躁狂、轻躁狂、抑郁、混合	决定当下治疗重点
严重度	轻、中、重，有无精神病性症状	决定是否需要住院、是否用物理治疗
缓解状态	部分缓解、完全缓解	判断疗效和复发风险
快速循环	一年四次以上	提示治疗需要调整，尤其是抗抑郁药
混合特征	同时有相反极性症状	自杀和冲动风险更高
季节模式	每年同一时段发作	帮助提前预防和安排随访
围产期起病	孕期或产后发病	涉及母婴安全和用药权衡

这些标注需要纵向信息才能填准。医生会问：第一次发作什么时候、之后每年几次、每次持续多久、之间能不能完全恢复、有没有季节规律、产后有没有变化、有没有精神病性症状、有没有快速循环。**诊断书写得细，随访才有依据。**

五、记录与就医

- ☐ 用时间线记下每次发作的起止时间、极性（高/低/混合）、严重度；
- ☐ 记录睡眠时长和睡眠需求，而不只是“睡得好不好”；
- ☐ 记录用药变化和症状出现的时间关系，尤其是抗抑郁药；
- ☐ 记录月经周期、产后、季节变化与发作的对应；
- ☐ 记录一年内的发作次数，判断是否达到快速循环；
- ☐ 记录有没有精神病性症状、自杀念头、冲动行为；

- ☐ 记录功能变化：工作、学习、财务、关系、自理；
- ☐ 找一位知情者帮忙核对，尤其是轻躁狂期；
- ☐ 把甲状腺、贫血、物质使用等检查结果带给医生；
- ☐ 复诊时主动问：“我的诊断后面有没有标注？需不需要更新？”

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- 躁狂期出现**几天不睡、完全不吃不喝、行为失控、暴力风险**：需急诊精神科评估。
- **木僵、缄默、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“混合就是又高兴又难过。”** 混合特征有明确的症状组合和时间要求，不是情绪矛盾这么简单；它比单纯发作更危险。
- **“一年发作四次就是快速循环。”** 必须是达到发作标准的心境发作，并且有缓解或极性转换，不是四次心情不好。
- **“快速循环是治不好的。”** 它治疗更复杂，但找出诱因（抗抑郁药、甲减、物质）后可以改善。
- **“环性心境就是性格问题。”** 它持续两年以上、造成功能损害，是一种需要评估的障碍，不是“矫情”。
- **“诊断后面的标注不重要。”** 标注影响治疗选择、住院判断和预后沟通，值得问清楚。
- **“情绪波动大就是双相。”** 边缘型人格、ADHD、创伤、甲亢、物质使用都可能，需要纵向史和排除。
- **“抗抑郁药可以随便加。”** 在双相里，抗抑郁药可能诱发转躁、混合和快速循环，必须由医生权衡。
- **“症状好了就不用复诊。”** 双相是慢性、复发性的病，维持治疗和随访能减少下一次发作。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.
- 中华医学会精神医学分会. 《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

3.4 双相与单相、边缘型人格、ADHD 的鉴别

“情绪一会儿高一会儿低”是很多人对双相的理解，但真正让医生头疼的，是这三种情况长得很像：双相障碍、边缘型人格障碍、注意缺陷多动障碍（ADHD）。一个是被发作推动，一个是长期的人际与情绪模式，一个是从小持续到大的注意力与冲动问题。这一页讲怎么从时间尺度、触发因素、发育史去区分，也讲为什么它们可以同时存在。适合被给过多个诊断、或想理解“为什么医生问得这么细”的人。

一、先分清“发作”和“波动”

鉴别第一步不是看症状，而是看**时间结构**。双相的心境改变是发作性的：持续几天到几周，明显偏离平时的自己，常伴睡眠、精力、食欲、活动量的同步变化，之后缓解或转向另一极。边缘型人格的情绪波动更像“反应性风暴”：几小时到一两天，常由人际事件触发，来得快、去得也快。ADHD 则是从童年起就存在的底色，不是“这段时间才有”。

维度	双相发作	边缘型人格	ADHD
时间尺度	几天到几周	几小时到一两天	长期、持续
触发	常无明显诱因，或睡眠剥夺	多由人际冲突、被拒绝触发	与任务、环境有关
睡眠	睡眠需求明显减少	可能失眠，但很少“睡少仍精力旺”	入睡困难常见，白天仍疲惫
核心	心境与精力同步改变	关系、认同、冲动、自伤	注意力、多动、冲动
发作间期	可回到基线，也可能有残留	模式长期存在	症状持续，不分发作期

这张表只用于建立思路，不能拿来给自己或家人“对号”。三种情况可以共病，也可以互相误诊，最终要靠纵向史和面对面评估。

二、双相与单相抑郁

单相抑郁和双相抑郁的鉴别，核心只有一个问题：**有没有过躁狂或轻躁狂发作**。没有，就不能诊断双相；有，哪怕只有一次，诊断方向就要改。难点在于轻躁狂常被忽略，患者只记得抑郁，家人也只记得“他那阵子挺有劲”。

除了直接问高涨期，还可以看抑郁本身的特征：双相抑郁更常出现睡得过多、吃得过多、四肢沉重、精神病性症状、产后或季节性发作、早发、反复发作、家族史，以及抗抑郁药疗效差或诱发转躁。但这些只是线索，不能单凭一条定论。

治疗反应也能提供信息：单相抑郁用抗抑郁药通常逐渐起效；双相抑郁可能无效、越用越烦躁，或一用就“变了一个人”。**不要把“抗抑郁药无效”直接当成双相的证据**，它也可能是剂量、疗程、共病、躯体因素或诊断不准。

三、双相与边缘型人格

这是临床上最容易互相误诊的一对。边缘型人格障碍的核心是**长期的不稳定**：人际关系在理想化和贬低之间摆荡，害怕被抛弃，自我认同混乱，冲动（消费、性、物质、驾驶），反复自伤或自杀威胁，情绪空虚、易怒。情绪波动常由“他是不是不要我了”“他为什么回消息这么慢”这类事件触发，几小时内从爱到恨。

双相的核心是**发作**：情绪、精力、睡眠、活动量一起变，持续几天以上，不一定由人际事件触发。轻躁狂期可能话多、计划多、花钱多，但通常没有“被抛弃—自伤”的人际剧本；抑郁期则可能卧床、早醒、思维迟缓。

线索	更偏双相	更偏边缘型人格
情绪变化的速度	几天到几周	几小时到一两天
触发因素	常无明显诱因	人际冲突、被拒绝、被忽视
睡眠	躁狂期睡眠需求减少	失眠多与情绪事件相关
自伤	可见，但非核心	反复自伤、自杀威胁较常见
自我认同	发作间期相对稳定	长期空虚、认同混乱
关系模式	发作期可能紊乱	长期理想化与贬低交替

两者可以共病，而且共病并不少见。**不要用“边缘型”否定双相**：一个人可以有长期的人格模式，也可以有发作性的心境障碍；反过来，也不要把所有情绪不稳都归给双相，忽略创伤、依恋和人格层面的问题。诊断人格障碍尤其要谨慎，**不要在急性发作期下人格结论**，因为发作本身就会让人看起来“不像原来的自己”。

四、双相与 ADHD

ADHD 的核心是**从童年早期就存在的**注意力不集中、多动、冲动，至少持续六个月，出现在两个以上场景（家里、学校、工作），并造成功能损害。它不是发作性的：不会“这周有、下周没”，也不会伴明显的睡眠需求减少、夸大或心境高涨。

双相则相反：平时可能完全正常，发作期才出现话多、思维快、活动多、冲动、睡眠需求减少。ADHD 的“冲动”多是脱口而出、插话、坐不住；轻躁狂的“冲动”常带目标性——同时启动几个项目、大量花钱、觉得自己能做成大事。

线索	更偏 ADHD	更偏双相
起病	十二岁前，持续存在	任何年龄，发作性
病程	长期稳定	几天到几周，间歇
睡眠	入睡困难，但白天疲惫	睡眠需求减少，白天仍精力旺
自信	多与挫折相关	发作期明显夸大
冒险	冲动、欠考虑	目标性的大计划、投资、赌博
兴奋剂反应	可能改善注意力	可能诱发躁狂或混合

两者共病很常见。ADHD 患者可能因为冲动、话多、情绪不稳被误认为轻躁狂；双相患者也可能因为注意力差、坐不住被误认为 ADHD。**童年发育史是关键**：问怀孕生产、走路说话的时间、幼儿园和小

学老师的评语、有没有被诊断过 ADHD、青春期前后有没有明显变化。成人自我报告常不准确，尽量找父母或旧成绩单核对。

五、童年起病与发育史

儿童青少年期的双相诊断要特别谨慎。**长期、几乎天天易激惹，但没有明确发作期**，更常见于破坏性情绪失调障碍、ADHD、对立违抗、创伤反应或家庭环境问题，而不是双相。真正的儿童期双相通常有明确的发作性、家族史、精神病性症状或严重功能倒退，诊断需要专门评估。

发育史能提供很多线索：

- 孕期、分娩、早期发育有没有异常；
- 走路、说话、上学、交友的时间线；
- 幼儿园和小学老师的评语，注意力、冲动、情绪的记录；
- 有没有被诊断过 ADHD、学习障碍、抽动、孤独症谱系；
- 青春期、月经初潮、产后等激素变化与情绪的关系；
- 家族中双相、抑郁、自杀、物质使用的情况。

就诊前可以准备一份清单：

- ☐ 第一次情绪明显异常是什么时候，持续多久；
- ☐ 是“一直这样”，还是“一段时间这样，之后恢复”；
- ☐ 睡眠需求有没有明显减少，还是只是睡不着；
- ☐ 情绪波动有没有触发因素，还是“无缘无故”；
- ☐ 有没有自伤、冲动消费、危险驾驶、物质使用；
- ☐ 从小到大，注意力、冲动、交友、学习成绩怎么样；
- ☐ 老师、家人、伴侣分别观察到什么；
- ☐ 用过哪些药，有没有转躁、混合、快速循环；
- ☐ 有没有甲状腺病、脑部疾病、癫痫、物质使用；
- ☐ 家族中有没有双相、精神分裂症、自杀。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- 躁狂期出现**几天不睡、行为失控、暴力风险**：需急诊精神科评估。
- **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

六、常见误区

- **“情绪波动大就是双相。”** 要看时间尺度、触发因素、睡眠和精力变化，以及是不是发作性。
- **“边缘型人格就是作、就是矫情。”** 它是一种有明确诊断标准的障碍，常与创伤有关，需要专业治疗，不该被污名化。
- **“有边缘型人格就不可能是双相。”** 两者可以共病，不能用一个诊断否定另一个。
- **“ADHD 就是坐不住，长大就好了。”** ADHD 可持续到成年，并影响工作、关系和财务；也不是“意志力差”。
- **“孩子发脾气就是双相。”** 长期易激惹更常见于其他情况，儿童双相诊断需要严格评估。
- **“量表能区分这三种。”** 量表只能提示方向，不能替代纵向访谈和发育史。
- **“一次诊断就是终身的。”** 诊断会随信息修正，尤其在急性期下的判断需要随访验证。

参考来源

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.
- NICE. *Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management* (NG87). 2018.
- World Health Organization. *ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

3.5 双相诊断的常见误区与量表

MDQ 勾了 8 条，是不是就“确诊双相”？YMRS 分数高，是不是就“躁狂了”？双相诊断里，量表能帮忙，但不能替代纵向病史。这一页讲 MDQ、YMRS 等工具的用途和局限，也讲“天才病”“情绪化就是双相”“一次兴奋就确诊”这些常见误区。适合做过双相筛查、被多个诊断绕晕，或想理解“医生为什么要问这么多年前的事”的人。

一、MDQ：筛查工具，不是诊断

MDQ（心境障碍问卷）是自评筛查工具，包含十几个关于“是否有过一段时间”的问题，涉及情绪高涨、易激惹、精力、睡眠、话多、思维快、花钱、冒险等；还要求这些症状是否同时出现、是否造成中度或严重的问题。常见的阳性筛查口径是“七条及以上、同时出现、并造成中度或严重问题”，但不同版本和使用场景的切分并不完全一样。医生用它来快速判断“要不要进一步问双相”，而不是用它下诊断。

量表	谁来评	主要用途	主要局限
MDQ	患者自评	初筛双相谱系	敏感度在不同样本差异大，假阳性和假阴性都不少
HCL-32	患者自评	筛查轻躁狂	更偏“外向、精力旺”，容易把正常高能量算进去
YMRS	医生他评	躁狂严重度、试验随访	需培训，主要覆盖躁狂，不覆盖抑郁
CGI-BP	医生他评	整体严重度、疗效	主观总体印象，不能单独诊断

MDQ 的问题在于“回忆”和“自我观察”。轻躁狂的人常觉得“那阵子挺好”，不会把它当成症状；抑郁的人可能把正常的开心日子也算成“高涨”。不同科室、不同人群里，MDQ 的敏感度和特异度差异很大：在精神科门诊，它可能漏掉一些双相；在普通人群，它可能把不少正常人筛成阳性。**阳性不等于确诊，阴性也不能排除双相。**

二、YMRS 与其他量表

YMRS（Young 躁狂评定量表）是他评工具，医生根据访谈和观察给躁狂症状打分，常用来评估严重度和追踪治疗变化，在临床试验里用得多。它覆盖情绪高涨、活动增多、睡眠、言语、思维、破坏性行为、外表、自知力等，但**不是诊断工具**，也不能替代对抑郁期、混合特征、病程的评估。

量表的使用有几个前提：受过训练、在相对稳定的状态下评、结合知情者信息、定期复评。一个刚入院、极度兴奋的人，YMRS 可能很高；一个已经部分缓解的人，分数可能不高，但功能还没恢复。**分数只是横截面，病程才是纵向线。**

三、“天才病”与创造力

双相常被浪漫化成“天才病”：梵高、诗人、艺术家、创业者……好像躁狂就等于灵感，治疗就等于扼杀才华。这种说法有两层问题。

第一，**相关不等于因果**。研究确实发现双相与创造力之间存在统计关联，尤其在艺术、写作领域，但关联可能来自共同因素（认知风格、家庭环境、社会阶层），也可能来自“轻躁狂时效率高”的主观体验。它不能证明“双相让人更有才华”，更不能证明“治疗会毁掉才华”。

第二，**它忽略了代价**。轻躁狂时的“高效”常伴随判断力下降、冲动消费、关系破裂、睡眠剥夺，随后往往是更深的抑郁。很多患者事后回忆，那段时间“看起来很好，其实失控”。**治疗的目标是减少发作、恢复功能，不是把人变得平庸。** 如果担心药物影响创作状态，可以和医生讨论调整方案，但不要自行停药。

四、常见误区

- **“情绪化就是双相。”** 情绪化是人格、压力、激素、睡眠、物质都可能带来的；双相要求发作性、持续时间、功能影响和排除。
- **“一次兴奋就是双相。”** 要看持续几天、是否明显不同于平时、有没有睡眠需求减少和功能改变；一次熬夜赶工不算。
- **“双相就是抑郁加躁狂，没有抑郁就不是。”** 双相 I 型只要有躁狂发作即可诊断，不要求抑郁；双相 II 型则必须有抑郁。
- **“双相只需要吃抗抑郁药。”** 单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合和快速循环，双相的治疗通常以心境稳定剂为骨架。
- **“轻躁狂不用治。”** 轻躁狂也可能带来冲动决定、财务和关系损失，且双相 II 型的抑郁负担很重。
- **“量表高分就是确诊。”** MDQ、YMRS 都只是筛查或严重度工具，诊断要靠纵向访谈和排除。
- **“双相是遗传的，治也没用。”** 遗传风险确实较高，但不是命运；规律治疗能减少复发、改善功能。
- **“得了双相就不能工作、不能结婚、不能生孩子。”** 很多人在治疗下可以正常工作、经营关系、生育；孕产期需要提前规划，但不是绝对禁忌。
- **“吃药会失去自我、失去创造力。”** 药物可能带来困倦、体重变化等副作用，可以和医生调整；不治疗带来的发作和功能损害，往往更伤“自我”。
- **“确诊就是贴标签，不如不知道。”** 准确诊断能带来匹配的治疗和解释，也可能带来标签压力；是否告知他人、如何告知，可以自己决定。

五、确诊需要纵向史

双相诊断最关键的证据，不是某一次量表，而是**时间线**：第一次发作什么时候、之后每年几次、每次持续多久、之间能不能完全恢复、有没有季节或产后规律、有没有药物诱发、家族里有没有类似情况。医生会把这些拼成“生命图表”，再结合面谈和精神检查判断。

诊断还要求**病程和功能损害**：躁狂至少持续一周、轻躁狂至少四天、抑郁至少两周，并且造成明显功能改变、需要住院，或伴精神病性症状。同时要排除至少三类情况：单相抑郁（没有轻躁狂或躁

狂）、物质或药物或躯体病所致的心境改变（兴奋剂、类固醇、甲状腺病等）、以及其他精神障碍（边缘型人格、ADHD、精神分裂症或分裂情感）。量表既不能确认，也不能排除这些。

就诊前可以这样准备：

- ☐ 按年份列出情绪明显异常的时段，标注“高”“低”“混合”；
- ☐ 每段持续多久，睡眠、话量、活动、花钱、冲动有什么变化；
- ☐ 有没有住院、急诊、自伤、自杀尝试；
- ☐ 用过哪些药，用药后有没有转躁、混合、快速循环；
- ☐ 有没有产后、季节性、青春期起病的规律；
- ☐ 家族中双相、抑郁、自杀、物质使用的情况；
- ☐ 找一位知情者一起回忆，带上旧病历、成绩单、照片；
- ☐ 把甲状腺、脑部、物质使用等检查结果整理好；
- ☐ 复诊时问：“支持双相的证据是什么？还需要排除什么？”；
- ☐ 如果诊断有疑问，可以寻求第二意见，但不要自行停药。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现**自杀念头、计划或准备**，或已经自伤：不要独处，立即联系信任的人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现**混合状态**：整夜不睡、思维飞奔、冲动易怒，同时极度绝望，风险很高，尽快精神科急诊评估。
- 出现**幻觉、被害或夸大妄想、命令性幻听**，或有伤人风险：先保证安全，拨打 120 或 110。
- 躁狂期出现**几天不睡、行为失控、暴力风险**：需急诊精神科评估。
- **木僵、拒食拒水、长时间不动**：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后出现**高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变**，或**严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。

如果拿不准“算不算严重”，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。

参考来源

- Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. *American Journal of Psychiatry*. 2000.
- Young RC, Biggs JT, Ziegler VE, Meyer DA. A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. *British Journal of Psychiatry*. 1978.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. 2022.
- NICE. *Bipolar disorder: assessment and management* (CG185). 2014, updated 2020.

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 4：焦虑障碍确诊

焦虑的躯体症状很像心脏病、甲亢、低血糖。确诊既要看症状组合，也要先排除“不是焦虑”的原因。

4.1 焦虑障碍总论与分类

心慌、手抖、胸口发紧、夜里反复想“会不会出事”，是焦虑最常见的样子。有人被一句“你就是想太多”打发，也有人把每次心跳加快都当成心脏病，反复跑急诊。这一页讲清楚正常焦虑从哪里开始变成焦虑障碍，以及广泛性焦虑、惊恐障碍、广场恐惧、社交焦虑、特定恐惧、分离焦虑各自怕什么、怕多久。读完你能带着更清楚的问题去就诊，但不要拿它给自己或家人下诊断。

焦虑本来是保护机制

焦虑是身体在说“可能有危险”。交感神经被激活，心跳加快、呼吸变浅、肌肉紧绷、注意力收窄，这些反应在真正遇到威胁时能救命。适度焦虑还能提高表现：考试前紧张、上台前手心出汗，都属于正常范围。

正常焦虑和焦虑障碍的分界，通常不看“有没有焦虑”，而看四件事：

- **有没有明确对象**：正常焦虑多指向具体事件，事件过去就回落；焦虑障碍的担心常常弥散、停不下来。
- **和现实是否相称**：担心程度明显超过事情本身，或者事情很小也引发强烈反应。
- **能不能控制**：知道“想多了”却停不下，越想压越压不住。
- **有没有损害功能**：开始回避工作、社交、出门、乘车，或每天花大量时间担心、检查、求保证。

这四条不是诊断标准，而是医生访谈时会追的方向。真正的诊断还要看持续时间、躯体与物质因素、其他精神障碍和功能损害。【指南】

六类焦虑障碍：各自怕什么、怕多久

类型	核心担忧或恐惧	常见时间门槛	典型回避
分离焦虑	与依恋对象分离后对方会出事、自己回不去	儿童青少年约四周，成人约六个月	不肯上学、不肯独睡、出门要人陪
特定恐惧	某一个具体对象或情境，如高处、动物、打针	约六个月	绕开高楼、电梯、医院、狗
社交焦虑	被审视、被负面评价、出丑	约六个月	聚会、发言、吃饭、面试
惊恐障碍	再次惊恐发作，或发作后果	反复非预期发作，之后担心约一个月	避免独处、运动、密闭空间
广场恐惧	出现症状时逃不掉、得不到帮助	约六个月	公交、地铁、商场、排队、独自离家
广泛性焦虑	多件日常事持续担心，难以控制	约六个月	反复确认、拖延、过度准备

时间门槛是 DSM-5-TR 的常用口径，ICD-11 的表述不完全相同，以医生面诊和原文为准。【指南】

这些障碍不是互斥的。一个人可以同时有社交焦虑和惊恐障碍，也可以先有广泛性焦虑、后来出现广场恐惧。分类的意义在于找到最主要的恐惧环，而不是给人多加几个标签。

还有两类容易被忽略：选择性缄默（在特定场合持续不说话，多见于儿童）和物质/药物所致焦虑障碍、躯体疾病所致焦虑障碍。后两类不是“心理问题”，处理方向完全不同。

病程、功能损害与必须先排除的原因

焦虑障碍通常不是一两天的事。广泛性焦虑、社交焦虑、特定恐惧、广场恐惧多要求症状持续数月；惊恐障碍的关键不是发作本身，而是发作后约一个月的持续担忧或行为改变。儿童、老人、孕产期人群的表现常不典型：孩子可能只说肚子痛，老人可能只表现为失眠、食欲差、反复就诊。

功能损害要具体看：工作效率是否下降、是否频繁请假、成绩是否下滑、是否推掉聚会、家庭角色是否受影响、是否反复做检查、睡眠是否被担心占满。有的人表面还能上班，但下班后所有时间都用来准备和确认，这也算损害。

在确诊焦虑障碍前，医生通常会排除三类“看起来像焦虑”的情况：

1. **躯体疾病**：甲亢、心律失常、低血糖、嗜铬细胞瘤、哮喘、贫血、睡眠呼吸暂停、前庭疾病、癫痫等。它们可以原样复制心慌、出汗、发抖、气短。
2. **物质与药物**：咖啡因、能量饮料、酒精或戒酒、尼古丁、大麻、兴奋剂，以及激素、支气管扩张剂、减充血剂、部分抗抑郁药和抗精神病药。
3. **其他精神障碍**：抑郁、双相、创伤后应激、强迫、疾病焦虑、孤独症谱系、人格特质，都可能以“焦虑”为主诉。

这也是为什么第一次就诊常要抽血、做心电图，医生还会问得很细：什么时候开始、什么情况下加重、喝了什么、吃了什么、家里有没有类似情况。

就诊前可以准备的清单

- ☐ 把第一次出现症状的时间、当时的情境写下来。
- ☐ 记录一次典型发作：从开始到高峰多久、持续多久、具体身体感觉、当时在想什么。
- ☐ 列出已经回避的场合：地铁、电梯、会议、独自在家、医院等。
- ☐ 记录咖啡、茶、能量饮料、酒精、尼古丁的量和时间。
- ☐ 带上正在吃的所有药、保健品、减肥药，包括偶尔吃的。
- ☐ 写下既往检查结果：心电图、甲状腺功能、血糖、动态心电图等。
- ☐ 记录睡眠、体重、月经（如适用）、近期压力事件。
- ☐ 写下家族里焦虑、抑郁、双相、酒精使用的情况。
- ☐ 准备两三个最想问医生的问题，例如“还需要排除什么”“要不要做心理治疗”。

常见误区与急症边界

误区一：焦虑就是心理素质差。 焦虑障碍有生物学和心理学基础，不是“想开点”就能解决，也不是意志薄弱。

误区二：心脏查过没事，就一定是焦虑。 一次静息心电图正常，不能排除阵发性心律失常。若症状反复、有心脏病危险因素，医生可能安排动态心电图、心脏超声或运动试验。

误区三：能上班就不算病。 功能损害不只看“有没有停工”，还包括效率、回避、痛苦和医疗资源消耗。

误区四：焦虑症不用治，扛过去就好。 部分人会缓解，但长期回避会让问题固化，共病抑郁和物质使用的风险也会上升。治疗通常包括心理治疗和必要的药物，具体方案由医生决定。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**突发压榨性胸痛、胸闷持续不缓解、疼痛放射到左臂或下颌、冷汗、晕厥、明显呼吸困难、口唇发紫、意识模糊、单侧肢体无力或说话不清。这些首先按心脏或脑血管急症处理，不要先假设是惊恐发作。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**焦虑明显加重、无法出门、无法入睡、出现自伤或自杀念头、靠酒精或镇静药才能撑住、停药后出现抽搐或意识混乱。
>
> 第一次出现剧烈惊恐、又有心脏病危险因素（高血压、糖尿病、吸烟、家族史）时，宁可先看急诊排除心脏问题。

确诊之后，医生通常会和你讨论：主要问题是哪一种焦虑、有没有共病、要不要心理治疗、是否需要药物、多久复诊。诊断是解释和安排治疗的起点，不是给你贴一个终身标签。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

4.2 广泛性焦虑与惊恐障碍

广泛性焦虑和惊恐障碍常被混在一起：一个是“总在担心”，一个是“突然被恐惧击中”。但两者的时间门槛、害怕的对象、治疗重点并不相同。这一页把两者的诊断线索拆开，也讲清楚哪些躯体病会伪装成它们。适合反复心慌、担心，或被一句“焦虑症”打发的人读。

广泛性焦虑：担心的不是一件事，而是所有事

广泛性焦虑的核心不是某一次强烈恐慌，而是长期、弥散、难以控制的担心。担心内容常围绕工作、金钱、家人健康、孩子、琐事，一天里大部分时间都在想“万一”。【指南】

医生通常会看：

- 担心是否涉及多个领域，而不是只围绕一件事。
- 是否明显过度，与事情的实际风险不相称。
- 是否难以控制，自己也觉得“想停停不下来”。
- 是否持续数月，且大部分日子都存在。
- 是否伴随坐立不安、容易疲劳、注意力难集中、易激惹、肌肉紧张、睡眠差。
- 是否造成工作、学习、社交或家庭功能的损害。

这里的“数月”在 DSM-5-TR 里通常是六个月左右；ICD-11 对时间的要求表述不同，以原文和医生判断为准。六个月不是机械门槛，而是帮助区分“近期压力下的担心”和“长期特质性担忧”。

广泛性焦虑的身体症状常比“心理担心”更突出：肩颈紧、头痛、胃胀、腹泻、手抖、心悸、喉咙发紧、入睡困难。很多人先跑心内科、消化科，查了一圈没大问题，最后才到精神科。

广泛性焦虑还容易和抑郁共病。判断时要看先后和主次：是先长期担心、后来情绪低落，还是抑郁发作后开始反复担心；有没有兴趣减退、早醒、体重下降、自杀念头。两者共病很常见，不代表诊断错了。

惊恐发作：几分钟内冲到顶点的恐惧

惊恐发作的特点是“突然”和“很快到顶”。不是慢慢累积的紧张，而是在几分钟内出现强烈恐惧或不适，伴随一组躯体或认知症状。DSM-5-TR 列举了十余项，通常要达到至少四项才称为一次完整发作；少于四项的称为有限症状发作。【指南】

可以把这些症状分成四组来记：

症状群	常见表现	容易混淆
心脏呼吸	心悸、胸闷、胸痛、气短、窒息感	心绞痛、心律失常、哮喘、肺栓塞
神经前庭	头晕、站不稳、发抖、出汗、发冷或发热、麻木	低血糖、前庭疾病、癫痫
胃肠	恶心、腹部不适	胃肠病、食物中毒
认知	濒死感、失控感、失真感、脱离感	其他焦虑、解离、创伤反应

惊恐发作可以是“非预期”的（没有明显诱因）、情境性的（特定场合触发），也可以是情境易感的。夜间从睡眠中惊醒的惊恐发作也不少见。发作本身不危险，但第一次发作的人常坚信自己“要死了”或“要疯了”，这种体验是真实的，不是矫情。

惊恐障碍：发作之后那一个月的担心

惊恐障碍的关键不只是发作，而是发作之后的变化：持续担心再次发作、担心发作的后果（心脏病、失控、发疯），或者因为发作而明显改变行为（不敢独处、不敢运动、不敢坐地铁、反复查体）。这种担心通常持续一个月左右。【指南】

要把惊恐障碍和“一次惊恐发作”分开。很多人一生中会有一次惊恐发作，但不发展成障碍。只有反复发作，加上持续担忧或行为改变，才更接近惊恐障碍。

惊恐障碍常与广场恐惧共病。判断时要看：害怕的是“发作本身”，还是“发作时逃不掉、没人帮”？前者更像惊恐障碍，后者要考虑广场恐惧。两者可以同时存在。

功能损害很具体：频繁跑急诊、反复做心电图、不敢开车、不敢出差、依赖家人陪同、用酒精压惊。病程上，惊恐障碍常起病于青少年后期到三十多岁，女性更常见，但任何年龄都可能出现。

必须排除的躯体与物质原因

要排除的情况	线索	常做的检查
心律失常	突发心悸、晕厥、有心脏病史	心电图、动态心电图、心脏超声
甲亢	怕热、多汗、体重下降、手抖、腹泻	甲状腺功能
嗜铬细胞瘤	阵发性头痛、大汗、心悸、血压飙升	医生按线索安排儿茶酚胺相关检查
低血糖	饥饿、出汗、手抖、意识模糊，进食后缓解	血糖，必要时进一步检查
物质或药物	咖啡因、能量饮料、酒精戒断、兴奋剂、激素	用药史、尿检
其他精神障碍	抑郁、双相、创伤后应激、强迫、疾病焦虑	纵向病史与精神检查

嗜铬细胞瘤很罕见，但它的“阵发性心悸、头痛、大汗”与惊恐发作极像，医生会在有线索时排查，不必人人都查。相反，有心脏病危险因素的人，第一次剧烈胸痛必须先按心脏急症处理。

就诊清单与常见误区

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录最近一次发作：日期、时间、当时在做什么、从开始到高峰多久、持续多久。
- ☐ 写下发作时的具体身体感觉，尤其是胸痛的性质、有没有放射、有没有晕厥。
- ☐ 记录发作频率：一周几次、一个月几次、有没有夜间发作。
- ☐ 记录担心什么：再次发作、心脏病、失控、发疯，还是别的。
- ☐ 列出因为发作而改变的行为：不敢独处、不敢运动、不敢坐车、反复就医。
- ☐ 记录咖啡、能量饮料、酒精、尼古丁、减肥药、感冒药的用量。
- ☐ 带上既往心电图、甲状腺功能、血糖、动态心电图结果。

☐ 写下家族史和正在服用的所有药物。

常见误区

误区一：惊恐发作会把人吓死。 惊恐发作本身通常不会直接造成死亡，但第一次发作、或有心脏病危险因素时，必须先把心脏问题排除。不要把“年轻、查过心电图”当成永久保险。

误区二：发作时深呼吸就好。 缓慢呼吸对部分人有帮助，但过度深呼吸可能加重头晕、手脚麻。惊恐发作时更重要的是降低刺激、陪着当事人、避免让其独处后驾车，并尽快就医评估。

误区三：广泛性焦虑就是爱操心。 正常操心能停下来，广泛性焦虑的担心难以控制、持续时间长、伴随躯体症状和功能损害。

误区四：不发作就是好了。 惊恐障碍常伴随回避，回避不解决，发作可能被“养”回来。评估要看功能恢复，不只是发作次数。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**首次出现压榨性胸痛、胸痛持续不缓解、放射到手臂或下颌、冷汗、晕厥、严重气短、口唇发紫、心跳极快且伴头晕、意识模糊、单侧无力或说话不清。不要先假定是惊恐发作。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**发作频率明显增加、无法出门、无法工作、出现自杀念头、靠酒精或镇静药应对、停药后出现抽搐或意识混乱。
>
> 有心脏病、高血压、糖尿病、吸烟史或家族史的人，第一次剧烈惊恐应优先急诊排查。

确诊后，医生通常会评估共病、讨论心理治疗（如认知行为治疗）和是否需要药物，并安排随访。治疗目标是恢复功能，而不是追求“永远不焦虑”。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

4.3 社交焦虑、特定恐惧与广场恐惧

有人害怕当众发言，有人害怕电梯，有人害怕去超市排队时突然发作却逃不掉。三种“怕”看起来都是回避，但怕的对象、时间门槛和鉴别方向不同。这一页把社交焦虑、特定恐惧、广场恐惧放在一起比较，也讲回避和安全行为为什么会让问题更牢。

三种“怕”，怕的东西不一样

障碍	怕什么	典型情境	时间与功能
社交焦虑	被审视、被负面评价、出丑	发言、面试、聚餐、打电话	约六个月，常影响学业职业
特定恐惧	某个具体对象或情境	高处、动物、打针、飞行	约六个月，回避明确
广场恐惧	出现症状时逃不掉、得不到帮助	公交、商场、排队、独自离家	约六个月，回避成片

特定恐惧又常分为动物、自然环境、血液-注射-损伤、情境性几类。血液-注射-损伤型有个特点：可能先兴奋、后血压下降，出现头晕甚至晕厥，这与典型惊恐发作不同。

社交焦虑：怕的是被看见、被评价

社交焦虑的核心是“我会被负面评价”。不是单纯不想社交，而是明知别人未必在意，仍然强烈害怕自己说错话、脸红、手抖、声音发抖、被拒绝。表现可以是只害怕表演性场合（发言、考试、当众吃饭），也可以是广泛到几乎所有人际互动。

常见线索：

- 事前反复预演、事后反复回放，挑自己哪句话说得不好。
- 回避眼神、少说话、坐在角落、提前离场。
- 依赖安全行为：背稿、喝酒、带同伴、穿高领遮住脸红、一直看手机。
- 身体反应明显：脸红、出汗、心跳快、手抖、口干、声音发紧。
- 知道害怕过分，却控制不住。

时间门槛通常是六个月左右，且要有明显痛苦或功能损害。儿童可能表现为哭闹、发脾气、黏人、拒绝上学，而不是直接说“我害怕被评价”。

社交焦虑和内向不是一回事。内向是一种偏好：喜欢独处、在小圈子里自在，不觉得痛苦，也不需要回避。社交焦虑是害怕被评价，伴随强烈痛苦和功能损害，往往很想交朋友却不敢。

需要鉴别的还有：广泛性焦虑（担心多件事，不只社交）、惊恐障碍（怕发作而非怕评价）、抑郁（兴趣减退、自我评价低）、孤独症谱系（社交沟通差异不等于怕评价）、回避型人格（更长期、更弥散的模式）、躯体变形障碍（怕外貌缺陷被看见）。【指南】

特定恐惧与广场恐惧

特定恐惧：怕一个具体对象，知道不合理也躲

特定恐惧的恐惧对象相对明确：狗、蛇、血、针、电梯、飞机、雷雨、高处。接触或预期接触时几乎立即出现焦虑，往往主动回避，或者忍着巨大痛苦才能面对。DSM-5-TR 通常要求持续六个月左右。【指南】

特定恐惧的关键是“对象明确、回避明确、功能受影响”。如果害怕的对象其实指向别的东西，比如害怕坐飞机是怕惊恐发作、害怕医院是怕被诊断重病，就要考虑惊恐障碍、广场恐惧或疾病焦虑。

特定恐惧与创伤后应激的区别在于：特定恐惧不一定有创伤史；创伤后应激障碍会有闯入性回忆、噩梦、警觉增高和回避创伤线索。与强迫症的区别在于：强迫的回避是为了减轻强迫思维带来的痛苦，常伴随重复行为。

血液-注射-损伤型要特别提醒：有些人打针、抽血时会出现脸色苍白、出汗、恶心、头晕，甚至晕厥。这不是“矫情”，而是血管迷走反应，处理方式和典型惊恐发作不同。反复晕厥、摔伤风险高的人应尽快就医。

广场恐惧：怕的是“逃不掉、帮不上”

广场恐惧的核心不是“怕空旷”，而是害怕在难以逃离或得不到帮助的场合出现惊恐样症状或失能。常见情境包括：公共交通、开阔场所、封闭场所、人群排队、独自离家。

DSM-5-TR 通常要求涉及至少两类情境、持续约六个月，并造成回避或明显痛苦。【指南】广场恐惧可以伴惊恐障碍，也可以不伴。判断时要看：如果没有惊恐发作，是否仍然害怕这些场合？如果害怕的核心是“发作时没人帮”，更支持广场恐惧。

广场恐惧常被误认为“宅”或“懒得出门”。真正的区别是：想出门但不敢，或者必须有人陪、必须带药、必须规划逃生路线才敢出门。严重时可能长期困在家里，影响工作、社交、就医，甚至基本生活。

需要鉴别：社交焦虑（怕被评价，不是怕逃不掉）、创伤后应激（回避创伤相关线索）、抑郁（动力下降、兴趣减退）、躯体疾病（如未控制的心律失常、前庭病导致不敢出门）、老年痴呆早期（迷路、定向障碍）。老年人突然不愿出门，尤其要排查躯体病、认知下降和抑郁，不要直接归为“焦虑”。

回避与安全行为：为什么“忍着”不等于好转

回避是最直接的短期解决方案，也是最容易让恐惧固化的方式。每次躲开，大脑就学到“幸好没去”，下一次更怕。安全行为更隐蔽：必须带水、带药、带同伴、坐靠门的位置、全程看手机、喝酒壮胆。它们让当事人“撑过去了”，却没有机会学到“即使不靠这些，也不会出事”。

评估时要专门问安全行为，因为很多人不觉得自己在回避——“我还是出门了，只是必须有人陪”。

功能损害也要具体：是否拒绝了晋升、是否退学、是否无法独自就医、是否因为怕打针耽误治疗、是否长期不坐公共交通。回避越广，功能损害越大，也越需要系统治疗，而不是“多出去走走”。

就诊清单与常见误区

就诊前可以准备什么

- ☐ 列出所有害怕的场合，按严重程度排序。
- ☐ 记录每次回避时具体怕发生什么：被笑、晕倒、发作、没人帮、迷路。
- ☐ 记录安全行为：同伴、药物、酒精、靠门座位、手机、提前离场。
- ☐ 写下第一次出现的时间和当时的事件。
- ☐ 记录身体反应和持续时间，有没有晕厥、摔伤。
- ☐ 记录对工作、学业、社交、就医的实际影响。
- ☐ 带上既往躯体检查结果和用药清单。
- ☐ 如果考虑心理治疗，先问清楚当地有没有认知行为治疗资源。

常见误区

误区一：只是害羞，长大就好。 害羞不等于障碍；社交焦虑持续多年、影响学业职业时，需要评估和治疗。

误区二：多参加几次就好了。 无准备的“硬暴露”可能加重挫败感。暴露治疗需要在评估后有步骤地进行。

误区三：特定恐惧不重要。 怕打针可能耽误必要治疗，怕飞行可能影响工作，怕狗可能限制生活范围。是否治疗看功能损害，不看对象“幼不幼稚”。

误区四：广场恐惧就是怕空旷。 核心是怕逃不掉、得不到帮助，不是空间本身。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**惊恐样发作伴压榨性胸痛、晕厥、严重气短、心跳极快且头晕、意识模糊、单侧无力或说话不清；打针或抽血后反复晕厥、摔伤；因不敢出门导致不进食、不饮水、无法服药。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**回避范围不断扩大、无法上学或工作、出现自杀念头、靠酒精应对社交、抑郁症状加重。
>
> 社交焦虑常与抑郁共病。若出现持续情绪低落、无价值感或自伤念头，不要只当作“害羞”。

确诊后，医生通常会评估共病和功能损害，讨论认知行为治疗、暴露练习和是否需要药物。治疗不是“逼你变外向”，而是让你在重要场合有选择。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013.

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

4.4 焦虑的躯体模仿者与物质药物因素

心慌、出汗、手抖、气短，不一定来自焦虑。甲状腺、心脏、血糖、肾上腺、肺，以及一杯接一杯的咖啡、昨晚的酒、正在吃的药，都能做出几乎一样的表现。这一页讲最常见的“模仿者”，以及医生会用什么线索把它们找出来。读完你能更准确地提供病史，但不要自己停药或给自己下结论。

为什么必须先排查躯体原因

焦虑的躯体反应由交感神经和肾上腺系统驱动，而甲亢、心律失常、低血糖、嗜铬细胞瘤恰好也作用在这条通路上。结果就是：症状几乎可以复制，单凭“我感觉很焦虑”无法区分。

有几类线索提示要优先查躯体原因：

- 首次发作在中年以后，或症状突然变重。
- 静息心率持续很快，或发作时血压明显升高。
- 伴体重下降、怕热、多汗、腹泻、手抖。
- 伴晕厥、胸痛、活动后气短。
- 伴发热、意识模糊、局灶神经症状。
- 常规抗焦虑处理后效果差，或症状进行性加重。

这不是说每个焦虑的人都要做全套检查。医生会根据起病年龄、症状组合、体格检查和危险因素选择。

常见躯体模仿者

情况	常被当成	线索与常查
甲亢	广泛性焦虑、惊恐	怕热、多汗、体重下降、手抖、心率快；查甲状腺功能
心律失常	惊恐发作	突发心悸、晕厥、心脏病史；心电图、动态心电图
低血糖	惊恐、焦虑	饥饿、出汗、手抖、意识模糊，进食后缓解；查血糖
嗜铬细胞瘤	惊恐发作	阵发性头痛、大汗、心悸、血压飙升；按线索查儿茶酚胺
哮喘、慢阻肺	过度换气、惊恐	喘息、咳嗽、活动后气短；肺功能、血氧
贫血、电解质紊乱	乏力、心慌、焦虑	面色苍白、乏力、心悸；血常规、电解质

甲亢是门诊最常遇到的“焦虑模仿者”之一。甲状腺激素升高会让心率加快、代谢加快、情绪不稳、失眠、手抖，和广泛性焦虑非常像。抽一管血就能查，没理由漏。

心律失常的表现可以很戏剧化：突然心跳飞快、胸闷、头晕，几分钟或几十分钟后突然停止。静息心电图正常不能排除阵发性问题，医生可能安排动态心电图或事件记录器。对有心悸伴晕厥的人，这一步尤其重要。

低血糖常见于糖尿病患者用药不当、长时间不进食、大量饮酒后。心慌、出汗、手抖、饥饿感、注意力差，严重时意识模糊、抽搐。测血糖很快，别把低血糖当成“又焦虑了”。

嗜铬细胞瘤很罕见，但典型的三联征是阵发性头痛、大汗、心悸，伴血压升高。它不能靠“感觉”排除，医生会在有线索时安排检查。不要因为看了科普就要求做罕见病筛查，也不要因为罕见就完全想不到。

哮喘、慢阻肺、肺栓塞、贫血、电解质紊乱、睡眠呼吸暂停、前庭疾病、颞叶癫痫、更年期潮热，也都可能以“焦虑”为主诉。老年人和孕产妇的鉴别范围更宽，需要结合用药和躯体共病。

咖啡因、酒精、尼古丁与药物

咖啡因、酒精与尼古丁

咖啡因是最容易被忽略的“药物”。咖啡、浓茶、能量饮料、减肥咖啡、部分止痛药和感冒药都含咖啡因。摄入过多会引起心悸、手抖、失眠、坐立不安，甚至惊恐样发作。突然减少时又可能头痛、疲劳、注意力差。

酒精的特点是“先缓解、后反弹”。喝的时候放松，酒精代谢后出现心慌、出汗、焦虑加重，这叫反跳性焦虑；长期大量饮酒的人突然停酒，可能出现手抖、出汗、心跳快、幻觉、抽搐，这是戒断，属于急症。

尼古丁是兴奋剂，吸烟时心率加快、血压升高。戒烟过程中焦虑、易怒、注意力差也常见，但通常随时间缓解。判断时要问清楚时间关系：症状是在使用后出现，还是在停用后出现。

药物与补充剂

很多处方药会让焦虑加重或引起静息性坐立不安：

- 糖皮质激素、部分支气管扩张剂、减充血剂、甲状腺素过量。
- 部分抗抑郁药在开始阶段可引起激活、焦虑、失眠；部分抗精神病药可引起静坐不能，表现为“腿里像有虫”、坐不住，容易被误认为焦虑加重。
- 镇静催眠药、酒精、阿片类突然减量或停用，会出现戒断性焦虑、心悸、失眠，严重时抽搐。
- 兴奋剂、大麻、可卡因、冰毒等可引起心悸、偏执、惊恐。
- 部分减肥药、运动补剂、含麻黄碱或育亨宾的产品。

具体用多少、用多久，与个体差异、肝肾功能、合并用药都有关，必须由医生判断。重点是：**出现新症状时，把最近开始或停用的所有药、保健品、减肥产品都告诉医生**，包括“偶尔吃”的。

什么时候该查、查什么

不是所有焦虑都需要全套检查。医生通常会先做病史和体格检查，再按线索选择：

- 心电图，必要时动态心电图、心脏超声、运动试验。
- 甲状腺功能、血常规、血糖、电解质、肝肾功能。
- 有喘息或咳嗽时查肺功能、血氧。
- 阵发性头痛、大汗、心悸伴血压高时，按线索查儿茶酚胺相关指标。
- 打鼾、白天嗜睡、晨起头痛时考虑睡眠监测。

- 有发热、意识改变、局灶神经症状时，按急诊流程查感染、影像、脑电图等。

检查的目的是排除“需要不同治疗的原因”，不是把焦虑“查没了”。有些检查有假阳性、辐射、费用和焦虑放大效应，医生会权衡。除了躯体病和物质，还要想到其他精神障碍：抑郁、双相、创伤后应激、强迫、疾病焦虑、孤独症谱系和人格特质，都可能以焦虑为主诉。

判断时还要看病程和功能：症状是几周还是几年，持续还是阵发，是否影响工作、睡眠、社交和自理。同样一句“心慌”，持续多年且只在特定情境出现，与突然新发、进行性加重，处理方向不同。功能损害也要具体问，不要只用“还能上班”概括。

就诊清单与常见误区

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录症状与咖啡、酒、烟、能量饮料的时间关系。
- ☐ 列出所有处方药、非处方药、保健品、减肥药，注明开始和停用时间。
- ☐ 记录发作时有没有测过血压、心率、血糖。
- ☐ 写下体重变化、怕热、多汗、手抖、腹泻、心悸等情况。
- ☐ 记录月经情况（如适用）、更年期症状、孕产史。
- ☐ 带上既往心电图、甲状腺功能、血糖、电解质结果。
- ☐ 说明有没有晕厥、胸痛、活动后气短、打鼾、白天嗜睡。
- ☐ 不要自行停用激素、抗抑郁药、抗精神病药或镇静药。

常见误区

误区一：心电图没事，心脏就一定没事。 静息心电图正常不能排除阵发性心律失常，反复心悸伴晕厥需要进一步评估。

误区二：喝咖啡心慌不算病。 咖啡因相关焦虑是真实的，减少摄入后症状常改善；但也要排除同时存在的焦虑障碍和心律失常。

误区三：焦虑药和感冒药可以随便一起吃。 减充血剂、部分止咳药、激素等可能加重心悸和焦虑，合并用药要告诉医生。

误区四：戒酒靠意志，慢慢减就行。 长期大量饮酒突然停酒可能抽搐、出现幻觉，必须由医生评估，必要时住院戒断。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**压榨性胸痛、胸痛持续不缓解、晕厥、严重气短、口唇发紫、心跳极快伴头晕、血压极高伴头痛、意识模糊、抽搐、低血糖后意识不清、哮喘急性发作、酒精或镇静药戒断出现抽搐或幻觉。
>
> **尽快联系医生：**新出现的静息心动过速、体重明显下降、怕热多汗、反复心悸、活动耐量下降、正在用激素或兴奋剂后出现明显焦虑。
>
> 如果症状在用药后出现，带上药盒就诊；不要自行停药，尤其是激素、抗癫痫药、镇静药和抗抑郁药。

确诊焦虑障碍不等于“躯体检查就不用做了”。两者可以并存：一个人可以既有心律失常，也有惊恐障碍。关键是先把需要不同处理的原因找出来，再谈焦虑的诊断和治疗。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

4.5 焦虑诊断的常见误区与量表

GAD-7 分数高，是不是就确诊焦虑症？量表正常，是不是就不用看医生？这一页讲 GAD-7、PDSS、LSAS、SPIN 各自量什么、能做什么、不能做什么，也拆掉几个最常见的误解。适合已经做过量表、或正准备在网上自测的人读。

量表能做什么、不能做什么

量表是标准化的问卷，把一段时间内的症状频率、强度或回避程度变成分数。它的价值在于：

- **筛查**：在门诊或社区快速找出可能需要进一步评估的人。
- **量化严重度**：治疗前后对比，看变化趋势。
- **随访**：复诊时快速回顾，帮助医生调整方案。
- **研究**：让不同研究之间的严重度可比。

它不能做的是：

- **不能确诊**。量表不询问起病时间、功能损害、躯体疾病、物质使用和其他精神障碍。
- **不能替代精神检查**。医生需要看表情、语速、思维内容、自知力，还要追问细节。
- **不能跨量表比较**。GAD-7 的 15 分和 LSAS 的 60 分不是一回事。
- **不能替代个体化判断**。分数要放回年龄、文化、共病和生活处境里解释。

【指南】本页提到的自评量表只用于筛查、严重度评估和随访，诊断必须由有资质的精神科医生作出。

四个常用量表

量表	评什么	常见用法	主要局限
GAD-7	过去两周焦虑症状频率	初级筛查、严重度、随访	不区分焦虑类型，受躯体病影响
PDSS	惊恐障碍症状与回避，过去一周	惊恐严重度、治疗随访	只适用于已考虑惊恐障碍者
LSAS	社交焦虑的恐惧与回避	社交焦虑严重度、疗效评估	条目多，受抑郁和内向影响
SPIN	社交焦虑症状频率与痛苦	快速筛查、随访	不能区分社交焦虑与回避型人格

GAD-7 有 7 个条目，回忆过去两周，按“完全不会”到“几乎每天”四级评分，总分 0–21。常用切点大致是 5、10、15，分别提示轻、中、重度可能，但切点不是诊断线。它敏感于心慌、坐立不安、睡眠差，这些在甲亢、心律失常、抑郁里也会高。【研究】

PDSS 有 7 个条目，评估惊恐障碍的核心症状、回避和担忧，回忆过去一周，总分 0–28。它适合已经考虑惊恐障碍的人做严重度随访，不适合拿来给一个从没被评估过的人“自测”。【研究】

LSAS 有 24 个条目，分别评“害怕/焦虑”和“回避”，每项 0–3 分，总分 0–144。它在社交焦虑的研究和治疗评估中用得多，能区分表演性场合和一般社交场合。缺点是条目多，抑郁、内向、文化背景都会影响分数。【研究】

SPIN 有 17 个条目，按 0–4 评分，总分 0–68，常用切点约 19 分提示可能存在的社交焦虑。它短、好填，适合筛查，但同样不能确诊，也不能替代对功能损害和回避的评估。【研究】

量表分数要这样读：**同一个人、同一个量表、同一段时间，变化才有意义**。今天 GAD-7 是 12 分，不能推断“比隔壁 8 分的人病得更重”，也不能推断“必须吃药”。

六个常见误区

误区一：深呼吸就好。 缓慢呼吸、放松训练对轻度焦虑有帮助，但不能替代评估。惊恐发作时过度深呼吸可能加重头晕、手脚麻；反复发作、明显回避、功能受损的人需要正规治疗。

误区二：量表高分就是确诊。 量表高分只说明“值得进一步评估”。确诊还要看病程、功能损害、排除躯体与物质原因、与其他精神障碍鉴别。

误区三：焦虑症是性格问题，不用治。 焦虑障碍有明确的诊断标准和有效治疗。长期回避会固化恐惧，共病抑郁和物质使用的风险也会上升。

误区四：心悸查不出毛病，就一定是焦虑。 静息心电图正常不能排除阵发性心律失常；甲亢、嗜铬细胞瘤、低血糖也可能被漏掉。医生会根据线索选择检查，而不是一次查完就下结论。

误区五：吃药会成瘾，所以硬扛。 不是所有抗焦虑药都会成瘾，是否用药、用多久、怎么停，由医生根据病情决定。自行突然停用镇静药或抗抑郁药可能引起戒断或症状反弹。

误区六：焦虑症治不好。 多数人经过心理治疗、必要药物和生活方式调整可以明显改善。这里不承诺“治愈”，但“只能一辈子这样”也不符合事实。

一次规范诊断会看什么

如果医生只让你填了一张表就下结论，你有理由问一句“诊断依据是什么”。规范的做法通常包括：

- 详细病史：起病时间、诱因、病程、波动、既往治疗。
- 精神检查：情绪、思维、知觉、认知、自知力。
- 躯体与物质排查：甲状腺、心脏、血糖、用药、咖啡因、酒精。
- 功能损害：工作、学习、社交、家庭、睡眠、医疗使用。
- 鉴别诊断：抑郁、双相、创伤后应激、强迫、疾病焦虑、人格特质、孤独症谱系。
- 风险评估：自杀、自伤、物质使用、驾驶和照护风险。
- 纵向观察：一次门诊信息不足时，允许“待观察”。

这里要特别提醒：量表正常也不等于“没事”。有些人因为回避、羞耻或文化压力，会在问卷上淡化症状；有些人躯体症状突出，量表却只问情绪。量表是补充，不是替代。

就诊清单与急症边界

就诊前可以准备什么

- ☐ 带上做过的量表原始分数和日期，不要只记“阳性”。
- ☐ 写下量表没问到的部分：回避、功能损害、躯体病史、用药。
- ☐ 记录症状从什么时候开始，最重是什么时候。
- ☐ 列出咖啡、酒、能量饮料、尼古丁的用量。
- ☐ 带上甲状腺功能、心电图、血糖等检查结果。
- ☐ 写下家族史和既往治疗反应。
- ☐ 准备问题：“我还需要排除什么？”“量表分数在治疗中怎么用？”
- ☐ 如果考虑第二意见，带上病历和检查资料，不要隐瞒既往诊断。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**压榨性胸痛、晕厥、严重气短、心跳极快伴头晕、意识模糊、抽搐、酒精或镇静药戒断出现幻觉或抽搐、自杀念头伴计划。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**量表分数持续升高、回避范围扩大、无法工作或上学、出现自伤行为、靠酒精或药物应对。
>
> 量表不能判断急症。胸痛不会因为 GAD-7 分数高就变成“只是焦虑”，也不会因为分数低就不是心脏病。

量表是工具，不是判决书。它帮医生看见趋势，帮你说清症状，但诊断仍然要回到面诊、病史、功能损害和排除。你把信息准备得越具体，量表才越有用。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.
- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 2006.
- Connor KM, et al. Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). British Journal of Psychiatry, 2000.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 5：精神分裂症谱系确诊

精神病性症状可能来自精神分裂症，也可能来自双相、抑郁、物质、药物或躯体疾病。确诊需要纵向病程和排除。

5.1 精神分裂症诊断要点

听到“精神分裂症”四个字，很多家庭第一反应是“是不是一辈子完了”。但在医生那里，这个诊断要先过几道关：症状组合、一个月活跃期、六个月总病程、功能损害、排除其他原因。这一页把这些关拆开讲，帮助家属理解医生为什么谨慎，也理解为什么一次门诊常常不够。

三组症状：阳性、阴性、认知

精神分裂症的症状常被分成三组，理解这三组，才能听懂医生说的“阳性症状为主”“阴性症状明显”。

阳性症状是“多出来的体验”，包括幻觉（没有外界刺激却听见、看见）、妄想（与现实不符却坚信不疑）、思维形式障碍（说话跳跃、逻辑接不上）、行为紊乱。阳性症状比较显眼，也更容易被家属发现。

阴性症状是“少掉的功能”，包括情感表达平淡、言语减少、意志减退、兴趣和愉悦感下降、社交退缩。阴性症状常被误认为“懒”“冷漠”“不想好”，其实可能是疾病本身的一部分，也可能来自抑郁、药物副作用或环境刺激不足。

认知症状包括注意力、工作记忆、加工速度、执行功能、言语学习和社交认知的损害。它不如幻觉妄想显眼，却和能不能上学、上班、独立生活关系密切。很多患者出院后“症状没了但回不去”，认知损害是重要原因之一。

症状组	常见表现	容易被误读为
阳性症状	幻觉、妄想、言语紊乱、行为紊乱	装病、故意捣乱、性格怪
阴性症状	情感平淡、言语少、意志减退、社交退缩	懒、冷漠、抑郁、不配合
认知症状	注意力、记忆、执行功能、社交认知下降	笨、不用心、痴呆

三组症状都要在精神检查里评估，不能只问“有没有幻听”。诊断标准里的症状条目是医生访谈和纵向观察的框架，不是让家属拿来逐条打勾的清单。

时间门槛：一个月活跃期与六个月总病程

DSM-5-TR 对精神分裂症的病程有两道时间门槛：

- **活跃期至少一个月**：幻觉、妄想、言语紊乱、明显紊乱或紧张症行为、阴性症状等，需要持续一段显著时间；其中至少一项属于幻觉、妄想或言语紊乱。
- **总病程至少六个月**：包括活跃期，也包括前驱期和残留期。前驱期可能表现为成绩下降、交友减少、说话古怪、多疑、卫生变差；残留期可能只剩阴性症状或认知损害。

为什么要有六个月？因为短暂的精神病性反应并不少见：极度睡眠剥夺、物质中毒、急性应激、躯体疾病都可能引起幻觉或妄想，很多会在数天到数周内缓解。时间门槛是防止把“暂时的反应”误判为终身疾病。

这也是短暂精神病性障碍（一天到一个月）和精神分裂症样障碍（一个月到六个月）存在的意义。它们不是“轻一点的精神分裂症”，而是病程不同、预后不同、处理也可能不同。【指南】

ICD-11 与 DSM-5-TR 在时间门槛和条目细节上不完全一致。ICD-11 通常要求精神病性症状持续至少一个月，但不要求 DSM-5-TR 那样的六个月总病程；DSM-5-TR 则把前驱期和残留期一起算进六个月。医生用哪套标准，要看所在机构和培训背景。两套标准都要求持续的精神病性症状、排除其他原因；功能损害在 DSM-5-TR 中是明确的诊断条件。具体口径以原文和医生访谈为准。

功能损害：不只数症状

诊断精神分裂症，通常还要有工作、学习、人际关系或自我照料方面的明显下降。功能损害不是“有没有上班”这么简单：

- 学业或职业：成绩下滑、频繁请假、无法完成原本能完成的任务。
- 人际：朋友减少、回避社交、与家人冲突增多。
- 自理：个人卫生差、作息混乱、不管理钱财、不按时就医。
- 社会角色：无法承担照顾孩子、赡养老人等责任。

功能损害要与病前水平比较，也要考虑教育机会、文化期待、经济条件。一个本来就很内向的人，不能只用“朋友少”判断；一个高学历的人，也不能只用“还在上班”排除损害。

儿童、青少年、老年人和不同文化背景的人，表现可能不典型。青少年可能先出现成绩下降、易激惹、闭门不出；老年人首次出现精神病性症状，要优先排查躯体疾病、药物和痴呆，而不是直接归为精神分裂症。

四类必须排除的原因与首次发作

四类“看起来像但不是”的情况

第一类：心境障碍伴精神病性症状。 双相躁狂或抑郁发作时可以出现幻觉、妄想。关键看时间关系：精神病性症状是否只在大幅情绪发作期间出现？情绪症状是否占病程的大部分？如果精神病性症状在情绪正常时也持续两周以上，就要考虑分裂情感性障碍。

第二类：物质与药物。 兴奋剂、大麻、酒精戒断、致幻剂、糖皮质激素、多巴胺受体激动剂、抗胆碱能药物等都可引起幻觉、妄想、激越。起病与用药/停药的时间关系、尿检、观察停药后是否缓解，都很重要。

第三类：躯体疾病。 甲状腺功能异常、维生素 B12 缺乏、电解质紊乱、肝性脑病、低氧、脑卒中、脑肿瘤、癫痫、自身免疫性脑炎、谵妄等，都可能表现为精神病性症状。首次发作、年龄偏大、伴发热/头痛/抽搐/意识波动时，必须优先排查。

第四类：其他精神障碍。 孤独症谱系、创伤后应激、强迫症、人格障碍、严重抑郁、听力障碍、文化相关的体验，都可能被误认为精神病。需要看发育史、创伤史、症状是否符合该障碍的特征。

首次发作：医生为什么常写“待观察”

第一次发作时，医生掌握的信息往往不够：不知道会不会复发、会不会出现情绪发作、会不会与物质有关、对治疗反应如何。这时写“精神分裂症样障碍”“待观察”“未分化精神病性障碍”，不是水平差，而是负责。

早期诊断的好处是尽早干预；风险是贴错标签。规范的做法是：先保证安全、处理急性症状、排查躯体与物质原因，同时在随访中不断修正诊断。部分首次发作者最终诊断会改变，尤其是伴明显情绪症状或物质使用的人。【研究】

家属能做的，是记录时间线、保存检查资料、如实提供物质使用和家族史，而不是急着要一个“最终结论”。

就诊清单与常见误区

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录第一次异常的时间：说了什么、做了什么、和以前比哪里变了。
- ☐ 记录症状频率和持续时间：每天都有还是偶尔，持续几周还是几个月。
- ☐ 记录有没有情绪高涨或低落期，各持续多久。
- ☐ 记录物质使用：酒、大麻、冰毒、摇头丸、处方药、保健品。
- ☐ 记录躯体症状：发热、头痛、抽搐、意识波动、体重变化。
- ☐ 带上既往检查：甲状腺、血常规、电解质、影像、脑电图。
- ☐ 记录家族史和既往治疗反应。
- ☐ 记录功能变化：学业、工作、社交、自理、钱财管理。
- ☐ 记录风险：有没有自伤、自杀、伤人言语、命令性幻听。

常见误区

误区一：有幻觉就是精神分裂症。 幻觉可见于双相、抑郁、创伤后应激、物质中毒、癫痫、脑炎、听力障碍和正常人在入睡前的体验。要看持续时间和背景。

误区二：阴性症状就是懒。 意志减退、情感平淡可能是疾病、抑郁、药物副作用或环境剥夺。需要专业评估，不是靠催。

误区三：一次发作就要终身吃药。 是否长期用药、用多久，取决于复发次数、严重度、功能和生活处境。不要自行停药，也不要认定“永远好不了”。

误区四：得了精神分裂症就完了。 结局差异很大。有人一次发作后恢复较好，有人需要长期支持。早期治疗、家庭支持、就业和社交康复都能改善结局。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或 110，或去精神科急诊：**命令性幻听让患者伤害自己或他人、明确的自杀或伤人计划、严重激越、木僵拒食、紧张症表现、意识模糊伴发热、抽搐、高热伴肌肉僵硬。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**首次出现幻觉或妄想、症状突然加重、停药后复发、抑郁加重、出现自伤行为。
>
> 首次精神病性症状伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识时清时浊，先按躯体急症处理，警惕脑炎、感染、谵妄，不要先归因于“精神分裂”。

诊断是起点，不是判决。它帮助医生选择治疗、帮助家庭理解发生了什么，也需要在随访中接受检验。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

5.2 阳性、阴性与认知症状的检查

精神检查不是“聊聊天”，而是有目的地看、听、问。幻觉、妄想、思维形式障碍、情感平淡、意志缺乏、认知损害，各有不同的问法和鉴别点。这一页把这些症状拆开，给出一份可以照着用的提问提纲，也提醒哪些表现容易被误读。适合家属陪诊前阅读，也适合想理解医生记录的人。

幻觉与妄想

幻觉：什么算，什么不算

幻觉是没有相应外界刺激时的真实知觉体验。精神分裂症中最常见的是听幻觉，尤其是听到说话声、评论声、命令声，或“声音把自己的想法说出来”。【指南】

问的时候不要只问“有没有幻听”，可以这样开口：

- “有没有在周围没人时听到声音？是说话、骂人，还是别的？”
- “声音从外面来，还是脑子里？清楚不清楚？”
- “声音在说你什么？有没有让你做什么？”
- “你信它是真的吗？会不会害怕？”

需要区分的情况：

- **入睡前或刚醒时的短暂体验**：很常见，不一定有意义。
- **丧亲后的“听到逝者声音”**：在文化背景中可能属于正常哀伤反应。
- **耳鸣**：多是嗡嗡声、铃声，不是有内容的人声。
- **创伤后的闪回**：更像“重新经历”，不是外部声音。
- **物质或药物所致**：酒精戒断、兴奋剂、大麻、抗胆碱能药物都可引起。
- **听力障碍**：可能被误认为“有人议论我”，需要听力评估。

幻觉的内容、频率、来源、对行为的影响，比“有或没有”更重要。命令性幻听要单独评估风险。

妄想：坚信什么，怎么问

妄想是与现实不符、与文化背景不符、却坚信不疑的想法，不能用当事人的经历和教育背景解释。常见类型包括被害、关系、被控制、夸大、嫉妒、躯体等。

问的时候要具体，不要直接问“你有没有妄想”：

- “最近有没有觉得有人在针对你、监视你、害你？”
- “走在路上，有没有觉得陌生人在议论你、暗示你？”
- “有没有觉得自己的想法被人知道、被人控制，或身体被外力影响？”
- “有没有觉得自己有特殊能力、特殊身份？”
- “家里人有没有发现你最近特别多疑？”

需要区分：

- **超价观念**：情绪强烈、可以理解，但还没到不可动摇的坚信。

- **强迫思维**：知道“这是自己想出来的”，常觉得荒谬、想摆脱。
- **创伤后的警觉**：有过真实被害经历的人，多疑可能有现实基础。
- **文化或宗教信念**：要放在当事人的文化群体里判断。
- **谵妄或痴呆**：妄想常伴注意力、记忆、定向问题。

“内容离奇”不是唯一标准。被害妄想可以内容普通，却坚信到影响行为；夸大妄想也可能听起来合理。关键是信念的固定程度、对解释的反应、与行为的配合。

思维形式障碍：话为什么“接不上”

思维形式障碍看的是“怎么想、怎么说”，不是“说了什么”。常见表现：

- **思维散漫、破裂**：句子之间缺乏可理解的联系，旁人听不懂。
- **答非所问、离题**：问东答西，越说越远。
- **思维贫乏**：话少、内容空。
- **新词**：自创只有自己懂的词。
- **思维中断**：话说到一半突然停住，觉得脑子被抽空。
- **语词杂拌**：词与词堆在一起，语法崩解。

需要区分：失语症（脑血管病）、谵妄（注意力波动）、躁狂（语速快、跳跃但可理解）、焦虑（话多但逻辑在）、低教育或语言差异（表达不清但不是思维障碍）。

记录时最好原话照录，不要只写“思维混乱”。原话能帮助其他医生判断。思维形式障碍的评估也要看病程：偶发的跳跃可能是紧张、疲劳或语言习惯，持续数周、明显影响交流才更有诊断意义。

阴性症状与认知损害

阴性症状：不是“懒”

阴性症状包括情感表达平淡、言语减少、意志减退、兴趣和愉悦感下降、社交退缩。它们最容易被误解，也最难评估。

- **情感平淡**：面部表情少、语调平、眼神接触少。要区分药物引起的帕金森样表现、抑郁的“面具脸”、文化习惯。
- **言语贫乏**：回答简短、内容空。要区分内向、语言差异、听力问题。
- **意志减退**：不做计划、不主动做事。要区分抑郁、环境剥夺、长期住院后的“习得性无助”。
- **快感缺失**：对以前喜欢的事没兴趣。抑郁也会这样。
- **社交退缩**：不愿见人。要区分社交焦虑、孤独症谱系、被害观念导致的回避。

阴性症状与抑郁重叠很多。医生会看：情绪低落是否持续两周以上、有没有自责无价值、睡眠食欲变化、自杀念头；也会看阴性症状是否在情绪正常时仍然存在。

认知损害：最容易被忽略的一组

认知损害包括注意力、工作记忆、加工速度、执行功能、言语学习和社交认知。它不一定被患者主动报告，却直接影响功能：

- 注意力差：聊几句就走神，做事容易被打断。
- 工作记忆差：记不住刚听到的指令。
- 加工速度慢：反应慢，做事耗时。
- 执行功能差：不会规划、不会切换、遇到问题卡住。
- 言语学习差：记不住新信息。
- 社交认知差：误解表情、语气、意图。

认知损害不是“笨”，也不等于痴呆。它需要神经心理测评才能准确评估，临床上常通过简单提问和观察初步判断。抑郁、焦虑、睡眠不足、药物、物质使用也会影响认知，不能一律归因于精神分裂症。

评估任何一组症状，都要同时记录病程和功能：症状持续多久、几乎每天都有还是偶尔、对工作学习社交自理造成什么影响。只写“有幻觉”“情感平淡”，不足以支持诊断，也不足以安排治疗。

精神检查提纲与家属观察

症状	可以怎么问	需要区分
幻觉	周围没人时听到声音吗？说了什么？	入睡前体验、耳鸣、丧亲、物质
妄想	有人针对你、控制你吗？你信到什么程度？	超价观念、强迫、创伤、文化
思维形式	能不能把刚才的想法连起来说？	失语、谵妄、躁狂、语言差异
阴性症状	最近想做的事多吗？开心得起来吗？	抑郁、药物副作用、环境
认知	记性、注意力、做事速度有变化吗？	抑郁、睡眠、物质、痴呆

提问顺序通常从开放到具体：先问“最近怎么样”，再问睡眠、情绪、人际，再问有没有奇怪体验，最后问风险。不要一上来就追问幻觉，容易让当事人防御。

同样一组症状，还要排除三类原因：物质与药物（酒精、大麻、兴奋剂、激素等）、躯体疾病（甲状腺、电解质、癫痫、脑炎、谵妄等）、其他精神障碍（双相、抑郁、创伤后应激、强迫、孤独症谱系等）。精神检查提供症状线索，排除诊断还要靠病史、检查和随访。

家属补充很重要：患者可能不觉得有问题，家属能看到行为变化、社交退缩、卫生变差、说话古怪。但家属的描述不能替代精神检查，也不能只凭“他不肯承认”就断定有病。

家属能观察什么

- ☐ 说话内容是否变得离奇、跳跃、难以理解。
- ☐ 是否自言自语、对空说话、侧耳倾听。
- ☐ 是否坚信被监视、被迫害、被控制。
- ☐ 情绪表达是否明显变平，或突然激动。
- ☐ 是否整天躺着、不洗漱、不吃饭、不管理钱财。

- ☐ 睡眠是否明显减少，伴精力旺盛或行为紊乱。
- ☐ 是否出现自伤、自杀、伤人的言语或行为。
- ☐ 最近有没有用酒、大麻、兴奋剂或新的药物。

常见误区与急症边界

常见误区

误区一：问幻觉会“诱发”幻觉。 规范询问不会制造症状，反而能及时发现风险。

误区二：能说会道就没有思维障碍。 有些患者话很多，但逻辑跳跃、答非所问；要看内容连贯性，不只看语量。

误区三：阴性症状就是性格懒。 意志减退可能是疾病、抑郁或药物副作用，需要评估而不是指责。

误区四：认知损害就是傻了。 认知损害是特定领域的下降，不等同于智力低下或痴呆，也不是不可改善。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或 110，或去精神科急诊：**命令性幻听让患者伤害自己或他人、明确的自杀或伤人计划、严重激越、木僵拒食、紧张症、意识模糊伴发热、抽搐、高热伴肌肉僵硬。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**首次出现幻觉或妄想、症状突然加重、出现新的躯体症状、停药后复发。
>
> 精神病性症状伴发热、头痛、抽搐、意识波动，先排查脑炎、感染、谵妄等躯体急症。

症状检查的目的不是“找证据证明你有病”，而是把体验说清楚、把风险识别出来、把可治疗的原因找出来。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

5.3 分裂情感、短暂精神病性与妄想障碍

同样是幻觉、妄想，有人几周就好了，有人一辈子只有妄想、其他功能保留，有人则同时有严重的心境发作。精神分裂症谱系里，分裂情感性障碍、短暂精神病性障碍、妄想障碍的区分，主要看三件事：心境症状与精神病性症状的时间关系、病程长短、功能保留程度。这一页把这三条线讲清楚。

三条轴线：时间关系、病程长短、功能保留

障碍	精神病性症状	与心境症状的关系	病程与功能
精神分裂症	至少一个月活跃期	心境症状不占主导	总病程六个月以上，功能常受损
分裂情感性障碍	妄想或幻觉持续两周以上	心境发作占病程大部分	功能不定，需排除物质/躯体
短暂精神病性障碍	一天到一个月	可伴情绪波动	完全恢复至病前水平
妄想障碍	以妄想为主，至少一个月	心境症状短暂	功能相对保留，行为不一定怪异

这张表是简化版，不能拿来对号入座。诊断要看完整病程、功能、排除条件，以 DSM-5-TR/ICD-11 原文和医生访谈为准。【指南】

分裂情感性障碍：不是“精神分裂加抑郁”这么简单

分裂情感性障碍的核心是“心境发作”和“精神病性症状”同时存在，而且时间关系有严格要求：

- 在疾病全程中，有一段至少两周的妄想或幻觉，但当时没有明显的心境发作。
- 心境发作（抑郁或躁狂）在疾病的活动期和残留期里占大部分时间。
- 不能用物质、药物或躯体疾病解释。

换句话说，不是“有抑郁又有幻听”就够，而是要看精神病性症状是否在情绪正常时也独立存在，以及心境症状是否占了病程的大头。若精神病性症状只出现在心境发作期间，更可能是心境障碍伴精神病性特征。

分裂情感性障碍又分双相型和抑郁型。双相型有躁狂或混合发作，抑郁型只有重性抑郁发作。两型的治疗和预后不同，诊断时要写清楚。

需要排除：物质所致精神病性障碍、躯体疾病所致、精神分裂症、双相或抑郁伴精神病性特征。功能损害和病程也要记录，不能只写症状。临床上，分裂情感性障碍常在随访多年后才被确认，早期信息不足时医生会更谨慎。

短暂精神病性障碍与妄想障碍

短暂精神病性障碍：来得快，去得也快

短暂精神病性障碍的病程通常从一天到一个月，之后完全恢复到病前水平。症状可以是幻觉、妄想、言语紊乱、行为紊乱，常伴情绪波动或困惑。起病可能与重大应激有关，也可能没有明显诱因。

关键点：

- 病程短，一个月内缓解。
- 缓解后功能回到基线，不是“勉强能过”。
- 要排除物质、药物、躯体疾病和心境障碍。
- 复发风险存在，需要随访，不能因为“好了”就不管。

短暂精神病性障碍最容易和“急性应激反应”“物质中毒”“癫痫”“脑炎”混淆。首次发作、伴意识波动或躯体症状时，先排查躯体原因。

妄想障碍：只有妄想，其他相对保留

妄想障碍以持续一个月以上的妄想为核心，其他方面相对保留：

- 妄想内容通常不荒诞，可能涉及被害、嫉妒、躯体、夸大。
- 行为不一定明显怪异，工作、生活可能维持得不错。
- 心境症状短暂，不明显占主导。
- 功能损害常集中在妄想相关领域，而不是全面崩解。

妄想障碍容易被漏诊，因为患者不一定主动说，家属也可能觉得“就是多疑”。需要与以下情况区分：

- **偏执型人格**：长期多疑，但没有固定的妄想系统。
- **强迫症**：有闯入性想法，但知道不合理，常想摆脱。
- **躯体变形障碍**：聚焦外貌缺陷，可能有重复检查。
- **创伤后应激**：多疑与创伤经历相关。
- **物质或躯体疾病**：兴奋剂、酒精、甲亢、维生素 B12 缺乏、痴呆等。
- **文化或宗教信念**：要放在群体背景里判断。

妄想障碍的功能保留程度是重要线索，但不是“看起来正常就没病”。有的患者只在特定关系里出问题，其他场合完全正常。

功能保留与三类必须排除的原因

同样有妄想，功能状态差别很大：

- 短暂精神病性障碍：发作期功能明显下降，缓解后回到基线。
- 妄想障碍：功能相对保留，尤其在妄想主题之外。
- 精神分裂症：功能损害常较广泛，涉及工作、社交、自理。
- 分裂情感性障碍：功能随心境和精神病性症状波动。

功能评估要具体：能不能工作、能不能自理、能不能维持关系、能不能管理钱财、有没有需要监护。不要只用“还能上班”或“已经不上班”一句带过。病程也要写清楚：几周、几个月、几年，间歇还是持续，这对区分四种障碍至关重要。

第一类：心境障碍。 双相躁狂或抑郁伴精神病性特征，精神病性症状通常只出现在心境发作期间。若情绪正常时仍有独立的精神病性症状，要重新考虑分裂情感性障碍或精神分裂症。

第二类：物质与药物。 兴奋剂、大麻、酒精戒断、致幻剂、激素、多巴胺受体激动剂等都可引起精神病性症状。时间关系、尿检、停药观察很关键。

第三类：躯体疾病。 甲状腺功能异常、维生素 B12 缺乏、电解质紊乱、肝性脑病、脑卒中、脑肿瘤、癫痫、自身免疫性脑炎、谵妄等。首次发作、年龄偏大、伴发热/头痛/抽搐/意识波动时优先排查。

此外还要考虑孤独症谱系、创伤后应激、强迫症、人格障碍、听力障碍和文化相关体验。诊断不是“症状像不像”，而是“病程、功能、排除”三条线一起看。

就诊清单与常见误区

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录精神病性症状从什么时候开始，持续多久。
- ☐ 记录情绪高涨或低落期，各持续多久，和精神病性症状谁先谁后。
- ☐ 记录情绪正常时是否仍有幻觉或妄想。
- ☐ 记录功能变化：工作、社交、自理、钱财管理。
- ☐ 记录物质使用和所有药物、保健品。
- ☐ 记录躯体症状：发热、头痛、抽搐、意识波动、体重变化。
- ☐ 带上既往检查和精神科病历。
- ☐ 记录家族史和既往治疗反应。

常见误区

误区一：有妄想就是精神分裂症。 妄想可见于心境障碍、物质所致、躯体疾病、妄想障碍、痴呆等。要看时间关系和病程。

误区二：短暂发作不用管。 短暂精神病性障碍可能复发，也可能最初就是其他疾病的早期表现，需要随访。

误区三：分裂情感就是“两个病加在一起”。 它是一个独立的诊断类别，核心是心境症状与精神病性症状的时间关系，不是简单相加。

误区四：能上班就不是精神病。 功能保留是相对的，妄想障碍患者可能工作正常，但在特定关系或情境中严重受损。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或 110，或去精神科急诊：**命令性幻听、明确的自杀或伤人计划、严重激越、木僵拒食、紧张症、意识模糊伴发热、抽搐、高热伴肌肉僵硬。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**首次出现精神病性症状、症状突然加重、停药后复发、情绪症状加重。
>
> 首次精神病性症状伴发热、头痛、抽搐、意识波动，先按躯体急症处理，警惕脑炎、感染、谵妄。

诊断名称会随病程修正，尤其是前六个月。不要因为一次“短暂精神病性障碍”的诊断就放松随访，也不要因为“分裂情感”四个字就认定终身。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

5.4 精神病性症状的鉴别诊断

幻觉、妄想、行为紊乱，不等于精神分裂症。双相、抑郁、物质、药物、甲状腺、脑炎、谵妄，都可能做出同样的表现。鉴别诊断不是“多查几项”，而是沿着时间、物质、躯体三条线，找出最可能的原因。这一页讲医生通常怎么排，以及哪些情况不能等。

先问三个问题

面对一位刚出现精神病性症状的人，医生通常会先问：

1. **什么时候开始、怎么发展？** 突然几小时、几天，还是几周、几个月？有没有前驱期？有没有波动？
2. **有没有物质或药物？** 酒、大麻、冰毒、致幻剂、处方药、激素、减肥药、保健品，最近有没有加量或停药？
3. **有没有躯体线索？** 发热、头痛、抽搐、意识波动、体重下降、心悸、乏力、尿便异常、近期感染？

这三个问题能快速把方向分开：突然起病伴意识波动，先想谵妄、感染、物质；亚急性起病伴情绪高涨，先想双相；慢性起病伴阴性症状，才更像精神分裂症。

同时要记录病程和功能：症状持续多久、是否几乎每天存在、能否工作学习、能否自理、和家人关系如何。没有病程和功能，只凭一次访谈的“幻觉+妄想”，很容易把短暂反应、物质中毒或心境发作误当精神分裂症。

三类常见来源：心境、物质、器质

心境障碍伴精神病性症状

双相躁狂或抑郁发作时可以出现幻觉、妄想。判断的关键是时间关系：

- 精神病性症状是否只在大幅情绪发作期间出现？
- 情绪症状是否占病程的大部分？
- 情绪正常时，精神病性症状是否完全消失？

如果精神病性症状只在心境发作时出现，更可能是心境障碍伴精神病性特征。若情绪正常时仍有至少两周的独立精神病性症状，且心境发作占病程大部分，要考虑分裂情感性障碍。

躁狂伴精神病性特征常表现为夸大、被害、被控制，语速快、睡眠需求少、行为冲动。抑郁伴精神病性特征常表现为罪恶、贫穷、躯体疾病相关的妄想，伴严重抑郁和自杀风险。两类都需要尽快精神科评估。

物质与药物

这是最容易被漏掉、也最容易纠正的一类。常见包括：

- 兴奋剂：冰毒、可卡因、部分减肥药。
- 大麻、致幻剂、氯胺酮。

- 酒精：急性中毒、戒断性幻觉、酒精性精神病。
- 镇静催眠药戒断。
- 糖皮质激素、多巴胺受体激动剂、抗胆碱能药物、部分抗癫痫药。
- 过量使用甲状腺素、减充血剂、部分感冒药。

判断要看时间关系：症状是否在用药后出现、停药后缓解、再次使用后复发。尿检、血药浓度、停药观察都有帮助。但“查出物质”不等于“精神病性症状全是物质所致”，两者可以共病。

器质性原因

躯体疾病所致精神病性障碍常被误认为“原发性精神病”。需要想到：

- 内分泌与代谢：甲状腺功能异常、甲状旁腺异常、电解质紊乱、低血糖、肝性脑病、尿毒症。
- 营养：维生素 B12 缺乏、烟酸缺乏。
- 感染与免疫：梅毒、HIV、自身免疫性脑炎、系统性红斑狼疮。
- 神经系统：脑卒中、脑肿瘤、癫痫、多发性硬化、痴呆、谵妄。
- 缺氧、睡眠严重剥夺、术后状态。

线索包括：年龄偏大首次发作、急性或波动性起病、伴意识改变、发热、头痛、抽搐、局灶神经体征、认知下降、体重下降、既往躯体病史。医生会根据线索安排血液、影像、脑电图、腰穿等检查。

原因	线索	首查方向
物质/药物	用药或停药时间关系、尿检	毒物筛查、用药核对
心境障碍	情绪发作与精神病性症状同步	纵向病史、精神检查
器质性疾病	发热、头痛、抽搐、意识波动	血检、影像、脑电图
自身免疫性脑炎	年轻、癫痫、运动异常、意识下降	脑脊液、MRI、抗体

两个不能漏的急症

自身免疫性脑炎：容易被当成“精神分裂”的急症

自身免疫性脑炎，尤其是抗 NMDAR 脑炎，常以精神症状起病：焦虑、失眠、易激惹、幻觉、妄想、言语紊乱、行为异常。之后可能出现癫痫、口面部不自主运动、自主神经不稳定、意识下降、记忆和语言障碍。

它不常见，但漏诊代价大。以下线索要提高警惕（并非只见于年轻女性，儿童和男性也可发病）：

- 年轻患者，女性更常见，急性或亚急性起病。
- 前驱期有发热、头痛、乏力。
- 精神症状后出现癫痫、运动异常、意识波动。
- 记忆、语言、定向明显下降。
- 常规抗精神病治疗效果差，或出现不明原因发热、心动过速、血压波动。

诊断需要脑脊液、脑电图、头颅 MRI 和自身抗体检测，由神经科/精神科共同判断。不是每个精神病性患者都要查自身抗体，但“精神症状 + 癫痫/运动异常/意识下降”不能只当精神分裂症。

谵妄：注意力波动是关键

谵妄是急性、波动性的注意力障碍和意识改变，常伴幻觉（多为视幻觉）、错觉、定向障碍、睡眠紊乱、行为紊乱。它起病快，白天晚上波动，注意力难以维持。

高危人群：老年人、住院患者、术后、感染、疼痛、脱水、电解质紊乱、多重用药、酒精或镇静药戒断。

谵妄是急症，不是“精神分裂症加重”。处理要找到并纠正病因，而不是只加抗精神病药。家属常能提供关键信息：昨天还好好的，今天突然不认识人、看到虫子和人影、夜里特别乱。

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录症状从什么时候开始，几小时、几天还是几个月。
- ☐ 记录症状有没有波动，白天晚上是否不同。
- ☐ 记录发热、头痛、抽搐、意识模糊、走路不稳。
- ☐ 列出所有药物、保健品、减肥药，注明开始和停用时间。
- ☐ 记录酒、大麻、冰毒、致幻剂等使用情况。
- ☐ 带上既往甲状腺、血常规、电解质、影像、脑电图结果。
- ☐ 记录情绪发作史和家族史。
- ☐ 记录近期感染、手术、旅行、动物接触。
- ☐ 记录功能变化：工作、学习、自理、钱财管理。

常见误区与急症边界

常见误区

误区一：幻觉就是精神分裂症。 幻觉可见于心境障碍、物质、谵妄、癫痫、脑炎、听力障碍和正常入睡前体验。

误区二：年轻人不会得脑炎。 自身免疫性脑炎恰恰多见于年轻人，且常以精神症状起病。

误区三：查出物质就完事了。 物质使用和精神障碍可以共存，需要分别评估，不能用一个解释盖住全部。

误区四：谵妄是“疯了”。 谵妄是躯体急症，处理病因是第一位。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**首次精神病性症状伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识模糊或波动、颈项强直、局灶无力、说话不清；高热伴肌肉僵硬、大汗、意识改变；木僵拒食；明确的自杀或伤人计划。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**首次出现幻觉或妄想、症状快速加重、停药后复发、抑郁加重。
>
> 不要因为“以前诊断过精神分裂症”就把新出现的发热、抽搐、意识变化归为“老毛病”。

鉴别诊断不是为了否定患者的体验，而是为了找到可治疗的原因。有些原因纠正后症状会明显改善，有些需要长期治疗；方向不同，结果可能完全不同。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

5.5 精神分裂症诊断的常见误区与量表

PANSS 分数高，是不是就确诊精神分裂症？“人格分裂”和“精神分裂”是不是一回事？一次发作是不是意味着终身服药？这一页讲 PANSS、BPRS 的用途和局限，也拆掉几个最常见、最伤人的误解。适合刚拿到诊断的家庭，也适合想和医生讨论诊断依据的人。

PANSS 与 BPRS：量的是严重度，不是诊断

PANSS（阳性与阴性症状量表）有 30 个条目，分为阳性症状、阴性症状和一般精神病理三个分量表，每项 1－7 分，总分 30－210。它由受过训练的专业人员访谈评分，常用于临床研究和严重度随访。它能把“幻觉多严重”“情感平淡多明显”变成可比较的数字，但它不负责回答“是不是精神分裂症”。【研究】

BPRS（简明精神病评定量表）条目更少，通常 18 项，也有扩展版本，评的是精神病性症状的严重度，适合快速评估和疗效随访。它同样不是诊断工具。

量表	结构与评分	主要用途	主要局限
PANSS	30 项，阳性 7、阴性 7、一般 16，1－7 分	严重度、研究、疗效随访	耗时、需培训、不负责诊断
BPRS	常为 18 项，1－7 分，也有扩展版	快速严重度评估、疗效随访	覆盖较粗、不涵盖功能与病程

两者的共同局限：

- **依赖评分者**：不同医生、不同培训，分数可能有差异。
- **不涵盖病程**：不能告诉你症状持续了多久、是不是六个月。
- **不涵盖功能**：不能替代对工作、社交、自理的评估。
- **不负责鉴别**：不能区分精神分裂症、双相、物质所致、脑炎。
- **文化与社会背景**：语速、情绪表达、宗教体验会影响评分。

量表是“体温计”，不是“诊断书”。它能提示严重度，不能单独下结论。【指南】

量表不能替代的四件事

1. **时间**：一个月活跃期、六个月总病程，量表问不出来。
2. **功能**：能不能上学、上班、自理、维持关系，量表只覆盖一部分。
3. **鉴别**：物质、药物、躯体疾病、心境障碍，必须靠病史和检查。
4. **纵向变化**：诊断会随病程修正，量表只是某一个时间点的切片。

这也是为什么医生不会只凭 PANSS 分数下诊断。一个 PANSS 分数很高的患者，可能是双相躁狂、物质中毒或脑炎；一个分数不高的患者，也可能因为阴性症状和认知损害而功能严重受损。分数必须放回病史、病程、功能和排除条件里解释。

鉴别时至少要想到三类原因：心境障碍（双相、抑郁伴精神病性特征）、物质与药物、躯体疾病（甲状腺、电解质、癫痫、脑炎、谵妄等）。量表对这三类原因没有分辨能力。

六个常见误区

误区一：“疯了”就是精神分裂症。 “疯了”是日常说法，不是诊断。精神病性症状可见于双相、抑郁、物质中毒、谵妄、脑炎等。把患者叫“疯子”既不准，也会加重污名和病耻感。

误区二：精神分裂症就是“人格分裂”。 精神分裂症不是“一个人变成几个人”。解离性身份障碍（旧称多重人格）是另一种障碍，核心是身份状态的断裂和记忆空白。两者不是一回事，混用会让患者被误解。

误区三：一次发作就要终身吃药。 是否长期用药取决于复发次数、严重度、功能、副作用和生活处境。有人需要长期维持，有人在医生评估后可以调整。不要自行停药，也不要认定“永远好不了”。

误区四：吃药会把人吃傻。 部分药物会引起嗜睡、反应慢、体重增加、静坐不能，这些需要和医生讨论调整，但不是“越吃越傻”。不治疗导致的反复发作、认知损害和社会功能下降，代价往往更大。

误区五：阴性症状就是懒、性格问题。 意志减退、情感平淡可能是疾病、抑郁、药物副作用或环境剥夺。指责会加重病耻感，也会耽误评估。

误区六：问幻觉会诱发幻觉。 规范询问不会制造症状。相反，不问可能漏掉命令性幻听和自伤风险。

诊断不是判决：结局差异很大

精神分裂症的结局异质性很大。有人经过治疗恢复较好，能工作、能建立关系；有人需要长期支持，反复发作，功能受损。影响结局的因素包括起病年龄、未治疗时间、症状类型、认知损害、家庭支持、物质使用、治疗依从性。

“一次发作不能定终身”有两层意思：一是诊断本身可能随病程修正，尤其是前六个月；二是功能结局不是确诊那一刻就写死的。早期治疗、心理社会康复、家庭支持、就业支持都能改善结局。【研究】

但也不要把康复写成“都能好”。有些患者需要长期照护，有些会有残留症状。诚实地说“差异很大、需要长期随访”，比承诺“治愈”更有用。

怎么和医生讨论诊断

如果你对诊断有疑问，可以直接问，不必对抗：

- “这个诊断主要依据哪些症状和病程？”
- “有没有排除物质、躯体疾病和心境障碍？”
- “目前是确定诊断，还是需要观察？”
- “什么情况下诊断会改变？”
- “功能损害主要体现在哪些方面？”
- “下一步治疗目标是什么？”

第二意见是合理需求。带上病历、检查、用药清单，如实说明既往治疗，不要因为想“推翻诊断”而隐瞒信息。诊断讨论的目标不是赢，而是把信息补齐。

就诊清单与急症边界

就诊前可以准备什么

- ☐ 记录症状开始时间、持续时间、波动情况。
- ☐ 记录幻觉、妄想的具体内容和对行为的影响。
- ☐ 记录情绪发作史：有没有持续几天到几周的高涨或低落。
- ☐ 记录物质使用和所有药物。
- ☐ 记录功能变化：学业、工作、社交、自理、钱财。
- ☐ 记录家族史和既往治疗反应。
- ☐ 带上 PANSS/BPRS 等量表分数和日期（如有）。
- ☐ 写下最想问医生的三个问题。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **立即拨打 120 或 110，或去精神科急诊：**命令性幻听让患者伤害自己或他人、明确的自杀或伤人计划、严重激越、木僵拒食、紧张症、意识模糊伴发热、抽搐、高热伴肌肉僵硬。
>
> **尽快联系精神科或拨打 12356：**首次出现幻觉或妄想、症状突然加重、停药后复发、抑郁加重、出现自伤行为。
>
> 精神分裂症患者的自杀风险高于一般人群，尤其在起病早期、抑郁共病、出院后一段时间。不要因为“他只是说说”而忽略。

诊断标签会影响自我认同、家庭关系、工作和保险。它应该被谨慎使用，也应该被允许讨论和修正。量表、医生、家属和患者本人，都是这个过程中的参与者，但最终诊断要由有资质的精神科医生作出。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.
- Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 1987.
- Overall JE, Gorham DR. The Brief Psychiatric Rating Scale. Psychological Reports, 1962.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 6：强迫及相关障碍确诊

强迫症不是“爱干净、追求完美”，而是有闯入性想法和重复行为，耗时且痛苦。

6.1 强迫症诊断要点

这一页讲强迫症（英文缩写 OCD）确诊时，医生到底在看什么。它适合反复检查、反复清洗、被某个念头长期缠住的人，也适合想理解“为什么医生说得这么谨慎”的家属。读完你会分得清强迫思维和强迫行为，知道“耗时与功能损害”为什么比“症状像不像”更决定诊断，也会明白医生为什么一定要先排除别的可能。

一、强迫思维与强迫行为：先分清两个词

强迫思维：反复冒出来、不受欢迎的想法、画面或冲动。它的关键词是“闯入”——不是你去想的，是它自己跳出来的。常见内容有：怕污染、怕自己伤害别人、怕做错事、怕说错话、与性有关的念头、与宗教或道德有关的念头、对“对齐、对称、刚好”的强烈要求、反复怀疑“我到底关没关”。

真正折磨人的不是念头本身，而是念头带来的那种“不对劲、必须解决”的感觉。几乎所有人都偶尔会有奇怪的闯入性想法，区别在于：大多数人耸耸肩就过去了，而强迫症的人会把它当成“必须处理的警报”。

强迫行为：为了压住焦虑、或为了“防止坏事发生”而重复做的动作或心理活动。

- **外显行为**：洗手、消毒、检查门锁和燃气、反复数数、按固定顺序摆放、反复确认、反复求保证。
- **内隐行为**：在心里默念某句话、反复回放刚才的场景、在心里“抵消”一个坏念头、反复祈祷、反复自我确认“我没有做那件事”。

关键不在于动作本身，而在于**想法和行为之间的功能联系**：做了之后焦虑短暂下降，过一会儿又反弹，于是下次更要做。这个“缓解—反弹”循环，是强迫症最典型的现象，也解释了它为什么越演越烈。

和“习惯”的区别：习惯不做也不难受；仪式带有“必须”“否则就会……”的强迫感，不做会明显焦虑。

二、三条现实标尺：耗时、痛苦、功能损害

症状可以列很长，但诊断的门槛落在“影响生活”上。【指南】

- **时间**：临床上常参考“每天花在这些想法和行为上大约一小时以上”。这是一个参考线，不是唯一开关：有人半小时但完全无法工作，也有人两小时但勉强维持。
- **痛苦**：本人主观上有多难受、多羞耻、多害怕。
- **功能**：工作效率、学习成绩、人际交往、睡眠、出门、就医、花钱（反复购买清洁用品、反复换手机），以及家人被迫配合仪式的程度。

- **回避**：这是最容易被漏掉的一条。因为怕触发，有人不做饭、不抱孩子、不去医院、不坐公共交通、不参加考试。回避越多，损害往往越重。

问功能损害要问得很具体：这周因为反复检查迟到过几次？手洗到破皮、裂口、流血了吗？家人是否要帮你重复确认？这些细节比“你强迫吗”有用得多。

三、自知力与病程：两个常被忽略的维度

自知力是一条连续的线，不是开关

诊断里会写“自知力”，指的是：你多大程度上认为自己的担心是过头的。【指南】

自知力水平	大致表现	沟通上的意义
良好	明确知道“这不合理”，但仍控制不住	通常较能配合结构化治疗
较差	大部分时候觉得“万一真出事呢”	需要更多解释与逐步练习
缺乏 / 近乎妄想	坚信不疑，别人劝不动	需与妄想性障碍等仔细鉴别

三件事要说清楚：

1. **自知力差不等于“不是强迫症”**，它只是严重度的一个维度。
2. **自知力差不等于“精神病”**。这个词在日常语境里被用坏了，医学上指与现实脱节的精神病性症状，不能混用。
3. **自知力会波动**。睡不好、压力大、情绪低落时，人会突然变得“很信自己的担心”，这不是装，也不是变严重了不可逆。

反过来说，“我知道不合理”也不能用来安慰自己“所以我不严重”——很多人正是带着完整的自知力，每天耗掉几个小时。

病程：多数是慢性、波动性的

强迫症在诊断上没有一个像“抑郁两周”“惊恐一个月”那样统一的硬性时间门槛，医生更看的是：症状是否**持续存在或反复发作**、是否已经**占据生活**、是不是**最近才突然出现**。【指南】

- **起病年龄**：有两个高峰，一个是儿童期，一个是青春期到成年早期。男孩偏早、女孩偏晚的说法在不同研究里数字不一致，只能当参考。儿童期起病常与抽动一起出现。
- **波动**：压力、睡眠不足、生病、考试、换工作、怀孕和产后，都可能让症状加重。
- **突然起病要警惕**：如果症状在几周内从无到极重，尤其伴随发热、抽搐、意识变化、行为紊乱，要先想躯体原因，而不是急着贴标签。【临床经验】

产后有一种常见又极难开口的表现：反复出现“我会不会伤害宝宝”的念头。这类念头在强迫症里很典型，本人往往极度恐惧、拼命回避，却从不敢说。要把它和产后精神病区分开——后者可能出现坚信婴儿被替换、听到指令性声音、意识混乱，属于急症。

四、必须先排除的三类情况

“像强迫”不等于“是强迫症”。下面三类是医生常规要过一遍的。还要提醒一句：强迫型人格特质（过度追求秩序、完美、控制）和强迫症不是一回事。前者通常觉得“这样挺好”，后者是被迫、痛苦、想摆脱。

类别	可能长得像的地方	医生通常会做什么
躯体与神经系统	抽动障碍的动作像仪式；颞叶癫痫可有重复行为；链球菌感染后突然出现的强迫样症状仍存争议	追问动作能否短暂忍住、有无意识改变、起病是否突然，必要时转神经科
物质与药物	兴奋剂、咖啡因过量、酒精或镇静药变化后焦虑加重，继发反复检查	核对用药清单、饮酒与咖啡因、停药时间线，必要时化验
其他精神障碍	焦虑症的担忧、躯体变形障碍的反复照镜、囤积、拔毛、抠皮、孤独症谱系的重复行为、精神分裂症的妄想、抑郁的反刍	看“想法是不是闯入的”“行为是不是为了消减焦虑”，并看起病顺序

五、就诊准备、常见误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 用一周时间，记下反复出现的念头（写关键词即可，不用美化）
- ☐ 记下念头出现后你做了什么、做完多久好转、多久又回来
- ☐ 粗估每天花多少时间（分成几段算，比硬猜准）
- ☐ 列出你因为怕触发而回避掉的事
- ☐ 记录身体代价：皮肤破损、脱发、失眠、请假、迟到、额外花费
- ☐ 列出正在吃的药、保健品、咖啡、酒、尼古丁
- ☐ 家族里有没有强迫、抽动、焦虑、抑郁的人
- ☐ 如果涉及“怕伤害别人或孩子”的念头，先写在纸上，就诊时直接递给医生
- ☐ 儿童就诊：带上家长和老师的观察，注明起病时间、是否伴随抽动或成绩骤降

常见误区

- **“强迫症就是爱干净。”** 只有一部分人是清洗型。还有检查型、对称型、伤害念头型、宗教道德型、纯粹内隐仪式型。
- **“想得多就是强迫。”** 不是。关键看念头是否闯入、是否引起强烈抵抗与痛苦、是否有仪式去中和它。
- **“我知道不合理，所以我不算。”** 自知力是连续谱，且会随状态波动。
- **“症状越多越严重。”** 严重度主要看耗时、痛苦和功能损害，不是数条目。
- **“这是性格问题，改改就好了。”** 强迫症是有神经生物学基础的障碍，靠“意志力”通常越压越重。【研究】

什么时候需要联系医生或去急诊

> **不要等的情况：**

- 出现伤害自己或他人的念头，并且已经做了准备动作、或已经实施——立即拨打 120（必要时 110），或去最近医院急诊，不要独处。
- 产后出现伤害婴儿的念头，同时伴有坚信婴儿被替换、听到声音、意识时清时浊——按急症处理，立即急诊。
- 清洗到皮肤大面积破损、感染、无法进食或无法出门——尽快联系精神科，不要硬扛。
- 强迫症状突然出现，并伴发热、剧烈头痛、抽搐、意识不清——先按躯体急症走急诊。
- 因为仪式导致连续多日严重缺睡、脱水、无法工作或无法照顾孩子——尽快就诊，必要时住院评估。
- 服药后出现明显坐不住、冲动、情绪失控——联系开药医生，不要自行停药。

确诊之后，下一步通常是评估严重度、共病和风险，再讨论心理治疗（如暴露与反应阻止）与药物治疗的先后或组合。具体方案由面诊医生决定，本页不涉及用药细节。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment（CG31）, 2005（2020 更新）.
- NIMH. Obsessive-Compulsive Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

6.2 强迫思维与反刍、担忧、侵入性想法

“我脑子里一直在想一件事，这算强迫吗？”这是门诊里最常见的问题之一。同样是一个念头在心里打转，可能是强迫思维，可能是抑郁式的反刍，可能是焦虑式的担忧，也可能只是人人都有的普通闯入性想法。这一页把这四种情况分开讲，帮你和医生把“到底是什么在转”说清楚，也解释为什么“求保证”和“想法等于做了”的信念会把问题越滚越大。

一、四种“想个不停”的对照

先看一张对照表。它只用来帮你描述体验，不用来自我判定。

类型	典型样子	你对它的感觉	想完之后
强迫思维	突然冒出“我是不是刚撞了人”“孩子会不会被我伤害”	不请自来、荒谬、吓人、与我的价值观相反	必须做点什么才能安心，否则坐立不安
反刍	反复琢磨“我为什么会这样”“我是不是个失败者”	像自己在思考，但越想越沉、越没答案	情绪更低、更累，没有真正的结束点
担忧	反复推演“明天汇报会不会搞砸”“家人晚归是不是出事了”	觉得这是“必要的准备”，是在负责任	暂时觉得想到了对策，很快又担心下一个
普通闯入性想法	一闪而过的怪念头、画面、冲动	一愣、有点别扭，随即淡出	不处理，几分钟就过去了

强迫思维的核心不是“内容可怕”，而是三件事同时出现：它是闯入的（不是主动想的）、它和你珍视的东西正好相反（所以格外吓人）、它带着一种“必须解决”的紧迫感。

反刍的核心是“为什么”和“我这个人怎么样”，它跟情绪低落绑得很紧。反刍的人常常觉得“我是在分析问题”，但实际上分析不产生结论，只产生更多分析。它是抑郁和焦虑的维持因素之一。【研究】

担忧的核心是“接下来会怎样”。广泛性焦虑的人担忧的内容多是现实议题：钱、健康、工作、家人安全。他们通常不觉得这念头荒谬，反而觉得“不想才是不负责”。

普通闯入性想法极为普遍。研究发现，绝大多数人偶尔都会有伤害、性、亵渎类的怪念头，只是不当回事。这一点很重要：**有怪念头不代表你有问题，也不代表人品有问题。**

二、区分的维度与“求保证”的循环

医生用来区分的几个维度

医生不会让你“对号入座”，而是沿着几个维度问：

1. **它是闯进来的，还是你主动开始想的？** 强迫思维几乎总是“突然袭击”。反刍往往有起点（比如躺在床上开始复盘）。
2. **它和你的价值观是什么关系？** 强迫思维常是“反向的”：越爱孩子的人越怕伤害孩子，越看重道德的人越被亵渎念头折磨。反刍和担忧则通常与自我形象、现实处境一致。

3. **有没有“中和”的动作？** 强迫思维后面往往跟着仪式：默念、检查、洗手、求保证、心里“抵消”。反刍后面跟着的是继续想；担忧后面跟着的是查资料、做准备。
4. **它什么时候来？** 反刍在情绪低落、夜里、独处时明显加重；强迫思维可以被具体触发物点燃（门锁、刀具、公共厕所、新闻）。
5. **结束方式是什么？** 强迫以“做完仪式”暂时结束；反刍没有结束；担忧以“想到办法”暂时结束。

这里必须说清楚：以上只是描述性线索，不是计分表。**“中了几条”不能用来给自己下诊断**，因为这些体验在人群里大量重叠，最终要看病程、功能损害和排除条件。

求保证：短期有效，长期上瘾

“求保证”指反复向别人确认：我没做错吧？我刚才没说错话吧？我没得那种病吧？我关燃气了吧？也包括反复上网搜索症状、反复问医生同一个问题、反复让家人复述“没事的”。

它之所以顽固，是因为它真的有效——但只有效几分钟。焦虑下降后，大脑学到的是“问一下就能安心”，于是下一次更早去问。这叫负强化，是强迫症最典型的维持机制之一。【研究】

和“正常人也会查一下”的区别不在行为，而在：

- **频率**：一天几次、几十次，还是偶尔一次。
- **确定性要求**：是否能接受“大概没事”，还是必须得到百分之百的保证。
- **卷入他人**：是否把家人、同事、医生拖进循环，得不到回答就崩溃。
- **功能代价**：是否因此迟到、请假、反复就医、反复检查手机。

要注意，求保证不只出现在强迫症里。疾病焦虑、广泛性焦虑、抑郁、人格障碍、甚至部分躯体疾病患者都会有。单凭“爱问”不能定诊断，医生会看它是不是一个更大的强迫循环的一部分。

三、思维—行为融合：想法被当成了事实

“思维—行为融合”是个术语，说白了就是：**把想法当成已经发生的事，或当成会成真的事。** 常见三种形式：

- **想法等于行为**：“我想到打孩子，就说明我其实想打。”
- **想法等于概率**：“我想到车祸，今天就会出事。”
- **想法等于道德污点**：“我有这种念头，我就是个坏人。”

这种融合是强迫症最痛苦的部分，也是很多人不敢开口的原因。它会把一个一闪而过的念头变成一场道德审判。**在强迫症里，念头的内容和这个人的真实意愿往往是相反的**——这一点值得反复告诉自己和家人。

但也要小心两点：

1. **文化差异。** 有些文化环境里，“想不吉利的事会招来灾祸”是共享信念，不能一律当病理。判断要看它是否给你带来显著痛苦和功能损害，以及是否超出你所在环境的常规。
2. **不要用它当免罪符。** 有念头不等于会行动，但如果有真实的行为冲动、计划，仍需如实告诉医生。这与“念头等于行为”的强迫式恐惧是两件事。

四、病程、功能与需要一起排除的情况

病程与功能：判断严重度看这三样

不管叫哪一种“想”，医生都会问：

- **每天占多久**：是十几分钟，还是几个小时？
- **能不能停下来**：能不能主动转移注意力，还是必须做完仪式？
- **损害在哪里**：工作、学业、睡眠、亲密关系、育儿、社交、经济。

反刍和担忧往往与抑郁、焦虑的病程绑在一起：情绪一低落，反刍就加重；焦虑一升高，担忧就泛化。强迫思维的病程更独立一些，常常是慢性波动，压力大时加重。

需要一起排除的情况

看起来像	为什么像	区分线索
广泛性焦虑	都在反复担心	焦虑的担忧多与现实议题相关，且觉得“必要”
抑郁	都在反复想	反刍围绕自我否定，伴持续情绪低落与兴趣减退
创伤后应激	都有闯入性画面	创伤的闯入是“发生过的事”的重现，伴回避与警觉
疾病焦虑	都反复查症状	焦点固定在“有没有病”，检查后仍不放心
强迫型人格	都追求秩序与确定	人格特质通常自我协调，不觉得痛苦、不想改变
精神病性障碍	都有难以撼动的信念	妄想不伴随“抵抗”，且常有其他精神病性症状

躯体与物质因素同样要过一遍：甲状腺功能异常、贫血、咖啡因过量、兴奋剂、酒精或镇静药变化，都可能让人思维黏滞、焦虑加重、反复检查。

五、就诊准备、常见误区与就医时机

就诊前可以做的记录

- ☐ 选一天，记下每次“想停停不下来”的时刻：几点、在哪、当时在做什么
- ☐ 写下念头的大意（不用全文，关键词即可）
- ☐ 写下你随后做了什么（洗手？检查？问人？搜索？）
- ☐ 写下多久之后好转，以及多久又回来
- ☐ 统计一天大概花掉多少分钟
- ☐ 列出因为这些念头而回避掉的事
- ☐ 标注哪些时刻情绪最低——这能帮医生区分反刍与强迫
- ☐ 如果念头涉及伤害、性、亵渎，可以直接写下来交给医生，不必当面说出口

常见误区

- **“想得多就是强迫。”** 关键在闯入性、抵抗、仪式和功能损害，不在“想得多”。

- **“有可怕念头说明我危险。”** 强迫症的念头内容与真实意愿通常相反，且绝大多数不会转化为行动。这一点需要医生当面解释清楚。
- **“反刍就是想不开，劝劝就好了。”** 反刍是抑郁和焦虑的维持因素，需要针对性干预，不是道理问题。
- **“为了证明我不强迫，我故意不做仪式。”** 突然硬扛常导致更强的反弹，规范的做法是在治疗框架里逐步练习。
- **“查资料查明白了就好了。”** 反复搜索本身可能就是求保证仪式。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现伤害自己或他人的想法，并伴有计划、准备动作或已经实施——立即拨打 120（必要时 110），不要独处。
> - 反复出现“我会伤害孩子/家人”的念头，同时不敢独处、不敢抱孩子、失眠加重——尽快精神科就诊，这类情况有有效治疗，不要独自硬扛。
> - 因为反复检查、反复求保证导致无法上班、无法入睡、家庭冲突升级——尽快就诊。
> - 念头伴随听到声音、坚信被监视、坚信自己被替换——按精神病性症状急诊评估。
> - 突然出现思维混乱、言语散乱、几天不睡——急诊。
> - 服药后出现明显坐不住、冲动增加——联系开药医生，不要自行停药。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment（CG31）, 2005（2020 更新）.
- Nolen-Hoeksema S, et al. Ruminative coping and depression. 相关综述。

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

6.3 躯体变形、囤积、拔毛与抠皮

强迫及相关障碍不是一个病，而是一组病。它们共享“反复做某事、停不下来”的外形，但核心机制、自知力水平、就医去向和治疗重点都不一样。这一页讲四种最容易被误解的情况：躯体变形障碍、囤积障碍、拔毛癖和抠皮症。它们常被当成“虚荣”“懒”“坏习惯”，实际却是需要被识别的临床问题，而且往往隐藏多年才被说出来。

一、同一“家族”，四种不同的病

DSM-5-TR 把这几类放在“强迫及相关障碍”这一章里，是因为它们在现象和治疗反应上有重叠，而不是因为它们是一个病。【指南】

障碍	核心行为	最主要的痛苦	自知力通常如何
躯体变形障碍	反复检查、修饰、比对容貌	觉得自己丑，怕被别人注意	常较差，接近妄想
囤积障碍	难以丢弃物品，堆积	丢弃时强烈痛苦，生活空间被占满	常较差，家人先崩溃
拔毛癖	反复拔自己的毛发	羞耻、外观受损、难以停止	多数知道不该拔
抠皮症	反复抠抓皮肤	羞耻、留疤、感染	多数知道不该抠

看到这里先记住一句话：**它们和“爱美”“节俭”“手欠”不是一回事。** 区别在于能不能停、停下来有多难受、以及生活被影响到了什么程度。

二、躯体变形障碍与囤积障碍

躯体变形障碍：不是虚荣，是“看自己看错了”

躯体变形障碍（英文缩写 BDD）的核心是：对身体外观的某个或某些部分持续过度关注，觉得自己有缺陷，而这个缺陷在别人眼里轻微或根本不存在。【指南】

常见关注点：鼻子、脸型、皮肤、头发（变稀）、体型、肌肉不够、牙齿、生殖器。行为上会出现：

- 反复照镜子、反复摸、反复比对左右脸；
- 反复修饰：长时间化妆、换衣服、调整发型、反复拍照；
- 反复求保证：“我这样看起来奇怪吗？”
- 反复和别人的照片比对，或反复查整容信息；
- 反过来，也有人**完全回避镜子、回避拍照、白天不出门**。

两个容易被漏掉的点：

1. **起病常在青春期**，且常与校园嘲笑、外貌相关的欺凌有关。【研究】青少年说“我丑”时，如果伴随上述行为并影响上学，值得认真评估，而不是简单回一句“你很好看”。
2. **自杀风险高。** 躯体变形障碍的自杀意念和自杀未遂比例在精神障碍中属于较高的一类。【研究】这不是吓唬人，而是提醒：当一个人因为“外貌”不上学、不出门、反复说不想活，要认真对待。

与强迫症的关系：BDD 在现象上很像强迫症——反复检查、反复求保证、反复比较。区别在于焦点固定在“外貌”和“别人怎么看我”，而强迫症的仪式往往围绕污染、伤害、对称、宗教等主题。两者可以共病。

囤积障碍：不是懒，也不是抠门

囤积障碍的核心是：**持续难以丢弃物品，不管它们实际有没有价值**，结果物品堆积到占据生活空间、妨碍正常使用。【指南】

常见表现：

- 家里走道被占、床不能睡、厨房不能用、门打不开；
- 丢弃时出现强烈焦虑、纠结、甚至哭泣；
- 家人反复清理，然后爆发激烈冲突；
- 常伴“以后会用得上”“这是回忆”“扔了就是浪费”的信念；
- 常合并注意缺陷、老年抑郁、孤独、躯体疾病。

和强迫症的“收藏仪式”区别：强迫症的摆放、对称、计数通常伴随闯入性念头和“必须”的感觉，本人觉得荒谬；囤积的信念更接近“这些东西真的有用/真的有感情”，自我协调性更强，求治动机往往来自家人或安全问题。

必须一起考虑的其他原因：

- **老年抑郁**：动力下降、无力整理，容易被误当囤积；
- **痴呆**：执行功能下降、重复购买、判断力减退；
- **精神分裂症谱系**：阴性症状、社交与生活自理能力下降；
- **强迫症**：以“怕污染所以不敢扔”或“必须对称”为动机；
- **物质或躯体疾病**：脑损伤、额叶病变、慢性疼痛导致的活动受限。

安全风险要单独说：火灾（杂物堵住燃气和电线）、跌倒、卫生问题、蟑螂鼠患、被邻居投诉、被强制清理、甚至失去住房。老年人囤积还常伴随营养不良和用药混乱。

三、拔毛癖与抠皮症：看起来像“坏习惯”的重复行为

拔毛癖：反复拔自己的头发、眉毛、睫毛、胡须、体毛，导致可见的毛发缺失。拔之前常有紧张或“非拔不可”的冲动，拔的时候或拔完后有放松、满足感。【指南】不过相当一部分人是在**无意识状态**下拔的——看电视、看书、发呆时手自动伸过去，事后才发现。

抠皮症（也叫皮肤抠抓障碍）：反复抠、挤、抓、咬皮肤，造成明显皮损、结痂、疤痕，甚至感染。同样可能先有紧张感、后有放松，也可能在自动化状态下进行。

两者共同的临床特点：

- **羞耻感极强**，常用帽子、假发、长袖、口罩遮掩，就医时也未必主动说；
- 常被误认为皮肤病、脱发、营养不良，先跑皮肤科；
- 起病多在青春期前后，可与强迫症、躯体变形障碍、抑郁、焦虑共病；

- 女性就诊比例较高，但男性同样存在，常因“不好意思”而漏诊。

和强迫症的区别：强迫症的拔毛/抠皮常带明确的仪式意义（比如“必须拔到对称”“拔掉这根才能安心”），而拔毛癖和抠皮症更多是一种以身体感觉为驱动的重复行为，核心是“拔/抠的冲动—释放”。两者可以同时存在，这时诊断会同时给出。

四、病程、功能损害与需要排除的情况

这四种障碍有一个共同点：**病程长、被发现晚、功能损害被低估**。

维度	具体表现
病程	多起于青少年期，未经治疗常持续多年、慢性波动
社交	不敢见人、不敢拍照、退出集体活动、恋爱回避
学业工作	迟到、缺课、无法专注、因外貌或皮损放弃面试
家庭	反复争吵、被迫参与检查或清理、经济负担
医疗	反复看皮肤科/整形科/内科，检查做完仍不放心

功能损害是诊断的必要部分。一个人可能符合症状描述，但如果完全不影响生活，医生通常会更谨慎，先观察而非急于下诊断。

类别	具体例子	区分线索
躯体疾病	斑秃、真菌感染、湿疹、毛囊炎、甲状腺问题、缺铁	皮损形态、分布、化验；拔毛/抠皮通常有形状不规则、边界清楚的特点
物质与药物	兴奋剂、激素类药物、酒精、可卡因	时间关系：用药或戒断后出现，停药观察可减轻
其他精神障碍	强迫症、抑郁、焦虑、进食障碍、精神病性障碍、孤独症谱系、抽动障碍	起病顺序、是否有闯入性念头、是否有体像扭曲、是否有其他精神病性症状

特别提醒：**不要把所有“反复照镜子”都归给躯体变形障碍**。进食障碍的人也会反复检查体型，社交焦虑的人也会担心外貌被评价，文化环境里的外貌压力也会造成类似行为。区别在于核心恐惧是什么、体重和进食行为是否异常、以及是否存在体像扭曲。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 记录行为的频率与时长：一天几次、每次多久、在什么情境下发生
- ☐ 记录触发：照镜子、拍照、看社交媒体、洗澡、紧张、无聊、睡前
- ☐ 记录“之前—之中—之后”的感受：紧张、释放、麻木、后悔
- ☐ 记录身体后果：脱发范围、皮损、疤痕、感染、是否用衣物遮掩
- ☐ 记录回避：不去游泳、不拍照、不社交、不上学
- ☐ 记录家人反应：是否反复清理、争吵、代买东西
- ☐ 记录外貌关注的部位和具体想法（“别人都在看我的鼻子”）
- ☐ 带上正在用的药、护肤品、外用药，以及做过的检查结果

常见误区

- **“拔毛是坏习惯，忍忍就行。”** 它是有神经生物学基础的重复行为，单纯靠意志常失败，还会加重羞耻。
- **“脱发就是肾虚、营养不良。”** 边界清楚的斑片状脱发、眉毛睫毛缺失，要想到拔毛癖。
- **“爱美而已，哪有病。”** 躯体变形障碍的关键不是爱美，而是痛苦、回避和功能损害。
- **“囤积就是懒、就是穷。”** 很多囤积者经济条件良好，核心是丢弃时的强烈痛苦。
- **“抠皮就是皮肤不好。”** 反复同一部位、边界清楚、越抠越多的皮损，要问行为本身。
- **“这些都不是大病。”** 它们常伴抑郁、焦虑和自杀风险，且治疗有明确方向，值得被认真对待。【指南】

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 因为外貌或皮损产生“不想活了”的念头，或已经自伤——立即拨打 120，或去最近医院急诊，不要独处。
> - 抠皮、拔毛造成大面积破损、明显感染（红肿热痛、流脓、发热）——尽快急诊或皮肤科处理，同时联系精神科。
> - 囤积导致燃气、电路被杂物堵塞，或老人跌倒、无法通行——先排除安全隐患，必要时联系社区与消防，尽快精神科评估。
> - 出现意识模糊、记忆力明显下降、重复购买、走失——按老年急症评估，警惕谵妄与痴呆。
> - 拔毛后出现大片秃发并被同学欺凌、拒绝上学——尽快就诊，不要等“长大就好”。
> - 反复整容、反复要求手术，或已多次手术仍不满意——建议先在精神科/心理科评估，再决定是否手术。

确诊之后，下一步通常是评估共病、安全风险和功能损害，再讨论心理治疗（如认知行为治疗、习惯逆转训练）与药物治疗的取舍。具体方案由面诊医生决定。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment（CG31）, 2005（2020 更新）.
- NIMH. Body Dysmorphic Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

6.4 强迫症与焦虑、抽动、ASD、精神分裂的鉴别

强迫症最容易被“看错”的地方，不是没人认识它，而是它太像别的东西：像焦虑症的反复担心，像抽动症的不自主动作，像孤独症谱系的重复刻板，也像精神分裂症的顽固信念。这一页把四条最容易混的边界拆开讲，给你可观察的区分线索，也说明为什么“时间顺序”和“损害形态”往往比单个症状更能决定诊断。

一、为什么这几类老是被混在一起

因为它们在表面上都符合三个描述：重复、难以停止、影响生活。

- 焦虑的人反复担心，看起来像强迫思维；
- 抽动的人反复做动作，看起来像强迫行为；
- 孤独症谱系的人反复排列、转圈、拍手，看起来像仪式；
- 精神分裂症谱系的人坚信某种“必须做”的规则，看起来像自知力差的强迫症。

但它们的**驱动力**完全不同：强迫是“为了消除一个灾难性的可能”，焦虑是“为了应对一个现实的威胁”，抽动是“为了释放一个身体冲动”，孤独症谱系的重复是“为了调节感官与情绪”，精神病性的信念则是“与现实脱节的固定结论”。

而且这些情况经常**共病**。强迫症与焦虑障碍、抽动障碍、孤独症谱系的共病率都不低。【研究】所以临床问题往往不是“到底是哪一个”，而是“哪一个是主线、哪一个需要先处理”。

二、与焦虑、抽动的边界

焦虑障碍：担忧有没有“现实感”

维度	更像强迫症	更像焦虑障碍
念头性质	闯入、荒谬、与价值观相反	现实议题：钱、健康、工作、家人
对念头的态度	想摆脱、觉得没意义	觉得是必要的准备与负责
后续行为	仪式化的中和（洗、查、默念）	反复计划、查资料、做准备、回避
触发	具体线索（门锁、刀具、公共厕所）	泛化的处境（考试、汇报、分离）

广泛性焦虑的人也会反复检查门锁，但他们的理由是“万一真没锁呢”，而不是“不检查就会出事”的仪式感；检查完通常就睡了，不会因为“检查的次数不对”再重来。

社交焦虑的人怕被评价，也会反复回想自己说过的话，这更像“事后反刍”，不是强迫思维。惊恐障碍的人怕的是身体感觉本身（心跳、头晕），回避的是场所，不是污染或伤害。

一个实用的追问：**“如果你百分之百确定没事，你还会做这个动作吗？”** 强迫症的人多半会说“那当然不会”，焦虑的人会说“那我也会小心一点”。

抽动障碍：先有冲动，还是先有担心

抽动是突然、快速、反复的动作或发声，比如眨眼、耸肩、清嗓、吸鼻、甩头。它的关键特征是**先有一种身体上的“要动”的感觉**（术语叫前驱冲动），动了之后紧张释放。【指南】

维度	强迫行为	抽动
起因	一个念头带来的焦虑	一种局部身体冲动或痒、紧、憋
目的	防止坏事发生	释放冲动，没有“防止”的含义
形式	常复杂、有固定顺序、可带心理成分	简短、刻板、部位会变
能否忍	能忍一段时间，但焦虑上升	能短暂抑制，抑制后爆发
睡眠中	通常不做	抽动在睡眠中明显减少或消失

两者常同时出现。儿童期起病的强迫症合并抽动的比例不低，而抽动秽语综合征的孩子也常有强迫样仪式。这时候医生会同时给两个诊断，并分别评估严重度，而不是二选一。

还要注意：抽动可以被“命令”暂时压住，但压住之后会有更强的反弹，这和强迫的“忍住不做仪式”很像，容易被家长误解为“他能控制，就是故意的”。

三、与孤独症谱系、精神分裂症的边界

孤独症谱系：重复是“调节”，还是“消灾”

孤独症谱系（ASD）的重复行为包括：拍手、摇晃、转圈、排列物品、反复看同一段视频、坚持固定路线、对特定主题的强烈兴趣。

区分的关键不在动作，而在**功能和情绪**：

- **ASD 的重复行为**：多用于自我刺激、调节感官输入、维持可预测性。做的时候常显得投入、平静，被打断会烦躁甚至崩溃，但很少伴随“灾难要发生”的恐惧。
- **强迫行为**：目的是消除焦虑、防止灾难。做的时候常显得痛苦、紧绷，做完短暂轻松，随后又自责“我怎么又做了”。

再看**感官**：ASD 常有感觉过敏或迟钝（怕噪音、怕标签、挑食、转圈寻求前庭刺激）；强迫症的“怕污染”是对污染与疾病的恐惧，不是感官不适。

再看**社交沟通**：ASD 的社交差异是长期的、从早期就有的；强迫症患者的社交回避多是“怕触发”或“怕被看出仪式”。

一个常踩的坑：把 ASD 孩子的刻板动作当成强迫症来治，或把强迫症孩子的仪式当成“刻板行为”而不处理。两者共病时，需要分别评估。

精神分裂症谱系：妄想性强迫与强迫性妄想

这是四条边界里最需要谨慎的一条。

强迫症伴自知力缺乏：信念仍围绕一个“强迫主题”（污染、伤害、对称），即使非常坚信，也常能被特定情境触发，且没有其他精神病性症状。

妄想：固定、不可动摇、与现实脱节，且往往扩展到生活的多个方面，可能伴随幻觉、思维形式障碍、情感平淡、行为紊乱。

临床上还有两个模糊地带：

- **强迫性妄想**：妄想的内容带有强迫性质（比如“我必须每天四点起床，否则全家会死”），但整体已进入妄想水平；
- **抗精神病药所致强迫样症状**：部分患者在用药后出现强迫症状，需要核对时间关系。

区分线索：

1. **只在一个主题上，还是弥漫到全部生活？**
2. **有没有其他精神病性症状？**（幻听、被监视感、思维被插入）
3. **信念能不能被现实检验？** 强迫症的人即使坚信，通常仍会承认“听起来有点夸张”；妄想则完全不接受反驳。
4. **起病与病程**：强迫症多在青少年期隐匿起病、慢性波动；精神病性障碍常有明确的发作期与功能下降。

重要提醒：把强迫症误诊为精神分裂症，代价很大（用药方向、标签、家庭态度都会变）；反过来，把精神病性症状当成“强迫”而延误，也有风险。这类判断必须由精神科医生面谈完成，不要靠网上的量表。

四、鉴别线索表与病程功能轴

鉴别对象	更像强迫的线索	更像另一诊断的线索
焦虑障碍	念头闯入、荒谬、有仪式中和	担忧围绕现实议题、觉得必要、无明显仪式
抽动障碍	动作有目的、有固定顺序、为消灾	先有身体冲动、动作简短、睡眠中减少
孤独症谱系	痛苦、想摆脱、怕灾难	投入平静、调节感官、社交差异从早期存在
精神分裂症谱系	局限于一个主题、无其他精神病性症状	信念弥漫、伴幻觉或思维障碍、功能显著下降

这张表只能当“问诊提示”，不能当判据。

单个症状容易骗人，**时间轴不容易骗人**。

- **起病年龄**：强迫症常见两个高峰（儿童期、青春期到成年早期）；抽动多在学龄前到小学阶段起病；ASD 的差异从婴幼儿期就有；精神分裂症多在青春期后期到成年早期首次发作。
- **病程形态**：强迫症慢性波动、随压力起伏；抽动有起落，青春期后常减轻；ASD 稳定持续；精神病性障碍以发作或持续衰退为特征。
- **功能损害的形态**：强迫症的损害集中在“耗时”和“回避”；抽动的损害在社交尴尬与躯体不适；ASD 的损害在社交沟通与适应变化；精神病性障碍的损害更全面，涉及工作、人际、自理。

这也是为什么医生会花很多时间问“第一次是什么时候”“那之后有没有完全正常的时期”。这些问题比“你现在有多少症状”更有诊断价值。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊准备清单

- ☐ 写下症状第一次出现的大致年龄，以及当时的诱因
- ☐ 画出时间线：哪几年重、哪几年轻、有没有完全缓解期
- ☐ 描述动作前的感觉：是“担心出事”，还是“身体憋得慌”

- ☐ 描述被打断时的反应：焦虑上升，还是暴怒、崩溃
- ☐ 记录有没有幻觉、被监视感、说话别人听不懂
- ☐ 记录社交与沟通的历史：从小是否就难、是否有固定兴趣
- ☐ 带上既往的诊断、用药清单和量表结果
- ☐ 如果家里有类似表现的人，一并告诉医生

常见误区

- **“有重复动作就是强迫症。”** 抽动、ASD 的刻板、药物的锥体外系反应都可以是重复动作。
- **“他坚信，所以是精神病。”** 自知力缺乏的强迫症同样可以非常坚信。
- **“孤独症的人不会有强迫症。”** 会，而且共病并不少见。
- **“焦虑和强迫是一回事。”** 治疗重点不同：焦虑更偏暴露与放松，强迫的核心是反应阻止。
- **“一次门诊就能分清。”** 常常不能。纵向观察、家属补充信息、量表随访都是诊断的一部分。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现命令性幻听、坚信被迫害或被控制、明显行为紊乱——立即拨打 120（必要时 110），尽快精神科急诊评估。
> - 出现伤害自己或他人的念头并有计划或准备行为——立即急诊，不要独处。
> - 抽动突然全面加重，伴发热、吞咽困难、走路不稳——急诊，警惕躯体与神经系统问题。
> - 儿童在链球菌感染后突然出现强迫症状与行为改变——尽快就诊，说明感染时间。
> - 服药后出现坐不住、肌肉僵硬、发热、意识改变——立即急诊。
> - 因为仪式无法上学、无法工作超过两周——尽快精神科就诊。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment（CG31）, 2005（2020 更新）.
- NICE. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis（CG170）, 2013（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

6.5 强迫症量表与诊断误区

量表在强迫症的诊疗里很有用，但它几乎从不单独决定诊断。这一页讲清楚：耶鲁—布朗强迫量表（Y-BOCS）到底测什么、自评量表能做什么不能做什么、以及为什么“想得多就是强迫”“强迫症都很爱干净”这类说法会把真正需要帮助的人挡在门外。适合已经做过量表、被分数吓到或安慰到的人读。

一、Y-BOCS 是什么，不是什么

Y-BOCS 是目前国际上最常用的强迫症**严重度**评定量表，由 Goodman 等人于 1989 年发表。它属于**他评量表**——由受过训练的医生或评估者提问并打分，不是自己填。【指南】

结构大致是：10 个条目，前 5 条评强迫思维，后 5 条评强迫行为。每条 0–4 分，总分 0–40。它评的不是“你有没有这个症状”，而是“这个症状占了你多少时间、干扰你多少、让你多痛苦、你花多大力气抵抗、你能控制多少”。

用途	能做什么	不能做什么
严重度分级	给出一个可比较的分数区间	不能替代面诊下诊断
疗效随访	治疗前后对比，看变化幅度	不能反映全部生活功能
科研与分型	统一口径，便于研究比较	不能区分强迫与焦虑、抽动
沟通工具	让患者和医生看到“哪一块最重”	不能预测个体结局

常被引用的分档大致是：0–7 分亚临床，8–15 分轻度，16–23 分中度，24–31 分重度，32–40 分极重。不同版本与不同研究的分界略有差异，**这些数字是描述严重度的刻度，不是诊断门槛**。有人 12 分但完全无法上班，也有人 26 分仍在勉强维持——分数之外还要看功能。

另外还有儿童版（CY-BOCS）和症状清单版本（用于逐条核对症状内容）。它们的作用是“不漏项”，不是“定诊断”。

二、自评量表的边界

常见的自评工具包括 OCI-R（强迫症量表修订版，18 题）、FOCI、VOCI、Padua 量表等，以及各种网络流传的“强迫症测试”。

它们的共同优点是：几分钟填完、能筛查、能随访、能让人鼓起勇气走进诊室。

它们的局限也很明确：

- **无法区分“强迫”与“焦虑、抑郁、抽动、完美主义”**。条目里“我经常检查东西”这句话，焦虑的人、细心的人、被规训得很严的人都会打高分。
- **“强迫”这个词在大众语境里被用坏了**。有人理解的“强迫”是“我很讲究”，而量表问的是“你是否被无法控制的想法和行为困扰”。
- **容易被误读**。比如“我有时会有邪恶的念头”，很多人会理解成“我偶尔生气”，而不是“闯入性的、让我痛苦的念头”。
- **文化差异**。讲究卫生、注重秩序、尊重规则，在不同家庭里的基线不同。

- **网络测试大多没有验证**，常把“强迫型人格”“洁癖”“完美主义”混进去，甚至直接给出“你有强迫症”的结论。

以 OCI-R 为例，它总分 0–72，常被引用的筛查参考值在 21 分左右，不同人群、不同译本会有差异。**它提示“值得进一步评估”，不提示“你确诊了”。**【研究】

三、为什么医生不会只凭量表：病程、功能与排除

量表测的是“此刻有多重”，诊断要的是“这条线是怎么走过来的”。

- **病程**：症状从什么时候开始？是持续存在还是阵发？有没有完全缓解的时期？压力大时是否加重？突然起病要警惕躯体原因。
- **功能损害**：工作、学业、睡眠、人际、育儿、经济分别受到什么影响？回避掉了哪些事？家人被卷入多深？
- **排除**：

类别	常见例子	医生会怎么处理
躯体与神经	抽动障碍、颞叶癫痫、甲状腺功能异常、脑损伤	追问意识改变、动作特点，必要时转诊或检查
物质与药物	咖啡因过量、兴奋剂、酒精、镇静药变化	核对时间线，停药观察
其他精神障碍	焦虑、抑郁、躯体变形、囤积、拔毛、ASD、精神病性障碍	看起病顺序、自知力、有无其他症状

量表高分 + 功能完好 + 病程很短，医生更可能写“强迫症状”或“待观察”，而不是直接下障碍诊断。这不是敷衍，而是诊断的严谨。

四、四个常见误区

误区一：“想得多就是强迫”

“我总在想事情，是不是强迫症？”——这是最普遍的误解。

强迫症的核心不是“想得多”，而是：念头**闯入**、你**想赶走它**、它带来**强烈痛苦**、你用**仪式去中和**、并且**耗时到影响生活**。

而“想得多”可能对应很多情况：

- **反刍**：围绕“我为什么这样”，与情绪低落绑在一起；
- **担忧**：围绕未来的现实问题，觉得是必要准备；
- **计划与复盘**：有明确目的，做完就结束；
- **思维黏滞**：抑郁或疲劳时思维变慢、转不动；
- **普通闯入性想法**：几乎人人都有，一闪而过。

反过来也成立：**强迫症不一定要“想很多”**。有人主要是外显仪式（洗手、检查），脑子里的念头很短；有人主要是内隐仪式（默念、回放），外人完全看不出来。

误区二：“强迫症都很爱干净”

影视剧里的强迫症几乎都是戴手套、反复洗手、家里一尘不染。现实里，这只是其中一个亚型。

常见的强迫主题至少包括：污染与清洗；怀疑与检查（门锁、燃气、电器、作业）；对称、秩序、计数；伤害念头（怕自己伤害孩子、伴侣、陌生人）；性与道德、宗教相关的亵渎念头；“刚刚好”的感觉（必须重复到某种感觉才对）；纯粹内隐的仪式（默念、心里抵消、反复确认记忆）。

有些人家里很乱，因为整理本身变成了仪式，做到一半崩溃放弃；有些人完全不洗手，但每天花三小时检查。用“爱干净”去识别强迫症，会漏掉一大半人，尤其会漏掉那些被伤害念头折磨、羞于开口的人。

误区三：把强迫型人格当成强迫症

强迫型人格特质指的是：过度追求秩序、完美、控制，凡事要按规矩来，显得刻板、固执。它的特点是**自我协调**——本人通常觉得“这样挺好，是别人不够认真”，并不痛苦，也不急于改变。

强迫症的特点是**自我不协调**——本人觉得这些念头和行为荒谬、丢人、想摆脱，却被困住。

两者可以同时存在，但概念不同，处理重点也不同。把两者混为一谈，会让真正痛苦的人被回一句“你就是太较真”。

误区四：反复做量表，把测量变成仪式

这听起来有点讽刺，但很常见：反复上网做测试、反复量自己的分数、反复问医生“我这个分数算不算严重”、反复搜索“强迫症会不会疯”。

这些行为和洗手、检查在机制上是同一件事——**求保证**。短时间能安心，长期会强化“必须确认”的循环。

一个实用建议：把量表留给定期的复诊，比如每 4–8 周一次；中间想测的时候，先在记录本上写下“我现在想测，是因为焦虑升高了”，然后等 20 分钟再决定。

五、就诊准备与就医时机

量表是尺子，不是判决书。它能告诉你“现在有多重、比上次好没好”，但不能告诉你“你是不是这个病”。诊断要靠面诊、病程、功能损害和排除，三者缺一不可。

就诊准备清单

- ☐ 带上做过的量表结果，注明日期和版本
- ☐ 记录最近两周每天大致的耗时（分段估算）
- ☐ 列出最困扰你的三个念头或行为，按痛苦程度排序
- ☐ 记录功能损害：迟到、请假、失眠、皮肤破损、家庭冲突
- ☐ 记录回避掉的事
- ☐ 列出用药、保健品、咖啡、酒、尼古丁

☐ 准备好想问医生的问题：-［ ］我这个分数代表什么？-［ ］有没有共病需要一起评估？-［ ］需不需要做躯体检查？-［ ］下次复评大概什么时候？

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现伤害自己或他人的念头，并有计划或准备行为——立即拨打 120（必要时 110），不要独处。
> - 因仪式导致连续多日几乎不睡、不吃、不出门——尽快精神科就诊，必要时急诊。
> - 清洗或抠抓造成大面积皮肤破损、感染、发热——先急诊处理躯体问题，同时联系精神科。
> - 症状突然加重，伴发热、抽搐、意识不清——按躯体急症走急诊。
> - 产后出现伤害婴儿的念头，或坚信婴儿被替换、听到声音——立即急诊。
> - 服药后出现明显坐不住、肌肉僵硬、发热——立即急诊。

参考来源

- Goodman WK, et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale（Y-BOCS）. Archives of General Psychiatry, 1989.
- Foa EB, et al. The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised（OCI-R）. Psychological Assessment, 2002.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- NICE. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment（CG31）, 2005（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 7：创伤及应激相关障碍确诊

创伤后的反应不只有 PTSD。急性应激、适应障碍、复杂性创伤、解离，需要分开看。

7.1 创伤后应激障碍诊断要点

创伤后应激障碍（英文全称 Post-Traumatic Stress Disorder，缩写 PTSD）不是“受过刺激就一直难过”，而是一组有明确时间门槛、有特定症状组合、并且明显影响生活的障碍。这一页讲医生确诊时会看哪几件事：创伤暴露、四组症状、一个月的门槛、以及功能损害和排除条件。也会说明为什么“说出来”不是诊断的前提，你不必为了看病把细节全讲一遍。

一、第一步不是问症状，而是问“发生了什么”

PTSD 的诊断有一个其他障碍没有的前提：**必须先有创伤性事件的暴露**。【指南】DSM-5-TR 把它分成几种情形：

- **直接经历**：自己遭遇事故、暴力、性侵、自然灾害、战争、严重疾病；
- **亲眼目睹**：看到别人身上发生；
- **间接得知**：亲近的人遭遇暴力或意外死亡、威胁性事件；
- **反复接触细节**：因职业原因反复接触创伤细节（急救、尸检、儿童保护、接警）。

这里有两个需要说清楚的地方。

第一，不是所有难受的事都算“创伤性事件”。 标准强调的是实际或被威胁的死亡、严重伤害、性暴力。失恋、考试失败、被批评、经济困难会带来痛苦，但不一定符合这个前提。说这句话不是为了比较谁的苦更大——痛苦是真实的，只是**诊断名称不同**：这类情况更可能落在适应障碍、抑郁或焦虑的范畴里。

第二，不要拿它来审判自己。 有人经历大事却反应不大，有人经历看起来“没那么严重”的事却症状很重。个体差异很大，与“坚强不坚强”无关。【临床经验】

二、四组症状：闯入、回避、负性认知与情绪、警觉增高

1. 闯入（再体验）

- 不由自主地闪回，感觉事情又发生了一遍；
- 反复做与事件有关的噩梦；
- 看到、听到、闻到类似的东西时，出现强烈的情绪或身体反应（心跳、出汗、僵硬）；
- 有些人的“闪回”不是画面，而是一阵说不清的身体恐惧。

闪回和普通回忆的区别：普通回忆是“我想起那件事”，你知道自己在现在；闪回是“我好像又在那儿”，当下的时间感、位置感会短暂丢失。

2. 回避

- 回避人、地点、活动、物品；
- 回避谈论、回避相关新闻、回避医院；
- 回避相关的想法和感受，用忙碌、酒精、刷手机把自己填满。

回避是维持症状的关键：越回避，大脑越确认“这件事不能碰”，恐惧就越难消退。

3. 负性认知与情绪

- 持续的自责：“都怪我”“我当时应该……”；
- 对自己、他人、世界的固定负面信念：“我完了”“没人能信”“世界处处危险”；
- 持续的快感缺失、疏离感、与人隔一层；
- 记不清事件的某些部分（不是普通的忘记，而是片段缺失）；
- 持续的恐惧、惊恐、愤怒、羞耻。

4. 警觉与反应性改变

- 惊跳反应过强，一点动静就心跳加速；
- 易怒、攻击性增加；
- 注意力难以集中；
- 入睡困难、易醒；
- 鲁莽或自我毁灭行为（飙车、酗酒、无保护性行为）；
- 过度警觉，总要观察出口在哪。

三、一个月门槛、病程与功能损害

时间是 PTSD 诊断里最容易被忽略、也最容易被误用的部分。

时间	通常的考虑
事件后 3 天内	症状常见，多属正常应激反应，通常先观察与支持
3 天到 1 个月	若症状明显，考虑急性应激障碍
超过 1 个月	若符合症状组合与功能损害，考虑 PTSD
事件后数月才出现	迟发型，较少见但存在，仍可能符合诊断

需要说明：ICD-11 与 DSM-5-TR 在时间门槛上的表述不完全一致，ICD-11 更强调症状持续“至少数周”，并且把症状分成三个核心群（再体验、回避、当前威胁感），不把负性认知与情绪单列为核心群。【指南】不同国家、不同医生用的系统不同，你会看到不一样的措辞，这很正常。

病程：有人几周内缓解，有人持续数年。症状常随周年日、新闻、身体疲劳、睡眠不足而波动。共病抑郁、焦虑、物质使用很常见，会让病程更复杂。

功能损害：症状清单可以对得很齐，但如果生活没受影响，医生会更谨慎。功能要看这些方面：

- **工作与学业**：请假、效率下降、无法集中、回避出差或夜班；
- **人际**：疏离、易怒、冲突、无法亲密、过度保护孩子；
- **育儿**：有的父母会过度警觉、无法让孩子独立出门；

- **健康**：反复检查身体、回避体检、失眠、酒精或镇静药使用；
- **社会功能**：不敢坐公交、不敢去人多的地方、不敢恋爱；
- **法律与经济**：工伤、赔偿、诉讼、失业。

问损害要具体：这周请了几天假？多久没见朋友？晚上几点才能睡着？

四、必须排除的情况与几个常被误解的细节

类别	常见例子	区分线索
躯体与神经	脑震荡后综合征、颅脑外伤、甲状腺功能异常、慢性疼痛、睡眠呼吸暂停	症状以躯体为主，躯体治疗后精神症状减轻
物质与药物	酒精、镇静药、兴奋剂、大麻；戒断	时间关系明确，停用后观察
其他精神障碍	抑郁、焦虑、惊恐、双相、边缘型人格、复杂哀伤、适应障碍	看是否有事件锚定、闪回的具体性、起病顺序

重点说两个：

- **抑郁**：PTSD 常与抑郁共病，但抑郁的核心是持续的情绪低落与兴趣减退，不一定有事件锚定的闪回和回避。
- **边缘型人格**：两者都有情绪不稳、自伤、关系困难。区别在于 PTSD 的症状围绕特定事件，而人格模式是长期、跨情境的。可参看 7.4 创伤相关障碍与焦虑、抑郁、人格的鉴别。

几个常被误解的细节：

- **“我没有闪回，所以不是 PTSD。”** 不是。有人主要表现为麻木、回避、易怒、失眠，没有清晰的画面闪回。
- **“事情过去很久了，早该好了。”** PTSD 的病程可以很长，且不会因为“时间到了”自动消失。
- **“我必须把细节全讲出来，医生才能诊断。”** 不需要。诊断看的是症状模式、时间线、功能损害，不需要你复述创伤细节。你有权说“这部分我现在不想讲”。【临床经验】
- **“我一提就崩溃，是不是不适合看病？”** 崩溃本身说明这件事还没被处理，不代表你不能就诊。可以提前告诉医生“我只能说大概，细节我说不了”。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 事件发生的大致时间、类型（不用写细节）
- ☐ 症状从什么时候开始，最早出现的是什么
- ☐ 睡眠情况：入睡、易醒、噩梦
- ☐ 回避清单：哪些人、地点、话题、场合
- ☐ 情绪与想法：有没有持续的自责、疏离、无望
- ☐ 警觉：惊跳、易怒、注意力
- ☐ 功能：工作、学业、人际、育儿
- ☐ 酒精、镇静药、其他物质的使用量
- ☐ 既往治疗、用药、诊断

☐ 有没有自杀念头、自伤行为（这条最重要，请如实说）

常见误区

- **“PTSD 只有退伍军人才会得。”** 交通事故、暴力、性侵、医疗事件、丧亲都可能。
- **“不提就不会有事。”** 回避短期有效，长期维持症状。
- **“谈创伤会二次伤害，所以别谈。”** 不恰当、过早、强迫的披露确实有害；但在安全、可控、有准备的条件下，治疗性接触是有帮助的。【指南】
- **“时间会治愈一切。”** 一部分人会自愈，另一部分人需要治疗。等待不是策略。
- **“确诊 PTSD 就等于一辈子。”** 诊断描述的是当前状态，不是终身判决。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划——立即拨打 120，或去最近医院急诊；不要独处，联系一个信任的人陪着。
> - 闪回时出现自伤、冲出马路、砸东西等危险行为——先保证安全，必要时 110。
> - 连续多日几乎不睡、不吃、无法照顾自己或孩子——尽快急诊评估。
> - 用大量酒精或镇静药“压”症状，出现停药后抽搐、幻觉、意识混乱——立即急诊，不要自行硬戒。
> - 听到命令性声音让你伤害自己或别人——立即急诊。
> - 症状持续一个月以上并影响工作生活——尽快精神科门诊，不需要等到“更严重”；也可拨打 12356 心理援助热线。

确诊之后，下一步通常是评估安全风险、共病与功能损害，再讨论心理治疗（如聚焦创伤的认知行为治疗、眼动脱敏与再加工）与药物治疗的取舍。具体方案由面诊医生决定，本页不涉及用药细节。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.
- NIMH. Post-Traumatic Stress Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

7.2 急性应激障碍与适应障碍

事情刚发生的头几天，人发懵、发抖、反复回想、睡不着，这算病吗？事情过去两三个月了，人却越来越撑不住，又算什么？这一页讲两个常被混淆、也常被轻视的诊断：急性应激障碍和适应障碍。它们的共同点是“由应激源引起”，区别在于应激源的性质、症状的样子和时间的位置。读完你会知道，什么时候该观察，什么时候该就诊，以及“正常悲伤”和“需要治疗”的边界在哪里。

一、急性应激障碍：事件后的第一个月

急性应激障碍（英文缩写 ASD）发生在创伤性事件之后，时间窗大致是**事件后 3 天到 1 个月**。DSM-5-TR 把它归在“创伤及应激相关障碍”里，症状分布在几个方面：闯入、负性心境、解离、回避、警觉增高。需要达到一定数量的症状，并且造成明显痛苦或功能损害。【指南】

它和 PTSD 的区别，主要不在症状内容，而在**时间**和**是否包含解离**：

- 时间：ASD 在 1 个月内，PTSD 要求超过 1 个月；
- 解离：ASD 明确把解离症状纳入，包括麻木、感觉不真实、觉得世界像隔了一层玻璃、记不起事件的某些片段；
- 预后：一部分人在一个月内缓解，一部分人发展成 PTSD。ASD 不是“轻度的 PTSD”，也不是“必然变成 PTSD”。

解离要单独解释一下，因为很多人不知道自己经历了它：

- **人格解体**：觉得自己不是自己，像在旁观自己演戏，身体不是自己的；
- **现实解体**：周围世界变陌生、变平、像假的，声音变远；
- **解离性遗忘**：记不起事件的某些时段，不是普通的“记性差”；
- **时间感改变**：事情像慢动作，或像过了很久其实只有几分钟。

这些体验很容易让人以为自己“疯了”。其实它是大脑在过载时的一种保护性反应，很常见，也可以被治疗。

二、适应障碍：应激源没那么“极端”，痛苦却是真的

适应障碍的核心是：**有一个可识别的应激源**，在应激源出现后 **3 个月内**起病，出现明显的情绪或行为症状，造成功能损害，而且不能用其他精神障碍更好地解释。【指南】

应激源可以是失恋、离婚、失业、搬迁、移民、考试失败、被辞退、经济困难、慢性疾病、照护负担、家庭冲突。它不需要达到“威胁生命”的程度——这正是它和 PTSD 的关键差别。

DSM-5-TR 按主要表现分成几个亚型：以情绪低落为主、以焦虑为主、混合型、以行为问题为主、混合情绪与行为问题。ICD-11 的写法不同，把适应障碍放在“应激相关障碍”里，强调症状与应激源的时间关系和对功能的妨碍。

关键的时间规则：应激源消除后，症状通常在 6 个月内缓解。如果超过这个时间还在持续，医生会重新考虑诊断——是不是抑郁、焦虑、PTSD，或者应激源本身是长期的（比如长期照护、长期家暴）。

三、四条时间线，以及三条容易混淆的边界

情况	起病时间	持续时间	核心特征
正常应激反应	事件后立即	数小时到数天，逐渐减轻	发懵、失眠、反复回想，但能逐步恢复日常
急性应激障碍	事件后 3 天到 1 个月	不超过 1 个月	闯入、解离、回避、警觉，功能明显受影响
创伤后应激障碍	事件后超过 1 个月	常持续数月到数年	四组症状持续存在，回避成为主要应对方式
适应障碍	应激源后 3 个月内	应激源消除后 6 个月内缓解	情绪或行为症状，与应激源关系明确

这张表是“时间提示”，不是判据。诊断还要看症状数量、功能损害和排除条件。

丧亲、失恋、失业之后的难过，是最容易被误判的一片区域。

正常悲伤：情绪起伏，会有“看到遗物突然崩溃”的时刻，也会有一两天能笑出来；谈论逝者时是怀念与痛，不是彻底的无价值感；功能大体保留，能处理必要事务；随着时间推移，痛苦变钝，但不会“忘记”。

适应障碍：痛苦持续、泛化，开始影响工作、人际、睡眠，出现回避、易怒、躯体不适，但核心仍与应激源相连；应激源改善后，症状会跟着松动。

抑郁发作：情绪低落与兴趣减退持续两周以上，几乎每天、大部分时间；伴随自我否定、无价值感、无望感、注意力下降、食欲与睡眠改变；不再与具体事件紧密挂钩，而是弥漫到生活各个角落。

值得知道的两个细节：

1. **DSM-5 起取消了“丧亲排除”条款**，也就是说，丧亲后出现的抑郁发作可以被诊断为抑郁，不需要“等满一年”。【指南】
2. **持续性复杂哀伤障碍**（英文 prolonged grief disorder）在 DSM-5-TR 与 ICD-11 中已成为独立诊断，核心是长期的、强烈的思念与功能受损，时间门槛在成人通常为丧亲后 12 个月。它与普通悲伤的区别在于“卡住”和“无法重建生活”。

四、功能损害与需要排除的情况

领域	可以问的具体问题
工作学业	这周请了几天假？能不能完成基本任务？
日常自理	有没有几天不洗澡、不吃饭、不出门？
人际	有没有主动切断联系？是否频繁冲突？
育儿照护	能不能照顾孩子、老人？有没有把孩子推开或过度保护？
风险行为	是否大量饮酒、飙车、自伤？

需要排除的情况有三类。

第一类，**躯体与神经问题**：脑震荡后综合征、颅脑外伤、甲状腺功能异常、贫血、慢性疼痛、睡眠呼吸暂停。事故后的头晕、注意力差，可能既有心理因素也有脑震荡因素。

第二类，**物质与药物**：酒精、镇静药、兴奋剂、大麻；戒断反应。事件后“靠酒睡觉”很常见，也最容易把诊断带偏。

第三类，**其他精神障碍**：抑郁、焦虑、惊恐、PTSD、边缘型人格、精神分裂症谱系。要看症状是否早于事件存在——如果一个人在事件前就有长期的情绪不稳，事件可能只是加重因素。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 事件发生的时间（大致即可，不必讲细节）
- ☐ 症状从第几天开始，最早是什么
- ☐ 有没有“不真实感”“像在旁观自己”“记不起那一段”
- ☐ 睡眠、食欲、体重的变化
- ☐ 回避了什么：地点、人、话题、工作
- ☐ 有没有自责、无望、无价值感
- ☐ 酒精、安眠药、其他物质用了多少
- ☐ 功能：请假日数、能否照顾自己和孩子
- ☐ 事件前有没有类似的情绪问题
- ☐ 有没有自杀念头、自伤行为（请如实说）

常见误区

- **“急性应激障碍一定会变成 PTSD。”** 不一定，很多人一个月内明显缓解。但症状重、解离明显、缺乏支持的人风险更高。
- **“适应障碍是矫情，扛扛就过去了。”** 它有明确的诊断地位和功能损害，也可以严重到需要治疗。
- **“没到一个月不能看医生。”** 可以看，而且应该看。等待不会让诊断更准确，只会让人更孤立。
- **“丧亲后一年内不能诊断抑郁。”** 这个说法已经过时。
- **“解离就是疯了。”** 解离是常见的应激反应，不是精神病性症状。
- **“谈事件会加重症状。”** 强迫披露有害，但在安全、可控、有准备的前提下谈，是治疗的一部分。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划——立即拨打 120，或去最近医院急诊，不要独处。
> - 出现解离性漫游（不知道自己怎么到了某地）、长时间失忆、不认识熟悉的人——尽快急诊评估。
> - 连续多日不睡、不吃、不能照顾孩子或老人——尽快急诊。
> - 大量饮酒或吃安眠药后出现意识混乱、抽搐、呕吐——立即急诊。

> - 事件后出现剧烈头痛、呕吐、抽搐、意识时清时浊——先按躯体急症走急诊。
> - 症状持续一个月以上，或适应障碍超过半年仍未缓解——尽快精神科门诊。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.
- NIMH. Post-Traumatic Stress Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

7.3 复杂性创伤与解离的识别

有些人的创伤不是“一件事”，而是很多年：从小被打、被骂、被忽视、被性侵，或长期处在暴力的婚姻、家庭、机构里，逃不掉也说不出口。这类经历留下的影响，往往比单次事件更广，涉及情绪、自我认同、亲密关系和身体。这一页讲两件事：复杂性创伤在诊断上是什么样子，以及解离——那种“我不像我了”“这段记忆没了”的体验——怎么被识别和评估。

一、复杂性创伤：ICD-11 里的一个独立诊断

“复杂性创伤后应激障碍”（英文缩写 CPTSD）在 **ICD-11** 中是一个正式诊断，位置与 PTSD 并列。【指南】它的结构是：

- **PTSD 的三个核心群**：再体验（闪回、噩梦）、回避、当前威胁感（过度警觉）；
- **加上三个“自我组织紊乱”（DSO）的领域**：1. **情感调节困难**：一点小事就爆发，或长期麻木、空、无法感受；2. **自我概念受损**：持续羞耻、觉得自己有缺陷、无价值、失败；3. **关系困难**：难以信任、难以靠近、容易被触发，或在关系里反复讨好、退缩、失控。

需要强调：**DSM-5-TR 没有把 CPTSD 列为独立诊断**，它把这些表现分散在 PTSD、抑郁、解离障碍、人格障碍等条目下。所以同一个人的诊断名称，可能因为医生用哪套系统而不同。这不是谁对谁错，是分类系统的差异。【指南】

另外一个常见误解：CPTSD 不是“PTSD 更严重一点”。区别不在严重度，而在**症状的广度**——是否扩展到情绪调节、自我认同和关系模式。

二、长期人际创伤：为什么它不一样

典型的长期人际创伤包括：童年期反复的身体虐待、情感虐待、性虐待、严重忽视；长期家庭暴力；被控制、被拐卖、被强迫从事某种活动；长期霸凌；战争与难民经历；在封闭机构中受到系统性对待。

它和单次事故的差别在于四点：

1. **反复发生**：大脑学到的不是“这件事过去了”，而是“这件事随时会再来”；
2. **无法逃离**：尤其童年，施害者往往是照顾者，依赖与恐惧绑在一起；
3. **发生在关系里**：所以“人”本身变成了危险的来源，信任变得困难；
4. **发生在发育期**：影响情绪调节、自我感、依恋模式的形成。

这解释了一个常被误解的现象：为什么有些人明明离开了那个环境很多年，仍然一遇到相似的语气、表情、关门声就崩溃。那不是“还没放下”，是身体记住了。

三、解离：大脑的“断电”与“隔开”

解离是一个连续谱，从日常的“走神”到严重的身份与记忆断裂。常见的类型：

类型	体验描述	外人看到的样子
人格解体	觉得自己不是自己，像在旁观自己，身体陌	说话像在念稿，情感平淡

类型	体验描述	外人看到的样子
	生	
现实解体	世界变假、变平、像隔着玻璃，声音变远	反应慢，像“不在场”
解离性遗忘	记不起某段时间、某件事，甚至自己的信息	被问到时说“不知道”“一片空白”
身份混乱	不同状态下像变了个人，喜好、语气、记忆不连贯	家人觉得“前后不像同一个人”
解离性漫游	无目的出行，事后不记得怎么到的	突然出现在异地

关键区分：解离不是“装”，也不是“疯”。它是大脑在过载时切断连接的一种保护反应。很多人第一次听到“解离”这个词会说：“原来那种感觉有名字。”

也要和几个东西分开：

- **走神**：普通的注意力漂移，不伴记忆空白和身份改变；
- **癫痫的局灶性发作**：可有发呆、无目的的重复动作（自动症）、事后遗忘，需要神经科评估；
- **精神病性症状**：解离时的“内部声音”常是自己的想法变成声音，能与现实保持一定距离；幻听则更像“外面传来的声音”，常伴妄想；
- **物质作用**：酒精、大麻、镇静药都可造成类似体验。

四、评估、病程功能与需要排除的情况

访谈比量表重要得多。医生通常会问：

- 有没有“时间丢失”“事后发现自己在别处”；
- 有没有“觉得自己不是自己”“世界不真实”；
- 记忆是连续的，还是像有断片；
- 别人有没有说过“你刚才像变了个人”；
- 这些体验是什么时候开始的，和压力、睡眠、特定话题有没有关系。

量表方面，常用的有：

- **DES-II（解离体验量表）**：28 个条目，0–100% 自评，用于筛查解离体验的强度；它不能诊断，分数高只说明“值得进一步评估”。【研究】
- **结构化访谈**：如 SCID-D 一类的半结构化访谈，由受过训练的专业人员使用，用于区分解离性遗忘、人格解体、身份混乱等。
- **创伤史问卷**：如生活事件清单（LEC-5）、童年创伤问卷（CTQ），用于系统梳理经历，但**不是诊断工具**，也不该在第一次见面就要求逐条详述。

评解离有一个原则：**先建立稳定，再碰内容**。在一个人还没有基本的安全感和调节能力时，深挖创伤细节可能造成再创伤化。这不是回避，是顺序问题。

复杂性创伤的特点是**长期、跨情境、广泛**：

领域	常见表现
病程	症状常从童年或青春期开始，持续多年，随生活压力波动
情绪	长期低落、羞耻、易怒，或麻木、空虚
自我	“我是坏的”“我不配”“我是负担”

领域	常见表现
关系	难以信任、过度讨好、反复进入伤害性关系、或完全回避亲密
身体	慢性疼痛、胃肠不适、疲惫、躯体化
功能	学业中断、工作不稳、社交狭窄、育儿困难

功能损害的广泛程度，是复杂性创伤区别于单次事件 PTSD 的重要线索之一。

需要排除的情况：

类别	为什么像	区分线索
边缘型人格障碍	都有情绪不稳、自伤、关系困难、身份混乱	人格模式长期跨情境；CPTSD 的症状更明确围绕创伤与闪回
双相障碍	都有情绪大起大落	双相是发作性、有明确的持续天数与精力改变
精神分裂症谱系	都有“听到声音”、现实感异常	解离的声音多在脑内、可与现实检验共存；精神病性症状更持久
抑郁与焦虑	都有情绪症状	是否有事件锚定、解离、闪回
躯体疾病	慢性疼痛、疲惫、胃肠症状	检查结果、病程、与创伤线索的时间关系
物质与药物	酒精、镇静药可致遗忘与解离样体验	时间关系、停药观察

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 你想说到哪里、不想说什么，可以先写下来
- ☐ 有没有“时间丢失”“事后发现自己在别处”
- ☐ 有没有“不真实感”“像在旁观自己”
- ☐ 记忆是连续的，还是断断续续
- ☐ 别人有没有说过你“像变了个人”
- ☐ 情绪波动的触发点：语气、表情、关门声、某个地点
- ☐ 自伤、自杀念头（请如实说，这关系到安全）
- ☐ 睡眠、酒精与药物使用
- ☐ 目前是否仍处在不安全的环境里（这条最重要）

常见误区

- **“复杂性创伤就是 PTSD 的严重版。”** 不是。区别在症状广度，不在分数高低。
- **“解离就是多重人格。”** 解离是一个谱系，身份混乱只是其中一端，且诊断需要严格评估。
- **“谈创伤一定要把细节全讲出来。”** 不必。稳定优先，节奏由你掌握。
- **“时间久了自然会好。”** 一部分人会，一部分人需要针对性治疗；长期回避常让症状固化。
- **“有创伤史就一定能解释一切。”** 创伤是重要线索，但不能替代鉴别诊断。躯体病、物质、其他精神障碍都要排。
- **“诊断了 CPTSD 就没救了。”** 诊断描述的是当前状态和需要，不是判决。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划——立即拨打 120，或去最近医院急诊，不要独处。
> - 发生解离性漫游、长时间失忆、不认识熟悉的人或地方——尽快急诊评估。
> - 目前仍处在暴力、控制、性侵的环境中——先联系可信任的人、报警（110）或当地庇护机构，安全优先于诊断。
> - 解离发作时出现冲出马路、自伤、误食等危险行为——先保证环境安全，必要时急诊。
> - 出现命令性幻听让你伤害自己或他人——立即急诊。
> - 大量饮酒或镇静药后出现意识混乱、抽搐——立即急诊。

确诊之后，医生通常会先评估安全（是否仍在危险环境、有无自伤自杀风险）、稳定程度（睡眠、物质使用、支持系统），再决定治疗顺序。复杂性创伤的治疗通常分阶段：先建立稳定与情绪调节能力，再处理创伤记忆，最后重建关系与生活。具体方案由面诊医生或治疗师决定。

参考来源

- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（Complex PTSD）.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.
- Bernstein EM, Putnam FW. Development, reliability, and validity of a dissociation scale（DES）. Journal of Nervous and Mental Disease, 1986.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

7.4 创伤相关障碍与焦虑、抑郁、人格的鉴别

经历过创伤的人来就诊，主诉常常不是“我有闪回”，而是“我睡不着”“我高兴不起来”“我一谈恋爱就崩”。这时候，医生面对的是一个容易出错的岔路口：把创伤反应误当成抑郁，把抑郁误当成创伤，把长期的关系困难直接归给人格问题。这一页讲 PTSD 与焦虑、抑郁、双相、边缘型人格的重叠在哪里，以及“先后顺序”和“因果链”为什么是鉴别诊断的核心工具。

一、为什么会混：四重原因

1. **症状本来就重叠**。PTSD 有情绪低落、兴趣减退、注意力差、失眠；抑郁也有这些。PTSD 有过度警觉、惊跳；焦虑也有。
2. **共病率很高**。PTSD 与重性抑郁的共病在不同研究中常被引用为接近一半，与焦虑障碍的共病也很常见。【研究】共病不是例外，是常态。
3. **时间上互相纠缠**。创伤后先出现抑郁，几个月后才出现闪回；或者先有长期焦虑，遇到事件后加重。只问“现在有什么症状”，很难分开。
4. **叙事会被诊断塑造**。一个人被诊断为抑郁多年，可能从没人问过创伤史；反过来，一个人一旦被贴上“创伤”的标签，之后所有症状都可能被归给创伤。

二、与抑郁、焦虑的边界

抑郁：看“事件锚定”和“弥漫程度”

维度	更像 PTSD	更像抑郁发作
触发	具体线索引发闪回、惊恐、僵硬	清晨加重，与具体线索关系不大
内容	反复回到同一个场景、同一种恐惧	弥漫的自我否定、无望、兴趣丧失
回避	回避特定地点、人、话题	回避社交是因为没力气、没意义
睡眠	噩梦、易醒、警觉	早醒或入睡困难，不一定有噩梦
自责	围绕事件：“我当时应该……”	围绕自我：“我这个人就是失败”

两者**可以同时成立**，这时诊断会写“PTSD 共病重性抑郁障碍”。共病不是诊断不精确，而是临床事实。

一个实用追问：**“如果那件事从来没发生，你现在的情绪会不一样吗？”** 回答往往能提示症状与事件的关联强度。

焦虑：威胁是“过去留下的”，还是“未来可能发生的”

广泛性焦虑的核心是“未来会出事”的担忧，内容随生活变化：钱、健康、工作、家人。PTSD 的核心是“过去的事还在发生”的体验：闪回、噩梦、被触发。

- 焦虑的人怕“万一”，PTSD 的人怕“又来”。
- 焦虑的人警觉是泛化的，PTSD 的人警觉常被特定线索点燃。
- 惊恐发作两者都可有，但 PTSD 的惊恐常与创伤线索绑定。

PTSD 也常与惊恐障碍、社交焦虑、广场恐惧共病。回避行为尤其容易混：一个不敢坐公交的人，可能是怕惊恐发作（广场恐惧），也可能是怕路过事发地点（PTSD）。

三、与双相、边缘型人格的边界

双相：看“发作性”和“精力”

这是最容易被漏掉的一条，因为漏掉的代价很大（治疗方向完全不同）。

维度	更像 PTSD / CPTSD	更像双相障碍
情绪变化	由线索触发，几分钟到几小时	持续数天到数周的发作
睡眠	失眠、噩梦，但精力通常下降	睡眠需求明显减少而精力旺盛
活动	回避、退缩	目标性活动增多、话多、计划多
自我评价	羞耻、无价值	夸大、自信膨胀
家族史	不一定	常有双相或抑郁家族史

提醒两点：第一，双相患者常共病 PTSD，创伤史不会“排除”双相；第二，抗抑郁药后出现“像换了个人”，要回头追问轻躁狂史，而不是简单归为“创伤被激活”。

边缘型人格：最容易吵起来的一条边界

边缘型人格障碍（BPD）与复杂性创伤的重叠非常高，研究里两者共病常见，临床上常被混用。【研究】

维度	更偏 CPTSD	更偏 BPD
起病	症状明确围绕创伤，闪回与回避突出	长期的关系、身份、冲动模式，跨情境
自伤	多为调节解离与闪回	多为调节被抛弃感、表达痛苦、影响他人
关系	难以信任、易被触发	剧烈起伏、理想化与贬低交替、害怕被弃
身份	自我感缺失、羞耻	身份紊乱、目标与价值观反复改变
独处	可能偏好独处以避免触发	常难以忍受独处

这里必须说清楚两件事：

1. **BPD 不是“人格有缺陷”，也不是“矫情”。** 它是有明确诊断标准、有有效治疗、且常与创伤相关的一种障碍。用贬义的方式说“你就是人格问题”，既不准确，也有害。
2. **有创伤史不等于有 BPD，有 BPD 也不等于一定有创伤史。** 两者相关，但不是因果等式。

四、因果链、时间顺序与病程功能

鉴别不是“二选一”，而是画出一条时间线：

1. **事件之前**：有没有长期的焦虑、情绪低落、冲动、人际困难？如果有，说明这些可能是原发的或体质性的。
2. **事件之后**：症状在多久内出现？是否与事件内容相关？是否随事件线索波动？
3. **之后的变化**：有没有完全缓解的时期？有没有发作性的精力改变？有没有物质使用？
4. **当前维持因素**：睡眠、酒精、持续的威胁、家庭环境、经济压力。

四种常见的因果链：

- **创伤 → PTSD → 抑郁**（最常见）；
- **抑郁 → 回避与退缩 → 更容易遭遇事件**（间接路径）；
- **长期焦虑 → 事件后症状更重**（易感因素）；
- **双相或 BPD → 事件被卷入发作**（事件是触发，不是全部原因）。

诊断顺序的一般原则是：**先排除躯体与物质原因，再处理最危险、最可治的部分，最后才做人格层面的判断**。人格诊断通常需要长期观察，不宜在急性期下结论。

两条辅助线：

- **病程形态**：PTSD 慢性波动、与线索相关；抑郁是发作性，可有完全缓解期；双相是发作性且伴精力改变；BPD 是长期、跨情境、从青春期早期就有端倪。
- **功能损害形态**：PTSD 的损害集中在回避与警觉；抑郁集中在动力与兴趣；双相集中在发作期的失控与后果；BPD 集中在关系与冲动控制。

这两条线不能单独定诊断，但能帮医生判断“哪个是主线”。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊准备清单

- ☐ 画一条时间线：创伤事件、首次情绪问题、首次就医、首次用药
- ☐ 标注有没有“完全正常的时期”，持续多久
- ☐ 记录情绪波动的持续时间：几小时，还是几天
- ☐ 记录睡眠需求的变化：是睡不着，还是不需要睡
- ☐ 记录自伤的时间与情境：是为了缓解闪回，还是因为害怕被抛弃
- ☐ 记录关系模式：是否长期剧烈起伏
- ☐ 列出既往诊断与用药反应，特别是“吃药后像变了个人”
- ☐ 家族史：双相、抑郁、自杀、物质使用

常见误区

- **“有创伤史就一定是 PTSD。”** 创伤是风险因素，不是诊断本身。
- **“抑郁就是 PTSD 的一部分，不用单独治。”** 共病需要分别评估，治疗重点可能不同。
- **“BPD 就是创伤造成的。”** 相关，但不是简单因果；BPD 也有遗传与气质因素。
- **“诊断人格问题就是给这个人判死刑。”** 人格障碍可以治疗，且诊断会随年龄与治疗改变。
- **“先把创伤挖出来，其他症状就会好。”** 顺序常常相反：先稳定，再处理记忆。
- **“共病就是医生没本事，不能给一个明确诊断。”** 共病是真实的临床现象，不是诊断失败。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划——立即拨打 120，或去最近医院急诊，不要独处。
> - 出现明显的兴奋、几天不睡、话多停不下来、冲动消费或冒险——尽快精神科急诊评估，警惕躁狂发作。

> - 出现命令性幻听、坚信被迫害——立即急诊。
> - 自伤伤口较深、出血不止、或伴感染——先急诊处理伤口。
> - 大量饮酒或镇静药后意识混乱、抽搐——立即急诊。
> - 目前仍处在暴力或控制关系中——先保证安全，报警（110）或联系庇护机构。

鉴别创伤相关障碍，靠的不是“哪个症状更像”，而是三件事：**事件锚定、时间顺序、功能损害形态**。三者对上，诊断才站得住；对不上，就要考虑共病、躯体原因，或者干脆写到“待观察”。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management（CG185）, 2014（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

7.5 创伤史询问与量表

“医生会不会让我把那天的事从头讲一遍？”这是很多人不敢去精神科的原因之一。答案是：不需要。诊断创伤相关障碍，不靠你复述细节，而靠症状模式、时间线、功能损害和排除条件。这一页讲医生通常怎么问创伤史、PCL-5 这类量表能做什么不能做什么、以及为什么“不强迫披露”不是客气话，而是一条专业原则。

一、询问创伤史的目的，不是“挖出来”

先明确三件事：

1. **为了诊断**：确认症状是否与事件相关，判断是否符合创伤暴露的前提。
2. **为了安全**：了解目前是否仍处在危险中（施害者是否还在身边、是否有自伤风险）。
3. **为了治疗计划**：决定先稳定还是先处理记忆。

不是为了满足好奇，也不是为了让你“哭出来就好了”。**披露本身不是治疗**，在准备不足时强行披露，可能造成再创伤化。【临床经验】

二、怎么问：从远到近，从功能到细节

专业询问通常遵循几条原则：

- **先说明目的与边界**：“我需要了解大概发生了什么，来判断你的症状和它的关系。细节你可以不说，随时可以停。”
- **从一般到具体**：先问“有没有经历过让你觉得生命受威胁、或身体受到严重伤害的事”，再逐步缩小。
- **用行为化、中性的语言**：避免“你是不是被……”这种带预设的追问。
- **多问影响，少问细节**：“这件事之后，你睡觉怎么样？”“有没有什么地方你不敢去？”
- **允许沉默和拒绝**：沉默不是不配合，可能是解离、羞耻或恐惧。
- **注意节奏**：一次门诊不必问完，可以分次。

场景	容易造成伤害的问法	更安全的问法
开场	“你到底经历了什么？从头说。”	“我需要了解一个大概，不用讲细节，你可以随时停。”
追问	“他为什么打你？你是不是做了什么？”	“那次之后，你身上有没有受伤？当时有人帮你吗？”
性相关	“具体做了什么？”	“有没有人违背你的意愿碰过你？说是或不是就可以。”
童年	“你父母是不是虐待你？”	“小时候在家里，有没有人让你觉得害怕、或者没人管你？”
反应	“你怎么还在想这件事？”	“这些画面一般什么时候来？来了之后你做什么？”

三、几个结构化工具，以及量表的局限

工具各自管什么

生活事件清单（LEC-5）：列出十几类可能的事件（自然灾害、事故、暴力、性侵、战斗、严重疾病、亲人意外死亡等），让受试者勾选“经历过、目睹过、听说过、工作接触过”。它的作用是**系统不漏项**，不是打分诊断。

童年创伤问卷（CTQ）：覆盖情感虐待、身体虐待、性虐待、情感忽视、身体忽视五个方面。它用于研究和临床筛查，能帮助梳理“长期、反复”的模式，但**不能替代访谈**，也不该被当成“创伤分数”。

不良童年经历问卷（ACE）：十类童年逆境，常用于公共卫生研究。它的问题是“累积风险”，不是诊断工具；分数高不等于一定有病，分数低也不等于没有受到影响。

PCL-5（DSM-5 版创伤后应激障碍检查表）：20 个条目，对应 DSM-5 的 PTSD 症状群，0–4 分评分，总分 0–80。它有三个常见用途：

- **筛查**：常被引用的参考界值在 31–33 分之间，提示“可能符合 PTSD，需要进一步评估”；
- **严重度监测**：治疗前后对比，看变化；
- **随访**：追踪症状波动。

它不能确诊。 确诊需要由受过训练的专业人员做结构化访谈（如 CAPS-5），结合病程、功能损害和排除条件。PCL-5 的分数高低，也不等于痛苦的大小。

量表的局限

局限	具体表现
回忆偏差	时间越久，记忆越容易被重构；情绪状态也会影响回忆
回避与否认	有人不愿承认症状，分数偏低；有人希望被看见，分数偏高
急性期	事件后几天填，症状还在变化，预测力有限
文化与语言	条目翻译、表达习惯、对“闪回”的理解差异
共病	抑郁、焦虑、解离都会推高分数
反复测量	可能变成求保证行为，短期安心、长期强化焦虑

还有一个常被忽略的问题：**量表本身可能成为一种仪式**。有人每天测一次，分数高就恐慌，分数低就怀疑自己“装病”。如果出现这种情况，应该和医生讨论，而不是继续测。

分数高时，还要想到别的解释

PCL-5 高分不等于只有 PTSD。至少要过一遍这几类：

- **抑郁与焦虑**：情绪低落、担忧、失眠都会推高条目分；
- **解离与解离障碍**：麻木、失真感会被误答成“情感麻木”；
- **物质与药物**：酒精、镇静药、兴奋剂既造成症状，也干扰作答；
- **躯体与睡眠问题**：疼痛、睡眠呼吸暂停、甲状腺问题会模仿警觉与疲劳；
- **急性应激与适应障碍**：时间线还没走到“一个月”，分数却已经很高。

病程与功能仍然是必需的：症状从什么时候开始、有没有缓解期、是否随周年日或新闻波动；工作、学业、睡眠、人际、育儿、经济分别受到什么影响。量表分数不能替代这两块——一个 40 分但生活基本维持的人，和一个 25 分但已经无法出门的人，医生给出的判断会不一样。这也是为什么量表只能做筛查与随访，不能单独构成诊断。

四、不要强迫披露：一条专业原则

“不强迫披露”不是纵容回避，而是基于几个现实理由：

- **再创伤化**：在缺乏稳定与安全感时详述创伤，可能引发闪回、解离、自伤冲动；
- **解离状态下信息不可靠**：人在解离时可能记不清、说不清，甚至事后不记得说过什么；
- **信任需要时间**：披露的前提是“我说话是安全的”，这在第一次门诊往往还不成立；
- **目的不同，要求不同**：治疗性评估和法律取证是两件事，后者需要专门的程序与规范。

替代做法是：**先问功能，后问内容**。比如不问“他具体怎么打的”，而问“那段时间你能上学吗”“晚上能睡着吗”“有没有人知道”。这些信息同样能支持诊断。

如果对方说“我不想说”，专业的回应是：“好，那我们不说这部分。以后你想说的时候再告诉我。”——然后继续问别的。

特殊情境要额外留意：

- **儿童**：用适龄语言，避免诱导性提问（“是不是某某做的？”），注意非施害方的照护者是否在场；孩子的叙述易受暗示，需要更谨慎。
- **老年**：可能有早期的创伤史从未被问过；同时要区分创伤反应与痴呆、抑郁、躯体疾病。
- **男性**：性侵与家暴的披露率低，羞耻感强，常以酒精、易怒、工作狂呈现。
- **性少数与少数群体**：要区分“创伤事件”与“长期的社会歧视压力”，后者也会造成持续警觉与回避，但不一定符合 PTSD 的创伤前提。
- **司法与工伤情境**：评估目的不同，需提前说明“这次评估的用途”，避免让当事人误以为在治疗。

五、就诊准备、误区与就医时机

就诊前可以准备的清单

- ☐ 先想清楚：哪些我愿意说，哪些暂时不说（可以写在纸上）
- ☐ 事件的大致时间与类型（不需要细节）
- ☐ 症状清单：睡眠、噩梦、闪回、回避、易怒、麻木
- ☐ 功能：请假日数、能否出门、能否照顾孩子
- ☐ 目前是否仍处在不安全的环境
- ☐ 酒精、镇静药、其他物质的使用
- ☐ 有没有自杀念头、自伤行为
- ☐ 想问医生的问题：- [ ] 我需要做量表吗？结果代表什么？- [ ] 会不会需要做躯体检查？- [ ] 治疗大概分几个阶段？- [ ] 如果我说不下去，可以怎么处理？

常见误区

- **“不问细节就是不负责。”** 诊断不依赖细节，依赖症状、时间线、功能和排除。
- **“量表分数高才是真的受过伤。”** 分数是筛查工具，不是伤害的度量。
- **“必须一次讲完，医生才能帮我。”** 可以分次，可以只说大概，可以随时停。
- **“我不说，医生就诊断不出来。”** 医生可以从功能、回避、警觉、睡眠等侧面获得信息。
- **“PCL-5 高分就是 PTSD。”** 它提示需要进一步评估，确诊靠临床访谈。
- **“反复测一测心里有底。”** 反复测量可能是求保证，反而维持焦虑。

什么时候需要联系医生或去急诊

> - 在谈到创伤时出现强烈解离、失控、自伤冲动——先停下，联系医生；若已发生自伤，立即拨打 120 或去急诊。
> - 出现自杀念头、计划或准备行为——立即急诊，不要独处。
> - 披露后持续数日失眠、无法进食、无法照顾自己或孩子——尽快联系医生。
> - 目前仍处在暴力、控制、性侵环境中——先保证安全，报警（110）或联系当地庇护机构。
> - 出现解离性漫游、长时间失忆——尽快急诊评估。
> - 大量饮酒或镇静药后意识混乱、抽搐——立即急诊。

这一页想留下三句话：问创伤史的目的是判断关联与安全，不是让你复述；量表负责筛查和随访，访谈负责诊断；披露的节奏，应该由承受的人掌握。

参考来源

- Weathers FW, et al. The PTSD Checklist for DSM-5（PCL-5）. National Center for PTSD, 2013.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 8：进食障碍确诊

进食障碍不只是“吃多吃少”，而是行为、体重、体像和躯体并发症的组合。

8.1 神经性厌食

神经性厌食是进食障碍里躯体风险最高的一类，也是最容易被家人误以为“只是太自律、太挑食”的一类。这一页讲医生依据什么考虑这个诊断、限制型和暴食清除型差在哪里、哪些躯体信号意味着不能再等。读完之后，你至少能分清：**体重低本身不是诊断，医生会同时看体重、怕胖和体像三件事**。

一、诊断看什么：三根支柱

【指南】按 DSM-5-TR 的思路，医生考虑神经性厌食时，通常同时看三组表现：能量摄入长期低于身体需要，导致体重明显偏低；对增重有强烈恐惧，或者有持续阻碍增重的行为；对自己体重和体形的体验出现扭曲，自我评价过度受体重、体形影响，或者始终不认为低体重是个问题。这三组表现要互相印证，而不是拿一张单子逐条打勾。

以 DSM-5-TR、ICD-11 原文和医生的结构化访谈为准。ICD-11 的写法更强调“显著低体重”或“体重快速下降”，两套标准在细节上并不完全一样，所以同一个人在不同医院可能得到措辞不同的名称。

体重：低到什么程度算低

成人门诊里，医生常用 BMI（体重公斤数除以身高米数的平方）做参照，18.5 以下通常被视为偏低。但这个数字只是参照，不是判据：

- **儿童和青少年**要看年龄性别对应的生长曲线和 BMI 百分位。一个孩子从原来的第 75 百分位掉到第 10 百分位，比“绝对数字还行”更值得警惕。
- **下降速度**和绝对值同样重要。有研究提示，短期内快速掉重的人，即使 BMI 还没跌到很低，也可能已经出现心率、电解质问题【研究】。
- **起点体重偏高的人**更容易被漏掉。原本体重较大的人掉到“正常范围”，看上去不瘦，但医生会追问掉了多少、多快、怎么掉的。

怕胖：不只是“想瘦一点”

怕胖的表现不一定是嘴上说“我怕胖”。很多人会说“我不是怕胖，我只是想健康一点”“我只是不想水肿”。医生更看行为：

- 反复称重、量围度，一天很多次；
- 把食物切成小块、拖很久才吃完、把食物藏起来或偷偷丢掉；
- 用大量喝水、喝黑咖啡、嚼口香糖、吃大量蔬菜来“占住胃”；
- 拒绝在别人面前吃饭，或坚持自己做饭、自己装盘；

- 为“抵消”一点点食物而增加运动，运动带有明显的强迫性和补偿性。

体像：照镜子和心里那张图对不上

体像障碍（对身体外形的主观体验扭曲）是这一诊断里最容易被忽略、也最容易被家属否认的一条。患者可能已经明显消瘦，仍觉得自己“某个部位很胖”；或者承认瘦了，但认为“再瘦一点才安心”。还有一种情况是**缺乏对严重性的认识**：本人不觉得有问题，是家人、同学、体检医生发现异常。

这三条里，体重是最容易测量的，怕胖和体像最容易被漏掉。所以规范的面诊会问得很具体：最近吃什么、怎么吃、和谁吃、吃完做什么、有没有称重、有没有催吐或用药。

二、限制型与暴食清除型

DSM-5-TR 把神经性厌食分成两个亚型，区分点在于最近一段时间（通常按近三个月看）有没有反复的暴食或清除行为，而不是体重高低。

亚型	主要行为	常见线索	躯体风险侧重
限制型	靠少吃、禁食、过度运动减重，没有反复暴食或清除	吃得越来越少、食物种类越删越多、运动量明显增加	营养不良、心率慢、骨密度下降
暴食清除型	有反复暴食，或用催吐、泻药、利尿剂、灌肠等清除	体重可能不算极低、腮腺肿大、牙釉质磨损、手背有茧	电解质紊乱、心律失常、消化道损伤

需要说明的是，亚型不是终身标签，同一个人可以在两个亚型之间移动，也可能先表现为限制型，后来出现暴食清除。临床上还有一个容易被忽略的群体：体重并不算极低，但行为模式已经很像厌食，这类人在 ICD-11 里可能被归到别的名称下。**不要因为体重“还过得去”就排除这个方向。**

三、病程、功能损害与严重度

诊断不只看当下这一刻。医生会问：这种状态持续多久了？是几个月还是几年？中间有没有好转期？体重的最低点是多少？

病程上，神经性厌食常在青少年期起病，起病往往被一段“开始减肥”“开始吃素”“开始健身”的经历包裹着，家属很难指出确切日期。青少年起病者如果拖到成年才就诊，往往已经合并骨密度下降、身高增长受限、学业中断等长期后果。

功能损害是这个诊断的必要部分，不是附加项【指南】：

- **学业与工作**：注意力、记忆受营养不良影响，成绩下滑、缺课、休学；
- **社交**：回避聚餐、回避集体活动，逐渐与朋友断联；
- **家庭**：饭桌变成冲突现场，家人轮流监督吃饭，全家生活被进食问题占据；
- **医疗**：反复门诊、检查、住院，花费大量时间和钱。

严重度上，DSM-5-TR 用成人 BMI 分档（轻度、中度、重度、极重度），但医生不会只看 BMI：心率、血压、电解质、有没有晕厥、有没有自伤自杀风险，都会影响“这个人在哪一档、要不要住院”。

四、躯体并发症与住院指征

神经性厌食不是“瘦一点、难看一点”，它是会累及多个系统的疾病。低体重和清除行为会带来：

- **心血管**：心率偏慢、血压偏低、站起来头晕（体位性低血压）、心悸、心电图改变（如 QT 间期延长）；
- **电解质与代谢**：低钾、低钠、低磷、低镁，代谢性碱中毒或酸中毒，低血糖；
- **消化**：便秘、腹胀、胃排空延迟、反流，暴食清除型还可能出现食管撕裂、胰腺炎；
- **内分泌与骨骼**：月经停止或闭经、甲状腺功能指标“假性偏低”、骨密度下降、骨折风险升高；
- **血液**：贫血、白细胞减少；
- **皮肤与毛发**：皮肤干燥、怕冷、胎毛样细软毛发增多、脱发；
- **神经与认知**：注意力下降、反应变慢、情绪低落、易怒。

其中**再喂养综合征**（重新加量进食后出现的严重电解质紊乱，尤其是低磷）是最危险的一幕，可能发生在住院“开始好好吃饭”之后的几天内，所以恢复进食必须在医疗监测下进行，不能家属自己在家猛补。

住院指征各地标准略有差异，但通常会考虑以下情况【指南】【临床经验】：

- 体重极低或短期内快速下降；
- 心率持续偏慢、血压低、有晕厥或体位性低血压；
- 电解质明显异常，或心电图异常；
- 低体温、脱水；
- 反复严重暴食清除，或滥用泻药、利尿剂、减肥药；
- 合并严重抑郁、自伤自杀风险；
- 门诊治疗无效，或家庭无法保证进食环境；
- 青少年生长停滞、学校功能完全中断。

具体到某个人是否需要住院，由精神科与内科、营养科共同判断，不靠单一数字。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 出现以下任一情况，不要等下次门诊：晕厥或差点晕倒、站起来眼前发黑、心跳很快或很乱、胸痛、抽搐、意识模糊、说话含糊、持续呕吐无法进水、呕血或黑便、明显乏力到走不动、体重一周内掉得很快。请立即拨打 120 或去最近医院急诊，并告诉接诊医生“最近吃得很少/有催吐或泻药”，这句话会直接影响处理。
>
> 如果本人有自杀念头、自伤行为，或已经写下计划，不要独处，让家人陪着，拨 120 或去精神科急诊；也可拨 12356 心理援助热线。**低体重合并自杀风险，是需要住院评估的组合**，不是“想开点”能解决的。

五、鉴别：看起来像厌食、但不是的情况

医生不会只凭“瘦 + 吃得少”下结论。至少有三类情况需要先排开：

类别	具体例子	关键区别
躯体疾病	甲亢、1 型糖尿病、炎症性肠病、乳糜泻、结核、肿瘤、胃轻瘫、肠系膜上动脉压迫综合征	有相应化验/影像异常；甲亢多是吃得多还瘦，糖尿病有多饮多尿，胃肠病有腹痛腹泻；通常没有怕胖和体像扭曲
物质与药物	兴奋剂、减肥药、泻药滥用、化疗药、部分	有明确用药或物质使用史；停药后食欲体重可

类别	具体例子	关键区别
	抗抑郁药引起的食欲下降	回升；动机不是怕胖
其他精神障碍	抑郁障碍（食欲下降、体重掉）、强迫症（进食仪式、怕污染）、回避限制性摄食障碍（ARFID）、精神病性障碍（怕被下毒）、孤独症谱系的刻板进食	抑郁以情绪低落和兴趣丧失为主，不伴怕胖；ARFID 是“不感兴趣/怕噎/挑质地”，没有体像问题；强迫的回避是为了减焦虑，不是为了减重

还有两类常被忽略：**社交焦虑或创伤相关的进食回避**，以及**文化性禁食**（宗教斋戒、极端节食风气）。医生会看动机、看有没有体像扭曲、看恢复后的反应，而不是看体重一个数。

六、就诊前可以准备什么

门诊时间有限，准备得越具体，判断越准。可以照着下面这份清单写下来带给医生：

- ☐ 体重变化：最早什么时候开始掉、最低多少、现在多少、身高多少；家里有没有旧照片或体检记录
- ☐ 最近两周典型的一天吃什么、喝什么，包括零食、饮料、代餐
- ☐ 有没有暴食（一次吃下明显多于常人的量、感觉停不下来），大概多久一次
- ☐ 有没有催吐、泻药、利尿剂、减肥药、灌肠，频率多少
- ☐ 运动情况：种类、时长、是不是“不运动就难受”
- ☐ 月经：最后一次时间、是否规律、有没有停经（女性）；男性也要问性欲和晨勃变化
- ☐ 躯体症状：头晕、心悸、怕冷、便秘、脱发、乏力、注意力差
- ☐ 最近有没有晕倒、抽搐、呕血
- ☐ 情绪与风险：有没有绝望感、自伤、自杀念头
- ☐ 既往检查：血常规、电解质、肝肾功能、甲状腺、心电图、骨密度
- ☐ 用药与保健品：包括中药、减肥茶、代购药
- ☐ 家族史：进食障碍、抑郁、焦虑、酒精使用
- ☐ 家属观察：吃饭时的行为、藏食物、饭后立刻去卫生间、情绪变化

家属陪同很有价值，但要注意方式。**在诊室里指责“你就是不吃饭”，通常换来沉默或对抗**；更有效的是描述事实：“这三个月她只吃水煮菜，晚饭后常去卫生间，体重从 52 公斤降到 41 公斤。”

常见误区

- **“体重正常就不是厌食。”** 暴食清除型的体重常常在正常范围甚至偏高，但躯体风险并不低。
- **“能吃就是没病。”** 暴食也是症状；而且很多人在外面吃、回家吐。
- **“她只是爱美/自律。”** 自律是选择，厌食是选择能力被压缩：明知有害也停不下来。
- **“逼她吃下去就好了。”** 突然大量进食可能诱发再喂养综合征；进食恢复需要节奏和监测。
- **“这是青春期叛逆，长大就好。”** 拖延与病程迁延、骨密度下降、慢性化相关，早识别早干预更重要【研究】。
- **“查了甲状腺和胃肠都正常，所以是装病。”** 正常结果恰恰排除了部分“躯体模仿者”，支持医生往进食障碍方向想。

确诊之后通常怎么走

确诊不是终点。规范做法通常包括：营养康复（把进食量和体重逐步拉回安全区间）、针对进食障碍的心理治疗（如聚焦青少年/家庭的疗法、认知行为取向）、监测躯体指标、处理共病（抑郁、焦虑、强迫、创伤）。药物可能在合并抑郁或焦虑时使用，但**具体用不用、用什么、用多久，由面诊医生决定，本页不涉及剂量**。

对家属来说，最实际的两件事：一是把“吃饭”从道德评判里拿出来，当成一件需要配合治疗的事；二是别独自扛，照护者也需要支持。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（进食障碍部分）.
- NICE. Eating disorders: recognition and treatment (NG69), 2017（2020 更新）.
- NIMH. Eating Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

8.2 神经性贪食

神经性贪食最容易被误解成“管不住嘴”，实际上它的核心是一段反复出现的失控进食，加上事后的补偿行为，以及强烈的羞耻感。这一页讲医生依据什么考虑这个诊断、为什么体重正常的人也可能很严重、以及和其他“吃得多”的情况怎么分开。读完之后，你大概能判断：**暴食本身不是诊断，暴食加反复补偿、再加自我评价被体重体形绑住，才构成医生关注的方向。**

一、核心是“暴食 + 补偿”，不是“吃得多”

【指南】按 DSM-5-TR 的思路，医生考虑神经性贪食时会看三件事：反复出现暴食发作；反复使用不恰当的补偿行为来防止体重增加；自我评价过度受体重和体形影响。暴食和补偿都要达到一定频率（通常按每周至少一次、持续三个月来把握），而且这些表现不能只发生在神经性厌食的病程里。具体条目与时间门槛以 DSM-5-TR、ICD-11 原文和医生访谈为准。

“一定频率”这句话很重要。逢年过节吃撑一次、聚餐后愧疚两天，不构成诊断；诊断看的是**反复、持续、失控**，以及它有没有把生活拧歪。

暴食长什么样

暴食（binge eating）不是“胃口好”，通常有几个特征：

- **量**：在一个独立时间段里吃下的东西，明显多于多数人在同样情境下的量；
- **失控**：吃着吃着停不下来，或者明知道不该吃还是继续；很难在想要的时候停下；
- **速度**：吃得比平时快很多，几乎不咀嚼；
- **感受**：吃到不舒服、胀痛仍继续；常常独自吃，因为羞于被别人看见；
- **事后**：强烈的厌恶、内疚、抑郁、自我谴责。

暴食时吃的东西往往是平时禁止自己吃的：甜食、油炸、主食、整袋零食。这和“嘴馋”不同——嘴馋是享受，暴食是失控加痛苦。

补偿行为：清除只是其中一种

补偿行为不只催吐。医生会逐一问：

- 自我诱吐；
- 滥用泻药、利尿剂、减肥药、灌肠；
- 禁食或极度限制下一餐；
- 过度运动（不是为了健康，而是为了“抵掉”刚才吃的）；
- 在 1 型糖尿病中故意少打或漏打胰岛素（有时被称作“代偿性胰岛素省略”，风险很高）。

很多人以为“吐出来就没吸收”，其实催吐只能排出胃里的一部分，热量吸收已经发生；而且反复催吐带来的电解质紊乱和心律失常，比体重问题更危险。

自我评价被体重体形绑住

这一条常被家属忽略。患者可能体重完全正常，但一天的大部分注意力都在体重、围度、镜子、食物上；一天的心情由早上称的数字决定。这种“自我价值 = 体重”的结构，是进食障碍诊断里的关键，也是它和普通“爱美”的分界线。

二、体重多正常，所以更容易被漏掉

神经性贪食患者的体重**多数在正常范围**，少数偏低或偏高。这带来两个后果：

1. **家人看不出来**。饭桌上可能一切正常，暴食发生在深夜、独处、外卖；
2. **医生也容易漏**。因为不瘦、不吐在明面上，主诉常是“胃不舒服”“月经乱”“情绪差”“牙齿敏感”，进食问题要主动问才会说出来。

【研究】贪食的患病率在女性青少年和年轻成人中相对较高，但男性、年长者、体重偏高者同样存在，只是更少被识别。男性患者更常被误认为“健身/增肌”或“就是能吃”。

医生常看的躯体线索包括：

线索	可能提示
腮腺、下颌角反复肿大（“蛙腮”）	长期催吐
牙釉质磨损、牙齿敏感、多龋	胃酸反复接触牙面
手背指关节处的茧或色素沉着	用手指诱发呕吐时的摩擦
血钾低、血氯低、代谢性碱中毒	催吐或滥用泻药、利尿剂
反复腹胀、便秘或腹泻	泻药依赖、肠道功能紊乱
月经不规律或停经	体重波动、营养不足、内分泌紊乱

这些线索只是提示，不是诊断依据。有这些表现的人也可能因为其他原因（如唾液腺疾病、胃食管反流、药物副作用）出现类似情况。

三、病程、功能损害与严重度

医生会问时间线：第一次暴食大概什么时候？那时有没有在节食？暴食和节食常常是一对循环——越严格限制，越容易在某个点崩掉，暴食后又更严格限制，循环加固。

病程上，贪食多在青少年后期到二十多岁起病，常常先有一段节食或减重经历。有人持续几个月，有人断断续续十几年。**“时好时坏”是常见形态，不代表不严重。**

功能损害通常体现在：

- **经济**：大量花钱买食物，事后又为钱焦虑、借钱、瞒着家人；
- **社交**：拒绝聚餐，或聚餐后立刻找借口离开去吐；逐渐不出门；
- **学业工作**：注意力被食物和体重占据，效率下降、缺勤；
- **身体**：反复就医查胃、查牙、查月经，却没人问到进食行为；
- **情绪**：羞耻、自责、抑郁、焦虑，部分人出现自伤。

严重度上，DSM-5-TR 主要按暴食和补偿行为的频率分档（轻度、中度、重度、极重度）。但临床判断不会只看次数：血钾、心律、有没有晕厥、有没有自杀风险，权重更高。

四、躯体并发症与需要急诊的信号

贪食的危险，很多时候不在体重，而在**清除行为**：

- **电解质紊乱**：低钾最常见，可导致乏力、心悸、心律失常，极端情况下心脏骤停；低氯、代谢性碱中毒也常见；
- **心血管**：心悸、胸闷、心电图改变（QT 延长、心律不齐）、体位性低血压、晕厥；
- **消化系统**：反流性食管炎、食管溃疡、贲门黏膜撕裂（呕血）、罕见但致命的食管或胃破裂；滥用泻药导致结肠功能紊乱；
- **口腔**：牙釉质侵蚀、龋齿、牙齿敏感、牙周问题；
- **腺体**：腮腺、唾液腺肿大；
- **其他**：脱水、皮肤干燥、指关节胼胝、月经紊乱、骨质疏松风险升高；
- **药物相关**：长期滥用吐根糖浆可致心肌损伤；滥用利尿剂、泻药可致严重脱水与肾前性损伤。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 出现以下任一情况，不要等到下次门诊：呕血或咖啡色呕吐物、剧烈腹痛且不缓解、心跳很快或很乱、胸闷胸痛、晕厥或差点晕倒、明显肌肉无力到站不稳、抽搐、意识模糊、一天内反复呕吐无法进水、尿量明显减少。请立即拨打 120 或去最近医院急诊，并主动告诉医生“我有反复催吐/用泻药”，因为这直接决定要不要查血钾和心电图。
>
> 如果出现自杀念头、自伤行为，或已经写下了计划，请让家人陪着，拨 120 或去精神科急诊；也可拨 12356 心理援助热线。**贪食合并抑郁和自杀风险并不少见**，不要独自扛。

五、与暴食障碍、厌食、抑郁的区分

“吃得多”有好几种，方向不同，处理也不同：

情况	暴食	补偿行为	体重与关键区别
神经性贪食	有，反复	有（催吐、泻药、禁食、过度运动等）	多数正常；自我评价被体重体形绑住
暴食障碍	有，反复	没有	常偏高；暴食后痛苦但不用清除/禁食等补偿
神经性厌食（暴食清除型）	有	有	明显偏低；整体表现符合厌食
抑郁障碍	可能暴食（非典型抑郁）	少见	可能增加；核心是情绪低落、兴趣丧失，不是体像

还有几类需要排开：

- **躯体疾病**：甲亢（吃得多、瘦、心慌）、糖尿病（多食多饮多尿）、胃肠疾病、寄生虫、吸收不良；
- **药物**：糖皮质激素、部分抗精神病药、部分抗抑郁药、胰岛素或降糖药引起的食欲增加；

- **其他精神障碍**：夜间进食综合征、冲动控制问题、双相躁狂期的进食增多、边缘型人格的冲动行为、创伤后的情绪性进食。

医生通常还会问：暴食前是什么情绪？孤独、无聊、愤怒、被批评之后？——这决定了治疗重点，也帮助区分“进食障碍”与“用吃来调节情绪”。

六、羞耻与隐瞒：为什么难开口

羞耻是贪食最典型的体验之一。很多人从来没跟任何人说过催吐，连配偶都不知道；有人专门练习“无声呕吐”，有人把食物包装藏起来，有人用两三个外卖账号。

这带来一个现实问题：**越羞耻，越晚就诊；越晚就诊，躯体风险越高。** 医生问这些问题不是为了评判，而是因为不问就查不出原因。

如果你准备开口，可以用一句很朴素的话起头：“我吃东西会控制不住，吃完会想办法吐掉，这件事我没跟别人说过。”剩下的医生会接着问。你也可以先写在纸上递给医生，很多人这样更容易说出口。

七、就诊准备清单

- ☐ 暴食频率：最近一个月大概多少次，一次吃多少（用具体食物举例比“很多”有用）
- ☐ 失控感：能不能中途停下，通常吃到什么程度才停
- ☐ 补偿方式：催吐、泻药、利尿剂、减肥药、灌肠、禁食、过度运动，各自频率
- ☐ 体重变化：现在、最高、最低；有没有被家人说“最近瘦了/胖了”
- ☐ 躯体症状：心悸、乏力、晕倒、呕血、腹痛、牙齿敏感、腮腺肿
- ☐ 月经情况（女性）；性欲与精力变化
- ☐ 情绪：暴食前后的情绪，有没有抑郁、焦虑、自伤、自杀念头
- ☐ 花钱与藏食物的情况：家人可补充观察
- ☐ 既往检查：血钾、电解质、心电图、胃镜、牙科记录
- ☐ 用药与保健品：减肥药、泻药、代购药、中药
- ☐ 家族史：进食障碍、抑郁、焦虑、酒精使用
- ☐ 想问医生的问题：需要查哪些血、要不要做心电图、心理治疗怎么安排

常见误区

- **“吐出来就不会胖，所以没事。”** 催吐不能完全阻止吸收，却会带来低钾和心律失常。
- **“体重正常，说明不严重。”** 贪食的严重度更多看频率、电解质和情绪风险，不看体重。
- **“就是自制力差。”** 暴食时的失控是症状，不是道德缺陷；靠“下决心”通常无效。
- **“多吃点、别吐就好了。”** 突然停止清除可能引发电解质波动，最好在医生指导下调整。
- **“只有女生才会得。”** 男性也会，且更容易被漏诊。
- **“这是减肥的后遗症，瘦下来就好了。”** 减重往往是诱因，不是解法；不处理循环，体重反弹后行为照旧。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：先评估躯体风险（电解质、心电图、牙齿），再安排心理治疗（认知行为取向的进食障碍治疗是常用的一线思路【指南】），必要时联合营养咨询与精神科药物。合并抑郁、焦虑、创伤时，治疗顺序由医生根据风险决定。**具体用什么药、用多久，不在本页范围。**

对家属来说，最有帮助的不是监督和盘问，而是：不评论体重和外貌，不在饭桌上审判，把“去就诊”当成一件正常的事陪着去。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（进食障碍部分）.
- NICE. Eating disorders: recognition and treatment (NG69), 2017（2020 更新）.
- NIMH. Eating Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

8.3 暴食障碍

暴食障碍是最常见、也最容易被当成“胖是因为不自律”的一类进食障碍。它和神经性贪食的关键差别只有一句话：**暴食之后没有反复的清除或补偿行为**。这一页讲医生依据什么考虑这个诊断、体重与代谢在其中扮演什么角色、以及它和贪食、抑郁、单纯肥胖怎么分开。

一、反复暴食 + 失控 + 痛苦，三者缺一不可

【指南】按 DSM-5-TR 的思路，医生考虑暴食障碍时会看：反复出现的暴食发作；暴食时明显感觉失控；暴食后有明显痛苦（厌恶、内疚、抑郁）；并且没有反复使用不恰当的补偿行为。频率通常按每周至少一次、持续三个月把握。具体条目与时间门槛以 DSM-5-TR、ICD-11 原文和医生访谈为准。

这里的重点是“三者缺一不可”：

- **只有吃得多**，没有失控感，可能只是食量大、社交性进食、或药物引起的食欲增加；
- **只有失控感**，量并不大（有人把“吃了一块蛋糕”也叫暴食），更可能是限制性进食后的心理反弹或焦虑；
- **只有痛苦**，没有暴食，可能指向抑郁、羞耻感或体像问题。

暴食的具体样子

医生会问得很细，因为“暴食”这个词每个人理解不同：

- 一个独立时间段内吃下的量，明显多于多数人在同样情境下的量；
- 吃得比平时快很多；
- 吃到身体不舒服、撑得难受还继续；
- 不饿的时候也大量进食；
- 因为羞于被看见而独自吃；
- 事后强烈自责、情绪低落。

DSM-5-TR 还列了几个“伴随特征”，比如吃得比平时快、吃到撑得难受还继续、不饿时也大量进食、因羞于被看见而独自吃、事后厌恶自己或情绪低落。这些不是必须全部满足，而是帮助医生判断这是不是典型的暴食，而不是“节假日吃多了”。

失控感：最难描述、也最关键

很多人形容不出来，只会说“停不下来”“像有人在推着我吃”“手不听使唤”。可以这样自测式回忆（不是诊断）：**当时你能不能选择停下？停下来有多难？** 如果答案是“想停但停不下来”，这个信息对医生很重要。

二、没有清除行为，是它和贪食的分水岭

特征	暴食障碍	神经性贪食
反复暴食	有	有
暴食时失控感	有	有

特征	暴食障碍	神经性贪食
清除/补偿行为	没有	有（催吐、泻药、禁食、过度运动等）
典型体重	常偏高，也有正常或偏低	多数正常
典型情绪	暴食后内疚、抑郁、羞耻	同左，常更强烈，伴体像焦虑
就诊常见主诉	减肥失败、血糖高、情绪差	胃不舒服、月经乱、牙齿问题

需要提醒：两者可以互相转换。有人在严格节食后先出现贪食，后来停止催吐，行为模式就变成暴食障碍；也有人反过来。**诊断看的是某一段时间的模式，不是一个人的永久属性。**

三、体重与代谢：相关，但不是同一件事

暴食障碍与体重偏高在统计上相关【研究】，但两者不是一回事：

- **多数体重偏高的人没有暴食障碍**。肥胖是一个身体状态，成因包括遗传、药物、睡眠、活动量、社会经济条件；
- **不少暴食障碍患者体重正常甚至偏低**；
- **把“胖”直接等同于“暴食障碍”，是一种常见的诊断错误**，也会加重体重污名。

暴食障碍真正需要关注的是代谢后果：

- 2 型糖尿病风险升高，血糖控制更差；
- 高血压、血脂异常；
- 非酒精性脂肪肝；
- 睡眠呼吸暂停（夜间憋醒、打鼾、白天嗜睡）；
- 关节负担、活动受限；
- 反复减重—反弹的“体重循环”，本身对代谢不利。

所以医生通常会查：身高体重、腰围、血压、空腹血糖或糖化血红蛋白、血脂、肝功能、必要时做睡眠监测。这些检查不是给暴食障碍“确诊”用的，而是评估它已经造成了什么。

四、病程、功能损害与严重度

暴食障碍常起病于青少年后期或二十多岁，也可能中年才明显。病程往往很长，很多人“减了十几年肥”，从没把暴食当成一个需要治疗的问题。

功能损害常被低估：

- **身体**：体重上升、血糖血脂异常、关节痛、睡眠差；
- **心理**：羞耻、自我厌恶、抑郁、焦虑，部分人回避社交和亲密关系；
- **社会**：回避游泳、拍照、体检；因体重被议论、被歧视；
- **经济**：反复买减肥产品、代餐、私教课程，花费大量金钱；
- **医疗**：反复减重门诊、内分泌门诊，却没人问“你会不会控制不住地吃”。

严重度上，DSM-5-TR 按暴食发作频率分档（轻度、中度、重度、极重度）。但临床上更看功能损害和代谢并发症：一个每周暴食两次、已经出现糖尿病的人，比一个每周四次、代谢正常的人更需要积极处理。

五、鉴别：和贪食、抑郁、单纯肥胖分开

至少四类情况需要排开：

1. 神经性贪食。 关键是有没有反复补偿行为。有些人会隐瞒催吐，医生需要直接问，或看腮腺、牙齿、手背、血钾。

2. 抑郁障碍。 非典型抑郁可以表现为食欲增加、体重增加、嗜甜，容易被当成暴食障碍。区别在于：抑郁的核心是持续的情绪低落和兴趣丧失，进食增多是其中一个表现；暴食障碍的核心是失控的暴食发作和围绕它的痛苦，情绪问题常是后果而非原因。两者也常常并存，需要医生判断先后与主次。

3. 单纯肥胖与代谢疾病。 没有反复失控暴食，只是体重高，不构成暴食障碍。反过来，也不能因为体重高就默认有暴食障碍。甲状腺功能减退、库欣综合征、下丘脑性肥胖等躯体原因也要排开。

4. 药物与其他精神障碍。 糖皮质激素、部分抗精神病药、部分抗抑郁药、胰岛素或降糖药可引起食欲明显增加；夜间进食综合征（晚上吃得最多、夜间醒来进食）、持续进食（整天不停地少量吃）、冲动控制问题、双相躁狂期的进食增多，都需要区分。Prader-Willi 综合征等遗传病也会有明显贪食，但通常起病更早、伴发育与智力问题。

六、体重污名：为什么很多人不愿就诊

“你这么胖，就是吃出来的”——这句话在诊室里出现的频率很高，也是很多人不敢就医的原因。体重污名会带来两个后果：患者把暴食藏得更深；医生把注意力全放在减重上，漏掉进食行为本身。

可以主动说的一句话是：“我不是来减肥的，我是想说我吃东西会失控。”这句话能把话题从体重挪到行为，而行为才是诊断的入口。

同时也要说清楚：**暴食障碍的治疗目标通常不是“降到某个体重”，而是减少暴食发作、改善情绪与代谢指标。** 只盯着体重，容易再次陷入“节食—暴食”的循环。

七、就诊准备清单

- ☐ 暴食频率：最近一个月多少次，通常在什么时间、什么情境
- ☐ 一次大概吃多少：用具体食物描述（“两碗饭、一整袋面包、一盒冰淇淋”）
- ☐ 失控程度：能不能中途停，什么情况下更容易失控
- ☐ 有没有清除行为：催吐、泻药、利尿剂、禁食、过度运动（这一条必须如实说）
- ☐ 体重轨迹：最高、最低、近一年变化；有没有反复减重
- ☐ 代谢相关：血糖、血脂、血压、脂肪肝、打鼾与白天嗜睡
- ☐ 情绪：暴食前后的情绪；有没有抑郁、焦虑、自伤、自杀念头
- ☐ 用药：激素、抗精神病药、抗抑郁药、降糖药、减肥药
- ☐ 家族史：肥胖、糖尿病、进食障碍、抑郁、酒精使用
- ☐ 想问医生的问题：需不需要查血糖血脂、心理治疗怎么排、要不要同时看营养科

常见误区

- **“暴食障碍就是贪吃。”** 暴食是有失控感和痛苦的发作，贪吃是享受，两者体验完全不同。
- **“不催吐就不严重。”** 暴食障碍的代谢后果和抑郁风险都很实在，不需要“吐”才算病。
- **“减到标准体重就好了。”** 不处理暴食循环，减重后反弹概率高，且可能加重羞耻。
- **“胖的人都有暴食障碍。”** 多数体重偏高的人并没有暴食发作。
- **“这是意志力问题，管住嘴就行。”** 靠意志对抗失控发作，通常失败并加重自责。
- **“孩子能吃是福。”** 如果孩子反复吃到难受、躲着吃、事后自责，需要问一问。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：心理治疗（认知行为取向的进食障碍治疗、人际心理治疗是常用思路【指南】）、营养与代谢管理、处理共病（抑郁、焦虑、睡眠呼吸暂停）。药物可能在合并抑郁或特定情况下使用，**具体方案由面诊医生决定，本页不涉及剂量**。减重手术不是暴食障碍的常规首选，术前通常需要先处理暴食行为。

对家属来说，最有用的是把评论体重的话咽回去，把“陪你去看医生”说出来。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 暴食障碍很少像厌食那样急，但有些情况不能等：剧烈腹痛且持续加重、呕吐不止、腹胀到无法呼吸（警惕急性胃扩张，虽罕见但凶险）；胸痛、心悸、晕厥；糖尿病患者出现低血糖或明显高血糖伴乏力、恶心、呼吸深快；进食时突然呛咳、呼吸困难（噎食）。
>
> 如果出现自杀念头、自伤行为，或已经写下计划，请不要独处，让家人陪着，拨 120 或去精神科急诊；也可拨 12356 心理援助热线。暴食障碍合并抑郁和自杀风险并不少见，**“只是吃的问题”这个说法会耽误事**。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（进食障碍部分）.
- NICE. Eating disorders: recognition and treatment (NG69), 2017（2020 更新）.
- NIMH. Eating Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

8.4 进食障碍的躯体评估与鉴别

进食障碍的诊断看起来是“心理”问题，但真正决定一个人要不要住院、能不能回家、有没有生命危险的，往往是躯体指标：电解质、心率、骨密度、月经。这一页讲这些检查各自在看什么、哪些躯体病会伪装成进食障碍、以及哪些信号意味着必须马上处理。**读完能带走一句：进食障碍的躯体评估不是“顺便查一下”，它是诊断的一部分。**

一、三项最要紧的躯体指标

电解质：低钾是最常见的“隐形炸弹”

反复催吐、滥用泻药或利尿剂，会把钾、氯、钠连同胃液一起丢掉。血钾低到一定程度，人可能只是觉得乏力、腿软、心慌，但心电图已经在变化：T 波低平、U 波出现、QT 间期延长，严重时室性心律失常甚至心脏骤停。

常见的电解质模式（仅作理解用，不能自行对号）：

模式	常见于	提示
低钾 + 低氯 + 代谢性碱中毒	反复催吐	胃酸丢失
低钾 + 代谢性酸中毒	滥用泻药	肠道碳酸氢盐丢失
低钠	大量饮水“压体重”、滥用利尿剂	严重时可致抽搐、意识改变
低磷、低镁	营养不良、再喂养初期	再喂养综合征的核心

再喂养综合征值得单独说：长期饥饿后突然增加进食，胰岛素分泌上升，磷、钾、镁迅速进入细胞，血磷骤降，可导致心力衰竭、心律失常、抽搐、意识障碍。它常发生在“开始好好吃饭”之后的几天内，所以恢复进食必须慢慢来，并在医疗监测下进行。这也是为什么不能家属自己在家“猛补”。

心率与血压：最便宜的危重信号

营养不良时，心脏会“省着跳”：静息心率偏慢、血压偏低、手脚发凉。看起来“很平静”，其实是代偿能力快用完了。

医生会做**立卧位血压**：躺着测一次，站起来 1 分钟和 3 分钟各测一次。收缩压明显下降或舒张压明显下降、伴头晕，提示体位性低血压，是脱水、血容量不足和自主神经调节受损的表现。

各地住院参考线不完全一样，很多中心会把以下情况列为需要紧急评估：静息心率持续很低（如低于每分钟 50 次）、站立后血压明显下降、低体温、晕厥史。**这些是参考线，不是绝对标准；具体判断由医生结合整体情况决定。**

骨密度与月经：被拖得最久的两件事

长期低体重、营养不足会抑制下丘脑—垂体—性腺轴，表现为月经停止（继发性闭经）、性欲下降；青少年则可能表现为初潮推迟、乳房发育停滞。骨骼在缺乏雌激素和营养的情况下，骨量积累不足、骨密度下降，骨折风险升高，而且**这部分损失不一定能完全恢复**。

所以规范评估会问：月经初潮年龄、最近一次月经、停经多久、是否规律；必要时做骨密度检查（双能 X 线吸收法）。男性同样会有性腺轴抑制，只是更少被问到。

需要强调：DSM-5-TR 已经不再把“闭经”列为神经性厌食的必要条件。**有月经不代表没病，没月经也不等于就是厌食**——运动员、压力大、多囊卵巢、甲状腺问题、高泌乳素血症都可以导致闭经。

二、门诊常做的检查，各自看什么

检查	主要看什么	异常可能提示
血常规	贫血、白细胞、血小板	营养不良、感染、骨髓抑制
电解质（钾钠氯钙镁磷）	清除行为、再喂养风险	心律失常、抽搐、无力
肝肾功能	转氨酶、白蛋白、肌酐、尿素	饥饿性肝损、脱水、肾前性损伤
血糖	低血糖	长期饥饿、严重肝损
甲状腺功能	TSH、游离 T4、T3	甲亢（鉴别）；低 T3 综合征（正常甲状腺性病态综合征，T3 低、TSH 正常或偏低）
心电图	心率、QT 间期、心律失常	低钾、低镁、药物影响
骨密度	腰椎、髋部	骨质疏松/骨量减少
淀粉酶	腮腺来源的淀粉酶	反复催吐导致腮腺肿大
尿常规、尿比重	脱水、感染、滥用利尿剂	肾前性损伤、电解质丢失

检查项目不是越多越好，医生会根据体重、清除行为、症状挑重点。**检查正常也不能排除进食障碍**——很多患者早期化验完全正常。

评估时医生会同时记录两件事：**病程**（体重下降持续多久、停经多久、暴食清除多久）和**功能状态**（能不能上学上班、能不能自己出门、需不需要人陪）。同样是低钾，刚出现两周和反复两年，处理强度不同；同样是心率慢，还能正常上课和已经卧床，意义也不同。这也是为什么复诊时的“这段时间怎么样”比单次化验更有信息量。

三、会伪装成进食障碍的躯体疾病

这是鉴别诊断里最容易被漏的一组，因为它们真的会让人“吃不下、瘦下去”：

- **甲状腺功能亢进**：怕热、多汗、心慌、手抖、大便次数多，**食欲常常是增加的**，体重却下降。关键区别是“吃得多还瘦”，而厌食是“吃得少”。少数甲亢患者食欲不高，需要靠化验区分。
- **糖尿病（尤其 1 型）**：多饮、多尿、多食、体重下降、乏力；血糖和酮体可以很快出问题。还有一类需要特别问：**故意少打或漏打胰岛素来控制体重**（有时被称作“代偿性胰岛素省略”），既有糖尿病又有进食障碍，风险叠加。
- **胃肠疾病**：炎症性肠病、乳糜泻、慢性胃炎、胃轻瘫、肠系膜上动脉压迫综合征（消瘦后脂肪垫消失，压迫十二指肠，出现餐后腹胀、呕吐）。这些会有腹痛、腹泻、呕吐、便血等定位症状。
- **慢性感染与肿瘤**：结核、HIV、淋巴瘤、消化道肿瘤，常伴低热、盗汗、淋巴结肿大、贫血、炎症指标升高。
- **肾上腺皮质功能减退**：乏力、低血压、体重下降、恶心、皮肤色素沉着，化验可见低钠、高钾——注意这与催吐造成的低钾方向相反。

- **药物与物质**：兴奋剂、减肥药、泻药滥用、化疗药、部分抗抑郁药、甲状腺素过量，都可导致食欲下降和体重减轻。

医生的思路通常是：先看有没有“定位症状”（发热、腹痛、腹泻、多尿、心悸、手抖），再看化验，而不是一上来就把人归到精神科。

四、会伪装成躯体病的进食障碍

反过来，也有很多人反复看消化科、内分泌科、心内科，查了一圈“没大毛病”，最后才发现是进食障碍。常见路径：

- 反复腹胀、便秘、反酸 → 消化科；
- 心悸、胸闷、乏力 → 心内科；
- 月经紊乱、不孕 → 妇科/生殖科；
- 头晕、低血糖、电解质异常 → 急诊；
- 牙齿敏感、龋齿 → 口腔科。

如果多个科室都查不出明确病因，而人又明显消瘦、怕冷、心率慢、情绪低落，接诊医生通常会想到问一句：“最近吃饭怎么样？有没有在控制体重？”

同时要和精神科内部的其他情况区分：

- **抑郁障碍**：食欲下降、体重减轻，但核心是持续情绪低落、兴趣丧失，没有怕胖和体像扭曲；
- **焦虑与强迫**：进食仪式、怕污染、怕噎，回避的动机是减焦虑，不是减重；
- **回避限制性摄食障碍（ARFID）**：对进食本身缺乏兴趣、对食物质地/颜色敏感、怕噎怕吐，同样没有体像问题；
- **精神病性障碍**：坚信食物被下毒，或受命令性幻听支配而拒食；
- **孤独症谱系**：对食物质地、温度、摆放有强烈偏好，看起来“极度挑食”。

五、急症信号：这些情况不要等门诊

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 出现以下任一情况，立即拨 120 或去最近医院急诊，不要等预约：

- 晕厥、差点晕倒、站起来眼前发黑；
- 心跳很慢、很快或很乱，胸闷、胸痛、心悸到难受；
- 抽搐、意识模糊、说话含糊、反应明显变慢；
- 持续呕吐、无法进水、尿量明显减少；
- 呕血、咖啡色呕吐物、黑便；
- 剧烈腹痛且持续加重、腹部胀到无法呼吸；
- 明显低体温、手脚冰凉、嗜睡叫不醒；
- 刚恢复进食几天内出现乏力加重、心慌、水肿（警惕再喂养综合征）；
- 有自杀念头、自伤行为或已写下计划——低体重合并自杀风险，需要住院评估。

> 到急诊时，请主动说三句话：“我最近吃得很少/有催吐或泻药”“我体重掉了多少、多快”“我在吃什么药”。这三句话能显著改变急诊的处理路径。也可拨 12356 心理援助热线。

六、就诊准备清单

- ☐ 身高、体重、最近三个月的变化曲线（有体检记录最好）
- ☐ 最近两周典型的一天饮食，包括饮料、代餐、零食
- ☐ 清除行为：催吐、泻药、利尿剂、灌肠、减肥药，各自频率
- ☐ 运动量与“不运动就难受”的情况
- ☐ 月经史：初潮年龄、最近一次、是否规律、停经多久（女性）；男性问性欲与晨勃
- ☐ 症状：头晕、心悸、怕冷、乏力、便秘、脱发、腹胀、反酸
- ☐ 有没有晕倒、抽搐、呕血、黑便
- ☐ 既往检查结果：血常规、电解质、肝肾功能、甲状腺、心电图、骨密度、胃镜
- ☐ 用药清单：处方药、中药、保健品、减肥产品、代购药
- ☐ 家族史：进食障碍、甲状腺病、糖尿病、抑郁、酒精使用
- ☐ 情绪与风险：抑郁、焦虑、自伤、自杀念头
- ☐ 想问医生的问题：需要查哪些项目、多久复查一次、什么情况下要住院

常见误区

- **“化验正常就没问题。”** 早期进食障碍的化验常常完全正常，正常结果不能排除诊断。
- **“心率慢是身体好、是运动员体质。”** 在明显消瘦、吃得很少的背景下，心率慢是代偿，不是健康。
- **“月经来了就说明没事。”** 闭经不是诊断的必要条件，有月经也可能存在严重限制性进食。
- **“补钙就能防骨折。”** 骨密度下降的主因是营养不足和性腺轴抑制，单补钙不够。
- **“先减肥，减完再看心理。”** 进食障碍背景下的减重容易强化症状，顺序应由医生判断。
- **“查不出病就是心理作用。”** 查不出病，恰恰提示需要问进食行为，而不是否定症状。

确诊之后通常怎么走

确诊后的第一步通常不是“谈饮食”，而是评估躯体安全：电解质、心电图、生命体征、体重下降速度、再喂养风险。安全之后，才是营养康复与心理治疗。合并抑郁、焦虑、强迫、创伤时，处理顺序由医生根据风险决定。**本页不涉及具体药物与剂量。**

对家属来说，最实用的是记住两条：**别在家自行“加餐补救”，也别把急诊当小题大做。**

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（进食障碍部分）.

- NICE. Eating disorders: recognition and treatment (NG69), 2017（2020 更新）.
- NIMH. Eating Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 9：物质使用与成瘾确诊

物质使用障碍不是“意志薄弱”，而是有诊断标准的慢性疾病；物质所致精神症状还要与原发性精神障碍区分。

9.1 物质使用障碍诊断框架

“物质使用障碍”是精神科诊断里被污名化最重的一类，很多人以为它等于“意志薄弱”“人品问题”。实际上它有一套明确的诊断框架：看控制能力、社会功能、危险使用和药理反应四条线，再看持续时间和严重度。这一页讲医生怎么用这套框架判断，以及为什么“耐受”和“成瘾”不能画等号。**读完能带走一句：诊断看的是模式和后果，不是用了什么、用了多少。**

一、四条线：医生到底在看什么

【指南】DSM-5-TR 把物质使用障碍的表现归为四组，共 11 条，要求在 12 个月内符合其中至少 2 条。这里只做要点转述，具体条目以原文和医生访谈为准。

维度	看什么	通俗说法
控制受损	用得比想的多、想减减不下来、渴求、大量时间围着它转	“停不下来、老想着”
社会功能损害	影响工作/学业/家庭角色、明知有矛盾还继续、为此放弃重要活动	“生活被它挤扁了”
危险使用	在危险场合使用（如开车、操作机器）、明知身体或心理已受损仍继续	“知道有害还照旧”
药理反应	耐受（同样剂量效果变差）、戒断（停用后出现特定症状）	“越用越多、一停就难受”

这四组不是四个“罪名”，而是四个观察角度。医生会结合使用史、家人描述、体检和化验，判断这些表现是否成簇出现、是否持续、是否已经造成实际损害。

需要提醒：**“至少 2 条”不等于“中 2 条就是病”**。同样是 2 条，一个人可能只是最近压力大、喝得比平时多；另一个人可能已经因此丢了工作。诊断要求结合病程、功能损害和排除其他原因，不能靠数条目。

控制受损：最核心的一组

控制受损包括：用着用着超过自己原本打算的量或时间；反复想减或停但没成功；花大量时间获取、使用、从效果中恢复；强烈的渴求（craving，一种“非用不可”的冲动）。

渴求不是“想要”，更接近“身体和脑子一起催你”。很多人形容“路过那条街，腿自己就往那边走”。这一条在诊断里权重很高，也是复发的重要预测因素【研究】。

社会功能损害：诊断的必要背景

诊断不只看“用多少”，还看“用它换掉了什么”：上班迟到、旷课、推掉家庭聚会、放弃原本喜欢的运动、因为买它而负债、和伴侣反复争吵。

这里的判断有个陷阱：**不能因为一个人使用物质就默认他功能受损**。有些人在特定文化或职业环境里规律饮酒，工作家庭都没受影响——这不构成障碍。反过来，有些人表面功能完好（高功能），但已经明显失控、偷偷使用、身体指标异常，也不能因为“看起来还行”就排除。

危险使用：最容易被本人低估

包括在危险情境下使用（酒后驾车、醉酒操作设备、独自使用阿片类），以及明知使用已经造成身体或心理问题仍继续（如明知肝酶升高仍大量饮酒、明知焦虑加重仍用兴奋剂）。

这一组常由家人、体检或事故记录发现，本人往往不觉得是问题。

二、耐受与戒断：不等于成瘾

这是最需要澄清的一组概念。

耐受（tolerance）：同样剂量下效果下降，需要更多才能达到原来的效果。它可以是药理现象，不一定代表成瘾。比如长期用某些降压药、抗抑郁药、止痛药，也可能出现耐受或需要调整剂量。

戒断（withdrawal）：停用或减量后出现一组物质特有的症状。它同样不等于成瘾：长期按医嘱使用苯二氮䓬类药物（一类镇静催眠药）的人，突然停药也可能出现焦虑、失眠、心慌甚至抽搐，但这不代表他在“滥用”。

临床上把“耐受 + 戒断”合称**生理依赖**。生理依赖讲的是身体适应了这种物质；成瘾（物质使用障碍）讲的是控制受损、不顾损害继续使用、生活被占据。两者可以同时存在，也可以分开：

- 有生理依赖、没有成瘾：术后用阿片类止痛，按医嘱减量，减药时有些不适，但没有失控和渴求；
- 有成瘾、生理依赖不明显：某些兴奋剂使用者在早期就出现强烈渴求和失控，但耐受与戒断并不突出。

把两者混为一谈的后果很实际：有人因为“我停药会难受，所以我已经成瘾了”而不敢减药；也有人因为“我没有戒断，所以我没问题”而错过干预。

三、严重度与病程

严重度按符合的条目数分档（轻度、中度、重度），这是 DSM-5-TR 的做法。ICD-11 的写法不同：它区分“物质依赖”和“有害的使用模式”，并标注使用的物质、是否处于急性中毒（intoxication）或戒断（withdrawal）状态。两套系统不能逐条对应，同一个人可能拿到不同措辞的诊断。

病程上，物质使用障碍常呈**复发—缓解**的波动形态，而不是一条直线：

- 起病年龄越早，病程越长、越容易反复【研究】；
- 缓解期通常按持续时间描述：早期缓解（一段时间内不符合诊断）与持续缓解（更长时间）；

- 复发很常见，**复发不等于治疗失败**，而是提示需要调整方案。

医生会问的关键时间点：第一次使用是几岁、什么时候开始规律使用、最长一次停止是多久、那次为什么能停、又为什么复吸。这些比“用了多少年”更有信息量。

四、功能损害：诊断里最容易被忽略的一半

诊断要求“造成明显损害或痛苦”。损害可以分布在：

- **工作与学业**：缺勤、绩效下降、退学、失业；
- **家庭**：争吵、冷战、离婚、子女照护受影响；
- **经济**：负债、变卖家产、挪用公款；
- **健康**：肝病、胰腺炎、心血管问题、感染、外伤、牙齿；
- **法律**：酒驾、治安处罚、涉毒案件（以现行法律为准）；
- **心理**：羞耻、抑郁、焦虑、自杀风险升高。

评估功能损害时，医生通常会分别问本人和家属，因为两者报告常常不一致：本人低估，家属高估。**这个差异本身就是信息**，不是谁在撒谎。

五、看起来像、但不是的情况

至少四类情况需要先排开：

类别	具体例子	关键区别
其他精神障碍	抑郁、双相、焦虑、ADHD、PTSD、精神病性障碍	物质使用可能是“自我治疗”；需看先后顺序、停药后症状是否持续
躯体疾病	甲减、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、慢性疲劳	乏力、情绪低、注意力差有躯体解释；治疗原发病后改善
药物因素	长期用苯二氮䓬类助眠、阿片类止痛、兴奋剂类减肥药	有明确医嘱与剂量调整过程；不一定符合“控制受损”
社会文化模式	应酬饮酒、节庆聚会、特定职业文化	没有失控、渴求与持续损害；环境改变后自然减少

还有一类常被误判：**假性成瘾**（pseudo-addiction）。一个人因为疼痛控制不足而反复要求加药、频繁就诊，看起来像“药物寻求行为”，实际是治疗不充分。反过来，真正的成瘾也可能被“我只是止痛”掩盖。这需要医生结合疼痛评估、用药记录和行为模式判断，不是靠一次印象。

六、筛查工具：只能筛，不能确诊

常用的有 AUDIT（酒精使用障碍筛查问卷）、AUDIT-C（简版）、DAST（药物滥用筛查）、ASSIST（多种物质筛查）、CRAFFT（青少年）。它们的共同点是：

- 用来**发现风险、决定要不要进一步评估**；
- 分数高提示“值得问下去”，不等于诊断；
- 分数低也不能完全排除，尤其是隐瞒或低估时。

量表不能替代结构化访谈，也不能替代家属信息和化验。

七、就诊准备清单

- ☐ 使用清单：酒精、烟草、镇静催眠药、大麻、兴奋剂、阿片类、新型精神活性物质，各自开始时间与频率
- ☐ 最近一个月典型的一天：什么时候用、用多少、和谁、什么情绪下用
- ☐ 有没有“想减减不下来”“比打算的多”的经历
- ☐ 停药/停酒后出现过什么：手抖、出汗、心慌、失眠、抽搐、幻觉、腹泻、烦躁
- ☐ 最长一次停止是多久，怎么做到的，为什么复吸
- ☐ 功能影响：工作、学业、家庭、经济、法律、健康
- ☐ 躯体问题：肝病、胰腺炎、胃病、心悸、外伤、感染
- ☐ 情绪与风险：抑郁、焦虑、失眠、自伤、自杀念头
- ☐ 用药清单：处方药（尤其镇静催眠、止痛药）、中药、代购药
- ☐ 家族史：物质使用、抑郁、双相、焦虑
- ☐ 想问医生的问题：需要查什么、要不要住院戒断、家属怎么配合

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 以下情况不能在家硬扛：

- **长期大量饮酒或长期用镇静催眠药的人突然停用**，出现手抖、大汗、心慌、幻觉、抽搐、意识混乱——这是戒断反应，可能危及生命，**必须医疗监护下停药**；
- 过量使用后叫不醒、呼吸很慢或很浅、嘴唇发紫——立即拨 120，阿片类过量有拮抗药，越早越好；
- 使用兴奋剂后胸痛、心跳极快、高热、抽搐、极度兴奋或被害感；
- 出现幻觉、被害妄想、明显激越或有伤人风险——先保证安全，拨 120 或 110；
- 有自杀念头、自伤行为或已写下计划。

> 到急诊时主动说清楚“用了什么、多少、最后一次什么时候”，不要因为怕麻烦或怕被指责而隐瞒。也可拨 12356 心理援助热线。

常见误区

- **“能喝是本事。”** 耐受提高意味着需要更多才有同样效果，是风险信号，不是能力。
- **“停得下来就没成瘾。”** 成瘾的核心是控制受损，不是能不能停一次。
- **“戒断说明我成瘾了。”** 生理依赖和成瘾是两件事，按医嘱用药的人也可能有戒断。
- **“成瘾是道德问题，靠意志就行。”** 它是慢性疾病，需要治疗；单靠意志的缓解率很低。
- **“只要不天天用就没事。”** 诊断看后果和模式，间歇性大量使用同样可能造成损害。
- **“戒了就好了，不用随访。”** 复发常见，随访和家庭支持是治疗的一部分。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：评估躯体风险（尤其戒断风险）、处理中毒或戒断、心理社会干预（动机访谈、认知行为取向、家庭参与）、必要的药物治疗、处理共病。**具体方案和药物由面诊医生决定，本页不涉及剂量。** 需要住院戒断的人，不应在家自行“干戒”。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（物质使用与成瘾行为部分）.
- WHO. Alcohol, drugs and addictive behaviours. https://www.who.int/health-topics/drugs-psychoactive
- NIMH. Substance Use and Co-Occurring Mental Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/substance-use-and-mental-health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

9.2 酒精使用障碍

酒精是中国人最常接触的成瘾物质，也是最容易被“应酬”“解压”“助眠”这些说法遮住的一类。酒精使用障碍的诊断并不看你喝什么酒、跟谁喝，而看控制、后果和身体反应。这一页讲医生怎么问饮酒史、耐受和戒断意味着什么、肝病与酒精所致精神障碍怎么识别，以及**为什么有些人不能自己在家硬戒**。

一、饮酒模式：量、频率、情境、失控

医生问饮酒史，通常不只问“喝不喝”，而是问出一张时间表：

- **喝什么、多少度、一次多少**：用“几两白酒/几瓶啤酒/几杯红酒”描述，比“一点”有用；
- **多久一次**：每天、每周几次、还是“一喝就连续几天”；
- **什么时候喝**：晚饭时、应酬时、睡前、还是**早上醒来先喝一口**；
- **和谁喝**：只在场合上喝，还是独自在家喝；
- **空腹喝**：空腹饮酒吸收快，伤害更大；
- **喝了之后做什么**：睡觉、发脾气、开车、失忆。

几个在临床上被反复提到的警示信号：

信号	含义
晨起饮酒（“回魂酒”）	提示夜间已出现戒断，需要用它缓解
独自饮酒、藏酒	羞耻与失控的常见表现
一喝就停不下来（“一口就喝到断片”）	控制受损的典型描述
因喝酒推掉工作、家庭、爱好	功能损害
明知肝病、胰腺炎、胃出血仍喝	危险使用

需要说明：**“每天喝”不等于酒精使用障碍，“偶尔大醉”也不等于没问题**。诊断看的是模式、失控与后果的组合。中国居民膳食指南对成年人饮酒有“如饮酒应限量”的表述，但限量建议不是诊断标准，也不能拿来给某个人“下结论”。

病程与功能损害

酒精使用障碍的病程差异很大：有人二十多岁开始每天大量饮酒，十多年后因肝病就诊；有人四十岁后因应酬逐渐加量，退休后才明显；也有人平时不喝、一喝就连续几天。**起病越早、喝得越密、戒断越重，病程越容易迁延。**

功能损害是诊断的必要部分，通常分布在：工作（缺勤、失误、被辞退）、家庭（争吵、冷战、离婚、子女照护受影响）、经济（酒钱、负债）、健康（肝病、外伤、胰腺炎）、法律（酒驾）。评估时医生会分别问本人和家属，因为两者报告常常不一致：本人低估，家属高估。

二、耐受与戒断：为什么不能自己硬戒

耐受

长期饮酒后，肝脏代谢酶被诱导、中枢神经系统适应，同样量的酒效果变弱。表现为“以前二两就上头，现在半斤才有感觉”。耐受提高意味着身体已经在改变，也是过量中毒风险上升的原因之一。

戒断：一张有时间表的过程

酒精是镇静类物质，长期使用后大脑习惯了它的抑制，一旦撤掉，神经系统会“反弹”过度兴奋。戒断反应通常按以下节奏出现（个体差异大，仅作理解）：

- **停酒后 6–24 小时**：手抖、出汗、心慌、恶心、焦虑、失眠、血压升高；
- **12–24 小时**：可能出现幻觉（酒精性幻觉症），意识通常清醒，能分辨“这是幻觉”；
- **24–48 小时**：可能出现癫痫样抽搐（“酒精性癫痫”），尤其在既往有戒断抽搐史的人；
- **48–96 小时**：**震颤谵妄**（delirium tremens，DT）——意识模糊、定向力差、明显震颤、大汗、发热、心跳很快、幻觉、极度不安。这是酒精戒断最危险的形式，不处理可危及生命。

还有一个现象叫**“点燃效应”**（kindling）：每一次严重的戒断，都会让下一次戒断来得更快、更重。所以“上次自己扛过来了”不是可以再扛的理由，而是风险更高的信号。

这也是本页最重要的一句话：长期大量饮酒的人不要自行突然停酒。 正确做法是先做评估，在医疗监护下戒断，必要时用苯二氮䓬类药物替代并逐渐减量（具体方案由医生决定，本页不涉及剂量）。

三、酒精相关躯体损害：肝病只是其中一件

长期饮酒几乎影响每个系统：

- **肝脏**：酒精性脂肪肝 → 酒精性肝炎 → 肝硬化；肝硬化后可能出现腹水、黄疸、食管胃底静脉曲张出血、肝性脑病；
- **胰腺**：急慢性胰腺炎，反复上腹痛、脂肪泻、血糖升高；
- **消化道**：胃炎、反流、食管炎、Barrett 食管、消化道出血；
- **心血管**：高血压、酒精性心肌病、心律失常（“假日心脏综合征”——周末大量饮酒后房颤）；
- **神经系统**：周围神经病变（手脚麻木）、小脑变性（走路不稳、说话含糊）、认知下降；
- **营养与代谢**：硫胺素（维生素 B1）缺乏可致**韦尼克脑病**（意识模糊、眼球运动异常、走路不稳），延误可发展为**科萨科夫综合征**（近事记忆严重受损、编造内容填补空白）；
- **感染与外伤**：免疫力下降、肺炎、结核；跌倒后硬膜下血肿；
- **肿瘤**：口腔、咽、食管、肝、结直肠等风险升高【研究】；
- **生殖与胎儿**：男性性功能下降、女性月经紊乱；孕期饮酒可致胎儿酒精谱系障碍。

这些损害有一个共同点：**早期往往没感觉**。很多人第一次发现，是体检肝酶升高，或一次呕血。

四、酒精所致精神障碍

酒精不只是“伤身”，它本身就能制造精神症状：

- **酒精性幻觉症**：停酒后出现听幻觉，意识清楚，可持续数天到数周；
- **酒精所致精神病性障碍**：被害妄想、嫉妒妄想（“我配偶出轨”），常与长期大量饮酒有关；
- **酒精所致抑郁障碍**：饮酒期或戒断期出现情绪低落、兴趣丧失，停酒后多数在数周内改善；
- **酒精所致焦虑障碍**：戒断期心慌、出汗、坐立不安，很容易被误当成“焦虑症”；
- **酒精所致睡眠障碍**：酒能让人入睡快，但会破坏后半夜睡眠，长期反而加重失眠；
- **酒精所致认知障碍/痴呆**：以记忆、执行功能下降为主；
- **震颤谵妄**：见上文，属急症。

区分“酒精所致”与“原发性”，关键看时间关系：症状是否只在饮酒期或戒断期出现、停酒后是否在数周内明显缓解、既往是否在没有饮酒时也有同样发作。这一部分在 9.4 物质所致精神障碍与原发性障碍 里详细讲。

五、鉴别：这些情况也可能“像喝酒喝出来的”

情况	相似之处	关键区别
原发性焦虑/抑郁	心慌、出汗、失眠、情绪低	起病早于饮酒、停酒后仍持续、无戒断时间关系
双相障碍	话多、兴奋、少睡、冲动	有明确的躁狂/轻躁狂发作史，不只出现在饮酒期
癫痫	抽搐	酒精性抽搐多在停酒后 24–48 小时；原发性癫痫有既往发作与脑电图特点
低血糖	手抖、出汗、意识模糊	测血糖可辨；饮酒后进食少的人风险更高
肝性脑病	意识模糊、行为异常、手抖	有肝硬化背景、血氨升高、扑翼样震颤
硬膜下血肿	意识改变、头痛、嗜睡	近期跌倒史，需影像学
镇静药戒断	与酒精戒断几乎一样	用药史；两者常叠加，风险更高

医生还会排除：甲状腺功能异常、低钠血症、感染、药物相互作用。**不要把“喝酒的人出现精神症状”一律归给酒精**，也不要一律归给精神科——两头都可能漏。

六、筛查与就诊准备

常用筛查工具是 AUDIT（酒精使用障碍筛查问卷）和 AUDIT-C（简版），它们用于发现风险、决定是否需要进一步评估，**不能用来确诊**。分数高提示值得细问，分数低也不能完全排除，尤其当事人低报时。

就诊前可以准备：

- ☐ 饮酒清单：种类、度数、每次量、每周次数、最近一次喝是什么时候
- ☐ 有没有晨起饮酒、独自饮酒、藏酒、断片
- ☐ 最长一次停酒多久，停时出现过什么症状
- ☐ 有没有戒断抽搐、幻觉、谵妄史（这一条直接关系戒断方案）
- ☐ 躯体问题：肝病、胰腺炎、胃出血、高血压、心律不齐、手脚麻木、走路不稳
- ☐ 情绪与睡眠：抑郁、焦虑、失眠、噩梦
- ☐ 功能影响：工作、家庭、经济、驾驶、法律

- ☐ 用药清单：镇静催眠药、止痛药、中药、保健品（与酒精叠加的风险）
- ☐ 家族史：酒精使用、抑郁、双相
- ☐ 近期化验：肝功能、血常规、凝血、血糖、电解质、腹部超声
- ☐ 想问医生的问题：需不需要住院戒断、有没有戒断风险、家属怎么配合

家属提供的信息很重要，尤其是“他自己说一周喝两次，实际每天都喝”这类差异。**记录比质问有用**：把空瓶、外卖记录、酒后行为记下来，比争吵更能帮医生判断。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 以下情况不要在家观察：
>
> - 停酒后出现**抽搐、幻觉、意识模糊、大汗发热心跳很快**——警惕戒断抽搐与震颤谵妄，立即拨 120；
> - 呕血、咖啡色呕吐物、黑便——警惕消化道出血；
> - 剧烈上腹痛、呕吐不止——警惕急性胰腺炎；
> - 意识不清、叫不醒、呼吸慢、体温低——警惕酒精中毒、低血糖；
> - 头部外伤后嗜睡、呕吐、瞳孔不等大；
> - 出现被害感、极度兴奋、冲动伤人风险——先保证安全，拨 120 或 110。
>
> 另一条常被忽略：**长期大量饮酒者不要自行“干戒”**。如果本人愿意停酒，先联系精神科或戒酒门诊评估，安排安全的戒断方式。也可拨 12356 心理援助热线。

常见误区

- **“红酒养生，所以不算。”** 酒精本身就是致癌物，酒的种类不改变风险。
- **“我酒量好，说明肝好。”** 酒量好多是耐受，不代表器官没受损。
- **“能自己停几天，就没成瘾。”** 停几天后再喝、且越喝越多，恰恰是控制受损的表现。
- **“戒断熬过去就行。”** 震颤谵妄有生命危险，硬扛是在赌。
- **“喝酒的人不会得抑郁，是喝出来的。”** 两者可以互相加重，需要分别评估。
- **“只要不喝就没事了。”** 长期饮酒造成的肝损、神经损害、认知损害，需要单独评估和处理。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：评估戒断风险与躯体状况、在医疗监护下完成戒断、补充营养（尤其硫胺素）、处理肝病等并发症、心理社会干预（动机访谈、认知行为取向、家庭参与）、必要时使用减少渴求或预防复发的药物。**具体药物与方案由面诊医生决定，本页不涉及剂量。**

对家属来说，最有用的是：把“你怎么又喝”换成“我们一起去看看医生”，并在本人同意的前提下参与治疗。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（物质使用与成瘾行为部分）.
- NICE. Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management of harmful drinking and alcohol dependence (CG115), 2011.
- WHO. Alcohol. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

9.3 镇静剂、兴奋剂、大麻与阿片

不同物质造成的问题完全不一样：镇静剂过量会让人“睡过去”，兴奋剂过量会让人“烧起来”，大麻容易被当成“无害消遣”，阿片类的致命点是呼吸变慢。这一页按四类物质分别讲急性表现、长期后果、戒断反应，以及它们最容易和哪些精神障碍混在一起。**读完能带走一句：先弄清是哪一类物质，再谈诊断和处理。**

一、为什么必须分类看

诊断物质使用障碍时，“用了什么”决定了风险、戒断方式和急症处理：

类别	代表物质	急性危险	戒断危险
镇静催眠类	苯二氮䓬类、唑吡坦等 Z 类药物、巴比妥类	嗜睡、共济失调、呼吸抑制（与酒精叠加最危险）	**高**：抽搐、谵妄，可危及生命
兴奋剂	甲基苯丙胺（冰毒）、可卡因、摇头丸、处方兴奋剂	心动过速、高血压、高热、抽搐、精神病性症状	中：疲劳、抑郁、强烈渴求，自杀风险升高
大麻类	大麻、合成大麻素	心慌、惊恐、幻觉、呕吐	低～中：烦躁、失眠、食欲下降
阿片类	海洛因、芬太尼、曲马多、处方止痛药	**呼吸抑制、昏迷、死亡**	中：极其难受但一般不致直接致命

这张表只用于建立印象，不能用来判断某个人“危险不危险”。**剂量、纯度、是否混用、基础疾病、耐受程度，都会改变风险。**

病程与功能损害：四类物质的共同点

不管哪一类物质，诊断都要求“持续一段时间 + 造成实际损害”。病程上常见三种形态：

- **逐渐加量**：耐受上升，使用从“偶尔”变成日常；
- **间歇暴发**：平时不用，一用就连续几天，停不下来；
- **长期维持**：用固定量避免戒断，生活围绕“别让自己难受”安排。

功能损害则集中在工作学业、家庭关系、经济、健康与法律五个方面，不同物质的重心不同：镇静剂更多是跌倒、事故、认知迟钝；兴奋剂更多是失业、冲动、心血管事件；阿片类更多是感染、过量；大麻更多是学业下滑、动力下降与关系冲突。**“还能上班”不等于没有损害**，很多人是靠加班补窟窿、靠家人兜底在维持表面正常。

二、镇静催眠药：最容易被“合法”掩盖的一类

这类药包括苯二氮䓬类（常说的“安定”类）和 Z 类药物（如唑吡坦），多用于抗焦虑、助眠、抗惊厥、酒依赖戒断。

急性表现

- 嗜睡、反应迟钝、说话含糊、走路不稳、记忆力差；
- 判断力下降，容易跌倒、出事故；

- 与酒精或阿片类同用时，呼吸抑制风险明显叠加——这是急诊常见的死亡组合；
- 意识模糊、呼吸变慢、叫不醒，属急症。

长期使用与依赖

长期规律使用会出现耐受（同样剂量效果变差）和生理依赖。突然停药可能出现：

- 焦虑反跳、失眠加重、心慌、出汗、手抖；
- 知觉异常（对声音、光特别敏感）、幻觉；
- **抽搐**（尤其短效、大剂量、突然停药）；
- **戒断性谵妄**：意识模糊、激动、幻觉，属急症。

所以这类药不能自行骤停，需要在医生指导下缓慢减量。这一点和“成瘾”是两件事：按医嘱长期用药的人也可能出现依赖，需要的是规范减药，不是被指责。

与焦虑、失眠、抑郁的重叠

这是临床上最纠缠的一块：

- 焦虑症患者用苯二氮䓬类缓解症状，用久了出现耐受，剂量上升，看起来像“药物滥用”；
- 长期使用后出现情绪迟钝、乏力、注意力差，被误认为抑郁加重；
- 停药后的反跳性焦虑，被误认为“病又犯了”，于是继续用，形成循环。

医生通常会问：用药前焦虑是什么样？用药后有没有“越用越多”？有没有超出医嘱自行加量？有没有从别的渠道获取？这些比“用了多久”更能区分“规范治疗”与“使用障碍”。

三、兴奋剂：急性期像“躁狂”，慢性期像“抑郁”

急性表现

- 兴奋、话多、精力旺盛、不需要睡；
- 心跳快、血压高、出汗、瞳孔放大、咬牙（磨牙）；
- 冲动、易激惹、判断力差；
- **精神病性症状**：被害感、被监视感、听幻觉，有时非常鲜明；
- **高热、抽搐、胸痛、心律失常**——这些是急症，可致命。

甲基苯丙胺与可卡因的急性中毒表现相似，但甲基苯丙胺作用时间更长，精神病性症状也更持久。

慢性表现

- 体重明显下降、营养不良、牙齿损坏（俗称“冰毒牙”）；
- 皮肤问题：反复抠抓皮肤；
- 情绪低落、兴趣丧失、疲乏——很像抑郁；
- 注意力、记忆、执行功能下降；
- 心血管损害（心肌病、高血压）、脑血管意外；
- 注射使用者还有感染风险（乙肝、丙肝、HIV、心内膜炎）。

戒断：不是“没事”，是“很难受且有风险”

停用后常见：极度疲乏、嗜睡、食欲增加、情绪低落、快感缺失、焦虑、强烈渴求，部分人出现自杀念头。医学上通常不认为兴奋剂戒断会像酒精或镇静剂那样直接致命，但**抑郁与自杀风险在这一期明显升高**，需要有人看着。

四、大麻：被低估的“常见物质”

大麻（含四氢大麻酚等成分）在一些人心里是“天然、无害、不上瘾”，实际情况更复杂。

急性表现

- 放松、欣快、话多、时间感变慢；
- 短期记忆和注意力下降、协调性变差（开车风险高）；
- 口干、心跳加快、眼睛发红；
- **焦虑、惊恐、偏执**，高剂量或高浓度产品更容易出现；
- 幻觉、被害感——大麻所致精神病性症状，通常在数小时到数天内缓解，但有个体差异。

慢性表现

- **大麻使用障碍**：控制受损、渴求、明知影响工作学习仍继续；
- 青少年期规律使用与认知发展、学业表现的不良结果相关【研究】，因果方向仍有讨论【待验证】；
- 呼吸道刺激（吸烟方式）、慢性咳嗽；
- **大麻剧吐综合征**：反复发作的剧烈呕吐与腹痛，**热水淋浴或泡澡能暂时缓解**是其特征性线索，很多人长期被当成“胃病”；
- 与精神病性障碍的关联：高浓度、青少年期起病、规律使用者的风险更高【研究】；但“大麻导致精神分裂症”这种单因果说法过度简化【待验证】。

戒断

停用后 1～2 周内可能出现：烦躁、易怒、失眠、食欲下降、焦虑、头痛、渴求。通常不危及生命，但会明显影响戒断的坚持。

五、阿片类：致命点是呼吸

急性中毒

典型三联：**瞳孔缩小、意识不清、呼吸变慢**。还可见皮肤湿冷、嘴唇发紫、叫不醒。这是可以致命的急症，阿片类有拮抗药（纳洛酮），**越早用越好**，所以不要犹豫、不要先“观察一下”。

长期使用

- 耐受迅速上升，剂量越用越大；
- 便秘、恶心、瘙痒、性功能下降、月经紊乱；
- 注射相关感染（乙肝、丙肝、HIV、皮肤脓肿、心内膜炎）；

- 过量风险随纯度波动、混用镇静剂或酒精而骤升。

戒断

流涕、流泪、打哈欠、出汗、鸡皮疙瘩、腹痛、腹泻、恶心、肌肉酸痛、失眠、焦虑、强烈渴求。过程非常难受，**一般不会直接致命**，但脱水、电解质紊乱、合并心肺疾病的人风险更高；新生儿戒断则是另一回事，需要儿科处理。很多人在戒断期因无法忍受而复吸，反而增加过量死亡风险。

六、和焦虑、抑郁、精神病的重叠

表现	可能是物质所致	更可能是原发精神障碍
心慌、出汗、手抖	戒断期、兴奋剂中毒	焦虑障碍，起病早于物质使用
情绪低落、兴趣丧失	兴奋剂“崩溃”期、酒精所致	抑郁障碍，停用数周后仍持续
被害感、听幻觉	兴奋剂、大麻、酒精所致	精神分裂症谱系，停用后长期存在
失眠	兴奋剂、戒断	原发性失眠，与物质无关

“先有鸡还是先有蛋”是这一块的核心问题。有些人用物质来缓解原本就有的焦虑、抑郁、失眠（“自我治疗”），也有些人本来没有精神症状，用物质之后才出现。医生会看：症状出现的时间顺序、停药后是否缓解、既往在没有使用时的发作史、家族史。这部分在 9.4 物质所致精神障碍与原发性障碍 里展开。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 以下情况立即拨 120，不要等：

- **阿片类过量**：叫不醒、呼吸很慢很浅、嘴唇发紫、瞳孔很小；
- **镇静剂过量**：深睡叫不醒、呼吸慢、与酒精同用后意识不清；
- **镇静剂或酒精突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱、大汗发热**——戒断谵妄，可致命；
- **兴奋剂相关**：胸痛、心跳极快且乱、高热、抽搐、剧烈头痛、极度兴奋或有伤人风险；
- **大麻相关**：严重惊恐、幻觉、反复呕吐到脱水；
- 任何物质使用后出现自杀念头、自伤行为或已写下计划。

> 到急诊时请如实说“用了什么、多少、最后一次什么时候、有没有混用其他东西”。隐瞒会直接影响抢救。也可拨 12356 心理援助热线。

七、就诊准备清单

- ☐ 物质清单：名称（俗称也写）、用法（口服/鼻吸/注射/吸入）、开始时间、频率
- ☐ 最近一次使用的时间、量、当时和谁在一起
- ☐ 有没有混用（酒精 + 镇静剂 + 阿片是最危险的组合）
- ☐ 戒断经历：停用时出现什么、持续多久、有没有抽搐或意识混乱
- ☐ 躯体问题：胸痛、心悸、高热、体重下降、牙齿、皮肤、便秘、月经
- ☐ 感染风险：注射史、共用器具史
- ☐ 情绪与睡眠：抑郁、焦虑、失眠、幻觉、被害感
- ☐ 功能影响：工作、学业、家庭、经济、驾驶、法律

- ☐ 用药清单：处方镇静剂、止痛药、减肥药、中药
- ☐ 想问医生的问题：需不需要住院戒断、有没有替代治疗、家属怎么配合

常见误区

- **“大麻是植物，不会上瘾。”** 大麻使用障碍有明确诊断，戒断症状也很常见。
- **“镇静剂是医生开的，所以安全。”** 长期使用会耐受、依赖，骤停可能抽搐。
- **“兴奋剂提神，不影响健康。”** 心血管和精神病性风险都很实在。
- **“阿片戒断会死人，所以不能戒。”** 戒断极难受但一般不直接致命；真正致命的是过量和感染，需要规范治疗而非放任。
- **“戒了就是好了。”** 复发常见，后续的康复支持同样重要。
- **“只要不注射就没风险。”** 鼻吸、吸入、口服同样可致过量与依赖。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：识别物质种类与使用模式、评估中毒与戒断风险、处理急症、在医疗监护下戒断（镇静剂与酒精尤其不能自行骤停）、心理社会干预、处理共病、减少伤害（如针具交换、纳洛酮携带，具体以当地服务为准）。**药物与方案由面诊医生决定，本页不涉及剂量。**

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（物质使用与成瘾行为部分）.
- NICE. Drug misuse in over 16s: psychosocial interventions (CG51), 2007; Harmful drinking and alcohol dependence (CG115), 2011.
- NIDA. Commonly Used Drugs Charts. https://nida.nih.gov/research-topics/commonly-used-drugs-charts

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

9.4 物质所致精神障碍与原发性障碍

同一个幻觉，可能来自精神分裂症，也可能来自连续几天的冰毒；同一段抑郁，可能是原发性抑郁，也可能是停酒后的戒断期。这两类情况处理方式不同，误判的代价也不同。这一页讲医生靠什么把“物质所致”和“原发精神障碍”分开，尿检能证明什么、不能证明什么，以及判断不清楚时应该先做什么。**读完能带走一句：时间关系是线索，不是判决；停药观察比一次化验更有分量。**

一、判断的四个支点

【指南】DSM-5-TR 对“物质/药物所致精神障碍”的思路，大致可以拆成四问：症状是不是在中毒或戒断期间（或刚结束后）出现？这种物质本身有没有能力产生这类症状？症状能不能用独立的精神障碍更好地解释？症状是否只出现在谵妄过程中？这四问没有一条能单独定案，必须合起来看。

支点一：时间关系

时间关系是最有用、也最容易被误用的线索。

- **支持物质所致**：症状在开始使用、加量、或停药后短时间内出现；症状的起伏与使用/停用同步；以前每次用这种物质都出现类似表现。
- **支持原发**：症状在长期不使用物质时也出现过；首次发作明显早于物质使用；停药很久后仍持续。

多数物质所致的精神症状会在停用后数天到数周内明显减轻。临床上常把“停用后一段时间仍不缓解”作为转向原发诊断的重要提示，但**具体观察多久、怎么算缓解，DSM-5-TR 与 ICD-11 的表述不完全一样，也因物质种类而异**（比如大麻、苯二氮䓬类半衰期长，症状拖得更久）。所以不要拿“满一个月”当硬杠。

支点二：停药观察

停药观察是这套判断里最朴素、也最可靠的一步：在安全的前提下，让当事人停用一段时间（同时处理戒断），再看症状剩下多少。

- 如果停用后幻觉消失、情绪回到基线，物质所致的可能性大；
- 如果停用后症状依旧、甚至更清楚，原发障碍的可能性上升；
- 如果停用后症状先好转、后来又出现，需要考虑两种可能：复吸，或原发障碍在停药后显露。

停药观察有两个前提：**安全**（不能让人在无人看护下自行硬戒酒精或镇静剂）和**时间**（观察期要足够长，且期间最好有尿检或家属确认没有复吸）。

支点三：尿检

尿检（尿液药物筛查）是重要工具，但它证明的东西比很多人以为的少。

能证明	不能证明
最近一段时间内用过某类物质	用的是什么纯度、多少量、用了多久
当事人是否如实报告（配合访谈）	症状是不是由该物质引起
戒断期间是否偷偷复吸	精神障碍是原发还是继发

能证明	不能证明
是否存在混用	新型精神活性物质（常检测不到）

还有两个现实问题：

- **窗口期**：不同物质在尿里能查到的时间差别很大。酒精代谢快，常规尿检查不到，需要测乙基葡萄糖醛酸苷等指标；大麻在规律使用者体内可存留较久；可卡因、阿片类、苯丙胺类通常只有几天。**尿检阴性不等于没用过，阳性也不等于“就是它导致的”。**
- **假阳性与假阴性**：部分药物、食物（如大量罂粟籽）可能造成假阳性；合成大麻素、部分新型物质常规筛查查不出。有疑问时需要用质谱等确证方法。

所以尿检的正确用法是：**配合访谈，验证时间线，而不是代替诊断。**

支点四：纵向病史与旁证

医生会尽量还原一条时间线：第一次精神症状是几岁？那时有没有用物质？有没有在不使用物质的时期也发作过？家族里有没有精神分裂症、双相、抑郁？病前功能如何（学业、工作、人际）？

旁证同样重要：家属观察到的“用之前就有点不对劲”、旧病历、学校记录、体检记录。**很多“物质所致还是原发”的难题，最后是靠时间线解开的，而不是靠一次急诊访谈。**

二、先按物质所致处理，还是先治原发

这是临床上最实际的问题，也是家属最常问的：“到底该按哪个治？”

比较稳妥的顺序通常是：

1. **先保证安全**：处理中毒、戒断、自伤自杀风险、冲动伤人风险、躯体并发症。这一步不分原发继发。
2. **处理可逆因素**：补液、纠正电解质、补充硫胺素、控制兴奋激越、治疗感染或外伤。
3. **创造“干净”的观察窗**：在医疗支持下停用相关物质，尽量让症状在没有物质干扰的情况下显露。
4. **重新评估**：症状是否持续、是否符合某个原发障碍的完整标准（病程、功能损害、排除条件）。
5. **该治就治**：如果原发障碍的证据足够，按原发障碍治疗；如果仍不明确，按“待观察”处理，同时处理共病，而不是无限期等待。

这里有一个常见的极端：**“等戒了再说”**。对酒精、镇静剂依赖者，这句话有时是必要的；但对有明显抑郁、精神病性症状、自杀风险的人，一味等待戒断会耽误治疗。反过来，另一个极端是**“一看到用物质就把所有症状归给它”**，结果原发障碍被漏掉，出院后很快复发。

【临床经验】多数成瘾治疗机构采取的是“整合治疗”：物质使用与精神症状同时处理，而不是先治好一个再治另一个。

三、共病：双重诊断是常态而不是例外

【研究】物质使用障碍与抑郁、焦虑、PTSD、ADHD、双相、精神分裂症的共病率很高。共病不是“多贴一个标签”，它影响病程、治疗反应和风险：

- 抑郁 + 酒精：自杀风险叠加，酒精会削弱冲动控制；
- 焦虑 + 镇静剂：容易形成“焦虑—用药—耐受—反跳—更焦虑”的循环；
- PTSD + 兴奋剂或大麻：常被当作“自我治疗”失眠与噩梦；
- ADHD + 兴奋剂：处方兴奋剂滥用与未治疗 ADHD 都常见，需要仔细区分；
- 精神分裂症 + 物质：症状加重、复发率升高、抗精神病药依从性下降。

评估共病时，医生会尽量判断“谁先谁后、谁在维持谁”，但也要接受一个现实：**有时分不清先后，仍然可以同时治疗。**

四、容易混淆的几种情况

表现	更像物质所致	更像原发障碍
幻觉、被害感	使用兴奋剂/大麻/酒精后数小时至数天出现，停用后较快缓解，自知力恢复	停用数周仍存在，伴阴性症状、思维形式障碍、功能持续下降
情绪低落	停酒或停兴奋剂后出现，数周内改善	起病早于物质使用，或停用后持续超过数周
焦虑、心慌	戒断期、咖啡因或兴奋剂之后	起病早于物质使用，无戒断时间关系
失眠	兴奋剂、戒断期	长期存在，与物质无关
意识模糊、注意力波动	中毒、戒断性谵妄、感染、电解质紊乱	谵妄本身即为躯体急症，不属于“原发精神障碍”

还有几类必须排开的“模仿者”：

- **躯体疾病**：甲亢、低血糖、低钠、感染、肝性脑病、自身免疫性脑炎、癫痫发作后状态；
- **药物**：激素、抗胆碱能药、部分抗生素、抗帕金森药、部分中药——重点是“新加的药”与症状的时间关系；
- **谵妄**：意识水平和注意力波动是核心，属急症，不能按精神病性障碍处理；
- **做作性障碍/装病**：少见，但涉及法律或赔偿时需谨慎，不能只凭印象判断。

五、就诊准备清单

- ☐ 症状时间线：第一次出现是什么时候，当时有没有用物质
- ☐ 物质时间线：第一次使用、最近一次使用、用量、频率、是否混用
- ☐ 有没有“不用物质的时期”也出现同样症状，持续多久
- ☐ 停药后症状是好转、不变还是加重（家属观察很关键）
- ☐ 既往精神科诊断与用药，包括停药原因
- ☐ 家族史：精神分裂症、双相、抑郁、物质使用
- ☐ 病前功能：学业、工作、人际、性格变化
- ☐ 躯体排查：甲状腺、血糖、电解质、肝肾功能、感染指标、必要时影像
- ☐ 尿检/血检结果（如有），以及检测时间
- ☐ 想问医生的问题：现在按哪个方向治、观察多久、什么时候复评

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 以下情况不要等门诊：

- 意识模糊、注意力涣散、胡言乱语、认不出人——可能是谵妄，属急症；
- 停酒或停镇静药后抽搐、幻觉、大汗发热——戒断谵妄，可致命；
- 胸痛、心跳极快或很乱、高热、抽搐；
- 叫不醒、呼吸慢、嘴唇发紫——警惕过量；
- 出现命令性幻听、坚信被迫害而准备“反击”、有明显伤人风险——先保证安全，拨 120 或 110；
- 自杀念头、自伤行为或已写下计划。

到急诊时，请如实说明物质使用情况，即使涉及违法内容——医生关注的是抢救，不是追责。也可拨 12356 心理援助热线。

常见误区

- **“尿检阳性就说明精神病是吸毒吸出来的。”** 阳性只能说明用过，不能说明因果。
- **“尿检阴性就说明他没吸毒。”** 窗口期、假阴性、新型物质都会让结果失真。
- **“等戒干净了再看精神问题。”** 有自杀风险或严重精神病性症状时，等待可能有害。
- **“既然有物质使用，就不用治抑郁了。”** 共病需要同时处理，否则互相拖累。
- **“一次急诊看到幻觉就定了精神分裂症。”** 诊断需要纵向病程，急诊访谈只是起点。
- **“物质所致的精神症状会自己好，不用管。”** 多数会缓解，但期间的冲动、自伤、事故风险是真实的。

确诊之后通常怎么走

规范做法通常包括：先处理安全与可逆因素，再在“干净”的观察窗内复评；明确原发障碍的，按原发障碍治疗；不明确的，标注“待观察”并安排随访；同时处理物质使用与精神共病。**药物选择与疗程由面诊医生决定，本页不涉及剂量。** 对家属来说，最有帮助的是记录时间线、保管好药物、减少家中酒精与镇静剂的可及性。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022（物质/药物所致精神障碍部分）.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（物质使用与成瘾行为部分）.
- NICE. Coexisting severe mental illness and substance misuse (CG120), 2011（2016 更新）.
- NIMH. Substance Use and Co-Occurring Mental Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/substance-use-and-mental-health

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 10：神经发育障碍确诊

ADHD 和 ASD 是“从早期就开始”的发育性障碍，不是成年后突然出现的注意力差或社交困难。

10.1 ADHD 诊断

很多家长第一次听到“注意缺陷多动障碍”（ADHD）这个词，是在老师说“孩子挺聪明，就是坐不住、老走神”之后；很多成年人则是反复丢东西、迟到、账单逾期、被说“不上心”很多年之后，才第一次怀疑自己。这一页讲医生凭什么把这些日常现象判断成 ADHD，又凭什么不这么判断。读完你应该能分清三件事：症状表现、病程门槛、功能损害——以及为什么三者缺一不可。

核心表现：不是“注意力少”，是“注意力不听调度”

ADHD 的核心不是注意力总量比人少，而是注意力不听调度：该拉回来的时候拉不回来，该推出去的时候推不动。用大白话说，大脑里那个负责排期、启动、刹车和记事的“调度台”效率偏低，这叫执行功能，包括计划、启动任务、抑制冲动、工作记忆（把事情暂存在脑子里）、时间感。所以 ADHD 的人常常不是不知道该做什么，而是知道却启动不了、开始了却收不住、收住了却记不住下一步。

临床上通常看三组表现：

- **注意缺陷**：走神、听不进长指令、丢钥匙和手机、拖延到最后一刻、任务做到一半跳走、别人说话时“人在心不在”。
- **多动**：儿童是坐不住、离座、爬上爬下、手脚不停；成人更多是内心坐立不安、话多、总想同时做几件事。
- **冲动**：抢话、插队、先做后想、情绪一上来就爆发、冲动消费、冲动辞职、开车抢道。

有两件事需要先纠正。第一，不是所有 ADHD 都好动。以注意缺陷为主的表现，在女孩和成人里更常见，看起来是“安静地走神”“做事慢、乱、拖”，容易被当成性格问题、态度问题或“懒”。第二，能长时间打游戏、拼模型、刷视频，并不排除 ADHD。兴趣驱动下的高度投入和“被要求时的专注”是两套不同的通路，前者甚至可能表现为过度聚焦，忘了吃饭、忘了时间。

三个门槛：发育期起病、跨场景、六个月以上

医生不是数症状，而是看症状背后的形状。以 DSM-5-TR 为例，需要若干个症状在 12 岁以前就已经出现，在两个以上场景里存在，持续至少六个月，并且造成功能损害；ICD-11 的表述接近，同样强调发育期起病。具体条目数量和措辞以原文为准，这里只做要点转述。【指南】

门槛	医生会追问什么	它主要排除什么
发育期起病	小学成绩单评语、老师反馈、家长回忆、旧作业本、童年照片	成年后因压力、失眠、抑郁才出现的注意力下降
跨场景	学校或单位、家里、社交、开车、管钱，是否都受影响	只在某一个人、某一类任务前出现的问题

门槛	医生会追问什么	它主要排除什么
持续六个月以上	是常年如此，还是一阵一阵	适应反应、心境发作、急性应激
功能损害	学业、工作、金钱、驾驶、关系、健康管理	有特点但没有造成实际困难的情况

“12 岁前”这个门槛最容易被忽略，也最有诊断价值。它的意思是：这不是最近两年才有的毛病，而是一条从童年延伸过来的线。为什么抠这个年龄？因为成年之后出现的注意力下降，更常见的解释是焦虑、抑郁、失眠、慢性压力、甲状腺问题、物质使用，而不是新发的 ADHD。ADHD 可以一直被漏诊，但不太可能“成年后突然长出来”。

功能损害与病程：为什么“有症状”不等于“有障碍”

诊断的另一半是损害。同样的特质，放在一个节奏宽松、可以自己安排时间的工作里，可能只是“有点乱”；放在需要多线程、准时交付、频繁开会的位置上，就可能变成反复出错、被辞退。所以医生会问得很具体：有没有挂科、留级、被劝退；工作换了几份、为什么换；信用卡是不是循环还款；有没有因为走神出过车祸或违章；家里是不是天天为作业吵架；体检、复诊、吃药是不是总忘。

病程也要问。ADHD 是发育性障碍，症状会随年龄变形：儿童期的跑跳，成年后变成内心不安和话多；儿童期的丢三落四，成年后变成时间估计失准、同时开很多头却收不了尾。相当一部分人成年后仍有残留症状，只是损害换了形式——从成绩变成金钱、关系和健康管理；也有人通过选择适合自己的职业、找到能兜底的伴侣或助手，把损害压得很低，于是“看起来不像”。【研究】诊断看的不是“现在像不像”，而是这条线从什么时候开始、怎么走到今天。

共病在这类就诊里非常常见：焦虑、抑郁、学习障碍、抽动、孤独症谱系、睡眠问题、物质使用。共病会让损害更重，也常常是患者真正来就诊的原因——很多人不是因为“注意力差”来，而是因为“最近抑郁了，顺带发现自己一直这样”。

成人诊断与童年回溯：证据从哪来

成人 ADHD 的诊断，难点不在症状，而在证据。成年人的自述会被现在的困难染色：工作不顺时回看童年，很容易觉得“我从小就这样”。所以规范的做法是找第三方材料——小学成绩单上的评语（“上课说话”“作业拖拉”“聪明但不用心”）、旧作业本、家长和老师的回忆、甚至当年的处分记录。如果这些材料一致指向童年期就存在注意、冲动或活动量的问题，证据才站得住。

成人表现也和儿童不同，值得单独说：外显的多动减少了，转成内心坐不住、话多、爱打断；注意问题表现为开会走神、读长文要读几遍、任务切换困难、拖到最后一刻靠肾上腺素冲刺；冲动表现为冲动消费、突然辞职、路怒、情绪一点就着；执行问题表现为东西乱、忘记缴费和复诊、答应的事转头就忘。这些表现单独看都不特殊，凑在一起、并且从中小学就存在，才有意义。

就诊前可以按这份清单准备，能明显提高一次门诊的信息密度：

- ☐ 症状最早什么时候出现，举两三个具体场景，而不是“从小就那样”
- ☐ 小学成绩单、老师评语、旧作业本、奖状与处分记录
- ☐ 现在最受影响的三个领域各举一例：学业或工作、金钱、关系

- ☐ 睡眠情况：打鼾、憋气、晨起头痛、白天嗜睡
- ☐ 咖啡、烟、酒、保健品，以及正在吃的所有药
- ☐ 家族里有没有类似表现、学习困难、抽动、焦虑抑郁
- ☐ 过去有没有被诊断过焦虑、抑郁、双相、创伤、学习障碍
- ☐ 这次最想解决的一件事，越具体越好

看起来像 ADHD，但不是：三类必须排除的情况

这是最容易出错的地方。注意力差、坐不住、冲动，是很多情况的共同出口，不是 ADHD 的专利。医生通常会按三类去排除：躯体与睡眠问题、物质与药物、其他精神障碍。

类别	常见例子	区分线索
躯体与睡眠	睡眠不足、睡眠呼吸暂停、甲状腺功能亢进、贫血、听力或视力问题、失神发作、部分感冒药与激素	起病与躯体状况同步；处理躯体问题后注意明显改善；失神发作是短暂“断电”，不是走神
物质与药物	咖啡因、尼古丁、酒精、大麻、兴奋剂、镇静药戒断	症状与使用时间对应；停用观察数周；必要时尿检
其他精神障碍	焦虑、抑郁、双相、创伤后应激、孤独症谱系、学习障碍、人格特质、环境混乱	是否只在心境发作期出现；是否跨场景；发育史是否支持

展开说几条最常见的混淆。焦虑的人不是“注意力差”，而是工作记忆被担忧占满了，坐着也不安，看起来像多动；区别在于焦虑常伴心慌、肌肉紧张、入睡困难，且注意力问题随焦虑起伏。抑郁的注意力下降和动力下降是一起出现的，还有早醒、食欲变化、兴趣丧失，通常是几周到几个月的发作，而不是从小如此。双相的注意力分散只在轻躁狂或躁狂期明显，同时有睡眠需求减少、话多、花钱变多、计划变多。创伤后应激的警觉、闪回、回避，起病时间往往和某个事件对得上。孤独症谱系的社交差异、刻板动作、感觉敏感，常被误读成“不听指令”“坐不住”。学习障碍是某一项学业技能特定受损，不是普遍性的注意问题。还有一种常被忽略：环境本身太乱——家庭冲突、校园霸凌、教室太吵、照顾者长期缺位，孩子当然坐不住。

量表在这里的位置要说清楚。SNAP-IV、Conners、成人 ASRS、DIVA 结构化访谈，作用是把手头模糊的主诉变成可比较的分数、跟踪变化、方便和医生沟通。它们不能确诊。自评量表受当下情绪和期待影响，常模也有文化差异；高分不等于有病，低分也不能完全排除，尤其是那些靠高智力和社会资源代偿得很好的成人。

量表之外：常见误区与就医边界

几个反复出现的误区值得单独列出来：

- **“成绩好就不是 ADHD”**：高智力可以靠短期冲刺和外部结构掩盖，直到大学或工作后要求变高才崩。
- **“能打游戏三小时，注意力没问题”**：兴趣驱动的专注不能用来排除诊断。
- **“长大就好了”**：部分人缓解，更多人残留，只是损害从成绩换成了金钱、关系、健康。

- **“就是懒、就是家教问题”**：ADHD 是神经发育差异，不是道德缺陷；但也不等于可以不为自己的行为负责。
- **“成人不会得”**：童年起病，成年才被识别，这两件事常被混为一谈。
- **“做个量表就确诊”**：量表是筛查工具，诊断要靠病史、发育史、功能损害和排除。

> **什么时候需要联系医生或去精神科门诊**

- 注意力问题伴随持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失、明显焦虑或失眠
- 出现自伤、自杀念头，或说出“活着没意思”“不如消失”
- 儿童出现拒绝上学、被同学排斥、攻击行为、成绩突然大幅下滑
- 成人出现工作或学业难以为继、冲动消费导致债务、危险驾驶

> **什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）**

- 突然出现的意识模糊、抽搐、剧烈头痛、反复呕吐——先排除脑部与代谢急症
- 服用兴奋剂后出现胸痛、心悸、高热、严重失眠伴言行紊乱
- 大量饮酒或镇静药突然停用后出现抽搐、幻觉、意识混乱

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。不确定算不算严重时，按严重处理，宁可白跑一趟。

确诊之后通常会发生什么？医生会把诊断、共病和功能目标放在一起谈：先处理最影响生活的那一块，可能是睡眠，可能是抑郁，也可能是工作里的具体困难。非药物的部分包括环境改造、时间管理与提醒工具、家长培训和学校支持、行为教练；药物由医生根据年龄、共病、心血管风险和耐受性评估，具体品种与剂量不在本页范围。随访看的不是“分数降了多少”，而是睡眠、工作、关系、金钱这些实际功能有没有变好。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management（NG87）, 2018.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NIMH. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

10.2 ASD 诊断

孤独症谱系障碍（ASD）是这几年被讨论得最多、也最容易被误读的一个诊断：一边有人说“现在的孩子怎么这么多孤独症”，一边有大量成人直到三四十岁才第一次被识别。这一页讲医生到底在看什么——不是“孩子聪不聪明”“爱不爱说话”，而是社交沟通的方式、重复刻板的模式、感觉处理的异常，以及这些差异从多大开始。读完后你能分清：哪些是发育差异，哪些是需要评估的信号，以及为什么“看着挺正常”不能作为排除理由。

社交沟通的差异：不是“不想理人”，是“读不懂规则”

很多人对 ASD 的第一印象是“不理人、不亲近”，这其实只对了一小部分。更准确的描述是：社交的“直觉”没有自动装好。普通人不用教就知道什么时候该看对方眼睛、什么时候接话、别人这句话是客套还是认真、玩笑的边界在哪里；ASD 的人往往要靠观察和推理去学这些规则，学得会，但很费力，而且容易在陌生场合失灵。

临床上通常从三个方向看社交沟通：

- **社交与情感的互相往来**：不主动分享自己感兴趣的东西，对话像单向播报，不太会轮流，别人难过时不知道该怎么回应，或者回应得“不在点上”。
- **非言语交流**：眼神接触少或过多、面部表情少、语调平、手势少、站得太近或太远、听不懂弦外之音和讽刺。
- **建立和维持关系**：朋友少或关系停留在很浅的层面，只聊自己固定的主题，不懂职场和群体里的潜规则，容易在合作中被孤立。

这里要提醒一句：社交动机弱和社交能力弱不是一回事。有些 ASD 的人非常想交朋友，甚至比谁都渴望，只是不知道怎么开始、怎么维持、什么时候该退一步，于是反复受挫。这种“想而不得”带来的痛苦，常被误读成“性格内向”或“不合群”。

重复刻板与感觉异常：被忽略的另一半

只看到社交困难，会漏掉一半。ASD 的另一个核心是行为、兴趣和感觉的模式“窄而深、要求一致”：

维度	日常可能的样子	常被误读成
重复动作与言语	晃手、转圈、踮脚走、重复某句台词或广告词	怪癖、故意捣乱
坚持同一性	固定路线、固定餐具、顺序被打乱就崩溃	固执、被惯坏
兴趣狭窄而深	长期只钻研一个主题，记得大量细节	天才、偏科
感觉异常	怕吹风机和嘈杂环境、只吃几种质地、拒绝衣服标签、喜欢旋转和按压	矫情、挑食、事多

感觉异常这一条最容易被忽略，也最影响生活。同样的一间教室，别人觉得正常，ASD 的人可能被日光灯频闪、风扇声、同学的翻书声同时灌进来，处理不过来，于是捂耳朵、离座、发脾气。这不是不听话，是过载。反过来，也有人对疼痛、冷热不敏感，受了伤自己不说，家长发现时已经好几天。

判断这些行为是不是 ASD 的一部分，关键不在行为本身，而在它的功能：是为了自我刺激、缓解焦虑、维持可预测感，还是为了逃避某个感官刺激。同样的重复动作，在智力障碍、强迫症、抽动障碍、严重焦虑里都能见到，处理方式完全不同。

早期发育史：为什么医生一定要问头几年

ASD 是神经发育障碍，症状在发育早期就已存在。DSM-5-TR 与 ICD-11 都要求追溯到童年早期，即使社交要求要到上学、上班之后才把人压垮。【指南】所以医生会花很多时间问头几年的事：几个月会笑、什么时候会指、会不会用眼神和手指把大人的注意力引到自己感兴趣的东西上（这叫共同注意）、有没有假装游戏、语言是几岁出来的、有没有退步。

时间	值得记录下来的表现
12 月龄前	叫名字没反应、不咿呀学语、不会看你手指的方向
12 至 18 月龄	不会用手指指东西给你看、不会假装打电话喂娃娃、有意义的词很少
24 月龄	不会说两个词的短语、重复别人的话、只反复玩玩具的某个部件
任何年龄	已经会的语言或社交技能退步；对变化极度痛苦；莫名其妙的自伤

这些不是诊断条目，而是需要记录和评估的信号。单个信号很常见，很多孩子短暂出现过又消失；真正有意义的是几个信号同时存在、持续存在，并且影响到日常功能。反过来，早期“看起来一切正常”也不能完全排除——尤其是女孩，很多人的早期差异被“乖”“安静”“听话”掩盖了。

谱系的两端：智力、语言与“看起来很正常”

“谱系”两个字是有分量的。同样是 ASD，有人终身需要照护，有人读到博士、结婚生子，只在社交细节上显得特别。DSM-5-TR 用标注来描述这种差异：是否伴智力障碍、语言能力受损程度、是否伴已知的医学或遗传状况。ICD-11 的做法类似，把语言和智力功能分开标注。所以“ASD”这个标签本身说明不了严重程度，必须看标注和功能。

被漏诊最多的两类人值得单独说。第一类是女孩和女性：她们的社交困难常表现为“努力模仿”“观察别人怎么说话”“回家后复盘”，兴趣可能集中在看起来正常的领域（动物、明星、文学），表面配合度高，代价是长期的疲惫、焦虑和“不知道自己是谁”。第二类是高智力成人：靠规则学习和逻辑推理搭建了一套社交脚本，工作能应付，但在亲密关系、职场政治、感官过载上反复碰壁，往往先被诊断成焦虑、抑郁、人格问题，甚至被说“想太多”。

还要说清一个和诊断有关的细节：ASD 与智力障碍可以同时存在。如果社交沟通的水平明显低于整体发育水平，才更支持 ASD；如果各项发育普遍落后且彼此匹配，要优先考虑智力障碍。这个区分对支持方案影响很大。

诊断还要求这些差异带来临床上显著的损害，而损害的样子差别很大。学龄前可能是语言落后、不会和同伴玩、频繁情绪崩溃；学龄期是拒绝上学、被排斥、写作业耗时过长；成年后是失业、只能做与能力不匹配的工作、社交孤立、反复的焦虑抑郁。损害不一定写在脸上：一个靠高智力代偿的成人，可能在会议上表现得体，回家后彻底耗竭——这种代价也算损害。病程上，ASD 是终身性的，核心差异通

常不会消失，但功能可以随环境适配、技能学习和支持明显改善。所以医生要写清楚损害在哪些方面、到什么程度，因为这直接决定支持方案。

共病与鉴别：三类“看起来像但不是”

ASD 极少单独出现。常见共病包括 ADHD（注意与多动）、焦虑、抑郁、睡眠障碍、抽动、癫痫、胃肠问题、进食挑食。共病不是“多贴一个标签”，而是决定先处理什么：一个因为感官过载而拒绝上学的孩子，先调整环境比先加药更有意义；一个共病抑郁的成人，抑郁不处理，社交训练也推不动。

必须排除的情况，通常分三类：

类别	例子	区分线索
躯体与发育	听力障碍、语言发育障碍、选择性缄默、智力障碍、癫痫（尤其失神发作）	先做听力和发育评估；语言障碍的孩子社交意愿通常保留
其他精神障碍	社交焦虑、依恋创伤与机构养育史、强迫症、精神分裂症阴性症状、分裂型人格	社交焦虑是想社交但怕被评价；创伤史常伴警觉与解离；强迫是自我不协调的闯入思维
环境与文化	双语环境、文化差异、长期被霸凌、家庭互动模式极端	换环境后差异是否消失；是否只在特定语言或场景出现

展开几条关键的。社交焦虑的人有社交动机，独处时放松，怕的是被负面评价，抗焦虑治疗有效；ASD 的人往往是不懂规则、被感官压垮，独处时反而恢复。依恋创伤和机构养育的孩子可能表现得过度亲近陌生人（社交脱抑制），也可能回避，但模式会随安全感变化，而 ASD 的差异更稳定、更早。强迫症的重复行为是为了消除焦虑、常伴“如果不做会出事”的想法，且多在正常发育之后出现；ASD 的重复更多是自我刺激和维持同一性。精神分裂症的阴性症状（情感平淡、退缩）起病更晚，常伴阳性症状和功能衰退，而 ASD 是从小一路走来。

评估工具要说清楚用途。ADOS-2 是半结构化的观察工具，ADI-R 是给家长的访谈工具，两者常一起用，是国际上较公认的辅助手段，但仍需要医生结合发育史、功能水平和鉴别来下结论。【指南】问卷（如 SRS、AQ）只是筛查，分数高不代表确诊，分数低也不能排除高代偿的成人。

就诊清单、常见误区与就医边界

初次就诊带这些，比反复描述“感觉不太对”有用得多：

- ☐ 发育里程碑：走路、说话、指物、假装游戏分别是几个月
- ☐ 有没有退步：几岁时退的，退了什么
- ☐ 幼儿园或学校的老师反馈、被同学排斥的具体事件
- ☐ 感官敏感清单：怕什么声音、什么质地、什么光
- ☐ 固定行为清单：路线、餐具、顺序、兴趣主题
- ☐ 睡眠、进食、便秘、癫痫样发作
- ☐ 家族里有没有类似的人、语言迟缓、学习困难
- ☐ 如果看成人：童年照片、成绩单评语、当时被说“怪”的具体事

常见的误区：

- **“他不看人，所以不是孤独症”**：眼神只是其中一条，很多人能短暂对视，靠的是训练。
- **“会说很多话，肯定不是”**：语言好不代表社交沟通好，有些孩子说话很正式、很书面，社交理解却明显吃力。
- **“长大就好了”**：核心差异通常持续一生，改变的是应对方式和环境匹配度。
- **“孤独症都是天才”**：少数人在特定领域有突出能力，多数人没有，这个刻板印象会耽误支持。
- **“疫苗导致孤独症”**：这一说法已被大量研究否定，把资源花在这里，会耽误孩子真正需要的评估和支持。
- **“诊断就是贴标签”**：对很多人来说，诊断解释了一生的困惑，也换来了合理的支持和保障；标签的风险要一起评估。

> **什么时候需要联系医生或去精神科门诊**

- 语言或社交技能出现退步，尤其是已经会的词不说了
- 拒绝上学、严重焦虑、情绪低落持续两周以上
- 挑食导致体重下降、只吃极少数食物、营养风险
- 自伤行为：撞头、咬手、抓破皮肤

> **什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）**

- 首次出现抽搐、意识丧失——按癫痫急症处理
- 自伤导致出血、骨折、意识改变
- 严重攻击行为、走失、离家后无法找到
- 极度兴奋、几天不睡、言行紊乱，或出现木僵、拒食

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。孩子的状态说不清时，按更严重的可能处理。

确诊之后通常会发生什么？医生会同时给出功能描述：语言、智力、适应行为、共病。干预的重点是环境适配和技能支持，包括结构化的日常安排、视觉提示、社交技能训练、家长培训、学校支持计划；共病的焦虑、抑郁、睡眠、癫痫分别处理。药物不改变 ASD 的核心特征，只针对具体共病，品种与剂量由医生评估。对成人来说，诊断常带来的是“终于解释清楚了”，接下来是工作环境调整、感官减负和针对性的心理支持。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis（CG170）, 2013（2020 更新）.
- NIMH. Autism Spectrum Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

10.3 成人 ADHD 与 ASD 的识别

有一类来访者很典型：从小被说“聪明但不用心”“怪”“不合群”，长大后能工作、能结婚，却在换城市、升职、生孩子或读研之后突然撑不住，被诊断成焦虑、抑郁，治了几年也不见好。回头一问，问题从小学就在。这一页讲成人 ADHD 与成人 ASD 长什么样、为什么容易被漏掉、代偿是怎么把问题盖住的，以及它们和焦虑、抑郁、双相、人格问题怎么区分。读完后你至少能判断：值不值得去做一次发育史的评估。

为什么成年才发现：代偿、环境与“看起来还行”

成人被漏诊，通常不是医生水平不够，而是三个原因叠在一起。【临床经验】

第一是环境曾经很配合。中小学有固定课表、有人催作业、有考试排名把问题暴露出来；到了大学或工作，结构突然撤掉，要求变成“自己安排、长期交付、多线并行”，差异才显形。这也是为什么很多人是在读研、外派、创业、当父母之后才“崩”的——不是病变重了，是环境要求超过了代偿能力。

第二是代偿。高智力的人可以靠临时抱佛脚、靠记忆、靠把流程背下来应付很多年；社交上可以靠观察和模仿搭一套脚本；生活上可以靠伴侣、助理、父母兜底。表面看一切正常，代价是长期过度用力：慢性疲惫、下班后瘫掉、周末才能恢复、一有变化就焦虑。这种“高功能”的代价，常常要到三十几岁身体和情绪一起出问题才被看见。

第三是症状被别的诊断盖住。成人精神科门诊更常处理情绪问题，医生看到的是抑郁、焦虑、失眠、物质使用，容易停在第一层。加上女性、注意缺陷为主型、语言能力好的 ASD，表现都不符合大众印象里的“多动”“不理人”，漏诊率就更高。

不过要提醒的是，“高功能”不是诊断标准。成人诊断同样要求损害：反复失业、债务、关系破裂、健康被拖垮，或者长期靠透支维持。只是“我觉得自己很像”“网上测试分数很高”，通常不足以支持诊断。评估的意义在于把损害讲清楚，而不是给自己找一个解释。

成人 ADHD 的样子：从“坐不住”变成“撑不住”

成人的多动大多内化了，外人看不见，自己很难受。表现会随年龄变形：

领域	儿童期常见	成人期常见
注意	上课走神、作业拖拉	开会走神、读长文要读几遍、任务切换困难
活动量	离座、跑跳、手脚不停	内心坐立不安、话多、同时开很多头
冲动	抢话、插队、先做后想	冲动消费、突然辞职、路怒、情绪一点就着
组织	丢文具、忘作业	时间估计失准、账单逾期、家里乱、忘记复诊
情绪	挫折耐受低、哭闹	小事引爆、爆发后自责、被说“玻璃心”

还有两个成人特有的现象。一个是“时间盲”：不是不知道 deadline，而是感受不到它，直到最后一刻才被肾上腺素推着动，长期靠危机驱动。另一个是情绪调节困难：挫折一来就崩，几分钟后又恢复，事后羞耻。这种“快起快落”常被误当成双相或人格问题，区别在于它由具体挫折触发、持续时间短、没有睡眠需求减少和精力持续升高的阶段。

成人 ASD 的样子：尤其是女性和语言能力好的人

成人 ASD 最容易被误解的一点是：会说话、有工作、能结婚，所以“不像”。但社交沟通的差异不会因为语言好就消失，它换了一种形式存在。

常见的样子包括：社交像在“执行流程”，靠提前准备话题、靠模仿别人的反应，结束后需要长时间独处恢复；对字面意思敏感，听不懂玩笑、讽刺、暗示，容易在职场被说“不会看眼色”“太较真”；对规则和公平异常在意，容不下模糊和例外；日常安排高度固定，路线、餐具、作息被打乱就烦躁；感官敏感，开放工位、日光灯、电话铃声、空调声都可能造成过载，于是戴耳机、避开聚餐、拒绝出差；兴趣窄而深，可能正好变成职业优势，也可能占满所有话题。

女性还有一个特殊现象，常被称为“掩饰”或“伪装”：观察同伴、背下社交脚本、刻意维持眼神和微笑、模仿语气。短期看很成功，长期代价是耗竭、焦虑、抑郁、自我认同混乱，以及“我不知道哪个才是我”。很多女性是在孩子被诊断 ASD 之后，对照自己才发现“原来我也是”。

这里必须纠正一个常见误解：ASD 的人显得“只顾自己”，多数时候不是自大，而是取别人视角这件事需要额外费力。这不等于可以不为伤人的话负责，但把它当成“自私”来批评，通常只会让人更退缩。

ADHD 与 ASD 的重叠：为什么经常同时存在

两者都是神经发育障碍，共病很常见，而且表现互相“染色”：ADHD 让 ASD 的人更难维持固定流程，ASD 让 ADHD 的人更受不了变化。【研究】区分的关键不在单个症状，而在背后的机制。

维度	更偏 ADHD	更偏 ASD
社交困难来源	打断别人、抢话、忘约定、冲动说错话	读不懂潜台词、不懂轮流、感官过载后退出
兴趣	广泛、跳跃、三分钟热度	窄而深、长期钻研、细节惊人
变化	厌倦重复、主动找新鲜	需要可预测、变化引发强烈痛苦
感官	一般不明显，或寻求强刺激	敏感或迟钝很突出，影响日常
时间	时间感差、长期迟到	常守时，但对计划被打乱反应强烈
情绪爆发	挫折触发、来得快去得快	过载或变化触发、恢复慢

如果两条线都很明显，医生可能同时给两个诊断。这不是“贴两个标签”，而是因为两者的支持重点不同：ADHD 更依赖外部结构、提醒和药物评估；ASD 更依赖环境适配、感官减负和社交脚本训练。

与焦虑、抑郁、双相、人格的混淆

这是成人识别里最容易走偏的一段，值得逐条说。

看起来像	实际可能是	关键区别
社交焦虑	ASD	社交焦虑是想社交但怕被评价，独处放松；ASD 是不懂规则、过载，独处恢复
广泛性焦虑	ADHD	焦虑的“坐不住”伴心慌、肌肉紧张；ADHD 的注意问题从小就有，不随焦虑起伏
抑郁	ADHD 或 ASD	抑郁的注意力下降是发作性的，伴早醒、兴趣丧失；发育性差异是终身的
双相	ADHD 情绪不稳	双相有持续数天的睡眠需求减少、精力升高；

看起来像	实际可能是	关键区别
		ADHD 是分钟级的爆发
边缘型人格	ADHD 或 ASD	人格问题以关系不稳、自我认同、被抛弃恐惧为核心；ADHD 以执行功能为主
自恋或冷漠	ASD	ASD 的“不顾人”多是换位思考费力，不是需要被仰视

再补几条容易漏的：长期用酒精或大麻“自我治疗”的成人，先要区分物质所致还是原发；甲状腺功能异常、睡眠呼吸暂停、慢性睡眠不足都能造成注意力和情绪问题；女性在经期、产后、围绝经期的激素波动会放大原有差异，别把阶段性的变化当成终身的特质。

诊断顺序上，比较稳妥的做法是：先在相对稳定的时期评估，先把能治的治掉——抑郁、焦虑、失眠、物质使用、睡眠呼吸暂停；同时收集发育史证据，包括成绩单评语、旧作业、家人和老师的回忆、童年照片和视频。共病常见，不必二选一，但也不要把所有问题都归给一个诊断。

就诊清单、误区与就医边界

成人做这类评估，带材料比带情绪有用：

- ☐ 小学和初中的成绩单评语、班主任反馈
- ☐ 童年照片、视频里有没有回避眼神、独自玩、重复动作
- ☐ 最早什么时候觉得“我和别人不一样”，举三件具体的事
- ☐ 工作史：换过几份、为什么换、有没有被辞退
- ☐ 社交：朋友数量、维持多久、聚会后要不要恢复很久
- ☐ 感官：怕什么声音、光线、质地，怎么应对
- ☐ 睡眠、咖啡、酒、烟、正在吃的药
- ☐ 家族里有没有类似的人、语言迟缓、学习困难、精神科病史

常见的误区：

- **“能上班就不是”**：高代偿的人往往工作能力很强，代价在别处。
- **“小时候成绩好，肯定不是 ADHD”**：靠智力和冲刺能撑到大学。
- **“会社交就不是 ASD”**：脚本化社交也是社交，看的是耗竭和失灵的场景。
- **“成人不会得”**：是童年起病、成年才被识别，不是成年新发。
- **“诊断了也没用”**：成人诊断的价值在于解释、环境调整、共病处理和自我接纳。
- **“自己看资料对号入座就行”**：发育史需要第三方证据，鉴别需要排除，这两件事自己做不了。

什么时候需要联系医生或去精神科门诊

- 情绪低落、兴趣丧失持续两周以上，或焦虑影响到工作和睡眠
- 注意力问题伴随明显记忆下降、迷路、性格改变——需要排查躯体原因
- 长期靠酒精、镇静药、兴奋剂才能应付日常
- 反复失业、债务、关系破裂，自己已经撑不住

什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）

> - 出现自杀念头、计划，或已经自伤
> - 服用兴奋剂后胸痛、心悸、高热、严重失眠伴言行紊乱
> - 大量饮酒或镇静药突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。成人 ASD 与 ADHD 共病抑郁时自杀风险会升高，任何自杀相关表达都按急症对待，不要当成“说说而已”。

确诊之后通常会发生什么？成人 ADHD 的处理包括环境与流程改造、时间管理训练、针对共病的心理治疗，以及由医生评估的药物治疗；成人 ASD 的处理更多是环境适配、感官减负、社交与职场支持、共病治疗。两者都不追求“变成另一个人”，而是把环境和要求调到能长期承受的位置。诊断也不是终点，它更像一张地图：告诉你哪些困难有解释，哪些还需要继续查。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management（NG87）, 2018.
- NICE. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis（CG170）, 2013（2020 更新）.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

10.4 神经发育障碍与焦虑、抑郁、双相、人格的鉴别

同样一组表现——注意力散、情绪起伏大、社交退缩、说话冲动——可以指向神经发育障碍，也可以指向焦虑、抑郁、双相，还可以是人格模式的一部分。这几种解释的治疗方向差别很大，弄错了不仅白费时间，还可能让真正的问题被盖住。这一页讲医生靠什么把它们分开：三个锚点、一张对照表、以及共病时先处理谁。读完后你大概能看懂，为什么医生总要问“这是从什么时候开始的”。

三个锚点：起病时间、跨场景、发育史

鉴别不靠单个症状，靠时间轴。医生脑子里通常有三个锚点，问诊的大部分时间都花在这上面。

第一个锚点是起病时间。 神经发育障碍的差异在发育早期就存在，只是可能到某个阶段才造成麻烦；心境障碍是发作性的，有明确的“之前挺好的”和“从某个月开始不一样了”；人格模式通常在青少年期到成年早期显形，然后长期稳定；应激相关的问题则能对上某个事件。一个人说“我从小就这样”，和说“我去年秋天开始这样”，指向完全不同的方向。

第二个锚点是跨场景与跨状态。 发育性差异在几乎所有场景都在：家里、学校、单位、朋友之间，而且不随情绪好坏大幅波动。心境发作不一样，抑郁期社交退缩、注意下降，缓解后恢复；躁狂期话多、精力旺，发作过去又回到原样。人格模式跨场景存在，但在亲密关系和压力下最明显，而且当事人往往觉得“这就是我的性格”，不太觉得有问题。

第三个锚点是发育史。 这是最容易被跳过、也最能定方向的一块。小学成绩单上的评语、老师当年说过的话、家长记得的里程碑（几岁说话、几岁会指物、能不能坐住一节课）、童年照片和视频、旧作业本。这些材料能回答一个关键问题：这些困难是“一直如此”，还是“后来才有”。

还有一个辅助信息是治疗反应。比如注意问题在规范治疗后明显改善，或者情绪稳定后注意问题消失，都能提供线索。但治疗反应不能用来确诊：兴奋剂对没有 ADHD 的人也有短期提神作用，抗抑郁药有效也不代表诊断就是抑郁。【临床经验】

三个锚点最后都要落到同一个问题上：损害在哪里、持续多久。同一个特质，在宽松的环境里可能只是风格，在要求高的环境里就变成障碍。所以诊断不只是“像哪个病”，还要说清楚它让这个人失去了什么——上学、工作、独立生活、亲密关系、身体健康，以及这种失去是持续多年，还是只在一段发作里。损害越具体，诊断越站得住；只凭“我觉得自己很像”，通常不够。

一张对照表：同一组表现，几种解释

维度	更像神经发育障碍	更像焦虑或抑郁	更像双相或人格
起病	发育早期，家长能回忆起幼儿园就有	焦虑常较早且持续；抑郁多为发作性	双相多在青少年后期至成年早期，发作性；人格模式青少年期起、长期稳定
形态	终身存在，随要求变化而起伏	随压力与处境波动，治疗后可缓解	双相有数天到数周的发作期；人格问题随关系与被抛弃、被批评而剧烈波动
睡眠	入睡困难、作息延迟，但睡眠量够就还好	焦虑是入睡难；抑郁是早醒、总睡不够	双相是睡眠需求减少却精力充沛；人格问题多为情绪性失眠

维度	更像神经发育障碍	更像焦虑或抑郁	更像双相或人格
精力	兴趣驱动，做喜欢的事能很久	抑郁是普遍性疲劳、兴趣丧失	双相是发作期精力升高；人格问题随情绪起落
社交	长期社交困难、不懂规则或容易过载	抑郁时退缩，缓解后恢复；焦虑是怕被评价	人格问题以关系不稳、被抛弃恐惧、自我认同混乱为核心
对结构	外部结构一撤就乱	结构帮助有限，核心是焦虑本身	结构帮助有限，核心是关系与情绪调节

这张表只能用来建立假设，不能用来对号。真实的人常常同时在两列里，比如一个 ADHD 的成人同时有社交焦虑，或者一个 ASD 的人共病抑郁。

常见混淆：四组最容易搞错的情况

ADHD 与焦虑。 焦虑的人工作记忆被担忧占满，看起来像走神；坐着不安、抖腿，看起来像多动。区别在：焦虑的注意问题随焦虑水平起伏，常伴心慌、出汗、肌肉紧张、入睡困难；ADHD 的注意问题从小学就在，做感兴趣的事时反而能高度集中。两者可以共存，治疗上先处理哪个，看哪个更影响功能。

ADHD 与抑郁。 抑郁的注意力下降和动力下降是一起出现的，还伴早醒、食欲改变、兴趣丧失、无价值感，通常是几周到几个月的一段，之前之后都不一样。ADHD 是从小一直存在，抑郁发作只是让它更难应付。反过来也要注意：长期被 ADHD 拖累的人，很容易继发抑郁，这时两个诊断都成立。

ADHD 与双相。 这是误诊代价最大的一组。双相的“注意力分散、话多、冲动”只出现在发作期，并且伴睡眠需求明显减少、精力持续升高、计划变多、花钱变多；ADHD 的情绪爆发是分钟级的，由具体挫折触发，爆发完常常后悔、疲惫。把 ADHD 当双相治，可能用上不需要的心境稳定剂；把双相当 ADHD 治，可能诱发转躁。所以医生一定会追问“有没有过连续几天不怎么睡还很精神”的时期。

ASD 与人格障碍。 ASD 的社交困难、兴趣狭窄、对批评敏感、看起来“冷”，容易被归为分裂样、分裂型、回避型甚至自恋型人格。区分的关键是发育史：ASD 的差异从小就有，伴感官异常和刻板需求；人格障碍的模式更多在关系中被激活，随对象和处境变化。反过来，长期被误解、被霸凌的 ASD 成人，也可能发展出回避、戒备、情绪不稳，这时两个问题可能都需要处理。

这里要专门提一个概念：诊断遮蔽。一旦某人被贴上“人格障碍”或“双相”的标签，后面的医生就容易把新出现的症状都解释成那个病，而不再考虑 ADHD、ASD、创伤、躯体疾病。这是临床上真实存在的偏差，也是为什么换医生时要把完整的时间线重新讲一遍。

共病与诊断顺序：不是二选一

共病在这几类障碍里是常态而不是例外：ADHD 常与焦虑、抑郁、学习障碍、抽动、ASD 共存；ASD 常与焦虑、抑郁、睡眠障碍、癫痫共存；双相与焦虑、物质使用共存。【研究】共病不是“多贴几个标签”，它意味着需要分别评估、分别处理。

比较稳妥的顺序是：

1. **先排除躯体与物质原因**：甲状腺、贫血、睡眠呼吸暂停、药物、酒精、咖啡因，这些能同时造成注意、情绪、睡眠的问题。
2. **先处理最紧急、最可逆的**：自杀风险、躁狂、谵妄、戒断、拒食，这些不能等。
3. **把能治的治掉**：抑郁发作、焦虑、失眠、物质使用，处理之后再评估剩下的部分。
4. **在相对稳定的时期评估人格与发育史**：心境发作期下人格诊断，误差很大。
5. **不确定就先写“待观察”**：给暂定诊断、约定随访时间，比硬下一个结论更负责。

就诊清单：把时间线写下来

这类鉴别最吃的就是信息。建议就诊前用一张纸或一个表格，把下面这些写清楚：

- ☐ 最早什么时候发现不对劲，当时几岁，谁先发现的
- ☐ 幼儿园和小学的老师说过什么，成绩单评语原文
- ☐ 有没有“之前挺好、某个月开始变了”的转折点
- ☐ 情绪低落或高涨分别持续多久，中间有没有完全正常的时期
- ☐ 睡眠：是睡不着、早醒，还是睡得少却很有精神
- ☐ 什么场景最明显：独处、工作、家里、朋友、陌生人
- ☐ 有没有一段时期话特别多、花钱特别多、计划特别多
- ☐ 咖啡、酒、烟、保健品、正在吃的药，以及停药后的变化
- ☐ 家族里有没有类似表现、语言迟缓、学习困难、精神科住院史

如果条件允许，让家人或伴侣也写一份。第三方观察常能补上当事人自己意识不到的部分，尤其是“发作期”和“一直如此”的区别。

常见误区

- **“有一个诊断就够了”**：共病常见，一个标签解释不了全部，硬解释会漏掉能治的部分。
- **“人格障碍治不好，所以不用查了”**：人格模式确实稳定，但共病的抑郁、ADHD、创伤是可以处理的，处理之后整个人的状态会不一样。
- **“量表分数高就是那个病”**：所有量表都只是筛查，鉴别靠病史和时间线。
- **“小时候正常，长大才有的，肯定不是发育问题”**：高代偿的人常常到要求变高才显形。
- **“诊断会变，说明医生不靠谱”**：信息增加后修正诊断是规范做法，关键是每一次修正都有依据。

什么时候需要联系医生或去精神科门诊

- 情绪低落、兴趣丧失持续两周以上，或焦虑明显影响工作与睡眠
- 注意力和记忆力在几个月内明显下降，伴迷路、性格改变
- 反复失眠、白天嗜睡、打鼾憋气——需要排查睡眠呼吸暂停

什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 连续几天几乎不睡、话多停不下来、花钱失控、言行紊乱——可能是躁狂或物质所致
- 突然意识模糊、抽搐、高热、剧烈头痛

> • 大量饮酒或镇静药突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。判断不了的时候，按更严重的可能处理。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management（NG87）, 2018.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management（CG185）, 2014（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 11：人格障碍确诊

人格障碍是长期、弥散、稳定的模式，不是一次情绪发作；诊断要谨慎，避免把创伤、心境发作、ASD 误当人格问题。

11.1 人格障碍总论与分类

“人格障碍”这四个字，在生活里常被当成骂人的话：难相处、自私、玻璃心、戏多。在诊断里，它指的是另一回事——一套从青少年期就开始、长期稳定、跨场景存在的思维与人际模式，僵化到让人反复付出代价。这一页讲人格、人格特质和人格障碍的区别，A、B、C 三组各是什么，以及医生凭什么说“这是人格问题”而不是“你最近状态不好”。读完后你至少能明白：为什么人格诊断要格外谨慎，为什么它不该成为一句评价人的标签。

人格、人格特质、人格障碍：三个层次

先把三个词分开，不然后面全是糊涂账。

人格是一个人在长时间里相对稳定的思维、情绪、行为与人际方式的总和。它包含你怎么看待自己、怎么对待别人、遇到压力时习惯怎么反应。人格不是一成不变的，但变化通常是缓慢的。

人格特质是人格的组成单位，可以理解成几条可以打分的倾向：有多容易焦虑（神经质）、有多愿意靠近人（外向性）、有多愿意合作（宜人性）、有多较真（尽责性）、有多愿意尝试新事物（开放性）。这是心理学里常说的“大五”。每个人都有这五条，只是分数高低不同。特质本身没有好坏：高尽责性在需要细致的工作里是优势，在需要灵活变通的场合可能变成死板。

人格障碍则是另一回事：不是某条特质分数高，而是整套模式僵化、弥散、长期稳定，明显偏离所在文化的期待，并且造成实际的痛苦或功能损害。关键词是“僵化”和“代价”——同一套反应被用在所有场合，不管有没有用；代价落在工作、关系、健康或法律上。

层次	是什么	例子	要不要诊断
人格特质	可测量的倾向，人人都有	容易紧张、喜欢独处、追求完美	不诊断，只描述
人格困难	特质偏极端，已经开始带来麻烦，但还没到障碍程度	因为太较真反复和同事冲突，但还能工作	通常不单独诊断，可作为关注点
人格障碍	长期、弥散、僵化的模式，造成明显损害	反复的关系破裂、失业、自伤，模式多年不变	由精神科医生评估后诊断

这个分层很重要。它意味着：一个人“性格难搞”不等于有人格障碍；反过来，有人格障碍也不等于“整个人都是坏的”。诊断描述的是一个特定模式带来的困难，不是对人的总评。

A、B、C 三组：描述性分组，不是严重度排名

现行的分类习惯把人格障碍分成三组。要强调的是，这种分组是描述性的，方便记忆和沟通，研究证据有限，很多人的表现跨组混合，所以别把它当成“三类人”。【待验证】

组别	核心主题	包含的常见类型	常见误解
A 组	古怪、多疑、退缩	偏执型、分裂样、分裂型	被当成“精神分裂”或“危险”
B 组	情绪化、戏剧化、冲动	反社会型、边缘型、表演型、自恋型	被当成“作”“坏”“自私”
C 组	焦虑、恐惧、克制	回避型、依赖型、强迫型	被当成“内向”“没主见”“完美主义”

A 组的特点是与人保持距离、解释世界的方式偏独特。偏执型是多疑、把别人的中性行为读成恶意；分裂样是情感表达少、几乎不需要亲密关系；分裂型是想法和言语偏奇特、有牵连感（觉得无关的事在暗示自己）、社交焦虑重。需要说明的是，分裂型在不同分类系统里的位置不一样：DSM-5-TR 把它放在人格障碍一章，同时承认它与精神分裂症谱系有关；ICD-11 则直接把它归到精神分裂症谱系里。

B 组的特点是在人际关系里情绪浓、反应快、冲动强。反社会型是长期无视他人权利和规则；边缘型是情绪、关系、自我认同都不稳，伴冲动和自伤；表演型是过度寻求关注、情绪表达夸张；自恋型是夸大感、需要被仰视、共情困难。B 组在临床上最常被污名化，也最容易被误诊——情绪起伏被当成双相，冲动被当成“人品问题”。

C 组的特点是以焦虑和回避为主。回避型是怕被否定而回避社交与机会；依赖型是过度需要被照顾、难以自己做决定；强迫型是极端的秩序、完美、控制，代价是效率和关系。注意，强迫型人格障碍和强迫症不是一回事：前者是“性格上必须按规矩来”，后者是有闯入性想法和重复行为。

诊断要满足什么：五个条件

医生不会因为一次见面、一次冲突就下这个诊断。通常要同时满足几件事。

第一，长期。 模式从青少年期或成年早期就开始，持续多年，而不是最近几个月才有。这一点要和心境发作、应激反应区分开——那些是“某段时间变了”，人格是“一直都是这样”。

第二，弥散。 不只在某一个关系或某一个场景里出现。只对伴侣这样、只对上司这样，更可能是关系问题或处境反应；对家人、同事、朋友、陌生人都差不多，才更像人格模式。

第三，僵化。 遇到新情境还是用同一套反应，明知道不管用也改不了。这是“障碍”的核心：不是风格问题，是缺乏弹性。

第四，造成损害。 落在具体的地方：反复失业、关系一再破裂、法律纠纷、健康受损、长期痛苦。没有损害，即使特质很极端，也通常不诊断。

第五，排除其他解释。 不能用其他精神障碍、物质使用、躯体疾病、文化背景来解释。这一条最容易被忽略，也最重要：抑郁期的人可能显得依赖、易怒、退缩；躁狂期的人可能显得自大、冲动；创

伤后的人可能显得多疑、情绪不稳；ASD 的人可能显得冷漠、不通人情。这些都不该直接归为人格障碍。

还有一个不能忘的背景：文化。某些文化里“多疑”可能是真实的安全经验（比如长期遭受歧视、移民身份不稳），某些文化里“依赖家庭做决定”是常态。诊断要求偏离的是“所在文化的期待”，不是主流社会的期待。

分类的两种思路：类别与维度

传统做法是“类别式”：数一数符合哪一型，归到 A、B、C 里的某一格。好处是直观、方便沟通、便于研究；坏处是很多人不符合任何一型的完整图像，却又有明显困难，于是被归到“其他”或干脆漏掉。

另一种思路是“维度式”。DSM-5 的第三部分提出了一套混合模型：先评估人格功能受损的程度（自我认同、自我方向、共情、亲密关系四个方面），再看五类特质维度的突出程度。ICD-11 走得更彻底：不再分具体类型，而是先定严重度（轻度、中度、重度），再标注突出的特质领域（消极情绪、疏离、对抗、去抑制、强迫性），另外保留一个“边缘型模式”的标注。两套系统都在往“看功能受损程度 + 看特质”的方向走。

这对患者意味着什么？意味着诊断的名称可能不同，医生说的“人格障碍”可能是旧分类里的某一型，也可能是新分类里的“中度人格障碍伴突出对抗特质”。名称不同不代表判断矛盾，关键是功能受损在哪、需要什么帮助。

常见误区与就医边界

- **“人格障碍是治不好的”**：人格模式确实稳定，但可以改变。结构化的心理治疗（如辩证行为治疗、心智化治疗、图式治疗）有研究支持，很多人几年后不再符合诊断标准。【研究】
- **“诊断了就是给我判刑”**：诊断的作用是解释困难、指导治疗、争取资源；它不该被用来否定一个人。
- **“脾气差就是人格障碍”**：脾气是状态，人格是长期模式，两者差很远。
- **“有人格障碍的人都很危险”**：绝大多数人伤害的是自己，不是别人；把少数极端案例当成全体，是污名。
- **“自己对照条目就能确定”**：人格评估需要纵向史、知情人信息、排除其他障碍，自己做不到。
- **“年轻人情绪不稳就是人格问题”**：青少年的大脑和身份还在发展，这个年龄段下人格诊断要非常谨慎。

如果你或家人正在考虑做人格评估，可以准备这些：

- ☐ 这些模式最早从什么时候开始，能不能举出中学时期的具体例子
- ☐ 在哪些场景最明显：家里、工作、朋友、亲密关系
- ☐ 因为这些模式付出过什么代价：失业、分手、纠纷、住院
- ☐ 有没有一段时期完全不一样（比如抑郁缓解后、搬家后）

- ☐ 成长经历：养育方式、重大丧失、被忽视或暴力的经历
- ☐ 有没有物质使用、冲动消费、自伤、违法记录
- ☐ 家人或伴侣怎么看，最好请他们写一段
- ☐ 过去被诊断过什么，用过什么治疗，效果如何

> **什么时候需要联系医生或去精神科门诊**

- 情绪长期低落、焦虑，或反复出现“活着没意义”的念头
- 人际关系反复破裂、工作难以维持，自己已经无法收拾
- 反复自伤、冲动性物质使用、暴食或催吐

> **什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）**

- 有自杀计划、已经自伤、或说出告别的话
- 出现伤人念头、正在失控、家中有人身安全风险
- 大量饮酒或镇静药后意识不清、抽搐

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。人格障碍相关的自伤常被误解为“求关注”，这是最危险的误解之一——所有自伤都要按真实风险对待。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

11.2 边缘型人格障碍

边缘型人格障碍（BPD）大概是被误解得最深的一个诊断：在网络上它是“情绪化”“恋爱脑”“作”，在急诊室里它是“又来了”。但它描述的是一群长期活在剧烈情绪、关系动荡和自我怀疑里的人，其中相当一部分有过自伤，也有真实的自杀风险。这一页讲 BPD 到底在描述什么，医生怎么把它和双相、创伤后应激、抑郁分开，以及为什么它不该是一句判决。读完后你至少能分清：什么是发作，什么是长期模式。

四条不稳：情绪、关系、自我认同、冲动

BPD 的核心可以用一句话概括：情绪调节的“恒温器”坏了，于是关系、自我感和行为跟着一起晃。具体落在四条线上。

情绪不稳。 不是普通的情绪起伏，而是几小时内的剧烈翻转：上午还觉得一切有希望，下午因为一句没回的消息掉进谷底，晚上又因为一个道歉恢复。情绪强度常常和事件不成比例，当事人自己也知道“反应过头了”，但当时压不住。跟双相不同的是，这种波动通常由人际事件触发，而且很少持续几天不动。

关系不稳。 典型的是“理想化”和“贬低”来回摆：刚认识时觉得对方完美、全心投入，一旦感觉被冷落、被批评、要分开，就迅速转为失望、愤怒、指责。这种摆动常让关系大起大落，也常让当事人事后困惑“我怎么又这样了”。背后往往是对被抛弃的强烈恐惧——可能是真实的分离，也可能只是对方回消息慢了一点。

自我认同不稳。 不知道自己是谁、想要什么、价值在哪；目标、职业方向、性取向、审美、朋友圈子可能频繁大变；独处时感到空，需要靠别人或强刺激来确认自己存在。这种“空”不是无聊，是一种持续的、说不清的空洞感。

冲动。 集中在能快速改变感受的行为上：冲动消费、暴食、酗酒、滥用镇静药、危险驾驶、冲动性性行为、突然辞职、自伤。这些行为常常发生在情绪最激烈的几十分钟里，事后后悔，但下次照样。

把这四条放在一起看，你会发现它不是“性格差”，而是一套在极端情绪下维持不住自己的系统。诊断要求的正是这种长期、弥散、跨场景的模式，从青少年后期或成年早期开始，持续多年。

自伤与自杀：最需要被认真对待的部分

BPD 最危险、也最常被误读的部分是自伤和自杀。

自伤（比如割手臂、烫烟头、撞墙、过量服药但当时并不想死）在 BPD 里很常见，功能往往不是“求关注”，而是：把难以忍受的情绪转成身体的痛，让自己冷静下来；惩罚自己；确认自己还活着、还有感觉；或者用极端方式表达“我撑不住了”。这些功能听起来矛盾，但在当事人那里是同时成立的。

需要区分两种风险：一种是反复的自伤，长期存在，靠它调节情绪；另一种是自杀企图，往往在严重的人际丧失、羞辱、绝望之后出现，计划性更强、致命性更高。两者可以并存，而且前者是后者的重要风险因素。所以临床上不会因为“她每次都只是划一下”就放松警惕。

还有一个现实问题：BPD 的人反复进急诊，容易被贴上“又来演戏”的标签，被匆匆处理、快速打发。这种态度本身会加重绝望，也真的会造成漏诊——一个真正服了大量药物的人，可能因为“她老这样”而被延误洗胃。这是医疗系统里被反复记录的偏差，不是个别现象。

诊断门槛：长期模式，不是一次崩溃

医生不会在急诊室里、在一个人刚吞了药的时候下这个诊断。原因很简单：那个时刻看到的是状态，不是人格。

诊断通常要求：模式长期存在，从青少年后期或成年早期开始；在多种关系、多种场景里都能看到；不是由物质、躯体疾病或其他精神障碍解释；并且造成明显的痛苦或功能损害。功能损害常常很具体：反复失业、学业中断、关系一再破裂、反复住院、法律或债务问题、身体状况被自伤和酗酒拖垮。

还要注意一个常见的时间陷阱：很多 BPD 的人在被诊断之前，已经有过抑郁、焦虑、双相、进食障碍、物质使用、创伤后应激的诊断。这不奇怪，共病很常见。但共病不等于原来的诊断错了，也不等于 BPD 是“最终解释”。医生要做的是分别评估，而不是拿一个标签盖住全部。

与双相、创伤后应激、抑郁的鉴别

这是 BPD 诊断里最关键的一段，因为治错了方向，代价很大。

维度	边缘型人格障碍	双相	抑郁障碍
波动的时间尺度	几小时到一天，随人际事件起落	几天到几周，成段出现	两周以上持续低落，昼夜节律明显
睡眠	情绪性失眠，总量不一定少	发作期睡眠需求明显减少仍精力充沛	早醒、总睡不够
触发	被冷落、被批评、分离	常无明显外部触发	常与压力、丧失相关
自我感	长期空洞、认同不稳	发作时自我评价改变，间歇期恢复	无价值感、自责
自伤	反复、用于调节情绪	少见，若有多在发作期	自杀风险高，自伤相对少
病程	长期、稳定，从青少年期延续	发作与缓解交替，间歇期基本恢复	发作性，可反复，间歇期恢复

创伤后应激与 BPD 的重叠最需要单独摆出来看：

维度	边缘型人格障碍	创伤后应激与复杂性创伤
核心	关系、认同、冲动的长期模式	创伤记忆的闯入、回避、警觉增高
触发	被冷落、被批评、分离	与创伤相似的情境、气味、声音、人
时间关系	从青少年期起，即使没有创伤线索也在	症状与创伤时间对应，随线索起伏
重叠之处	常共病，需要分别评估	复杂性创伤含情绪调节、自我概念、关系障碍

双相是最常被混淆的。两者的情绪波动都剧烈，但双相的“高”和“低”是成段的，持续数天到数周，伴随睡眠需求、精力、思维速度的整体改变；BPD 的波动是小时级的，跟着关系事件走。一个实用

的办法是做情绪日记，连续记录四周，标出情绪、睡眠、事件、行为，医生看曲线就能分辨。家族史、抗抑郁药后是否转躁，也能提供线索。两者可以共病，但共病不等于其中一个可以忽略。

创伤后应激和复杂性创伤与 BPD 重叠最多，因为很多 BPD 的人有创伤史。区别在于：创伤后应激的核心是创伤记忆的闯入、回避和警觉增高，症状与创伤线索紧密相连；BPD 的核心是关系、认同和冲动的长期模式，即使在没有创伤线索的时候也在。ICD-11 里的“复杂性创伤后应激”还专门包含情绪调节困难、负性自我概念、关系障碍，和 BPD 几乎正面重叠。临床上常见的做法是：两者都评估，看哪一组症状更突出、更需要优先处理，而不是争一个“到底哪个才对”。

抑郁的鉴别相对直接：抑郁是发作性的，两周以上的持续低落、兴趣丧失、早醒、食欲改变、注意力下降；BPD 的空洞感和情绪波动是长期的，且对人际事件高度敏感。BPD 共病抑郁非常常见，处理抑郁发作能明显降低风险，但不能因此忽略人格模式。

还有几个容易被漏掉的：ADHD 的冲动从童年就在，但没有认同不稳和被抛弃恐惧；ASD 的社交困惑和情绪爆发常被误读为 BPD，感官过载是关键线索；物质使用会放大所有症状，先处理物质问题再评估人格更可靠；甲状腺功能异常、经前期烦躁障碍也会造成情绪波动，别跳过基本的躯体排查。

污名、预后与治疗

关于 BPD，最需要纠正的三句话。

第一，“BPD 治不好”。 事实相反。追踪研究显示，很多人在三十几岁到四十几岁时症状明显减轻，不再符合诊断标准；即使仍有残留，功能也能恢复。【研究】真正拖累预后的，往往不是症状本身，而是共病的抑郁、物质使用、长期没有获得有效治疗。

第二，“BPD 的人是在操纵别人”。 那些极端行为更准确的解释是：在情绪超过承受上限时，用仅有的办法求救或自救。把它理解成操纵，会让身边的人更愤怒、更撤退，而这恰好又验证了当事人“我果然会被抛弃”的预期，形成恶性循环。

第三，“只能靠吃药”。 目前没有专门针对 BPD 的药物，药物主要用于共病的抑郁、焦虑、冲动或睡眠，且要避免多种药物叠加。【指南】真正有证据的是结构化的心理治疗，比如辩证行为治疗（DBT）、心智化治疗（MBT）、图式治疗、移情焦点治疗，以及结构化的通用管理。治疗的共同点是：有明确框架、有危机应对计划、帮助人识别情绪、承受情绪而不行动。

对家属来说，有用的做法往往不是讲道理，而是：稳定、可预测地回应；不因为威胁而妥协，也不因为愤怒而消失；把“我会在”说清楚；同时保护好自己的边界。这比任何一次争吵都更能降低风险。

清单、误区与就医边界

如果准备就诊，下面这些材料很有用：

- ☐ 情绪日记：连续四周，记录情绪强度、持续多久、发生了什么、做了什么
- ☐ 自伤记录：什么时候开始、什么情况下发生、当时想缓解什么
- ☐ 关系史：重要关系怎么开始、怎么结束、有没有反复的模式

- ☐ 从什么时候开始觉得“我和别人不一样”，中学时是什么样
- ☐ 睡眠：是睡不着，还是睡得少但很有精神
- ☐ 物质使用：酒、镇静药、其他，用量和频率
- ☐ 过去的诊断和用药，哪些有效、哪些加重了情绪
- ☐ 家族里有没有双相、自杀、物质使用、住院史

常见误区：

- **“情绪起伏大就是双相”**：双相是成段的发作，BPD 是小时级、跟人际事件走。
- **“自伤就是求关注”**：自伤多数是为了调节难以忍受的情绪，需要被认真对待。
- **“有了 BPD 诊断，别的病就不用查了”**：共病常见，抑郁、物质、创伤都要评估。
- **“BPD 是性格问题，改不了”**：长期心理治疗有明确证据，很多人显著改善。
- **“青少年不能诊断”**：这个年龄段要谨慎，但长期、明显的模式并非不能识别，关键是别把青春期的波动当成人格障碍。

什么时候需要联系医生或去精神科门诊

- 情绪低落、绝望感持续两周以上
- 自伤频率增加，或开始出现计划性
- 反复冲动性用药、酗酒、暴食，已经影响到身体
- 关系破裂后无法恢复日常功能

什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）

- 有自杀计划、写遗书、囤药、告别
- 已经自伤且出血不止、意识改变、服用了过量药物
- 出现命令性幻听，或坚信被迫害而准备反击
- 极度激越、无法保证自身安全

情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。服毒、过量服药不要等“看看会不会有事”，立即急诊，带上药盒。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Borderline personality disorder: recognition and management（CG78）, 2009.
- NICE. Post-traumatic stress disorder（NG116）, 2018.

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

11.3 自恋、反社会、回避与依赖型人格

这四种人格模式常被拿来当日常形容词：自恋是“爱发自拍”，反社会是“冷血”，回避是“社恐”，依赖是“黏人”。但作为诊断，它们描述的是长期、弥散、僵化到造成实际损害的模式，和日常性格差得很远。这一页把它们放在一起讲，是因为它们正好卡在几个最容易误判的边界上：自恋与自信、反社会与脾气差、回避与社交焦虑、依赖与正常的依恋需要。读完后你会更清楚，什么程度才值得做评估。

四种模式，一句话各自说清

类型	核心主题	典型表现	最容易被误认成
自恋型	需要被仰视，共情困难	夸大、优越感、对批评敏感、利用他人	自信、轻躁狂、被宠坏
反社会型	无视他人权利与规则	欺骗、冲动、攻击、无责任感、缺乏悔意	脾气差、年轻气盛、物质影响
回避型	怕被否定，宁可撤退	回避社交与机会、自我评价低、对拒绝极度敏感	社交焦虑、内向、抑郁
依赖型	需要被照顾，难以自主	决策困难、顺从、独处困难、害怕分离	黏人、文化习惯、抑郁

四者的共同点是：模式从青少年后期或成年早期开始，跨场景存在，自己往往不觉得有问题（或只觉得“别人不懂我”），代价却落在工作、关系、健康和法律上。区别在于核心主题不同：自恋是自我价值，反社会是他人权利，回避是羞耻，依赖是自主。

自恋型：夸大的外壳与脆弱的里子

自恋型人格障碍的核心不是“自恋”，而是一套围绕自我价值建立的心理结构：需要持续被看作特别、被仰视，同时很难真正把别人当成有独立感受的人。

外显的样子比较容易被认出：夸大自己的成就和能力，觉得自己应该和“特别的人”来往，需要大量赞美，对批评反应激烈（愤怒、贬低对方、或彻底撤退），在关系里偏向索取，难以真心为别人的成功高兴。但在临床上还有另一种更隐蔽的形态，常被称为“脆弱型自恋”：表面不一定张扬，内心却有强烈的优越感和被低估感，极度敏感于轻视，容易羞耻、反刍、嫉妒，容易觉得“他们不配”。

这两种形态的共同点是：自我价值感不稳，需要外部不断供给。所以自恋型的人常常在顺境里显得很有魅力、很有能量，一旦被批评、被拒绝、被忽视，就会迅速塌陷，出现抑郁、愤怒甚至自杀念头。

和其他情况怎么分：

- **与自信**：真正的自信比较稳定，不需要持续的外部确认，能接受批评而不觉得被摧毁，也能欣赏别人。
- **与轻躁狂的夸大**：轻躁狂的夸大是发作性的，伴随睡眠需求减少、话多、活动增多，几周内出现又消失；自恋的夸大是长期的性格底色。

- **与 ASD**：ASD 的人显得“只顾自己”，多数是取别人视角需要额外费力，不是需要被仰视；他们通常并不享受成为焦点。
- **与高成就者**：在一个只奖励强势的环境里，自恋式的行为可能被当成优点，这时候要看代价落在哪里——关系是否长期破裂、是否无法接受任何批评。

功能损害往往不在事业早期，而在关系和中晚年：伴侣长期感到被忽视、同事不愿合作、子女疏远、被批评后做出毁掉自己前程的反应。共病的抑郁、物质使用、焦虑很常见，常在自我价值受挫之后出现。

反社会型：不是“脾气差”，是长期无视他人权利

反社会型人格障碍描述的是一套持续的模式：不遵守社会规范、反复欺骗、冲动、易怒和攻击、鲁莽地不顾自己和他人安全、长期不负责任、伤害别人之后缺乏悔意。诊断通常还要求：在 15 岁以前就有品行问题的证据（比如反复说谎、逃学、欺负人、破坏财物、虐待动物），并且本人已满 18 岁。【指南】

这一型污名最重，需要说清楚几件事。

第一，反社会型不等于“杀人犯”。绝大多数符合这一模式的人并不会实施严重暴力，他们更常见的是欺骗、赖账、推卸责任、情感剥削、危险驾驶、在工作里踩着别人往上走。也有相当一部分人从未触犯刑法。

第二，它也不等于“脾气差”。间歇性暴怒障碍的人会因为小事爆发攻击，但事后常后悔，也没有长期的欺骗和不负责任；物质使用导致的行为改变，要看停用后的表现；品行障碍是 18 岁以前的对应诊断，不能直接套到成人身上。

第三，精神病态（psychopathy）是一个研究用的构念，侧重情感淡漠和操纵性，不等于反社会型人格障碍的诊断名称，两者有重叠但不重合。

第四，这一型确实存在真实风险，不能因为怕污名就回避不谈。对家人来说，需要关注的是：是否有暴力、威胁、经济控制、对孩子的忽视；这些情况下，安全计划比“讲道理”重要得多。

功能损害通常很具体：反复失业、债务、法律纠纷、家庭破裂、子女受影响。治疗动机常常很低，这是这一型最难的地方；但长期随访也发现，一部分人在中年之后行为明显减少，尤其是当他们有了稳定的关系和需要承担的责任时。【研究】

回避型与社交焦虑：怕被否定，还是怕被看见

回避型人格障碍的核心是：极度害怕被否定、被嘲笑、被拒绝，于是主动撤退。表现包括：回避需要与人打交道的工作或晋升机会，除非确定被喜欢才敢建立关系，对批评和拒绝过度敏感，在社交场合过度关注自己的表现，自我评价低，觉得自己“不如别人”“没意思”。

它和社交焦虑障碍的区别，主要在范围和重心：

维度	回避型人格障碍	社交焦虑障碍
范围	弥散到工作、社交、亲密关系、自我认同	多集中在被观察、被评价的场合

维度	回避型人格障碍	社交焦虑障碍
核心	羞耻感、自我价值低、“我不配”	害怕负面评价、怕出丑
亲密关系	连亲密关系本身也回避	通常渴望亲密，怕的是社交表现
起病	青少年期起，长期稳定	多在青少年期，可呈持续或波动
治疗重点	自我价值、羞耻、长期回避模式	暴露、认知重建、必要时药物

两者常共病，也可能被互相误诊。还有一个容易漏的：ASD 的人因为长期被排斥，也会发展出回避行为；抑郁的人会因为精力不足而退缩；分裂样人格是“真的不太需要关系”，而回避型是“很想要但不敢”。这三者的区别在动机，不在行为表面。

依赖型与“需要被照顾”：程度、代价与边界

依赖型人格障碍的核心是：过度需要被照顾，以至于难以独立做决定、难以表达不同意见、独处时强烈不安。表现包括：日常决定要别人替自己做，需要他人为自己的人生负责，不敢对重要的人表达反对（怕失去支持），独自做事时感到无助，关系结束之后立刻寻找新的依靠，甚至为了留住对方而忍受不合理对待。

要和几种情况分开：

- **与正常的依恋需要**：人本来就互相依赖，尤其在生病、丧亲、初为人母时。诊断看的是“长期、弥散、僵化、造成损害”，比如因为不敢自己做决定而错过治疗、因为怕失去伴侣而长期忍受暴力。
- **与文化**：在一些家庭和文化里，重大决定由长辈做主是常态。判断时要看这个人是否痛苦、是否因此失去发展机会，而不是看它是否符合主流生活方式。
- **与抑郁**：抑郁发作时会出现决策困难、依赖、无助，但通常是阶段性的，随抑郁缓解而改善。
- **与边缘型**：边缘型的依赖伴随剧烈的关系摆动、身份紊乱、冲动和自伤；依赖型更稳定、更顺从，较少冲动。
- **与躯体疾病**：长期患病、残疾确实会增加对他人的依赖，这是现实需要，不是人格问题。

功能损害的典型样子是：不敢争取晋升、不敢独自搬家或就医、在关系里长期委屈自己、被控制也不敢离开。共病的焦虑、抑郁很常见，也常常是就诊原因。

鉴别、误区与就医边界

这四种模式之间也会混：自恋型在受挫后可能表现得像回避型（撤退、羞耻），反社会型可能用魅力掩盖剥削，依赖型可能因为害怕失去而讨好到失去自我。医生做判断时，看的是长期模式、跨场景一致性、发育史和功能损害，不会只凭一次面谈。

- **“自恋就是自信”**：自信不需要持续被仰视，也能接受批评。
- **“反社会的人都没救”**：行为模式难改，但不是所有人一辈子不变；同时不能因为“可能有救”就忽视眼前的安全风险。
- **“回避型就是社恐”**：社恐怕出丑，回避型怕的是“我不配被喜欢”。
- **“依赖型就是爱黏人”**：黏人是行为，诊断看的是无法自主和因此付出的代价。
- **“诊断了就能解释一切”**：共病常见，抑郁、焦虑、创伤、物质使用都要单独评估。

如果你在考虑为家人或自己做评估，可以先记录这些：

- ☐ 这个模式最早从什么时候开始，中学时有没有类似表现
- ☐ 在哪些场景最明显：工作、朋友、亲密关系、家庭
- ☐ 付出过什么代价：失业、离婚、债务、法律问题、住院
- ☐ 被批评、被拒绝、被忽视时，通常怎么反应
- ☐ 有没有长期欺骗、冲动攻击、危险行为
- ☐ 独处时是什么感觉：放松、空虚，还是恐慌
- ☐ 做决定时，多大程度上需要别人替自己拿主意
- ☐ 家族里有没有类似模式、物质使用、违法记录

什么时候需要联系医生或去精神科门诊

- 长期情绪低落、羞耻感强烈，或出现“活着没意义”的念头
- 因为回避而失去工作、学业或重要关系
- 在关系里长期被控制、被威胁，需要安全和法律支持

什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）

- 有自杀计划或已经自伤
- 出现暴力威胁、跟踪、持械、限制人身自由——拨打 110
- 遭受家暴后受伤、被锁闭、被断药断食——先保证安全再求助
- 大量饮酒或服药后意识不清、抽搐

情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。涉及人身安全时，先离开现场、联系可信任的人，再考虑诊断的事。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment（CG159）, 2013.

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

11.4 人格特质、人格障碍与心境发作

一个人抑郁的时候可能变得极度依赖、易怒、回避所有人；躁狂的时候可能显得自大、冲动、到处招惹；刚经历丧失的时候可能怀疑自己是谁、觉得一切都没意义。这些表现如果单看几周，非常像人格障碍。但把状态当成人格，是精神科诊断里代价很高的错误之一：它会把一个可治疗的发作，变成一句关于“你这个人”的结论。这一页讲特质与障碍的区别、状态与特质的区别，以及什么时候不该下人格诊断。

特质与障碍：一条连续的线

先纠正一个常见的想象：人格特质和人格障碍不是两种人，而是同一条线上的不同位置。

每个人在大五维度上都有位置：神经质高的人容易焦虑、情绪波动大；外向性低的人偏好独处；宜人性低的人更爱争辩；尽责性低的人更随性；开放性高的人更愿意尝试。这些特质本身没有病理含义，它们决定了一个人的风格，也决定了在什么环境里如鱼得水、在什么环境里处处碰壁。

从特质走到障碍，通常要加上三个东西：**极端**（在人群里明显偏离）、**僵化**（不管什么场合都用同一套反应，学不会调整）、**损害**（在工作、关系、健康、法律上反复付出代价）。三者缺一，通常不构成诊断。一个极度较真但工作出色、关系稳定的人，不需要被诊断；一个较真到反复失业、和家人决裂、自己痛苦不堪的人，才值得评估。

这个连续谱的观点有两个好处。一是减少污名：人格障碍不是“另一种人”，而是极端特质加上僵化和损害。二是指导治疗：心理治疗的目标往往不是“换一个人格”，而是增加弹性——让同一套反应不再自动套用到所有场合。

状态与特质：为什么不能在发作期下人格诊断

状态是暂时的：几周的情绪低落、几天的躁狂、一次急性应激后的解离、一晚没睡后的易怒。**特质**是长期的：多年稳定的模式。

问题在于，状态会“模仿”特质。抑郁的人可能表现得像依赖型人格：做不了决定、离不开人、反复求保证；也可能像回避型：拒绝社交、觉得自己不配；还可能像边缘型：情绪崩溃、自伤。躁狂的人可能像自恋型：夸大、贬低别人、觉得自己无所不能；也可能像反社会型：冲动、无视规则、性行为放纵、挥霍。创伤后的急性期可能像分裂型：多疑、觉得被监视、言语混乱。这些都不是人格改变，而是状态在起作用。

更麻烦的是，状态还会影响“回忆”。抑郁的人回看童年，容易把一切都解读成灰暗的、被忽视的、失败的；这种被情绪染色的回忆，会让医生高估童年期的问题。反过来，轻躁狂的人可能低估过去的困难。所以人格评估不能只靠当事人当下的叙述，还要靠知情人、旧记录和稳定期的观察。

研究上有一个稳定的发现：抑郁缓解之后，同一个人在外向性、神经质上的得分会明显变化；也就是说，发作期测到的“人格”，有一部分其实是症状。【研究】这也是为什么规范的做法是：等发作缓解、状态稳定一段时间之后，再评估人格。

心境发作如何伪装成人格问题

状态	容易被看成	关键线索	稳定之后
抑郁发作	依赖型、回避型、边缘型	两周以上持续低落、早醒、兴趣丧失、症状随发作起伏	依赖与回避明显减轻
躁狂或轻躁狂	自恋型、反社会型、表演型	睡眠需求减少、精力升高、话多、发作性、几周内起落	夸大与冲动消退，本人常感后悔
创伤急性期	分裂型、边缘型、偏执型	与创伤时间对应、闪回、警觉、解离	随安全感恢复而减轻
物质使用期	反社会型、边缘型、冲动型	与使用时间对应、停用后观察数周	停用后行为明显不同
睡眠剥夺或甲状腺异常	轻躁狂、人格改变	起病急、伴躯体症状、实验室检查异常	纠正后恢复

以双相和边缘型为例。两者的情绪波动都剧烈，但双相是成段的：几天到几周内，睡眠需求、精力、思维速度、活动量整体改变；边缘型是小时级的，跟着人际事件走，睡眠总量往往不少。误把双相当边缘型，可能让人长期得不到心境稳定治疗；误把边缘型当双相，可能导致多种药物叠加，而真正有效的心理治疗被推迟。

再以抑郁和依赖型为例。抑郁发作时的“做不了决定、离不开人”，是动力和兴趣下降的结果；抑郁缓解后，同一个人可能相当独立。如果在他最糟的时候下依赖型人格的诊断，这个标签可能会跟着他很多年，影响医生对后续治疗判断。

什么时候不宜下人格诊断

这不是一份“禁止清单”，而是一组需要满足的前提。遇到下面这些情况，规范的做法是先处理状态，把人格评估往后放。

- 正处于抑郁、躁狂、混合发作的急性期
- 刚刚经历重大丧失、暴力、事故，还在急性应激或丧亲期
- 正在大量使用酒精或其他物质，或处于戒断期
- 刚发生自杀企图或严重自伤，仍在危机中
- 只见过一次面，没有知情人信息，也没有旧记录
- 当事人未成年，或刚进入成年早期，模式尚未稳定
- 存在语言、文化、听力或认知障碍，沟通本身受限
- 症状可以用躯体疾病、药物、睡眠问题解释

反过来，什么时候适合认真评估人格？

- ☐ 心境发作已经缓解，稳定至少数周
- ☐ 有知情人（家人、伴侣、老朋友）愿意提供观察
- ☐ 能拿到旧成绩单、旧病历、以前的老师评语
- ☐ 模式在多个场景、多段关系里都能看到
- ☐ 能说清楚这个模式从什么时候开始，中学时什么样

- ☐ 物质使用已经停用或明显减少，并观察了一段时间
- ☐ 躯体检查没有发现能解释症状的问题
- ☐ 医生愿意在诊断里写“暂定”并约定复评时间

诊断顺序与时间线

把顺序理清楚，比记住任何一个诊断名称都有用。

第一步，排除能解释一切的躯体与物质原因。 甲状腺功能异常、贫血、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、激素变化、药物副作用、酒精和其他物质，都能造成情绪不稳、冲动、多疑、退缩。这些不排除，人格评估没有意义。

第二步，处理最紧急的风险。 自杀、自伤、暴力、谵妄、戒断、拒食，先救命，再谈人格。

第三步，治疗发作。 抑郁、躁狂、焦虑、失眠、物质使用，该治就治。很多“人格问题”在发作缓解后会大幅淡化。

第四步，在稳定期做纵向评估。 结合知情人信息、旧记录、多场景观察，看模式是否长期、弥散、僵化，损害落在哪里。

第五步，允许不确定性。 信息不足时写“暂定”“待观察”，约定三到六个月后复评。诊断可以修正，这不是水平问题，而是规范做法。

这里还要提一个现实：人格障碍的诊断本身稳定性有限。不同医生、不同时间、不同评估工具，结论可能不同；几年后复评，一部分人不再符合标准。【研究】这不说明诊断没用，而说明它需要谨慎、需要时间、需要把“状态”和“特质”分开看。

误区与就医边界

- **“人格障碍是终身判决”**：模式稳定，但可以改变；很多人在几年后明显好转。
- **“情绪不稳就是人格问题”**：先看是不是发作、是不是物质、是不是睡眠和躯体问题。
- **“诊断越早越好”**：人格诊断恰恰要慢，尤其在青少年和急性期。
- **“有了人格诊断，就不用查别的”**：共病常见，漏掉抑郁、双相、ADHD、ASD、创伤的代价很大。
- **“人格问题只能靠吃药”**：药物主要处理共病和症状维度，真正改变模式的是结构化心理治疗。
- **“诊断变了，说明之前的医生错了”**：信息增加后修正诊断是正常的，关键是每次都有依据。

什么时候需要联系医生或去精神科门诊

- 情绪低落、易怒、失眠持续两周以上
- 人格评估后感觉被冒犯、被误解，想讨论诊断依据
- 两种诊断说法不一致，需要第二意见

什么时候需要立即急诊（拨打 120，必要时 110）

- 有自杀计划、已经自伤、或说出告别的话
- 连续几天几乎不睡、话多失控、行为紊乱
- 出现幻觉、坚信被迫害并有反击准备

> • 大量饮酒或镇静药后意识不清、抽搐

> 情绪危机可拨打 12356 心理援助热线。诊断上的困惑可以等，安全上的问题不能等。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision（DSM-5-TR）, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management（CG185）, 2014（2020 更新）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 12：躯体症状睡眠与器质性确诊

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

12.1 躯体症状障碍与疾病焦虑

反复头痛、心慌、胃部不适、浑身疼，一次又一次挂号、检查，报告却大多写着“未见明显异常”。家里人开始说“别查了，你就是想太多”，自己又不敢信——万一是漏了呢？这一页讲医生在这种情况下怎么判断：什么算躯体症状障碍，什么算疾病焦虑，什么其实是躯体病、抑郁焦虑或强迫。读完你能带走三件事：这两类诊断真正看的是什么、哪些检查不能省、以及怎么和医生谈“查不出来”。

一、诊断看什么：三个支点，一条时间线

过去门诊常用“躯体化”“植物神经紊乱”“医学无法解释的症状”来解释这类情况。这些说法有两个毛病：一是把“检查正常”直接当成了诊断依据，二是听起来像在暗示“你的症状是假的、装的”。

现在的分类思路变了。以 DSM-5-TR 为例，躯体症状障碍的诊断**不再要求**症状无法用躯体疾病解释，重点转到另一件事上：一个人对身体症状的**想法、情绪和行为**是否明显过度，并且已经造成痛苦和功能损害。

这个变化很关键，因为它承认了一件常被忽略的事：一个人完全可以同时有真正的躯体疾病（类风湿关节炎、炎症性肠病、糖尿病、冠心病）和躯体症状障碍。诊断问的不是“你有没有病”，而是“你对这些症状的反应，是否已经变成另一个需要处理的问题”。

【指南】按 DSM-5-TR 的思路，躯体症状障碍通常要三样东西同时成立：

1. **一个或多个让人痛苦的躯体症状**。常见的是疼痛（头、背、腹、关节）、疲劳、心慌、气短、胃肠不适、头晕。症状可以是某一个，也可以是很多个游走的。
2. **过度的想法、情绪和行为**。比如反复觉得“这次一定是大病”；为症状焦虑到睡不着；把大量时间花在查资料、量血压、摸淋巴结、跑医院上；或者相反，因为害怕查出问题而回避就医。
3. **病程与损害**。症状通常是持续的（临床上多理解为六个月以上），并且实实在在影响工作、学习、家务、社交或家庭关系。

疾病焦虑障碍的重心不一样：核心是**担心自己已经得了或即将得重病**，躯体症状可以没有，或者很轻（比如只是偶尔心悸）。行为上分两型：一型反复做检查、反复上网查、反复问医生求保证；另一型干脆回避医院、回避体检、不敢看科普。同样要求持续半年以上，并且造成明显痛苦或损害。

诊断不是数症状个数。医生还要看这些担心**是否与实际的医学风险相称**，以及**是否已经超出了“重视健康”的范围**。一个刚做完心脏支架的人担心胸痛，是合理的；一个二十多岁、各项检查正常的人每天摸十次脖子、每月做一次颈部超声，性质就不同。

维度	躯体症状障碍	疾病焦虑障碍	躯体病伴正常担心
核心	症状本身很痛苦，反应过度	怕得病，症状轻或无	有明确疾病证据
想法	“这痛一定有原因”	“我肯定得了癌症”	“我需要按医嘱复查”
行为	反复就诊、反复检查	反复求保证或回避就医	按计划随访
时间	通常半年以上	通常半年以上	与疾病病程一致

名称上还要有心理准备：ICD-11 里对应的名称是“躯体痛苦障碍”，并且把“健康焦虑/疑病”放在强迫及相关障碍一章；DSM-5-TR 则把疾病焦虑障碍与躯体症状障碍放在同一组。名称和归属不同，所以同一个人在不同医院可能拿到不同的词，这不等于谁诊断错了。

二、必须排掉的四类“看起来像但不是”

第一类：真正的躯体疾病。 这是最不能省的一步。甲状腺功能异常、贫血、维生素 B12 缺乏、糖尿病、系统性红斑狼疮、多发性硬化、炎症性肠病、慢性感染、肿瘤、心绞痛、心律失常、睡眠呼吸暂停，都可以表现为“说不清的疲劳、疼痛、心慌、头晕”。有些病早期检查就是阴性，需要随访和重复评估，而不是一句“你焦虑”就结束。

第二类：抑郁障碍、焦虑障碍、惊恐障碍。 抑郁常以疼痛、乏力、食欲和睡眠改变为主诉，患者自己未必觉得“情绪低落”；惊恐发作则是突发的剧烈心慌、胸闷、濒死感，很自然会被当成心脏病。区别在于：抑郁有持续的情绪低落或兴趣减退，焦虑有难以控制的担忧，惊恐有发作性高峰和后续的回避。这三类问题与躯体症状障碍常常同时存在，处理顺序要看哪一个更突出、更不能等。

第三类：强迫症与精神病性症状。 强迫症患者可能反复检查身体、反复洗手、反复求保证，但他们的体验是“我知道没必要，可是停不下来”，想法是闯入性的、被自己反感的。躯体症状障碍更多是“我真的觉得有病”。如果出现**坚信身体已经腐烂、被寄生虫占据、内脏被拿走了**，那已经接近躯体妄想，要考虑精神分裂症谱系、抑郁伴精神病性症状或器质性原因，处理路径完全不同。

第四类：做作性障碍与刻意夸大。 前者是有意识地制造或伪造症状（比如故意服药、污染伤口），动机是获得“病人身份”，本人往往否认；后者是为了明确的外部利益（赔偿、请假、逃避责任）。这两类都需要谨慎评估，不能靠一次门诊下结论，也不该被当成“人品问题”粗暴对待。

三、检查的边界：什么时候继续查，什么时候转随访

完全拒绝检查是危险的，无限检查同样有害。可以这样划：**有红旗信号，必须查；没有红旗信号、且已经完成过规范评估，重点转向随访而不是加项目。**

反复检查的代价是具体的：辐射和造影剂风险、穿刺和活检的并发症、假阳性结果引出一连串更贵的检查、过度治疗（比如因为一个意义不明的小结节做了不必要的手术），以及最容易被忽略的一种——**因为“都查过了”而延误了真正的新发病变**。

下面这些是需要在近期重新就医评估的信号，不是“焦虑的表现”：

- ☐ 半年内非刻意体重下降超过体重的百分之五
- ☐ 不明原因发热，尤其是持续两周以上或夜间盗汗

- ☐ 夜间被疼痛痛醒，或疼痛性质、部位在几周内明显改变
- ☐ 大便带血、黑便、呕血，或持续呕吐
- ☐ 新出现的肢体无力、说话不清、视物成双、走路不稳
- ☐ 新发癫痫样发作、意识丧失
- ☐ 头痛模式改变：突然剧烈、晨起加重、伴呕吐或视物模糊
- ☐ 摸到质硬、固定、逐渐长大的肿块
- ☐ 已经确诊的慢性病（糖尿病、高血压、哮喘）控制突然变差

四、就诊准备与“什么时候必须去急诊”

这类问题最怕“每次换一个医生、从头讲一遍、再查一轮”。准备一份自己的档案，能明显提高效率：

- ☐ **时间线**：第一次出现是什么时候，之后是持续还是阵发，每次持续多久，什么情况下加重（劳累、情绪、月经、进食、体位）。
- ☐ **症状清单**：按部位和频率写，不要只写“全身都不舒服”。
- ☐ **做过的检查**：把报告按时间顺序整理，标注哪家医院、什么时候、结果。已经做过的，不必重复做。
- ☐ **吃过的药**：包括处方药、非处方止痛药、中成药、保健品、减肥药。有些药物本身会引起心慌、出汗、胃肠不适。
- ☐ **功能影响**：这半年因此请过多少天假、少做了哪些家务、推掉了哪些社交、花了多少钱。
- ☐ **你最怕的那个病是什么**：直接告诉医生“我最怕是癌症/心脏病”。这句话对判断疾病焦虑非常有用。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现上面“红旗信号”中的任何一项，尽快门诊；突发剧烈头痛、胸痛、呼吸困难、意识改变、抽搐，直接拨打 120 或去急诊。
- 因为身体症状产生“活着没意思”“不如死了”的念头，或已经出现自伤行为：不要独处，联系家人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 反复检查已经严重影响生活（无法上班、无法照顾孩子、每天数小时查资料），或与家人因此持续冲突：尽快到精神科或心理科门诊评估，不必等到“想通”。
- 正在服用可能引起症状的药物（激素、某些抗生素、止痛药、中成药），且症状在加药后出现：尽快联系开药医生，**不要自行停药**。

五、常见误区与下一步

误区一：“检查都正常，所以是我自己想出来的。” 检查正常只说明“目前没查到”，不等于“症状不存在”，也不等于“不用管”。正确的说法是：症状真实，只是目前找不到结构性病因，需要从睡眠、情绪、应激和神经系统敏感性几个方向一起看。

误区二：“既然是心理问题，那就完全不用查了。” 相反，规范的一次系统评估是这类诊断的前提。区别在于：查一次，查得对；而不是查十次，每次加一个新项目。

误区三：“得了这个诊断，就是被判了‘装病’。” 躯体症状障碍是一个有诊断标准、有病程要求、有功能损害要求的临床问题，不是道德评价。它和高血压一样需要长期管理，只是管理的重点不同。

误区四：“只要说服自己没病就好了。” 单纯讲道理通常无效，因为担心不是靠逻辑维持的。有效的方式一般包括规律作息、逐步恢复活动、减少反复检查、处理同时存在的抑郁焦虑，以及必要时转诊心理治疗。

如果医生考虑躯体症状障碍或疾病焦虑障碍，常见做法不是“一句话打发”，而是几件事并行：把已有的躯体评估做完整、设定固定的随访节奏（比如每四周一次，而不是一有不舒服就挂号）、把反复检查换成“记录加等待”、同时处理抑郁焦虑和睡眠问题、必要时转介心理治疗（认知行为治疗对这类问题有较多证据）。

【临床经验】对患者最有帮助的一句话往往是：“我们不是不管你的症状，而是换一种管法。”对家属最有帮助的一句话是：“别急着说他想太多，先陪他把该查的查完，再一起把注意力从‘找病’转到‘恢复生活’。”

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（躯体痛苦障碍、疑病相关条目）.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

12.2 失眠、嗜睡与昼夜节律障碍

“睡不好”这三个字底下，藏着至少四种完全不同的病：失眠障碍、嗜睡障碍、昼夜节律紊乱、睡眠呼吸暂停。它们的治疗方向相反——失眠要压缩卧床时间，嗜睡要查原因，节律问题要调光，呼吸暂停要解决气道。这一页讲医生怎么把它们分开，以及什么时候“睡不好”已经不是睡眠问题，而是抑郁、焦虑或躯体病的信号。

一、先把四件事分开

同样是“白天没精神”，背后的机制可能完全相反。

- **失眠障碍**：有机会睡、环境也允许，但入睡难、睡不长、早醒，而且白天的功能被影响。
- **嗜睡障碍**：睡的时间不短，甚至很长，白天仍然困到必须睡，睡完也不清醒。
- **昼夜节律障碍**：总睡眠时长可能够，但**睡的时间点不对**。凌晨三四点才困、中午才醒，硬按社会时间起床就天天像倒时差。
- **睡眠呼吸暂停**：睡着一再憋气、缺氧、微觉醒，自己完全不知道，只觉得白天累、记性差、早上头痛。

这四类可以同时存在。一个人可以既有失眠，又有呼吸暂停；也可以既有抑郁，又有节律延迟。医生要做的不是选一个最像的，而是排一个顺序。

类型	最典型的一句话	关键线索	首选的检查方向
失眠障碍	“我躺下就是睡不着”	每周三晚以上、持续三个月	睡眠日记、访谈
嗜睡障碍	“我睡十小时还是困”	睡够仍困、睡着容易	嗜睡量表、多导睡眠监测
昼夜节律障碍	“我凌晨才有睡意”	周末与工作日差很多	睡眠日记、体动记录
睡眠呼吸暂停	“家人说我睡觉会憋气”	打鼾、目击憋气、晨起头痛	多导睡眠监测

二、失眠障碍：看的是白天，不是夜里

【指南】按 DSM-5-TR 的思路，失眠障碍要同时满足几件事：对睡眠的数量或质量不满意（入睡困难、维持睡眠困难、早醒）；每周至少三个晚上；持续至少三个月；**尽管有充足的睡眠机会**仍然如此；并且引起临床上明显的痛苦或功能损害（疲劳、注意力差、情绪不稳、工作效率下降）。还要排除其他睡眠-觉醒障碍、物质或药物所致、以及躯体疾病所致。

注意最后那句“有充足的睡眠机会”。一个每天加班到一点、六点起床的人睡不够，这叫睡眠不足，不叫失眠障碍。一个照顾婴儿的母亲夜里反复被叫醒，这在当时是环境所致。诊断要问的是：**给你八小时、安静的房间、没人打扰，你睡得着吗？**

【研究】临床上常用“三因素模型”来解释慢性失眠：有些人天生睡眠调节比较脆弱（易感因素）；一次考试、一场病、一段高压期把失眠引出来（诱发因素）；之后为了补觉而早睡、白天躺着、担心今晚又睡不着（维持因素）。到了慢性阶段，真正维持问题的往往不是最初的诱因，而是这些“补救行为”。

这解释了一个反直觉的现象：**在床上躺得越久，睡得越差。** 睡眠像饥饿，需要在床上积累“困意”。白天补觉、早早上床刷手机，等于把饥饿感一点点吃掉。

三、嗜睡、呼吸暂停与昼夜节律

嗜睡：困到出事，就不能只当“懒”

嗜睡障碍的核心是：**睡眠时间已经足够（通常七小时以上），白天仍然过度困倦**，表现为反复打盹、睡着、或在需要清醒的场合撑不住，持续三个月以上，并影响工作、学习或安全。

有两类必须由睡眠专科评估。一是**发作性睡病**，典型表现是四联征：日间过度嗜睡、猝倒（大笑或生气时突然腿软、头下垂、说话含糊，意识清醒）、睡眠瘫痪（醒来时动不了，几十秒到几分钟）、入睡前幻觉（刚睡着时看到或听到不存在的东西）。不是每个人四样都有。诊断需要多导睡眠监测加多次睡眠潜伏期试验，部分患者查脑脊液下丘脑分泌素。这类病常在青少年期起病，平均要好几年才被认出来，中间常被误诊为“抑郁”“懒”“注意力不集中”。二是**睡眠呼吸暂停**，典型线索是：响亮而不规律的打鼾、家人目击到呼吸暂停、夜里憋醒、晨起口干头痛、白天困、夜尿多、体重偏高、颈围粗。它不只是“打呼噜”——长期缺氧会增加高血压、心律失常、脑卒中和认知下降的风险，也会让抑郁治疗效果变差。诊断靠多导睡眠监测，不是靠自觉。

【临床经验】门诊里最容易被漏掉的是**瘦人也会有的呼吸暂停**（下颌后缩、鼻塞、扁桃体肥大）和**女性更年期后的呼吸暂停**（表现更像失眠、疲乏、头痛，而不是典型打鼾）。

昼夜节律：不是意志力问题

生物钟由光照、进食、活动、社交时间共同校准。当“内在的睡点”和“社会要求的起床点”错开，人就会出现类似长期倒时差的症状：早上起不来、晚上睡不着、白天昏沉、周末补觉后更乱。

常见类型包括**睡眠-觉醒时相延迟**（青少年最常见，不是“玩手机玩晚了”这么简单，而是生理性的睡点后移，强行早起等于每天跨越几个时区）、**倒班工作障碍**（症状随班表波动）、**时差障碍**（跨时区旅行后出现，通常几天到两周内缓解）、**睡眠-觉醒时相提前**（老年人多见，晚上很早困、凌晨很早醒）。

判断的关键是**睡眠日记**：连续两周记下上床时间、入睡时间、醒来时间、起床时间、白天打盹。看的是“模式”，而不是某一晚。一个只在工作日睡不够、周末能补回来的人，更可能是睡眠不足或社会时差，而不是失眠障碍。

四、睡眠与抑郁焦虑的关系，以及量表能做什么

【研究】失眠和抑郁的关系是双向的：失眠是抑郁发作的风险因素之一，抑郁也几乎总会带来睡眠改变。焦虑更多表现为入睡困难、夜里惊醒、脑子停不下来；抑郁更常表现为早醒、睡不实、醒了还是累。

但**不能用“早醒”直接推断抑郁**。早醒也见于正常老化、酒精、疼痛、呼吸暂停、环境噪音和单纯的焦虑。反过来，**“能睡”也不排除抑郁**——有些抑郁患者睡得很多（非典型特征）。

睡眠不足本身就会制造精神症状：一晚不睡，第二天情绪更差、更容易发火、注意力涣散；连续几天睡眠严重不足，甚至可能出现短暂的错觉和偏执。所以评估任何精神症状时，医生都会问睡眠——因为**先修睡眠，有时能修掉一半症状**。

工具	用途	不能做什么
睡眠日记（两周）	看模式、看差异、看卧床时间	不能区分呼吸暂停
ISI 失眠严重指数	量化失眠严重度、随访变化	不能确诊失眠障碍
ESS 爱普沃斯嗜睡量表	筛查白天嗜睡程度	不能区分嗜睡的原因
STOP-BANG	筛查呼吸暂停风险	不能替代睡眠监测
多导睡眠监测	诊断呼吸暂停、发作性睡病	需要专科预约，不是常规筛查

所有量表都只是筛查或随访工具。分数高说明“值得进一步评估”，不等于确诊。

五、就诊准备、就医提示与常见误区

- ☐ 连续两周的睡眠日记：几点上床、大概几点睡着、夜里醒几次、几点起、白天睡多久。
- ☐ 让同床或同住的人描述：打鼾吗？有没有目击到憋气、喘一下、踢腿？
- ☐ 记录白天困到什么程度：开会睡着？等红灯睡着？开车需要开窗？
- ☐ 列出所有正在吃的东西：安眠药、抗过敏药、减肥药、咖啡、茶、能量饮料、酒。
- ☐ 记录一周的咖啡因和酒精时间点（下午三点后的咖啡、睡前的酒）。
- ☐ 说明工作班表：是否倒班、是否跨时区、是否长期熬夜。
- ☐ 说明情绪：最近是否持续低落、失去兴趣、担忧停不下来。
- ☐ 说明其他症状：晨起头痛、口干、夜尿、体重变化、打鼾伴憋醒。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **开车、操作机械、高空作业时困到“断片”**：立即停止这些活动，尽快就诊。嗜睡导致的交通事故是可以预防的。
- **睡眠中呼吸暂停伴口唇发紫、憋醒后剧烈心慌、或白天困到突然摔倒**：尽快到呼吸科或睡眠专科评估，必要时急诊。
- **猝倒发作伴外伤、或第一次出现睡眠瘫痪伴极度恐惧**：尽快就诊，排除发作性睡病、癫痫及其他神经系统问题。
- **连续几天几乎不睡，同时话多、活动增多、情绪异常高涨或出现幻觉妄想**：可能是躁狂或精神病性发作，立即精神科急诊。
- **失眠伴随“活着没意思”、自伤念头**：不要独处，联系家人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- **自行加量吃安眠药、或与酒精同服后出现意识模糊、走路不稳、呼吸变慢**：立即急诊，不要等“睡一觉就好”。

误区一：“睡够八小时才健康。” 八小时是人群平均值，不是每个人的指标。有人六小时就够，有人需要九小时。真正要看的是白天功能。

误区二：“安眠药吃了就戒不掉，所以不能吃。” 这类药确实有依赖和耐受风险，尤其长期使用；但是否使用、用多久，需要医生根据具体情况权衡。**不要自行加量，也不要突然停药**（突然停可能反跳性失眠甚至抽搐）。

误区三：“打呼噜说明睡得香。” 响亮而不规律的打鼾，加上白天困，恰恰是呼吸暂停的典型线索。

误区四：“白天补一觉就补回来了。” 补觉能缓解一部分睡眠债，但会进一步推迟当晚的睡点，让节律更乱。长期看，规律比补觉更重要。

误区五：“失眠都是心理问题。” 失眠的原因包括躯体病、药物、呼吸暂停、不宁腿、疼痛、激素变化。只谈心理，容易漏掉能治的部分。

确诊之后，慢性失眠的一线处理是**失眠的认知行为治疗**（CBT-I），核心包括睡眠限制、刺激控制、认知调整和放松训练，有较多研究支持【研究】。嗜睡和呼吸暂停要先解决病因，呼吸暂停常用气道正压治疗、口腔矫治器或手术评估。节律问题以**定时光照、固定起床时间、必要时短期调整作息**为主。不管哪一类，有一条通用原则：**固定起床时间，比固定上床时间更重要。** 起床时间稳住了，睡意才会在该来的时候来。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed. (ICSD-3), 2014.
- 中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组.《中国成人失眠诊断与治疗指南（2017 版）》.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（睡眠-觉醒障碍章节）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

12.3 谵妄与痴呆

老人突然说“屋里有别人”、半夜要出门、白天糊里糊涂、晚上更乱——这可能是谵妄，是急症；也可能是一个慢慢进展的痴呆，在感染或换药后突然“露出来”。这两个词常被混用，处理却完全相反：谵妄要立刻找病因，痴呆要长期评估和支持。这一页讲医生靠什么分开它们，以及怎么和精神分裂症、抑郁区分开。

一、谵妄：不是“疯了”，是大脑供不上

【指南】谵妄（delirium）的核心不是幻觉，而是**注意力和意识的障碍**。按 DSM-5-TR 的思路，它通常表现为：

- **注意力出问题**：没法持续关注一件事，问话要重复，说着说着就飘走；让他从 100 减 7，做两下就乱了。
- **意识水平改变**：不是昏迷，而是“时清时浊”。上午还能认人，下午叫不应；或者一直昏昏欲睡、反应迟钝。
- **起病急、一天之内波动**：这一点最有诊断价值。家属常说“前天还好好的，昨天突然就不对了”。症状在 24 小时内起起伏伏，**晚上更重**，这叫“日落现象”。
- **其他认知改变**：记忆、定向（不知道自己在哪、今天几号）、语言、视空间都可能受影响；可能出现幻觉（多见生动的视幻觉）、片段的被害感、行为紊乱。

最关键的第四条：这些表现必须是**躯体疾病、药物、中毒或戒断的直接生理后果**，而不是用已有的痴呆或精神分裂症能更好解释的。

换句话说，谵妄不是“心理问题”，而是**大脑在报警**。它和胸痛、呼吸困难属于同一级别的信号。住院老人中出现谵妄，与住院时间延长、跌倒、功能下降和死亡风险升高相关【研究】。**谵妄是医疗急症，必须当天评估。**

谵妄有三张面孔，最容易漏掉的是“安静的那张”：

类型	表现	后果
活动过型	躁动、拉扯管路、喊叫、幻觉、攻击	容易被发现，也容易被误当“精神病”
活动低下型	嗜睡、少语、不动、反应慢、吃得少	**最常被漏诊**，常被当成“累了”“抑郁了”
混合型	两种状态交替出现	波动大，家属最难描述

活动低下型的老人不会闹，只是“突然变得很安静、不太吃东西、叫他反应慢”。这种表现如果出现在感染、手术、换药之后，要优先想谵妄，而不是先加抗抑郁药。常见诱因可以记成一句话：**感染、药物、电解质、缺氧、疼痛、尿潴留、便秘、脱水、戒断、术后、脑本身的问题。** 老年人、已有痴呆、听力视力差、刚做完手术、正在用多种药的人，风险更高。

二、痴呆：不是正常变老，也不只是“记性差”

痴呆（现在多称“神经认知障碍”）的核心是**认知功能比从前明显下降，并且已经影响到日常生活的独立性**。它通常是**隐袭起病、缓慢进展**，和谵妄的“突然”正好相反。

受影响的不只是记忆，还包括语言（找词困难、叫不出名字）、执行功能（做饭、算账、安排事情变难）、视空间（迷路、穿衣顺序乱）、注意力和判断力。判断“是不是病”，关键看两件事：**和本人以前比，是否明显下降；日常功能是否已经需要人帮。**

常见类型（只列最常见的几类，便于理解差异）：

- **阿尔茨海默病**：最常见，以近期记忆下降起病，逐渐累及语言、视空间和日常生活。
- **血管性痴呆**：与脑卒中、小血管病相关，可能呈“阶梯式”恶化，执行功能受损突出。
- **路易体痴呆**：认知**波动**明显、反复出现**生动详细的视幻觉**、有帕金森样表现（动作慢、僵硬、步态不稳）、常有 REM 睡眠行为障碍（睡着时把梦演出来）。要特别提醒：这类患者对某些抗精神病药物可能极度敏感，出现严重僵硬、意识恶化甚至危及生命，用药必须由医生谨慎评估。
- **额颞叶痴呆**：起病相对早，早期以**人格和行为改变**（变得不合宜、冷漠或冲动）或语言退化为主，记忆相对保留，容易被误认为“性格变了”“抑郁了”“躁狂了”。

三、三个最常混的鉴别

第一，谵妄 vs 痴呆。 最实用的区分是**起病速度和波动性**。痴呆是几年来的缓慢下滑；谵妄是几小时到几天的急转直下，一天之内忽好忽坏。两者可以叠加：痴呆患者最容易发生谵妄，而谵妄反复发作也可能提示背后存在尚未被识别的认知问题。**任何时候，痴呆患者出现“突然变差”，先按谵妄处理。**

第二，痴呆 vs 抑郁。 老年抑郁可以表现为“反应慢、记不住、不想动”，过去叫“假性痴呆”。区分的线索是：抑郁起病相对快（几周到几个月）、情绪低落或兴趣丧失突出、回答问题时倾向“我不知道”“记不清”，努力程度差但注意力本身没坏；痴呆患者则常常**尽力回答但答错**，还会用“编造”来填补空白（虚构），并且早期情绪未必低落。抑郁引起的认知下降在治疗抑郁后可以部分改善，所以**不把老年抑郁当痴呆，也不把痴呆当抑郁，都很重要**。

第三，痴呆/谵妄 vs 精神分裂症。 精神分裂症通常青壮年起病，幻觉妄想突出且系统化，认知损害相对轻，日常生活能力在早期多能保留；痴呆以认知和功能下降为主，精神病性症状多为片段、不系统。老年**首次**出现精神病性症状，尤其伴认知下降，必须先排除器质性原因（见 12.4 器质性与药物所致精神障碍的排查）。

维度	谵妄	痴呆	抑郁
起病	数小时到数天	数年到数月	数周到数月
波动	明显，日轻夜重	相对平稳	可有晨重夜轻
注意力	核心受损	中晚期受损	可差但能配合
情绪	恐惧、易激惹	早期可淡漠	低落、兴趣减退

四、家人怎么记录，医生会怎么查

家人常说的“他糊涂了”，对医生几乎没有信息量。下面这些记录才有用：

- ☐ **基线**：他平时能不能自己吃饭、洗澡、吃药、管钱？和三个月前比差在哪？
- ☐ **起病时间**：具体哪天几点开始不对劲？之前有没有感冒、摔倒、手术、换药、喝酒？

- ☐ **波动**：一天里什么时候最清楚、什么时候最乱？夜里怎么样？
- ☐ **注意力**：跟他说话能跟住吗？看电视能看几分钟？
- ☐ **幻觉内容**：看到了什么、听到了什么？是“好像有人”还是“坚信有人”？
- ☐ **用药清单**：所有处方药、非处方药、中成药、保健品，最近两周有没有加、减、换。
- ☐ **躯体情况**：有没有发热、咳嗽、尿痛、腹泻、便秘、疼痛、吃得少、喝得少。
- ☐ **安全**：有没有走失、开煤气、跌倒、把东西放错地方（比如把遥控器放冰箱）。

谵妄：全部要查。 首次出现意识混乱，基本检查通常包括血糖、电解质、肾功能、肝功能、血常规、尿常规、心电图、血氧，必要时感染指标、甲状腺功能、药物浓度、头颅影像、脑电图、腰穿。不是“过度检查”，因为漏掉低血糖、低氧、感染、卒中、酒精戒断的代价太大。

痴呆：一次系统评估。 通常包括病史（本人加知情者）、认知筛查（MMSE 或 MoCA，注意受教育程度会影响分数）、日常功能评估、神经系统查体、血液检查（甲状腺功能、维生素 B12、叶酸、电解质、肝肾功能、必要时梅毒血清学）、头颅影像。**量表分数不能单独确诊**，它只是拼图里的一块。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - **任何首次出现的意识混乱、注意力涣散、认不出人、看到不存在的东西**：立即急诊。这是谵妄，按急症处理，不要在家观察一夜。
> - 意识改变伴**发热、剧烈头痛、颈项僵硬、抽搐、口角歪斜、一侧肢体无力、说话不清**：拨打 120。
> - 痴呆或服用抗凝药的老人**跌倒撞到头**后出现嗜睡、呕吐、意识变差：立即急诊，警惕硬膜下血肿。
> - **木僵、缄默、拒食拒水超过一天、长时间保持一个姿势不动**：可能是紧张症或严重躯体衰竭，需急诊精神科评估。
> - 突然极度躁动、有伤人毁物或自伤行为，家中无法保证安全：拨打 120（必要时 110），不要单独强行约束。
> - 长期饮酒或长期服镇静药的人突然停用后出现**手抖、大汗、心跳快、幻觉、抽搐**：立即急诊，酒精戒断可致命。
> - 谵妄或痴呆患者出现**自伤、走失、把药吃错**：尽快联系医生调整照护方案。

五、常见误区与下一步

误区一：“人老了糊涂是正常的。” 正常老化会有处理速度变慢、偶尔找词困难，但**不会**让人认不出家人、不会在熟悉的地方迷路、不会突然不会用洗衣机。出现这些，要评估。

误区二：“他突然闹，是精神分裂症发作了。” 老年人首次出现精神病性症状，器质性原因的比例远高于精神分裂症。先查，再谈诊断。

误区三：“谵妄是吓着了，睡一觉就好。” 谵妄是躯体急症的信号，睡过去可能错过治疗窗口。

误区四：“约束起来免得他乱动。” 身体约束会增加躁动、跌倒、血栓和谵妄加重的风险。优先做的是：改善环境（开灯、减少噪音、放时钟和日历）、让家人陪、纠正脱水缺氧疼痛、白天活动晚上关灯、必要时由医生短期用药。

误区五：“痴呆就没有希望了，查也没用。” 一部分认知下降是可逆的（甲状腺功能减退、维生素 B12 缺乏、抑郁、药物、慢性硬膜下血肿、正常压力脑积水）。即使不可逆，早期评估也能换来更长的独立生活时间、更安全的照护安排和更早的家庭准备。

谵妄的处理是**找病因并纠正**，同时做非药物干预（定向提示、睡眠-觉醒节律、感官辅助、家属陪伴、早期活动）。抗精神病药只在严重激越、有伤害风险时由医生短期使用，不作为常规。

痴呆的处理是**多维度**的：治疗可逆因素、管理血管风险、认知和社交活动、照护者支持、安全安排（走失、用火、驾驶、财务）、预先讨论照护意愿。诊断本身不是终点，它更像一张地图——告诉你接下来要准备什么。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（谵妄、神经认知障碍章节）.
- WHO. Dementia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
- NIMH. Mental Health Information. https://www.nimh.nih.gov/health

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

12.4 器质性与药物所致精神障碍的排查

一个人突然变得多疑、话多、睡不着、说看到东西，家里人第一反应是“精神出问题了”。但在精神科，医生最先问的往往是另一串问题：最近发不发烧？有没有换药？查出过甲亢吗？喝酒吗？——因为甲状腺、维生素 B12、感染、自身免疫性脑炎、药物和酒精，都能把一个人变得“像精神病”。这一页讲医生按什么顺序排、哪些检查不能省、以及为什么“先查身体”不是敷衍。

一、为什么必须先排“器质性”，以及哪些信号提示要查

【指南】DSM-5-TR 和 ICD-11 都保留了一条基本规则：精神障碍的诊断，要求症状**不能更好地用躯体疾病、物质或药物的生理效应来解释**。这不是说精神障碍“不真实”，而是诊断顺序问题——先排除能改的、能致命的、能治好的。

原因很实际：**漏诊代价大**（脑炎、低血糖、低钠、酒精戒断、硬膜下血肿，延误几小时到几天，结果可能完全不同）；**治疗方向相反**（器质性原因要治病因，原发性精神障碍要精神科治疗，方向错了越努力越糟）；而且**排除躯体原因，不等于说“你的痛苦是假的”**——很多器质性原因纠正后，痛苦才真正缓解。

现实里并非每个首次就诊的人都要做全套检查。医生会根据年龄、起病方式、伴随症状、既往病史来决定查多深。下面这些线索出现得越多，越应该优先考虑器质性原因【临床经验】：

- ☐ **首次发病年龄很极端**：儿童期起病，或四十岁以后**第一次**出现精神病性症状。
- ☐ **起病很急**：几小时到几天内从正常变得完全不正常。
- ☐ **意识或注意力波动**：时清时浊、白天糊涂晚上闹（见 12.3 谵妄与痴呆）。
- ☐ **认知下降**：记不住刚发生的事、算不清账、找不到路。
- ☐ **神经系统体征**：口角歪斜、肢体无力、走路不稳、说话不清、眼球活动异常、抽搐、手抖。
- ☐ **伴随躯体症状**：发热、剧烈头痛、呕吐、体重明显下降、盗汗、心慌、怕热多汗。
- ☐ **自主神经不稳定**：心跳忽快忽慢、血压波动、大汗、体温异常。
- ☐ **病程不典型**：持续恶化不缓解、治疗完全无效、或反复“发作—恢复—再发作”且模式古怪。
- ☐ **有明确诱因**：新加药、加量、换药、停药、饮酒或戒酒、感染、手术、外伤、妊娠或产后。

二、常被漏掉的几类躯体原因

病因	容易被当成	关键线索
甲状腺功能亢进	焦虑症、惊恐障碍	心悸、怕热、多汗、手抖、体重下降、腹泻
甲状腺功能减退	抑郁症、痴呆	乏力、怕冷、便秘、水肿、反应慢、情绪低落
维生素 B12 缺乏	抑郁、认知下降、神经症	舌炎、四肢麻木、走路不稳、素食或长期服二甲双胍
感染（尿路、肺、败血症）	谵妄、精神分裂症首发	发热、尿痛、咳嗽、老年突然糊涂
自身免疫性脑炎	精神分裂症、紧张症	精神症状首发＋癫痫＋口面部不自主动作＋记忆下降
低钠、低钙、低镁	焦虑、意识混乱、抽搐	近期输液、利尿剂、呕吐腹泻、大量饮水

病因	容易被当成	关键线索
低血糖	醉酒、行为异常、惊恐	心慌、出汗、手抖、意识模糊，进食后好转
肝性脑病、尿毒症	痴呆、人格改变	扑翼样震颤、黄疸、少尿、便秘或消化道出血后加重
系统性红斑狼疮	抑郁、精神病性发作	皮疹、关节痛、脱发、口腔溃疡、蛋白尿
慢性硬膜下血肿	痴呆、抑郁、卒中	老年人、近期跌倒、服用抗凝药、逐渐加重的头痛
正常压力脑积水	痴呆、帕金森病	步态不稳＋尿失禁＋认知下降三联征
癫痫（尤其颞叶）	惊恐发作、幻觉、人格改变	发作性恐惧、似曾相识感、自动症、发作后混乱

【指南】**自身免疫性脑炎**值得单独说，因为它是“精神科最容易漏、神经科最该抢时间”的一类。以抗 NMDAR 脑炎为例，患者常是年轻人，最初表现是行为紊乱、幻觉、妄想、言语减少、情绪剧烈波动，甚至木僵；随后出现癫痫、口面部不自主运动、自主神经不稳、通气不足。早期头颅 MRI 可能正常，脑电图可能只显示弥漫性慢波。**精神症状＋癫痫＋运动异常＋记忆下降**这个组合，应该尽快请神经科会诊，而不是只调精神科药物。

三、药物与酒精：最常见的两类“人造”病因

药物

药物引起的精神症状，特点往往是：**用药或加量后出现，减量或停药后好转，再次使用又出现**。常见类别包括：

- **糖皮质激素**：失眠、欣快、易激惹、抑郁、躁狂样表现、精神病性症状，与剂量和个体敏感性有关。
- **抗胆碱能药物**（部分抗过敏药、解痉药、抗帕金森药）：记忆下降、意识模糊、幻觉，老年人尤其敏感。
- **左旋多巴及多巴胺受体激动剂**：幻觉、冲动控制问题（赌博、购物、性冲动）。
- **部分抗生素**（如喹诺酮类）：失眠、焦虑、意识混乱，罕见精神病性症状。
- **异烟肼**：可致情绪和认知改变，通常与维生素 B6 状态有关。
- **干扰素、部分免疫抑制剂、抗癫痫药**：抑郁、疲劳、认知变慢、行为改变。
- **苯二氮䓬类和镇静催眠药**：老年人可出现“矛盾反应”——本想镇静，结果更躁、更糊涂。
- **阿片类**：嗜睡、意识模糊、幻觉。
- **中成药、保健品、减肥产品**：成分不明，可能含重金属、激素或未标注的活性成分。

【临床经验】最重要的是**一份完整的用药清单**，包括你自己觉得“不算药”的东西。很多“治不好的焦虑”在停掉某种感冒药、止咳药或减肥茶后明显好转；很多“新发的抑郁”发生在开始用某种药之后的几周内。但请注意：**不要自行停药**。突然停激素、抗癫痫药、抗抑郁药、苯二氮䓬类，本身就可能引起严重反应。正确做法是把清单带给医生，由医生判断。

酒精

酒精可以以三种方式制造精神症状，处理各不相同：

1. **急性中毒**：话多、走路不稳、判断力差、记忆断片，严重时意识模糊、呕吐误吸、呼吸抑制。
2. **戒断**：停酒或减量后 6–24 小时出现手抖、出汗、心慌、焦虑、失眠；12–48 小时可能出现癫痫；48–96 小时可能出现**震颤谵妄**——意识混乱、生动幻觉、高热、大汗、心跳快，这是可以致命的急症。
3. **慢性损害**：维生素 B1 缺乏导致 Wernicke 脑病（眼球活动异常、走路不稳、意识混乱）和 Korsakoff 综合征（近事记忆严重受损、用编造填补空白）；长期饮酒还可致肝性脑病、小脑萎缩、周围神经病。

   长期大量饮酒的人**不能自行硬戒**。突然停酒是上述急症最常见的诱因，需要在医生指导下处理。

四、查多深，以及就诊前准备什么

层次	什么时候做	通常包括
第一层	几乎每个首次评估	血常规、电解质、血糖、肝肾功能、甲状腺功能、维生素 B12、尿常规、心电图
第二层	有红旗信号或第一层异常	感染指标、血氨、血气、尿毒物、妊娠试验、梅毒血清学、HIV、自身免疫抗体、头颅 CT 或 MRI、脑电图
第三层	高度怀疑特定疾病	腰穿、脑脊液自身抗体、内分泌激发试验、肿瘤筛查、专科会诊

这张表不是“必须全做”，而是告诉你医生在想什么。育龄女性在用药前通常会做妊娠试验；老年人首次出现精神症状，头颅影像的门槛会放低；免疫功能受损、静脉药瘾、近期旅行史的人，感染筛查会提前。

- ☐ **时间线**：把“哪天开始不对劲”和“哪天开始吃某种药”“哪天发烧/摔倒/喝酒”画在同一张纸上。
- ☐ **用药清单**：药名、开始时间、剂量变化、是否自行停过。包括中药、保健品、外用药。
- ☐ **既往检查**：把做过的化验和影像按时间整理，避免重复。
- ☐ **躯体症状**：体重变化、发热、盗汗、疼痛、排便排尿、月经、视力听力变化。
- ☐ **饮酒与吸烟**：种类、大致量、最近有没有减量或停。
- ☐ **家族史**：甲状腺病、自身免疫病、癫痫、精神疾病。
- ☐ **功能变化**：能不能上班、开车、管钱、独自出门。
- ☐ **带一个知情人**：很多细节本人记不清，家属的描述常常是诊断的关键。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - **意识改变＋发热＋肌肉僵硬＋大汗＋心跳快**：可能是恶性综合征或血清素综合征，**立即停药并拨打 120**。
> - **突然出现幻觉、被害感，同时有发热、头痛、抽搐、说话不清、肢体无力**：立即急诊，警惕脑炎、卒中、颅内感染。
> - **长期饮酒或长期服镇静药者突然停用后出现手抖、大汗、幻觉、抽搐**：立即急诊，不要在家“扛过去”。

- **糖尿病用药者出现心慌、大汗、意识模糊、行为异常**：先按低血糖处理（清醒者立即进食含糖食物），不缓解或已昏迷立即拨打 120。
- **木僵、缄默、拒食拒水超过一天、长时间维持奇怪姿势、对外界几乎无反应**：可能是紧张症，需急诊精神科评估，同时排查器质性病因。
- **服用新药后出现严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并急诊。
- **出现自杀念头或自伤行为**：不要独处，联系家人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

五、常见误区与下一步

误区一：“查了都正常，说明肯定是心理问题。” 常规检查正常只能排除一部分疾病。脑炎早期、部分内分泌病、自身免疫病，常规化验可能都正常。如果症状持续恶化或出现新体征，需要复查和升级检查，而不是简单归因。

误区二：“既然是药物引起的，停掉就好了。” 有些药物不能突然停（激素、抗癫痫药、苯二氮䓬类、抗抑郁药），突然停可能引起戒断、反跳甚至抽搐。减停方案要由开药医生定。

误区三：“精神科医生只会开精神药，不会看身体。” 规范的精神科评估一定包含躯体病史、用药史和必要的实验室检查；遇到可疑体征，会转诊神经科、内分泌科或感染科。

误区四：“器质性就是治不好的脑损伤。” 恰恰相反，这一类里有很多是**可逆**的：甲状腺功能异常、维生素 B12 缺乏、低钠、感染、药物反应、硬膜下血肿。查出来的意义，正在于它们能改。

误区五：“只要查出甲状腺有问题，精神症状就都归它。” 甲状腺功能异常和抑郁、焦虑可以并存。纠正甲功后症状没完全缓解，仍需单独评估精神障碍。**不要把所有症状都归给一个原因**（见 13.5 共病与多重诊断）。

如果找到明确的躯体或药物原因，处理方向是**治病因＋对症支持**，同时观察精神症状是否随之缓解。如果排查后仍无明确病因，也不等于“什么都没查出来”——这本身是一条重要信息，它让医生更有把握按原发性精神障碍来治，并把这作为后续随访的基线。

【临床经验】最理想的模式不是“精神科”和“其他科”二选一，而是**同时进行**：该查的查，该治的治，该等的等。对患者和家属来说，最有用的态度是：既不因为“怕是躯体病”而拒绝精神科评估，也不因为“说是心理问题”就放弃必要的躯体检查。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（器质性精神障碍、物质所致障碍章节）.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）.

- 中华医学会精神医学分会相关指南/共识（器质性精神障碍与谵妄评估部分）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

模块 13：特殊人群误诊与沟通

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

13.1 儿童青少年诊断

给儿童下精神科诊断，比给成人难得多：孩子的“症状”可能只是某个发育阶段的正常表现，也可能是在替家庭、学校或身体问题说话。而同一个孩子，妈妈说的、老师说的、孩子自己说的，常常是三份不同的报告。这一页讲医生怎么在发育的背景下判断，怎么处理“拒绝上学”和“易激惹”，以及怎么把 ADHD、ASD、创伤分开。

一、第一原则：先问“这个年龄这样正不正常”

成人诊断看“和以前比变了多少”，儿童诊断还要多一层：**和同龄人比，偏了多少**。

三岁孩子怕黑、怕陌生人，是正常的；十二岁还完全无法与父母分开，就需要看。四五岁在商场倒地大哭，不算罕见；十岁仍然每周多次因为小事砸东西，就值得评估。青春期的情绪起伏、追求独立、和父母顶嘴，本身也不是病。

【指南】发育的视角会改变整张诊断表：

- **症状的表现形式随年龄变。** 抑郁在小学生身上可能是肚子痛、不肯上学、黏人；在青少年身上才更像“情绪低落、自我否定”。
- **有些障碍有起病年龄门槛。** ADHD 要求症状在十二岁前就已经出现；ASD 要求早期发育阶段就有社交沟通的差异；破坏性情绪失调障碍限定在六到十八岁。
- **功能损害的判断标准不同。** 一个学龄前儿童“坐不住三分钟”可能正常；一个三年级学生因此完全跟不上课堂，就是损害。

年龄段	常见、多数会过去的表现	需要专业评估的信号
3–6 岁	怕分离、发脾气、怕黑、假装游戏	完全不看人、不说话、自伤、极度攻击
6–12 岁	坐不住、争强好胜、偶尔说谎	持续半年以上、跨场景、学业明显下滑
12–18 岁	情绪起伏、要隐私、挑战权威	自伤、拒学、幻觉、持续两周以上的低落

信息也不能只听一个人。规范的做法是**分别采集**孩子本人、父母或主要照护者、老师（有时还包括课后班老师、保姆、祖辈）。

三份报告经常不一致，这本身是信息，不是谁在撒谎：**家长看不到学校的样子**，老师看不到家里的样子，只在某一场景出现的问题可能与环境有关；**家长的焦虑会影响描述**，有的把所有行为都看成“病”，有的因为怕被贴标签而轻描淡写；**孩子会隐藏**，青少年尤其容易在父母面前维持“正常”，自伤、自杀念头、被欺凌常常只有在单独访谈时才说出来；**老师有比较样本**，见过几百个同龄孩子，对“明显偏离”的判断往往有价值，但一个班里的“最调皮”未必就是 ADHD。

常用的筛查工具（SDQ 长处与困难问卷、CBCL 儿童行为量表、Conners 量表、SCARED 儿童焦虑筛查、M-CHAT 幼儿孤独症筛查）作用是**系统收集信息、量化严重度、随访变化**，不能单独用来确诊。

二、拒绝上学：先当成症状，别当成态度

“不想上学”是儿童青少年最常见的主诉之一，也是最容易被误解的一个。它可能是：

- **分离焦虑**：离开父母就恐慌，常见于低龄或刚转学、家里刚发生变故的孩子。
- **社交焦虑或被欺凌**：怕被评价、怕当众出丑，或在校园里正在遭受排挤、勒索、暴力。
- **学习障碍**：阅读、书写、计算困难，长期挫败后发展为“一到学校就肚子痛”。
- **抑郁**：早上起不来、对什么都提不起劲、觉得“我不配”。
- **ASD 的感官过载**：走廊太吵、日光灯太亮、食堂太乱，撑不住。
- **躯体疾病**：睡眠不足、贫血、慢性疼痛、哮喘、癫痫。
- **家庭因素**：需要照顾生病的家人、家庭冲突、经济压力。

“拒绝上学”不是诊断，而是一个需要拆解的行为。 医生会问：是从哪天开始的？那天发生了什么？他是在家门口不去，还是到了学校才跑回来？不去的时候在家做什么？如果不用上学，他愿意出门玩吗？——最后一个问题很关键：**只拒绝上学、其他活动正常**，和**什么都不敢出门**，指向的方向不同。

家长可以这样记录两周：

- ☐ 哪天没去、当天早上发生了什么、谁说了什么。
- ☐ 前一天晚上的睡眠、第二天的身体不适（头痛、肚子痛、恶心）。
- ☐ 到校门口的反应：哭、发抖、僵住、逃跑。
- ☐ 不去学校时在家的状态：能玩、能笑，还是一整天躺着。
- ☐ 最近有没有被同学排挤、被老师批评、被威胁。
- ☐ 学业上有没有突然跟不上的科目。
- ☐ 家里最近有没有变故：搬家、二宝出生、离婚、亲人去世、经济问题。

三、易激惹，以及 ADHD、ASD、创伤怎么分

易激惹是儿童转诊里最常见的词之一，也是最难判断的一个。要点是看**频率、强度、持续时间、场景和年龄是否匹配**。

- **正常的发脾气**：多在疲惫、饥饿、被拒绝时出现，几十分钟内能平复，事后能讲道理，主要在家人面前。
- **破坏性情绪失调障碍（DMDD）**：以**持续一年的、频繁的**严重脾气爆发为特征，与年龄和发展水平明显不符，并且在家庭、学校等多个场景出现，发作间期也常处于易怒状态。起病通常在十岁前，诊断适用于六到十八岁。
- **对立违抗障碍（ODD）**：以持续的对抗、违拗、报复为主，情绪爆发的“爆发性”不如 DMDD 突出。
- **双相障碍**：关键在**发作性**——有明确的、持续数天的情绪高涨或易激惹期，伴随睡眠需求减少、话多、活动增多、夸大，而不是每天都在发火。

- **ADHD**：冲动、插话、等不及，情绪爆发常由挫折触发，来得快消得也快。
- **ASD**：爆发常由变化、感官刺激、沟通失败触发，事后可能自己也说不清。
- **创伤**：易激惹、警觉过高、回避，常伴睡眠差、惊跳反应强。
- **躯体因素**：睡眠不足、甲状腺功能亢进、缺铁、慢性疼痛、某些药物。

一个实用的提问是：“他发火的时候，是要达到某个目的，还是像被什么淹没了？”前者更像对立行为，后者更像情绪调节失控。

维度	ADHD	ASD	创伤相关
起病	十二岁前，常自幼	早期发育阶段	创伤事件之后
社交	想交朋友，但冲动、插话	社交动机与方式不同，理解暗示困难	回避、警惕、控制欲强
注意力	广泛性差，感兴趣的事能超聚焦	对特定兴趣极度专注	警觉分散，像在“扫视危险”
关键病史	跨场景、长期	早期社交沟通差异、重复刻板	明确或疑似创伤暴露

这三者可以**同时存在**：ADHD 与 ASD 可以共病，创伤也可能发生在一个本来就有 ADHD 的孩子身上。诊断顺序通常是：先处理最影响安全和功能的问题（如创伤、抑郁、拒学），再细化长期存在的发育性问题。

还需要排除的“模仿者”包括：学习障碍（阅读、书写、计算）、听力或视力问题（被当成“不听指令”）、睡眠不足或睡眠呼吸暂停（被当成 ADHD）、失神癫痫（被当成“走神”）、抽动障碍、焦虑与抑郁，以及单纯的“班里年龄最小”。

四、偏差提醒，以及家长可以带什么

【研究】儿童诊断里存在稳定的偏差模式，值得家长知道：

- **性别**：男孩的外化行为（多动、攻击）更容易被转诊为 ADHD 或行为问题；女孩的内化问题（焦虑、抑郁）更容易被忽略，ASD 女孩更常被漏诊，因为她们更早学会“伪装”社交。
- **经济与语言**：贫困、营养不良、家庭不稳定、语言不通，都会被误读为“发育落后”或“不配合”。
- **被收养、留守、频繁转学**：依恋中断会表现为注意力差、讨好、情绪不稳，容易被直接扣上 ADHD 的帽子。
- **文化期待**：某些环境里“安静听话”被高度赞赏，活跃的孩子更容易被当成病；反过来，某些环境里“能忍”被鼓励，孩子的痛苦被推迟到很晚才被看见。

这些不是“诊断不公”的空话，而是提醒：**当诊断结论和孩子所处的环境高度相关时，值得多问一句“还有没有别的解释”。**

去就诊时，可以带上这些：

- ☐ 时间线：什么时候开始、什么情况下加重、什么情况下好转。
- ☐ 三个场景的例子：家里、学校、和同伴在一起，各写一个具体事件。
- ☐ 老师的一段书面描述（不必长，几句话即可）。

- ☐ 成绩单、作业本、以前做过的评估报告。
- ☐ 睡眠、饮食、排便、屏幕时间的实际情况。
- ☐ 家族史：ADHD、ASD、学习困难、抑郁、双相、癫痫、甲状腺病。
- ☐ 已经试过的办法：奖励表、限制屏幕、换班、补习，效果如何。
- ☐ 你真正担心的是什么：是成绩、是安全、是亲子冲突，还是“怕他以后过不好”。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **出现自伤行为（划手、撞头、烫自己）或说“不想活了”**：不要独处，移除家中危险物品，尽快联系医生；有明确计划或已经实施，立即拨打 120 或去急诊。
- **出现幻听、坚信被害、说话混乱、突然完全变了一个人**：尽快精神科急诊评估，同时排查发热、感染、药物等躯体原因。
- **拒绝进食饮水超过一天、体重明显下降、只在夜里活动**：尽快就诊，儿童脱水比成人更快。
- **攻击行为已经造成自己或他人受伤，或家里无法保证安全**：拨打 120（必要时 110）。
- **怀疑孩子遭受虐待、性侵、严重欺凌**：先保证孩子安全，向学校、未成年人保护机构或公安机关求助，同时寻求心理支持。
- **突然出现抽搐、意识丧失、剧烈头痛、呕吐**：拨打 120。
- 你自己已经撑不住、整夜睡不着、出现伤害自己或孩子的念头：这不是矫情，尽快联系医生或拨打 12356 心理援助热线。

五、常见误区与下一步

误区一：“孩子小，不懂事，长大就好了。” 有些问题确实会随发育缓解，但持续半年以上、跨场景、已经影响学业和同伴关系的困难，等下去往往代价更大。

误区二：“诊断就是给孩子贴一辈子标签。” 儿童诊断更像“当前最合适的解释和工作假设”，需要定期复核。合适的诊断能换来资源（学校支持、康复训练、医保报销），也能让家长停止自责。

误区三：“成绩好就没问题。” 高功能的孩子会用成绩掩盖社交困难、焦虑和强迫；过度追求成绩本身也可能是焦虑的表现。

误区四：“ADHD 就是管得不严。” ADHD 是有神经发育基础的障碍，和教养方式不是因果关系。严格管教能改善行为，但不能“治好”注意力调节的困难。

误区五：“给他做个量表就能确诊。” 量表只提供线索。规范评估一定包含发育史、跨场景信息、功能损害和鉴别诊断。

儿童干预的重点通常不是“吃药还是不吃药”这一个二选一，而是多层面同时做：**家长培训**（怎么给指令、怎么设规则、怎么奖励）、**学校配合**（座位、作业量、考试安排）、**心理治疗**（焦虑、创伤、情绪调节）、**康复训练**（语言、社交、学习支持），必要时由医生评估是否用药。

【临床经验】对家长最有帮助的一句话是：**先别急着纠正孩子，先弄清楚他在哪个环节卡住了。**是听不懂、坐不住、害怕、还是没人教过？答案不同，办法完全不同。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87), 2018.
- NICE. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis (CG170), 2013（2020 更新）.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（神经发育障碍章节）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

13.2 老年诊断

同一位老人，可能同时在吃七种药、有三种慢性病、听力下降、最近又摔了一跤。在这种背景下判断“他是不是抑郁”“他是不是痴呆了”“他是不是疯了”，比在年轻人身上难得多，也更容易被一句“年纪大了”带过去。这一页讲老年精神科诊断的几条特殊规则，尤其是**老年第一次出现精神病性症状**该怎么查。

一、老年诊断为什么不一样

年轻人看精神科，医生主要听症状；看老年人，医生还要同时看四样东西——它们会把任何精神症状放大、扭曲，也会制造出并不存在的精神症状。

放大器	具体表现	会造成什么误判
躯体共病	心脏病、糖尿病、慢阻肺、肾衰、肿瘤、疼痛	乏力、食欲差、失眠被当成抑郁；缺氧、感染被当成痴呆
多重用药	五种以上药物同时使用	药物本身引起抑郁、谵妄、幻觉、跌倒
认知与感官下降	听力、视力、记忆、处理速度	听不清被当成“多疑”；看不清被当成“幻觉”
社会变化	退休、丧偶、独居、经济下降、搬离熟悉环境	悲伤被当成抑郁；孤独被当成退缩

【指南】因此，老年精神科评估通常比年轻成人更长：要问躯体病史、逐一核对用药、做认知筛查、评估日常功能（吃饭、穿衣、洗澡、如厕、行走，以及做饭、购物、管钱、服药、出行）、看跌倒风险和营养状态，还要问照护者能不能撑住。

功能评估是关键词。 诊断痴呆不只看“记性差”，而是看**日常生活能力是否已经需要人帮**；判断抑郁严重度，也常看“还能不能自己做饭、管钱”。一个能做八道菜、能自己坐公交的老人，和一个把盐当糖、出门就迷路的老人，即使量表分数相同，意义也完全不同。

二、老年抑郁：常不说“难过”，而说“难受”

老年抑郁最容易被漏掉，因为它长得不像教科书。

- **主诉以躯体为主**：吃不下、睡不好、没力气、浑身疼、便秘、头晕、心慌。问情绪，回答“还行吧”“我这个年纪还有什么好不好的”。
- **兴趣减退比情绪低落更突出**：以前天天去公园下棋，现在不去了；以前爱看戏，现在电视都不开。
- **认知损害明显**：反应慢、记不住事、注意力差，过去叫“抑郁性假性痴呆”，治疗抑郁后可以部分改善。
- **焦虑、易激惹、疑病**：反复担心自己得了重病，反复检查。
- **精神病性症状在老年抑郁中并不少见**：可能出现与罪恶、贫穷、疾病相关的妄想（“我早就该死了”“家里已经破产了”），也可能有幻听。这类表现容易被误认为痴呆或精神分裂症。
- **自杀风险更高**：老年男性是自杀率最高的人群之一【研究】，而且往往求助更少、计划更周密、手段更致命。

所以，问老年抑郁不能只问“你心情好吗”，要问：“最近还有什么事让你觉得有意思？”“这半个月，你早上醒来最想做什么？”“有没有觉得活着是负担？”后面这句，很多老人会诚实地回答。

筛查工具常用 GDS-15（老年抑郁量表简版）或 PHQ-9，但都只是筛查。**量表分数不能替代面谈**，尤其是听力差、文化程度低、方言不同的老人。

三、多重用药，以及谵妄、痴呆、抑郁的叠加

【指南】老年人常常同时看四五个科，每个科开两三种药，再加上子女买的中成药和保健品。药物之间的相互作用、抗胆碱能作用的叠加、肝肾功能下降导致的蓄积，都可能制造精神症状。要特别留意的几类：

- **镇静催眠药与苯二氮䓬类**：跌倒、记忆下降、白天嗜睡、矛盾性激越。
- **抗胆碱能作用强的药**（部分抗过敏药、解痉药、抗帕金森药、部分抗抑郁药）：意识模糊、幻觉、便秘、尿潴留。
- **降压药、利尿剂**：体位性低血压、头晕、跌倒；电解质紊乱可引起意识改变。
- **糖皮质激素**：失眠、欣快、易激惹、抑郁。
- **抗精神病药**：在痴呆老人中用于行为症状时，需要非常谨慎，与跌倒、卒中风险以及死亡风险升高相关，通常只在严重激越、有伤害风险时由医生短期使用。
- **阿片类、抗癫痫药**：嗜睡、意识模糊、认知变慢。

有时候，减少一种不必要的药，比增加一种新药更有效。但这必须由医生来做。**不要自行停用任何处方药**——突然停降压药可能反跳性高血压，突然停抗癫痫药可能诱发癫痫，突然停苯二氮䓬类可能出现戒断和谵妄。

谵妄、痴呆、抑郁这三者可以单独出现，也可以互相叠加，最典型的情形是：**一个轻度痴呆的老人，因为一次尿路感染或换了一种药，突然变得糊涂、躁动——这是谵妄叠加在痴呆上；等感染控制后，他恢复到的状态可能比之前更差。** 也有另一种情形：**一个抑郁的老人，因为不想动、不说话、吃得少，被当成痴呆；治疗抑郁后，认知明显好转。**

区分要点在 12.3 谵妄与痴呆 里有详细表格，这里只记三句话：**突然变差、一天之内波动——先想谵妄；几年缓慢下滑、日常生活越来越依赖别人——想痴呆；几周内出现、情绪和兴趣改变突出、常伴躯体主诉——想抑郁**。三者重叠时，处理顺序通常是：先处理谵妄的诱因（感染、药物、脱水、疼痛），再评估抑郁，最后做长期的认知和功能评估。

四、老年第一次出现精神病性症状：默认先查身体

这是本页最需要强调的一段。**六十岁以后第一次出现幻觉、妄想、严重猜疑，器质性原因的比例远高于精神分裂症。** 晚发性精神分裂症样精神病确实存在，但它是排除之后的诊断，不是第一诊断。

方向	典型线索
谵妄	急性起病、注意力波动、意识时清时浊、有感染或换药诱因
痴呆（尤其路易体）	认知波动、反复生动的视幻觉、动作慢、僵硬、睡着时把梦演出来
药物	新加或加量后出现，减量后好转；抗胆碱能、激素、左旋多巴、镇静药

方向	典型线索
感觉剥夺	听力下降后的被害感；视力下降后的幻视（Charles Bonnet 综合征，患者常自知“不是真的”）
抑郁伴精神病性症状	妄想内容与罪恶、贫穷、疾病相关，情绪低落突出
妄想障碍	除妄想外谈吐、功能相对保留，妄想内容不离谱
脑器质性	卒中、肿瘤、硬膜下血肿、正常压力脑积水、癫痫
代谢与感染	电解质紊乱、甲状腺功能异常、维生素 B12 缺乏、尿路感染、梅毒

对这类患者，医生通常会做：详细病史（一定带知情人）、完整用药清单、神经系统查体、认知筛查、头颅影像、脑电图（按需）、血液检查（血常规、电解质、肝肾功能、甲状腺功能、维生素 B12、必要时梅毒血清学）、尿常规。**不要因为“他以前一直很正常”就跳过这些。**

家属去就诊时，可以准备：

- ☐ **所有药盒**：直接把药盒、药瓶装袋带来，比口述准确。包括中药、保健品、外用药、别人给的药。
- ☐ **最近三个月的“变化点”**：换药、住院、跌倒、丧偶、搬家、感染、手术。
- ☐ **基线功能**：半年前他能不能自己买菜、做饭、管钱、坐公交？现在差在哪？
- ☐ **认知的具体例子**：重复问同一件事、忘关煤气、认错人、在熟悉的小区迷路。
- ☐ **精神症状的原话**：他具体说了什么？“有人要害我”是“感觉”还是“坚信”？有没有因此做什么？
- ☐ **睡眠与饮食**：几点睡、几点醒、夜里起来几次、最近体重变化。
- ☐ **听力与视力**：有没有助听器、眼镜？最近有没有明显下降？
- ☐ **安全**：有没有走失、跌倒、用火、乱吃药、给陌生人开门。
- ☐ **照护者状态**：谁在照顾？一天睡几小时？有没有撑不住的感觉？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **任何突然出现的意识混乱、认不出人、看到不存在的东西**：立即急诊，按谵妄处理（见 12.3 谵妄与痴呆）。
- **老年第一次出现幻觉、被害感、说话混乱**：尽快精神科急诊评估，同时查感染、药物、代谢和脑影像。
- **跌倒撞到头后出现嗜睡、呕吐、意识变差**，尤其正在服用抗凝药：立即拨打 120，警惕硬膜下血肿。
- **拒食、拒水超过一天，或明显脱水（口干、尿少、站起来头晕）**：尽快就诊或急诊。
- **木僵、缄默、长时间不动、对外界几乎无反应**：需急诊精神科评估，同时排查躯体原因。
- **说“活着没意思”“不想拖累家里”，或开始整理东西、交代后事**：不要独处，立即联系医生；有明确计划或已实施，拨打 120 或去急诊。
- **出现伤人、放火、持械等行为，家中无法保证安全**：拨打 120（必要时 110）。
- **走失**：立即报警（110），不要等二十四小时。

五、常见误区与下一步

误区一：“人老了就这样。” 衰老会带来变化，但不会带来持续加重的幻觉、妄想、拒食和功能骤降。这些是症状，不是年龄。

误区二：“他这是老糊涂，查也白查。” 一部分认知下降是可逆的：甲状腺功能减退、维生素 B12 缺乏、抑郁、药物、慢性硬膜下血肿、正常压力脑积水。查出来能改，就值得查。

误区三：“药越多越好，多开点总没坏处。” 老年人对药物更敏感，多种药物叠加的风险是实实在在的。定期做“用药重整”（由医生核对哪些还需要、哪些可以减）是有价值的。

误区四：“他疑心重，是性格变了。” 老年突然出现的猜疑，优先排查听力下降、谵妄、痴呆、药物和抑郁，而不是先归为“性格”。

误区五：“老人不会自杀。” 事实相反。老年自杀的成功率更高，而且常被“他只是心情不好”掩盖。任何自杀表达都要认真对待。

老年精神科的处理通常不是单一手段，而是同时做几件事：**精简和优化用药**、**治疗可逆的躯体因素**、**处理抑郁或精神病性症状**、**认知与功能支持**（作业治疗、认知训练、环境改造）、**照护者支持与喘息服务**、**安全安排**（防跌倒、防走失、用火用电、驾驶、财务）。

【临床经验】对家属最实用的一句话是：**把“他病了”和“他老了”分开看。** 属于老的，接受并适配；属于病的，检查并治疗。把两者混在一起，既容易过度治疗，也容易放弃本可以改善的部分。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（老年期精神障碍、神经认知障碍章节）.
- WHO. Dementia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
- 中华医学会精神医学分会老年精神病学组相关专家共识（老年抑郁与认知障碍评估）.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

13.3 孕产期诊断

怀孕和产后，是精神障碍最容易“第一次出现”的时期之一，也是最容易被一句“当妈的都这样”带过去的时期。产后情绪低落、产后抑郁、产后精神病，看起来都和“情绪不好”有关，但严重程度、起病时间、处理方式完全不同——其中产后精神病是可以危及母亲和婴儿生命的急症。这一页讲医生怎么把它们分开，以及家属该盯住哪些信号。

一、先分三件事，再把情绪低落与产后抑郁讲清楚

	产后情绪低落	产后抑郁	产后精神病
起病	产后 2–5 天最明显	产后数周内，也可更晚	多在产后 2 周内，常 48 小时至 2 周
核心	哭泣、情绪波动、焦虑、疲惫	持续低落、兴趣减退、自责	幻觉、妄想、意识混乱、行为紊乱
自知力	清楚，知道“我有点不对劲”	多数清楚，但可能觉得“我不配当妈”	常受损，不认为自己有病
严重度	轻，多可自缓	中到重，影响照护能力	急症，需立即精神科干预

这三者不是同一条线上的轻重档，而是**性质不同的三种状态**。把产后精神病当“严重一点的抑郁”来处理，是最危险的误判。

产后情绪低落：多数会自己过去，但不是“不用管”

产后三到五天，很多产妇会突然变得爱哭、易怒、焦虑、睡不好、觉得自己什么都做不好。这被称为“产后情绪低落”（baby blues），非常常见，不同研究报告的比例差异很大。它的特点是：**来得快、程度轻、两周内逐渐缓解**，不需要药物治疗，但需要实实在在的支持——有人帮忙做饭、有人接手夜里一次喂奶、有人听她说“我真的很累”，而不是“你想太多了”。

需要提醒的是：**“会自己过去”不等于“可以不管”。** 如果超过两周仍不缓解，或程度在加重，就不再是情绪低落，而要考虑产后抑郁。家属最容易犯的错，是在第二周、第三周还说“再等等看”。

产后抑郁：不是矫情，也不是“不会当妈”

【指南】产后抑郁的诊断框架和一般抑郁障碍相同：持续至少两周的情绪低落或兴趣减退，加上睡眠、食欲、精力、注意力、自我评价、无望感等方面的改变，并且造成明显的功能损害——抱不动孩子、无法喂奶、不敢单独和孩子待在一起、什么事都做不了。

产后抑郁有几个容易被忽略的特点：

- **焦虑比低落更突出。** 很多产妇的主诉是“我总是担心孩子会出事”“我一听到他哭就心慌”，而不是“我很难过”。
- **强迫性想法常见。** 反复检查孩子有没有呼吸、反复洗奶瓶、反复想“我会不会伤害他”（见下一节）。
- **自责与“我不配”。** 觉得自己不是好妈妈，觉得孩子跟着自己倒霉。这种想法本身可能是症状，不是事实判断。

- **对孩子的感情淡漠。** 有的母亲说不出“我爱他”，并因此极度羞耻。这可能是抑郁的表现，不代表她真的不爱孩子。
- **睡眠问题难以判断。** 新生儿本来就夜醒频繁，所以不能只用“睡不好”判断抑郁，要看**有机会睡的时候能不能睡**、以及白天是否持续疲惫。
- **孕期也会发生。** 产前抑郁同样常见，且与产后抑郁相关。

筛查常用 EPDS（爱丁堡产后抑郁量表），共十道题，界值因版本和地区不同（有的用九分、十分，有的用十三分），**分数只提示需要进一步评估，不能确诊**。特别要注意：EPDS 里有涉及自伤念头的一道题，任何阳性回答都必须被认真追问。

二、产后精神病：精神科最急的情况之一

【研究】产后精神病相对少见，研究估计大约每一千次分娩中有一到两例，但它属于**精神科急症**，因为风险直接指向母亲和婴儿。

典型表现：

- **起病急**：常在产后几天到两周内，突然变得不对劲。家属常描述“她好像换了个人”。
- **幻觉与妄想**：听到不存在的声音（有时内容与婴儿有关）、坚信孩子被掉包、被监视、被伤害，或坚信自己或孩子有罪。
- **意识与注意力波动**：说话跳跃、答非所问、搞不清时间地点，类似谵妄。
- **情绪剧烈波动**：极度兴奋、话多、不睡，或极度恐惧、绝望，可在几小时内切换。
- **严重失眠**：连续几天几乎不睡，且不觉得困。
- **行为紊乱**：抱着孩子不放、拒绝任何人接近、反复检查婴儿、做出危险举动。

风险包括自杀和伤害婴儿。 这不是为了吓人，而是这类疾病最需要被看见的部分。产后精神病需要**立即精神科急诊评估，多数需要住院**，并且不能把母亲和婴儿单独留在一起。有双相障碍史、既往产后精神病史、家族史的人，风险明显更高，应在孕期就提前告知医生并制定计划。

不要等“出了月子再说”。 产后精神病的窗口期就是最初两周，等待的代价可能是不可逆的。

三、产后强迫：最容易被误认为“她想伤害孩子”

这一节值得单独讲，因为它决定了一个母亲是被理解，还是被报警。

很多产后女性会出现**闯入性的、与伤害婴儿有关的想法**：把孩子从阳台扔下去、用刀划他、把他放进微波炉，甚至与性有关的内容。这些想法让她们极度恐惧、羞耻，不敢告诉任何人，因为“说出来别人会以为我是怪物”。

维度	产后强迫	产后精神病
对想法的态度	极度害怕、厌恶、拼命抵抗	可能相信这是真的，或被要求去做
自知力	清楚“这不是我想做的”	常受损
是否实施	几乎不会，且会主动回避（把刀收起来）	风险真实存在
伴随症状	反复检查、清洗、求保证	幻觉、妄想、意识混乱、失眠

有闯入性想法，不等于有伤害孩子的意图。 相反，越是为此痛苦、越是回避的人，越可能是强迫。但这句话不能反过来用：任何**具体的计划、准备行为、命令性幻听、或“我觉得我应该这么做”的信念**，都必须按急症处理。

四、必须排除的原因，以及孕期用药

孕产期的情绪变化，不都是“心理问题”。以下这些必须先排：

原因	线索
产后甲状腺炎	心慌、怕热、手抖、体重下降，或相反地怕冷、乏力、便秘；产后数月内出现
贫血	乏力、头晕、心慌、面色苍白，尤其分娩时出血多
感染	发热、下腹痛、恶露异味、乳房红肿热痛、尿痛
睡眠剥夺	连续多日碎片化睡眠，情绪和认知明显变差，补觉后改善
疼痛	伤口痛、腰痛、乳房胀痛，未充分处理
药物与激素	某些促排卵、激素、止吐、降压药物
分娩创伤	分娩过程中的恐惧、失控感、侵入性操作，之后出现闪回、噩梦、回避
双相障碍	既往有情绪高涨期、产后出现兴奋不睡话多
物质使用	酒精、镇静药、兴奋剂

已经确诊精神障碍的女性怀孕后，最常见的两个极端是：**自己把药全停了**，或者**什么都不敢说，硬扛到产后**。两者都可能带来风险。

【指南】规范的做法是：在备孕或发现怀孕时，尽快同时联系精神科和产科，把“停药的风险”和“继续用药的风险”放在一起讨论，包括病情复发的风险、孕期和产后的特殊风险、哺乳的考虑。这个决定没有标准答案，需要个体化权衡，**不能由患者自己拍板，也不能由某一个科单独决定**。

如果你正在服药并发现怀孕，**不要自行停药**，尽快联系开药医生。突然停药可能导致失眠、焦虑、病情复发，部分药物突然停用还会出现撤药反应。

五、家属能做什么，以及就医提示与常见误区

- ☐ 具体地接手：今晚你负责一次喂奶、这周你负责做饭、今天你带她出门走二十分钟。
- ☐ 不问“你为什么还不开心”，改问“今天哪件事最难”。
- ☐ 留意睡眠：如果她连续两三天几乎不睡，还很有精神，这不是“恢复得好”，要警惕。
- ☐ 留意语言：她说“我不配当妈”“孩子跟着我倒霉”“不如一起走了”，都要当真。
- ☐ 留意行为：反复检查婴儿、不敢单独和孩子待在一起、把孩子抱得不肯放手、说听到声音。
- ☐ 不评判她的想法：听到“我有时会想伤害孩子”，第一反应应该是“谢谢你告诉我”，而不是惊恐或指责。
- ☐ 保留求助渠道：产科、精神科、社区妇幼保健、心理援助热线，提前存好。
- ☐ 照顾自己：伴侣的抑郁和焦虑在产后也很常见，同样需要被看见。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **出现伤害自己或婴儿的念头、计划或行为**：立即拨打 120（必要时 110），**不要让孩子和母亲单独待在一起**，并让另一个成年人全程陪护。

- **听到命令她伤害孩子的声音，或坚信孩子被掉包、被魔鬼附身**：立即精神科急诊。
- **连续两三天几乎不睡，同时话多、兴奋、行为紊乱**：立即精神科急诊。
- **意识混乱、答非所问、搞不清时间地点**：立即急诊，同时排查感染、甲状腺、电解质、药物。
- **拒食、拒水超过一天，或木僵、长时间不动、不说话**：立即急诊。
- **产后大出血、发热伴下腹痛、乳房红肿热痛、伤口化脓**：立即急诊，这些是产科急症。
- **情绪低落超过两周且越来越重，或无法照顾自己和孩子**：尽快精神科或产科门诊，不必等到“满月”。
- 任何让你觉得“她不太对”的时刻，都可以先打电话给产科或精神科问一句。**宁可白问，不要赌。**

误区一：“产后情绪不好是正常的，忍忍就过去了。” 情绪低落多数会缓解，但产后抑郁和产后精神病不会靠忍过去。区别在于持续时间和严重程度。

误区二：“喂奶不能吃药，所以只能扛。” 是否用药、用哪种，需要精神科和产科一起评估，哺乳期也有可行的方案。**自行硬扛导致病情加重，对母婴的风险往往更大。**

误区三：“想到伤害孩子，说明我是个坏妈妈。” 闯入性想法在产后强迫中很常见，越是为此痛苦的人，越不可能真的去做。但这需要专业评估来区分，不能自己下结论。

误区四：“产后精神病是性格问题或受了刺激。” 它更可能与双相谱系、睡眠剥夺、免疫和激素变化相关，是疾病，不是道德失败。

误区五：“第一胎没事，第二胎也不会有事。” 既往产后精神病是再次发生的强烈风险因素，第二次怀孕应提前告知医生并制定预防计划。

处理通常分层：情绪低落以支持和休息为主；产后抑郁以心理治疗、社会支持和必要时的药物治疗为主；产后精神病以**尽快控制症状、保证母婴安全**为第一优先，常需住院，并安排出院后的随访和家庭支持计划。

【临床经验】对家庭来说，最重要的不是“谁对谁错”，而是**把风险说出口**。一个能在饭桌上说“我最近有过很可怕的念头”的家庭，比一个只能谈“宝宝真可爱”的家庭，安全得多。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance (CG192), 2014（2020 更新）.
- WHO. Maternal mental health. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/maternal-mental-health
- Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 1987.

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

13.4 文化、性别与诊断偏差

同一种痛苦，在不同的人身上会被叫成不同的名字：有人被说“想太多”，有人被说“矫情”，有人被说“疯了”，也有人被说“很有灵性”。诊断看起来是一套客观标准，实际却发生在具体的文化、性别和权力关系里。这一页讲三件事：文化怎样塑造症状的表达，性别刻板印象怎样让人被过度诊断或漏诊，以及怎么避免把“不一样”直接当成“有病”。

一、诊断不是照镜子，它长在文化里

【指南】DSM-5-TR 和 ICD-11 都强调，诊断要考虑**文化背景**：同样的症状，在不同文化里可能有不同的含义、不同的容忍程度、不同的求助路径。

举个最简单的例子：一个人说“我最近总是心慌、睡不着、觉得有人要害我”。如果他在一个刚经历过集体冲突的社区里，这种警惕可能是对真实危险的合理反应；如果他在一个安全的环境里突然出现，才更可能是症状。**判断“是不是病”，不只看症状本身，还要看它和处境是否相称。**

文化还会影响：**怎么表达痛苦**（有的文化鼓励说情绪，有的只能通过身体说——“我心里难受”变成“我胃不好”“我身上有气在窜”）；**什么时候算“病”**（同样程度的焦虑，在强调“能扛”的家庭里可能被忍到很晚，在高度关注健康的家庭里可能很早就被带来）；**去哪里求助**（先找精神科、先找综合医院、先找中医、先求神拜佛，路径完全不同，见到医生时已经走了很远）；**诊断被谁接受**（有的家庭能接受“抑郁症”，但不能接受“精神分裂症”）。

人类学和精神医学记录过许多“文化相关”的痛苦表达方式。它们不是猎奇，而是提醒：**症状的形态会被文化塑造。**

- ataques de nervios（拉丁美洲语境）：强烈的情绪爆发、哭喊、发抖、晕厥感，常与家庭冲突或丧亲相关。
- khyâl cap（柬埔寨语境）：担心“风”在体内上升，伴头晕、心悸、颈部紧缩，常与创伤经历相关。
- **对人恐惧症**（日本语境）：担心自己的体味、脸红、视线让对方不适，核心是“怕给别人添麻烦”，与社交焦虑有重叠也有差别。
- susto（拉丁美洲部分地区）：经历惊吓后“灵魂离体”的感觉，伴乏力、失眠、悲伤。

中文语境里也有自己的表达方式：**“神经衰弱”**在历史上曾被广泛使用，后来逐渐被抑郁、焦虑的诊断取代；**“上火”“气血不足”“肾虚”“想不开”“心结”**，都是把情绪和身体放在同一个框架里说的方式；**“中邪”“被附身”**则可能出现在严重精神症状的家庭解释里。

这些说法本身不是错误，它们是人们理解痛苦的资源。问题在于两种极端：**一种是把所有文化表达都当成病**（比如把宗教斋戒当成厌食、把仪式性的哭泣当成抑郁）；**另一种是把明显的病当成文化**（比如把幻觉解释为“阴阳眼”，把木僵解释为“闭关”）。

二、宗教与灵性体验：怎么和精神病性症状区分

这是最容易吵起来、也最容易误判的一块。区分不能靠“信不信”，要看几个具体维度：

维度	宗教/灵性体验	更支持精神病性症状
文化脚本	符合所在社群熟悉的框架	与本人文化背景明显不符
社群认可	被同信仰群体理解、接纳	被同群体认为“不对劲”
功能	日常生活、工作、关系基本维持	明显下降，无法自理或工作
自知力与可控性	知道是“体验”，能自主停止	坚信不疑，被支配，无法停止
伴随症状	无其他异常	伴失眠、混乱、阴性症状、衰退

需要强调的是：**有宗教信仰本身不是病，加入某个群体也不是病。** 只有当体验伴随明显的功能损害、脱离本人文化框架、并且符合其他症状群时，才需要精神科评估。反过来，**不能因为一个人有信仰，就把他的幻觉、自伤、拒食都解释为“灵性”**，从而延误治疗。

三、性别：一头被过度诊断，一头被漏诊

【研究】性别偏差在精神科诊断里是稳定的现象，而且方向相反。

群体	常见的偏差	后果
女性	躯体主诉更容易被归为“情绪化”“躯体化”；情绪激烈更容易被贴上边缘型人格标签	过度诊断；真正的躯体病被忽略
女性	ADHD、ASD 更常被漏诊，因为表现更“安静”、更会伪装	漏诊；被误为焦虑、抑郁、人格问题
男性	抑郁更常表现为易怒、酗酒、过度工作、冒险	漏诊；直到出现严重后果才被看见
男性	更少求助，自杀未遂少但完成率高	干预窗口更短

具体来说：

- **女性的疼痛和疲劳，常先被当成“心理问题”。** 子宫内膜异位、自身免疫病、甲状腺病、心脏病的女性患者，平均要经历更长的确诊延迟。**“她最近压力大”不应该成为不做检查的理由。**
- **边缘型人格障碍的诊断存在性别倾斜**，同样的冲动和情绪不稳，女性更容易被贴这个标签，男性更容易被贴“反社会”或“物质滥用”。标签一旦贴上，后续所有表现都可能被它解释。
- **ADHD 和 ASD 在女性中更容易漏诊**：女孩的多动可能表现为话多、关系冲突而非跑跳；ASD 女孩可能通过观察和模仿学会社交脚本，代价是巨大的内耗，直到青春期崩溃才被发现。
- **男性的抑郁常以愤怒出现**：易激惹、酗酒、沉迷工作、冒险驾驶、家庭暴力。问“你最近是不是很烦”比问“你抑郁吗”更容易得到真实回答。
- **经前期问题要区分**：经前烦躁不安障碍（PMDD）有明确的症状模式和时间要求，不是所有的经前不适都算；同样，也不能把正常的激素波动一律病理化。

性别偏差的根源不一定是医生“有偏见”，也可能是**训练数据、教科书案例、转诊路径**长期倾斜的结果。意识到这一点，本身就是纠偏的开始。

四、少数群体压力：真实的压力，不是“病”

贫困、歧视、移民、语言障碍、性少数身份、残障、长期照护负担——这些不是“想法”，是真实处境。它们会带来焦虑、抑郁、失眠、警觉、愤怒，这些反应在很多时候是**对不合理处境的合理反应**。

【研究】“少数群体压力”模型指出，长期面对歧视、污名、隐蔽身份的压力，会持续消耗心理资源，从而升高精神障碍的风险。这解释了一个常被误解的现象：某些群体的抑郁和焦虑比例更高，不是因为他们“更脆弱”，而是因为他们承受得更多。

这带来两条原则：

1. **不要把社会压力病理化。** 一个因为被裁员、被歧视、被家暴而痛苦的人，首先需要的是安全、公正、支持和资源，而不是一个“适应障碍”的标签。诊断不能替代改变处境。
2. **也不要因为“有原因”就不去评估。** 真实处境下的痛苦，同样可能达到障碍的程度、同样需要治疗。**“你有理由难过”和“你需要帮助”可以同时成立。**

临床上，医生需要问的是：这个反应**在程度、持续时间、功能损害上**，是否超出了处境的合理范围？如果一个人被裁员三个月后仍然无法起床、无法进食、出现自杀念头，那就不能只用“他在找工作压力大”来解释。

文化背景不是“额外信息”，它直接影响诊断的准确性。以下这些，值得在首次访谈时主动说：

- ☐ 你和家人怎么解释这个问题？（“上火”“想不开”“被人害”“命不好”“压力大”）
- ☐ 在此之前，你们试过什么？（中医、针灸、祈祷、符水、偏方、心理咨询、休假）
- ☐ 家里有没有类似的经历？当时怎么处理的？
- ☐ 你的信仰或仪式，哪些对你重要？哪些是不能碰的？
- ☐ 你说的“难受”，在你们的语言里最接近哪个词？
- ☐ 你有没有因为身份（性别、民族、宗教、性取向、残障、职业）被歧视或威胁过？
- ☐ 你希望医生怎么称呼你？用哪种语言交流更自在？
- ☐ 有没有什么话题在你的文化里不能对外人说？（比如家庭内部的事、性、自杀）

最后一条尤其重要。有些内容在当事人的文化里是绝对禁忌，硬问会失去信任；但完全不问，又可能漏掉关键信息。好的做法是**先说明为什么问、可以拒绝、可以换一种方式说**。

五、两种错误、就医提示与常见误区

第一种：把差异当病。 把口音、习俗、宗教仪式、家庭结构、性别气质、内向性格，当成症状的证据。比如把“不爱跟人对视”直接当成 ASD，把“话少”当成阴性症状，把“信教”当成妄想。

第二种：把病当差异。 用“他们那边的人都这样”“她就是个敏感的女孩”“男人嘛，压力大”来解释明显的精神症状，从而延误治疗。

判断的分界线仍然是那三条：**病程、功能损害、与本人文化背景是否相称。** 三者都考虑，才不容易走偏。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**

- 无论文化背景如何，**出现自杀念头、自伤行为、明确的伤人计划**，都要立即处理：不要独处，联系家人陪同，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- **木僵、拒食拒水、意识混乱、抽搐、高热**：按急症处理，不要先用“仪式”“闭关”“中邪”来解释。
- 家人或社群建议**用祈祷、驱邪、断食、停药的替代方式处理严重症状**时，可以并行寻求精神科评估，但**不要因此延误急诊**。
- 因身份遭受**暴力、威胁、跟踪、拘禁**：先保证安全，拨打 110，并寻求法律与心理支持。
- 如果你在就诊中感到被歧视、被羞辱、被草率下结论：可以要求换医生、寻求第二意见（见 13.6 如何与医生沟通诊断与第二意见），这不等于“闹事”。

误区一：“精神科诊断是客观的，和文化无关。” 诊断标准是工具，使用工具的人和使用时的语境都会影响结果。承认这一点，才能减少偏差。

误区二：“谈文化就是给疾病找借口。” 恰恰相反。理解文化是为了**更准确**地区分“处境反应”和“障碍”，既不漏诊，也不过度诊断。

误区三：“女性更容易情绪化，所以更容易得抑郁。” 求助行为和表达方式存在性别差异，患病率的差异也受社会因素影响。把“更容易被诊断”直接等同于“更容易患病”，是常见的推理错误。

误区四：“少数群体的心理问题都是社会问题，不需要治疗。” 社会问题需要社会解决，但个体仍然可能患病、仍然可以从治疗中获益。两者不冲突。

误区五：“尊重文化就要接受一切传统做法。” 尊重不等于放弃安全边界。任何涉及限制人身自由、暴力、拒食、延误急救的做法，都不能以“文化”为理由被接受。

诊断的目标不是把人分类，而是**理解一个人的痛苦从哪来、能怎么帮**。文化、性别、处境，都是这个理解的一部分，而不是需要被抹平的干扰项。

【临床经验】最实用的自我提醒是：当你想说“他就是想太多”“她们都这样”“这种人就是这样”的时候，先停三秒，问一句——**如果换一个性别、换一个阶层、换一种文化，我还会下同样的结论吗？**

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022（文化形成访谈与文化相关议题部分）.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（文化相关评估说明）.
- WHO. Mental health fact sheets. https://www.who.int/health-topics/mental-health
- NIMH. Mental Health Information. https://www.nimh.nih.gov/health

本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

13.5 共病与多重诊断

拿到诊断书，上面写着三个、四个甚至五个病名，很多人第一反应是：“我到底有几个病？是不是医生在乱贴标签？”反过来，也有人把所有不舒服都归给一个诊断：“这都是抑郁引起的”“这都是精神分裂症的阴性症状”。这一页讲共病为什么常见、诊断该按什么顺序排、以及什么时候多个诊断是必要的、什么时候是过度。

一、共病是常态，不是例外

【研究】在精神科门诊和住院人群中，同时符合两个以上诊断的比例很高。这不是医生水平差，而是因为这些障碍本来就共享症状、共享风险因素、常常互为因果。

组合	为什么要一起看	常见误判
抑郁＋焦虑	两者共享失眠、注意力差、易激惹	只治一个，另一个拖后腿
ADHD＋焦虑	注意力差既可能是 ADHD，也可能是焦虑	把 ADHD 当焦虑，或反之
创伤＋抑郁＋物质使用	创伤后常借酒助眠，酒又加重抑郁	只诊断物质依赖，忽略创伤
ASD＋ADHD	两者可同时存在，DSM-5 起允许共诊	只认一个，漏掉另一个
双相＋物质使用	躁狂期冲动饮酒、吸毒	把双相发作当成“喝酒闹事”
慢性躯体病＋抑郁	糖尿病、心脏病、疼痛与抑郁互相恶化	把抑郁当成“病的正常反应”
人格问题＋创伤	长期创伤会塑造人格模式	只贴人格标签，忽略创伤

共病之所以常见，至少有三个原因：**症状重叠**（失眠、疲劳、注意力差、易激惹，几乎出现在所有障碍里）；**互为风险因素**（焦虑久了会抑郁，抑郁久了会酗酒，ADHD 长期受挫会发展出焦虑和低自尊，创伤会改变情绪调节和人际关系）；**同一个底层因素**（遗传、早期逆境、睡眠紊乱、慢性炎症，可能同时增加多种障碍的风险）。

二、诊断不是越多越好

共病的另一面是**过度诊断**。一个人带着四五个标签走出诊室，未必说明医生看得仔细，也可能是每个症状都被单独命名了一次。

过度诊断的代价是具体的：**治疗互相打架**（同时按双相、边缘型人格、ADHD、焦虑来治，用药方向可能冲突）；**多药叠加**（药越多，相互作用、副作用、依从性差的风险越高）；**身份被标签占满**（“我是双相加边缘加 ADHD 加 PTSD 的人”，比“我有一段很难的时期，正在处理几件事”更难恢复）；**真正的问题被淹没**（当所有症状都有一个现成标签，那个没被命名的原因——睡眠呼吸暂停、甲状腺、创伤、家暴——就更难被看见）。

所以判断“多个诊断是否合理”，不看数量，看三件事：**每个诊断是否都有独立的病程和功能损害；每个诊断是否都能解释一组不能被其他诊断解释的症状；治疗上是否需要分别处理。**

三、排顺序：五个问题，两种陷阱

诊断不是并列的清单，而是有先后的结构。临床上常用的排序逻辑可以拆成五个问题：

第一，有没有躯体、药物或物质原因？ 这一步永远排在最前（见 12.4 器质性与药物所致精神障碍的排查）。甲状腺功能异常可以同时模仿焦虑和抑郁；长期饮酒可以同时制造抑郁、焦虑、失眠和幻觉。

第二，哪些是发作性的，哪些是长期的？ 这一点决定了诊断的“层级”。**发作性**（几周到一个疗程，有明确起止）：抑郁发作、躁狂发作、惊恐发作、精神病性发作；**持续性**（几年，稳定）：人格模式、焦虑特质、心境恶劣；**发育性**（从早期就有，贯穿一生）：ADHD、ASD、学习障碍。把发作当特质，会误诊人格；把特质当发作，会误诊双相。一个从小就这样、跨场景、稳定不变的模式，更可能是发育或人格层面的问题；一个“以前不是这样、最近两个月变了”的改变，更可能是发作。

第三，时间上谁先谁后？ 先后顺序是判断“原发”和“继发”的重要线索。先有创伤，后有回避和警觉，更支持创伤相关障碍；先有长期注意力困难，后有焦虑和低自尊，更支持 ADHD 为主、焦虑为继发。但时间先后不是唯一证据，因为很多障碍会互相加重。

第四，哪些症状能被一个诊断解释，哪些不能？ 这是“奥卡姆剃刀”的用法：优先用最少的诊断解释最多的症状。但如果剩下的一组症状有独立的病程、独立的治疗反应，就不能硬塞进同一个诊断。

第五，哪个最危险、最影响功能？ 治疗的优先级不完全等于诊断的优先级。一个人同时有轻度社交焦虑和重度抑郁伴自杀念头，先处理的是后者。

排序问题	要问自己的话	影响的决定
器质性	最近查过身体吗？换过药吗？	先查还是先治
发作/持续	是“最近变了”还是“一直这样”	发作性疾病还是人格/发育
先后	哪个先出现？	原发与继发
解释力	一个诊断能解释几组症状？	减少还是增加诊断
风险	现在最危险的是什么？	治疗先做什么

排序时要避开两个陷阱。

陷阱一：重复计数。 诊断标准里有一条常被忽略的规则：**一个症状如果能被另一个障碍更好地解释，就不应该同时算给两个诊断。** 这叫排除条款，目的是防止同一个症状被数两次。常见的重复计数包括：**注意力不集中**（抑郁发作时会出现，ADHD 也有；如果只在抑郁期出现，就不该单独诊断 ADHD）；**体重下降与拒食**（抑郁可以导致食欲下降，但如果有对体重增加的强烈恐惧、体像障碍、限制性进食行为，就要考虑厌食症）；**易激惹**（可见于抑郁、双相、ADHD、PTSD、对立违抗、ASD、睡眠不足，不能因为有易激惹就加一个“双相”）；**幻觉**（可见于精神分裂症、双相、抑郁伴精神病性症状、物质所致、器质性、谵妄）；**冲动与自伤**（可见于边缘型人格、抑郁、双相、ADHD、ASD、创伤，单靠自伤不能诊断人格障碍）。

陷阱二：把所有症状都归给一个病。 这更隐蔽，因为它听起来很“专业”。“这是精神分裂症的阴性症状”——可能是抑郁、是药物副作用、是长期住院导致的退缩、是甲状腺功能减退；“这是抑郁引起的”——可能是甲状腺、贫血、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、药物，也可能两者并存；“这是人格问题”——可能是未识别的 ASD、ADHD、创伤、双相、癫痫、听力下降；“这是焦虑”——可能是心律失常、低血糖、嗜铬细胞瘤、甲亢、药物反应。

一个实用的自查：**如果某个症状对针对“主诊断”的治疗毫无反应，就值得重新问一次“它真的属于这个病吗”。**

四、就诊时怎么讲清楚，以及可以问什么

共病的就诊最怕“说成一团”。可以按下面的结构准备一页纸：

- ☐ **时间线**：把每个问题的起点画在一条线上（例如：十二岁开始注意力差 → 二十岁第一次抑郁发作 → 二十五岁开始喝酒助眠 → 二十八岁出现闪回）。
- ☐ **分栏写症状**：哪一些是长期存在的，哪一些是最近几个月才有的，哪一些是吃药后出现的。
- ☐ **每个症状的功能影响**：具体到“因为什么做不了什么”。
- ☐ **用药史**：吃过什么、吃了多久、有没有效、有没有副作用。**不要只写药名，要写反应。**
- ☐ **治疗史**：心理咨询做过几次、什么流派、有没有帮助。
- ☐ **家族史**：不只是“有没有精神病”，还包括自杀、酗酒、住院、服药、学习困难。
- ☐ **你自己最想解决的一个问题**：一次门诊很难解决五件事，先定一个目标。

医生给出多个诊断时，这些问题值得问：

你想知道的	可以这样问
每个诊断的依据	“这几个诊断里，哪一个是最确定的？依据是什么？”
诊断之间的关系	“这些是各自独立的，还是有一个是主要的、其他是继发的？”
会不会重复计数	“我这两个诊断有重叠的症状，您是怎么分开的？”
治疗优先级	“如果只能先治一个，您会先治哪个？为什么？”
观察期	“有没有哪个诊断现在还不确定，需要再观察几个月？”
复诊时看什么	“下次复诊，您希望我重点记录什么，来判断诊断对不对？”

【临床经验】好的医生不会把诊断当成不可讨论的判决。他们会告诉你哪个诊断把握大、哪个是“工作假设”、哪个需要随访。**如果一个诊断完全无法解释、也不允许提问，那本身值得警惕。**

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **同时在吃多种精神科药物，出现嗜睡、走路不稳、手抖、心跳异常、发热、意识模糊**：尽快联系开药医生或急诊，警惕药物相互作用。
- **同时服用多种镇静药、止痛药或酒精**：呼吸抑制风险显著升高，出现呼吸变慢、叫不醒，立即拨打 120。
- **出现自杀念头、自伤行为，或开始囤药**：不要独处，让家人保管药物，立即联系医生或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- **多个诊断同时存在、治疗方案互相冲突时**：可以要求一次“用药重整”或多学科会诊，不要自行加减任何一种药。
- **木僵、拒食拒水、意识混乱、抽搐**：立即急诊。

五、常见误区与下一步

误区一：“诊断越多，说明病越重。” 诊断数量反映的是症状的复杂程度和分类方式，不等于严重程度。一个诊断也可能很重，五个诊断也可能都很轻。

误区二：“共病就是医生没本事，找不准一个病。” 共病是真实存在的临床现象，不是诊断失败。但共病也需要证据，不能靠“多贴几个保险”。

误区三：“既然是共病，就要每个都吃药。” 不一定。优先处理最影响功能和最危险的问题，其他问题可能通过心理治疗、生活方式、环境调整来处理。

误区四：“一个病能解释所有症状，就不该有第二个诊断。” 只有在“解释得通”的前提下才成立。如果某个症状有独立的病程、独立的治疗反应，硬塞进一个诊断反而会误导治疗。

误区五：“诊断变了，说明之前的医生是错的。” 诊断改变常因为信息增加（比如补充了童年史、发现了躯体原因、观察到了发作）。判断医生水平，不看他是否从不改口，而看他是否**根据新信息修正**。

共病的处理原则通常是：**先稳定最危险的部分，再逐步处理其他部分；优先用非药物手段处理不紧急的问题；定期复核每个诊断是否仍然成立。**

【临床经验】一个有用的习惯是：每次复诊带一张“当前诊断与用药表”，让医生和你一起看——哪些诊断还有证据、哪些药还在起作用、哪些可以减。诊断不是刻在石头上的，它应该随着你而变化。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022（共病与鉴别诊断说明）.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（多病共存与诊断排序说明）.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022.
- NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87), 2018.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

13.6 如何与医生沟通诊断与第二意见

一次精神科门诊，常常只有十几到二十几分钟。在这点时间里，医生要听完一段可能已经持续几年的故事，还要做判断。准备得好不好，直接影响诊断的质量。这一页讲三件实用的事：带什么去、怎么问出诊断依据、以及想要第二意见时怎么做才不伤合作。

一、时间很短，准备决定质量

先接受一个现实：门诊不是心理咨询，医生不可能在二十分钟里完全了解你。这不代表诊断一定粗糙，但意味着**你必须帮医生抓住重点**。

一个有效的开场通常是三句话：

1. **最主要的问题是什么**（一句话，不要从三年前讲起）。
2. **持续多久了，最近有没有变化**。
3. **现在最影响你生活的是什么**（上不了班、睡不着、和家人冲突、不敢出门）。

然后才是细节。很多患者失败的地方，是把最关键的信息放在最后五分钟才说，或者因为羞耻而完全不说（比如自伤、饮酒、幻觉、性方面的困扰）。

二、带什么：一份“就诊包”

带什么	为什么	常见遗漏
时间线（一页纸）	医生最需要“病程”	只记最近一次，忘了最早什么时候开始
用药清单	判断药效、副作用、相互作用	漏掉中药、保健品、别人给的药
既往检查与病历	避免重复检查，提供基线	只带最近的，早年的丢了
症状日记（两周）	看波动、看睡眠、看诱因	只写“睡不好”，没写几点睡几点醒
问题清单（三到五个）	避免出门才想起	问题太多，一个都没问清
一个知情人	补充本人看不到的信息	家属抢话，患者不敢说

具体建议：

- ☐ **把时间线写成一页**：横轴是年份，标出第一次发病、每次加重、住院、换药、重大生活事件（丧亲、失业、搬家、生育）。
- ☐ **用药单独一页**：药名、开始时间、剂量、吃了多久、有没有效、有没有副作用。**不要只写药名，要写反应。**
- ☐ **症状用例子写**：不写“我焦虑”，写“上周开会时我突然心跳到一百多，手抖，怕自己会倒下，跑出去了两次”。
- ☐ **功能损害写具体**：请了几天假、推掉了几次聚会、多久没做饭、孩子作业多久没管。
- ☐ **家族史**：不只是“有没有精神病”，还包括自杀、酗酒、住院、长期服药、学习困难、幼年夭折。
- ☐ **把最难以启齿的写在纸上**：如果说不出口，可以递给医生看。这比不说好得多。
- ☐ **带一个能帮你记得住的人**：但要提前说好，让患者本人先讲，家属补充，不要当场争执。

三、怎么问“依据”：五个问题

很多人离开诊室时，只知道“医生说我抑郁”，不知道医生凭什么这么判断。其实完全可以问，而且问得具体，医生通常愿意解释。

你想了解	可以这样问
诊断依据	“您考虑这个诊断，主要是根据哪几条？”
鉴别	“有没有别的可能？您是怎么排除的？”
检查	“还需要做什么检查？什么时候做？”
不确定的部分	“这个诊断现在是确定的，还是需要再观察？”
复诊信号	“如果诊断不对，出现什么情况我应该早点回来？”

【临床经验】问依据不等于质疑。有效的说法是：“我想理解您的判断，这样我回家也能配合。”——这句话把“质问”变成了“合作”。

反过来，有些问法容易让对话卡住：“我在网上查的都不是这样”“我朋友说我就是焦虑”“你能不能保证这个诊断对”。这些不是不能问，而是换一种说法效果更好：把“你错了”换成“我看到的信息和您的判断不太一样，能不能帮我理解一下”。

四、怎么描述症状才有效

医生做判断，靠的不是形容词，而是**具体的、可观察的、有时间地点人物的信息**。同一个症状，两种说法的信息量差别很大：

信息量低	信息量高
“我总是很焦虑”	“最近一个月，每周有三四天，下午开会前会突然心慌、手抖、想跑，持续二十多分钟”
“我睡不好”	“躺下一小时才能睡着，夜里三点左右会醒，醒了要一小时才能再睡，早上六点起”
“我心情很差”	“以前每天打游戏，这两周一次都没打开；孩子跟我说话我也不想回”
“我听到声音”	“安静的时候能听到有人在评论我，像在门外，男声，白天晚上都有，我会去开门看”
“我记性差”	“这个月忘了两次关煤气，上周在小区里找不到自己那栋楼”

还要说清楚**时间关系**：症状是在换药后出现的吗？喝酒后更重吗？月经前后有规律吗？考试周更明显吗？这些细节常常是鉴别的关键。

五、第二意见：这是标准做法，不是不信任

【指南】在医学里，寻求第二诊疗意见是常规做法，尤其面对重大诊断、治疗方案有争议、或你对结论有强烈不安时。精神科也不例外。

什么时候值得考虑：

- 诊断重大（精神分裂症、双相、人格障碍、痴呆），影响长期治疗和人生安排。
- 治疗方案风险较高，或你已经试过多种方案无效。
- 诊断与你的自我体验严重不符，且医生没有充分解释。
- 你感到被草率对待、被贴标签、被歧视。
- 涉及儿童、孕产、老年等特殊人群，诊断影响面更大。

怎么做更妥当：

1. **先告诉原来的医生。** “我想再听一位医生的意见，不是不信任您，是想更稳妥一点。”大多数医生会理解，甚至帮你推荐。
2. **带齐资料。** 病历、检查、用药清单、时间线。第二意见的医生最缺的是纵向信息。
3. **不要“考”医生。** 不要说“上一个医生说我是双相，你看他是不是错了”，而是“我想请您独立看一遍，您会怎么考虑”。
4. **接受局限。** 第二意见的医生只见你一次，没有长期观察，也可能给出不同但同样合理的判断。**不一致不等于其中一个一定错。**
5. **把两份意见放在一起看。** 关注“哪些是一致的、哪些分歧、分歧的原因是什么（信息不同？标准不同？观察时间不同？）”。

六、诊断改变怎么办

诊断改变在精神科很常见，原因通常不是“谁水平差”，而是：

- **信息增加**：补充了童年史、创伤史、家族史，或家属提供了不同描述。
- **时间推移**：观察到了发作、缓解、复发，原来的“工作假设”被修正。
- **躯体或药物因素被发现**：甲状腺、睡眠呼吸暂停、药物反应。
- **分类标准不同**：换医院、换医生，使用的标准版本或习惯不同。
- **原来的诊断过宽或过窄**：早期信息不足时的临时诊断，本就该复核。

面对诊断改变，最要紧的三件事：

1. **不要自行停药或换药。** 尤其是抗精神病药、抗抑郁药、心境稳定剂、苯二氮䓬类，突然停可能引起反跳、戒断甚至复发。
2. **问清楚“改变了什么”**：不只是名字变了，治疗方案变了吗？原来的药还要不要吃？需要补做什么检查？
3. **记录变化**：把每次诊断、时间、医生、依据记下来。这份记录在换医生时非常有用。

七、如果沟通不顺

不是每次就诊都顺利。遇到以下情况，你有权利做点什么：

- **被打断、被敷衍**：可以直接说“我还有一件最重要的事没说完，能不能给我两分钟”。
- **被贴标签、被道德评判**（“你就是矫情”“你就是不想上班”）：可以指出“这句话让我很难受，我想谈的是具体症状”。
- **感到被歧视**（因为性别、职业、民族、性取向、疾病史）：可以要求换医生，或向医院医务科反映。
- **对治疗方案有疑问**：可以要求书面说明，或要求会诊。
- **需要病历**：患者有权复印自己的病历资料，具体流程以就诊医院和现行法规为准。

《中华人民共和国精神卫生法》确立了自愿就医、知情同意等基本原则，具体条款以法律原文为准。了解这些，不是为了“对付”医生，而是为了让沟通更平等。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- **就诊后出现新的自杀念头、自伤冲动，或觉得“没人能帮我”**：不要独处，立即联系医生、家人，拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- **换药或加药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹、面唇肿胀、呼吸困难**：立即停药并拨打 120。
- **出现静坐不能（坐不住、来回走、极度烦躁）、眼球上翻、脖子僵硬、手抖加重**：尽快联系开药医生，不要自行处理。
- **木僵、拒食拒水、意识混乱、抽搐**：立即急诊。
- **在就诊中感到被威胁、被羞辱、被限制人身自由**：先保证安全，联系家人，必要时拨打 110。

八、常见误区

误区一：“问太多会被医生讨厌。” 绝大多数医生愿意解释，尤其是具体、简短、与合作相关的问题。真正影响关系的是指责和对抗，不是提问。

误区二：“第二意见就是不信任，会把关系搞僵。” 坦诚说明来意，通常不会。真正伤关系的是背着医生另找一套方案、然后自行改药。

误区三：“诊断变了，说明之前的治疗白做了。” 不一定。很多治疗在不同诊断下仍然有效（比如失眠的认知行为治疗、规律作息、心理支持）。诊断改变更像是地图更新，不是否定走过的路。

误区四：“医生说的都必须照做。” 你有知情权和参与决定的权利。可以问、可以讨论、可以在充分了解后表达偏好。但**不要自行改药**。

误区五：“有了第二意见，就不用再回原医生那里了。” 如果你决定换医生，最好明确告知并做好交接，让新医生拿到完整资料。突然消失会让治疗断档。

九、这一页想留下的一句话

诊断是医生和你一起完成的一件事，不是你被动接受的一个结论。**你提供的信息质量，和医生的判断质量，是同一件事的两面。**

【临床经验】最有用的一次复诊，往往不是“医生换了个药”，而是你带着一页纸说：“这是我这三个月的变化，这是我最想解决的一个问题，这是我最担心的一个可能。”——这三句话，胜过一小时的漫谈。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

附录：术语与诊断标准

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

A 术语表

这份表收了 60 个和“确诊”有关的术语，按主题分成四组，编号连续。每一条都用大白话解释，尽量说清“它在诊断里管什么”，而不是背定义。你可以按顺序读，也可以在拿到病历、量表或出院小结之后，回来查某一个词。需要提醒的是：术语是描述工具，不是自诊依据，任何一条都不能单独用来给自己或家人下结论。

怎么用这份术语表

先看分组，再决定从哪儿读。

分组	编号	什么时候查
诊断的基本概念	1–15	刚接触“诊断”这件事，想弄懂病程、功能、排除这些词
标准体系、病因与诊断变动	16–26	拿到诊断名称、听说 DSM 或 ICD、怀疑诊断被改过
精神检查与症状学	27–44	病历上出现“情感平淡”“思维散漫”“自知力不全”之类的描述
评估工具与筛查指标	45–60	做过量表、拿到筛查报告、想弄懂“敏感度”“假阳性”

三个使用建议。

第一，先读编号 1–6。 诊断、诊断标准、时间门槛、病程、功能损害、严重度，这六个词构成了后面所有内容的地基。理解了它们，再看具体障碍会轻松很多。

第二，看到陌生术语，先查“它描述什么”，不要急着查“它代表什么病”。 比如“情感平淡”描述的是一种表达状态，它可能出现在多种情况里，不能直接对应某个诊断。

第三，把术语和具体情境一起记。 “病程三个月”比“病程”这个词有用；“能上班但每天加班到十点、周末补觉”比“功能受损”有用。

可以照着做的核对清单

- ☐ 这个词是在描述症状、病程、功能，还是在描述一个诊断名称？
- ☐ 它有没有时间要求？是持续多久才算？
- ☐ 它有没有排除条件？需要先排除什么？
- ☐ 它是不是量表术语？量表只能筛查或评估严重度，不能确诊。
- ☐ 这个词是谁说的？医生、量表报告、网络文章，分量完全不同。
- ☐ 我有没有把“一次出现”当成“一直存在”？

- ☐ 我有没有把“文化或性格特点”当成症状？
- ☐ 看到不懂的词，我有没有直接问医生“这个词在我身上具体指什么”？

> **什么时候需要联系医生或去急诊**
>
> 术语表不能用来判断紧急程度。出现下列情况，先处理安全，再研究名词：

- 自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 命令性幻听、坚信被迫害并准备行动、明显激越或有伤人风险：拨打 120，必要时 110。
- 意识时清时浊、注意力飘忽、伴发热或感染：警惕谵妄，立即急诊。
- 木僵、缄默、拒食、长时间维持一个姿势：急诊精神科评估。
- 高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变：立即急诊。
- 长期大量饮酒或镇静药突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊。

三个常见误区

“查完术语表，就能给自己对号入座。” 术语描述的是现象，诊断需要把现象、病程、功能、排除拼在一起，由医生判断。单个术语几乎从不足以支持一个诊断。

“专业术语一定比大白话准确。” 术语的价值在于同行之间能对齐，不在于比“我最近总是提不起劲”更真实。跟医生沟通时，具体描述往往比术语更有用。

“量表名字越专业，结果越可靠。” 量表的可靠程度取决于它的用途、使用者和解读方式。自评量表给你一个方向，医生评定量表需要培训，两者都不能替代面诊。

诊断的基本概念（1–15）

1 诊断 对一组表现作出的专业命名与解释。它需要症状组合、病程、功能损害和排除四方面信息，作用是指向处理、预测病程和沟通，不是给人下定义。诊断是工作假设，可以随新信息修正。

2 诊断标准 一套由专业人员共同约定的描述性条目，规定某障碍需要哪些表现、持续多久、造成什么影响、需要排除什么。它不是化验指标，而是判断的框架。各国版本会修订，使用前要确认版本。

3 时间门槛 诊断标准里对“至少要持续多久”的要求。有的以两周计，有的以一个月、六个月计。设门槛是为了把一过性的应激反应排除在外。同一个症状，持续时间不同，结论可能完全不同。

4 病程 症状从出现到现在的整体走势，包括起病快慢、持续还是阵发、有没有完全缓解的间歇期、总时长。病程决定了很多诊断的归类。医生问“以前有没有好过一段时间”，问的就是病程。

5 功能损害 症状对日常生活造成的实际影响，包括工作学习、家务自理、社交、亲密关系、经济与安全。它是诊断成立的必要条件之一，也是判断严重度的核心。功能损害要看具体行为，比如请了几天假、多久没出门，而不是只看感受。

6 严重度 对当前状况轻重程度的分层，通常分轻、中、重，依据是症状数量、功能损害程度、有无精神病性症状和风险。严重度决定治疗强度，比如门诊、日间病房还是住院，但不等于预后。量表分数只是参考之一。

7 缓解与复发 缓解指症状减轻到不再满足诊断标准，或完全消失并维持一段时间；复发指缓解后再次满足标准。缓解不等于治愈，很多人需要维持治疗以防复发。复发常有前驱信号，比如睡眠变差、易怒、回避增多。

8 分类系统 把表现相近的人归入同一类别的框架，比如 DSM-5-TR 和 ICD-11。分类便于沟通、研究和资源配置，代价是会切掉连续谱上的灰色地带。现代精神科分类是描述性的，不是按病因划分的。

9 亚型与标注 在主诊断之下补充说明具体特点的标签，比如“伴混合特征”“伴精神病性症状”“伴焦虑痛苦”“季节性模式”。标注会影响治疗选择。不同分类系统的标注不完全对应。

10 诊断层级 当多组症状同时存在时，标准规定的“谁优先”规则。比如心境症状与精神病性症状的时间关系，会决定诊断落在心境障碍还是精神分裂症谱系。层级规则能减少重复诊断，但也可能掩盖真实共病。

11 排除条件 诊断标准里“必须先排除的情况”，通常是躯体疾病、物质或药物影响、其他精神障碍。排除不是走形式，它决定诊断是否成立。没做排除就下的诊断，只能算“初步考虑”。

12 待观察诊断 信息不足时给出的临时性结论，常写成“考虑某障碍”“待观察”“暂不除外”。它不是敷衍，而是规范做法，尤其在首次发作、青少年、老年和不典型表现时。复诊时要问清楚“观察什么”。

13 鉴别诊断 列出几个都能解释当前表现的可能，再逐一比较、排除的过程。精神科的鉴别对象包括躯体病、物质与药物、其他精神障碍。好的鉴别不是“想到很多病”，而是“知道用什么线索区分”。

14 共病 一个人同时符合两个或以上障碍的诊断标准。共病在精神科很常见，但不等于“标签越多病越重”。判断共病要看每组症状是否各自达到门槛、时间关系如何、分开处理后是否各自有反应。

15 原发性与继发性 原发性指没有找到明确的外部或躯体原因，继发性指症状由躯体病、物质或药物引起。临床上“原发性”是排除之后的结果，不是默认答案。把继发性写成原发性，是最常见的诊断错误之一。

标准体系、病因与诊断变动（16–26）

16 DSM-5-TR 《精神障碍诊断与统计手册》第五版文本修订版，美国精神医学学会 2022 年发布。它是描述性分类，条目细、操作性强，广泛用于临床、研究和保险。中文版与英文原文在个别措辞上有差异，引用时最好注明版本。

17 ICD-11 世界卫生组织《国际疾病分类》第十一次修订本，2019 年通过，2022 年 1 月 1 日生效；精神障碍在第 06 章“精神、行为与神经发育障碍”。它服务于全球统计与公共卫生，配套有临床描述与诊断指南。各国本地化进度不同。

18 躯体疾病所致精神障碍 由躯体疾病直接引起的精神症状，比如甲状腺功能减退引起的抑郁样表现、脑炎引起的精神病性症状。诊断关键是时间关系与相应的躯体证据，处理以原发病为主。它和“同时患有两种病”不是一回事。

19 物质或药物所致精神障碍 由酒精、毒品、处方药或戒断引起的精神症状。判断要点是使用与症状的时间关系、停药后是否改善、再次使用后是否重现。它与原发性精神障碍可以并存，需要纵向观察。

20 横断面与纵向 横断面指此刻看到的状态，纵向指一段时间里的变化。诊断既需要横断面，也需要纵向。只靠横断面，最容易把一次发作当成人格，或把人格当成一次发作。

21 诊断漂移 某个诊断的使用率在几年内或地区之间系统性变化，而人群实际患病情况未必同步改变。原因包括标准修订、疾病认知、编码与支付方式、药物市场、医生训练风格。它提醒我们，诊断名称里有一部分是时代的产物。

22 过度诊断 一个人被贴上某诊断，但这个诊断不会带来净收益，甚至带来伤害。常见于阈值下移、筛查普及、门诊时间短、把正常波动病理化。判断关键不是“诊断变多”，而是“当事人是否因此过得更好”。

23 漏诊 真实存在的障碍没有被识别出来。常见原因包括表现不典型、只报告躯体症状、隐瞒物质使用或创伤、文化与语言障碍、诊断遮蔽。漏诊的代价是延误治疗和慢性化，往往比过度诊断更隐蔽。

24 标签 诊断名称在社会生活中的延伸，它进入病历、保险、就业和家庭关系。标签能带来资源与理解，也可能带来污名和限制。把诊断当“工作假设”而不是“身份”，是减少标签伤害的关键。

25 病耻感 因患有精神障碍而感到羞耻、被贬低、需要隐藏的感受，分公众污名、自我污名和制度性污名。它会导致拖延就医、隐瞒病情、中断治疗。减少病耻感既需要社会层面的改变，也需要个人找到安全的披露范围。

26 第二意见 由另一位有资质的医生重新评估，通常用于诊断分歧大、治疗效果不佳或涉及重大决定时。它不是“不信任”，而是常规的复核机制。带去完整材料，比从头叙述更有效。

精神检查与症状学（27–44）

27 精神检查 医生通过观察与提问，系统评估外观、行为、言语、情绪、思维、知觉、认知和自知力的过程。它有结构，不是闲聊，同时看“内容”和“形式”。精神检查的结论是诊断的重要依据，但不能替代病史与随访。

28 主诉 病历第一行，通常写“最主要的问题加持续时间”。它决定后续提问的方向。主诉不等于全部问题，医生会在此基础上扩展。

29 现病史 从起病到现在的完整经过，包括诱因、起病形式、症状组合、波动、功能变化、自行处理与效果。它是诊断的核心材料。家属补充的对照信息往往很有价值。

30 自知力 一个人如何看待自己的状态：是否认为这些体验异常、是否认为自己需要帮助、是否愿意配合。它随病情波动，急性期常常受损。自知力差不是“不讲理”，而是症状的一部分。

31 情感平淡 情感表达的范围和强度明显收窄，语调平、表情少、对喜悲反应弱。它常见于精神分裂症谱系，也可见于重度抑郁、帕金森病、创伤后麻木。它描述的是外在表达变少，不等于内心没有感受。

32 情感不协调 情感表达与谈话内容或当下情境明显不匹配，比如讲悲伤的事时笑。它常见于精神分裂症，也可见于解离、脑器质性损害和文化表达差异。判断时要结合当事人的文化背景。

33 意志缺乏 主动发起和维持有目标行为的能力下降，表现为整天躺着、不洗漱、对什么都提不起劲。它与抑郁时的动力下降、药物副作用、阴性症状都有关。需要区分“不想做”和“启动不了”。

34 紧张症 一组以精神运动异常为核心的表现，包括木僵、缄默、违拗、蜡样屈曲、刻板动作、兴奋躁动等。它可以出现在精神分裂症、心境障碍、躯体疾病和药物反应中，属于需要紧急评估的状态。紧张症不是“闹脾气”，也不是某种人格。

35 木僵 对外界刺激反应明显减弱或消失的状态，可表现为不动、不语、不吃不喝，但意识可能清楚。原因包括紧张症、重度抑郁、器质性脑病、药物反应。它属于精神科急症，需要立即评估。

36 缄默 不说话，但不是不能说话，需先排除失语和构音障碍。可见于紧张症、重度抑郁、选择性缄默、创伤反应和器质性疾病。缄默持续时会带来脱水和营养不良风险。

37 幻觉 没有相应外界刺激时产生的真实知觉体验。常见于精神病性障碍，也见于物质中毒或戒断、癫痫、脑炎、谵妄、听力障碍和极度睡眠剥夺。有幻觉不等于精神分裂症。

38 错觉 有外界刺激但感知错误，比如把衣架看成人影。健康人在昏暗、疲劳、发烧时也会出现。持续、固定、伴随其他症状的错觉更有临床意义。

39 妄想 固定的、与事实不符的信念，即使有相反证据仍然坚信，且与所在文化背景不相符。常见主题有被害、关系、夸大、嫉妒、罪恶、被控制。妄想与“想法奇怪”的区别在于是否可被证据动摇。

40 牵连观念 把外界无关的事认为与自己有关，比如觉得路人的咳嗽在暗示自己。焦虑、疲惫、社交敏感时可以短暂出现；当它固定、泛化并影响行为时，更有临床意义。

41 思维形式障碍 思维在速度、连贯性、逻辑上的异常，包括思维奔逸、迟缓、中断、散漫、破裂性思维、贫乏。它描述“怎么想、怎么讲”，与“想了什么”相对。判断需要听整段话，而不是一句话。

42 思维奔逸 话多、语速快、话题跳跃、难以打断，本人常觉得“脑子转得飞快”。常见于躁狂或轻躁狂，也可见于焦虑激动、甲亢和药物作用。单次出现说明不了什么。

43 思维散漫与破裂性思维 散漫指句子之间缺乏逻辑、听不出主线；破裂性思维更重，句子之间也失去联系，变成词的堆砌。二者都需要医生在访谈中判断。日常的“跳跃”通常还能听懂大意，程度不同。

44 谵妄 急性起病、波动性的意识与注意力障碍，常伴错觉、幻觉、睡眠紊乱和行为改变。它由躯体疾病、感染、药物、戒断等引起，属于急症。老年人、术后和重症患者尤其常见，容易被误认为“痴呆加重”或“不配合”。

评估工具与筛查指标（45–60）

45 量表 把症状或功能转成分数的工具，用于筛查、量化严重度、随访对比。它不能确诊，分数受状态、理解能力和文化程度影响。规范用法是“量表提示方向，医生面谈确认”。

46 SCID-5 DSM-5 的结构式临床访谈，由受过训练的专业人员执行，逐条核对诊断标准。它用于研究和高质量临床评估，耗时较长。普通人不能拿它自评。

47 MINI 简明国际神经精神访谈，一种较短的结构化访谈，覆盖常见精神障碍，常用于筛查和多中心研究。它需要培训后使用，不能替代完整临床评估。

48 PHQ-9 9 个条目的抑郁自评量表，用于筛查、评估严重度和随访。分数高提示需要进一步评估，不等于抑郁症诊断。它包含较多躯体条目，慢性病患者可能出现假阳性。

49 GAD-7 7 个条目的焦虑自评量表，用于筛查广泛性焦虑和随访。它不能区分焦虑的类型，也不能确诊。分数变化比单次分数更有意义。

50 MDQ 心境障碍问卷，用于筛查双相谱系，重点是既往有没有过躁狂或轻躁狂期。它敏感度较高但特异度有限，阳性结果必须由医生进一步访谈。它不能替代纵向病史。

51 YMRS Young 躁狂评定量表，由医生评定，用于评估躁狂症状的严重度和治疗变化。它需要培训，不能单独用来确诊双相。评分应结合病史与功能。

52 HAMD 汉密尔顿抑郁量表，由医生评定，用于评估抑郁严重度和治疗反应。它包含较多躯体条目，躯体疾病患者可能被高估。它是评定工具，不是诊断工具。

53 Y-BOCS 耶鲁—布朗强迫量表，评估强迫思维和强迫行为的种类、耗时、干扰与抵抗。它是强迫症严重度的常用工具，需要医生访谈。分数不能替代诊断。

54 PCL-5 DSM-5 创伤后应激障碍症状清单，20 个条目，用于筛查和随访创伤后症状。它不能确诊，也不能区分创伤后应激障碍与其他创伤相关障碍。创伤后短期内分数偏高是常见的。

55 ADOS 孤独症诊断观察量表，由受过培训的评估者在标准化活动中观察社交沟通与重复行为。它是孤独症评估的重要工具之一，但必须结合发育史。单靠它不能确诊。

56 ADI-R 孤独症诊断访谈修订版，对主要照护者进行结构化访谈，回溯早期发育史。它常与 ADOS 配合使用。回忆偏差和受访照护者的不同会影响结果。

57 敏感度 真正有病的人中，被检查判定为阳性的比例。敏感度高意味着“漏得少”。筛查工具通常追求较高敏感度，代价是假阳性增多。

58 特异度 真正没病的人中，被判定为阴性的比例。特异度高意味着“误报少”。诊断性检查通常需要较高特异度，以避免把健康人卷进不必要的治疗。

59 假阳性 实际没病、却被判为阳性。量表分数高、筛查阳性、影像“异常”都可能是假阳性。假阳性会带来不必要的检查、用药和焦虑，是过度诊断的入口。

60 假阴性 实际有病、却被判为阴性。量表分数低、当事人隐瞒、症状不典型都会造成假阴性。假阴性带来的是延误，往往比假阳性更危险。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med, 2001.
- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med, 2006.

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。

B 诊断标准与指南版本

精神科的诊断标准和治疗指南每隔几年就会更新一次，网上的文章却常常停留在十年前。用错版本，轻则对不上医生的说法，重则按已经废弃的条目给自己“确诊”。这一页把常用的诊断标准、治疗指南、中国规范性文件和求助热线列成一张可以核对的清单，每条注明发布机构、年份、用途和证据等级，并说明怎么判断一条信息是不是已经过时。最后附本页的版本记录与免责声明。

这份清单怎么用

先分清四类文件，它们的“分量”完全不同。

文件类型	它管什么	举例	能不能当诊断依据
诊断标准	规定某障碍由哪些表现、多久、造成什么影响构成	DSM-5-TR、ICD-11	是，但必须由受训医生使用
治疗指南	在已诊断的前提下，建议怎么评估、怎么治、怎么随访	NICE 各障碍指南	不能，指南不负责下诊断
规范性文件	一个国家卫生系统内的诊疗规范、分级与转诊要求	《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》	参考，需结合临床
法律与公共服务	住院原则、隐私、权益、求助渠道	《精神卫生法》、12356	不涉及诊断标准

证据等级也需要说明。本页使用一个简化的标注，避免把不同体系混为一谈。

- **诊断标准**：由专业学会组织专家，基于文献与临床共识形成的描述性分类，属于“共识性分类”，不是疗效证据。
- **指南（NICE 等）**：基于系统综述，采用 GRADE 一类的方法评估证据质量并给出推荐强度，具体分级见原文。
- **中国指南/共识**：结合国际证据与国内实践，通常标注证据级别与推荐等级，引用时应写明版次。
- **规范性文件与法律**：具有行政或法律约束力，不属于“证据等级”体系。
- **科普与机构网页**：帮助理解，不构成诊断或治疗依据。

> 本页只做“版本索引”，不复制任何诊断标准的条文。具体条目请查原文，并由医生结合面谈判断。

两套诊断标准

目前国际上主流的两套是 DSM-5-TR 和 ICD-11。中国临床与研究常参考前者，疾病分类与统计上报对接后者。

标准	发布机构与年份	用途	证据等级
DSM-5-TR	美国精神医学学会，2022	临床诊断、研究入组、教学、保险	共识性描述分类
DSM-5	美国精神医学学会，2013	已被 DSM-5-TR 取代，旧文献常见	共识性描述分类
ICD-11 第 06 章及临床描述与诊断指南	世界卫生组织，2019 年通过、2022 年 1 月 1 日生效	全球统计、公共卫生、各国本地化	分类标准
ICD-10 第 V 章	世界卫生组织，1992	部分地区与旧病历仍在使用编码	分类标准，逐步被替代

DSM-5-TR 是 DSM-5 的“文本修订版”，主要变化包括新增延长哀伤障碍、补充自杀行为相关编码与术语、修订部分文化相关表述，条目主体与 DSM-5 大体连续。它不是“第六版”，把 DSM-5-TR 写成 DSM-6 是常见的错误。

ICD-11 与 ICD-10 的差别更大：章节结构重排，双相与抑郁合并入“心境障碍”，人格障碍改为维度模型，躯体症状相关障碍改称“身体不适障碍”，新增复杂性创伤后应激障碍、游戏障碍等。各国本地化版本上线时间不同，医疗机构切换编码的进度也不同，所以你会看到新旧编码并存的过渡期。

怎么选？ 对患者来说，通常不需要自己选。就诊时想知道的是“医生用的是哪套”，而不是“哪套更好”。两者对大多数常见障碍的判断方向一致，差异集中在时间门槛、分组方式和少数障碍的界定上。

治疗与评估指南

NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）的指南在国际上被广泛引用，特点是方法透明、更新有记录。下表列出与精神科诊断和评估关系最密切的几份。

指南	年份	用途	证据等级
Depression in adults: treatment and management（NG222）	2022	成人抑郁的识别、评估与治疗	系统综述 + GRADE
Bipolar disorder: assessment and management（CG185）	2014，2020 更新	双相的评估与长期管理	系统综述 + GRADE
Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults（CG113）	2011，2020 更新	广泛性焦虑与惊恐障碍	系统综述 + GRADE
Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）	2014，2020 更新	精神病与精神分裂症的评估与治疗	系统综述 + GRADE
Post-traumatic stress disorder（NG116）	2018	创伤后应激障碍的识别与治疗	系统综述 + GRADE
Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder（CG31）	2005，2020 更新	强迫症与躯体变形障碍	系统综述 + GRADE
Attention deficit hyperactivity disorder（NG87）	2018	儿童、青少年与成人注意力障碍	系统综述 + GRADE
Autism spectrum disorder in under 19s（CG170）	2013，2020 更新	19 岁以下孤独症谱系的识别与支持	系统综述 + GRADE

使用指南时要注意三点。

第一，指南不等于诊断标准。 NICE 指南会写“如何识别”“何时转诊”“如何评估风险”，但诊断仍以 DSM-5-TR 或 ICD-11 为准。拿指南里的一句话当诊断依据，是常见的误用。

第二，指南有适用范围。 多数 NICE 指南针对特定年龄、特定医疗系统。比如成人抑郁指南不直接适用于青少年，儿童孤独症指南不覆盖成人。跨年龄、跨系统套用会出问题。

第三，指南更新有节奏。 有的几年一次，有的只做定期监测后宣布暂不更新。看到“2014 年发布”，先看有没有更新的日期标注，不要直接判定过时。

中国指南、规范性文件与热线

中国的临床实践有自己的文件体系，与国际标准相互参照。

来源	年份	用途	证据等级
《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》	2015	中国抑郁障碍的识别、诊断与治疗	指南/专家共识
《中国双相障碍防治指南（第二版）》	2015	中国双相障碍的评估与管理	指南/专家共识
《中国精神分裂症防治指南（第二版）》	2015	中国精神分裂症的诊疗	指南/专家共识
《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》	2020	国家层面的诊疗规范、分级诊疗与转诊	规范性文件
《中华人民共和国精神卫生法》	2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行	住院原则、隐私保护、权益保障	法律
12356 心理援助热线	2025 年起全国推行	心理援助与危机转介	公共服务
WHO mhGAP 干预指南（第 2 版）	2016	非专科医疗环境下的识别与处理	国际指南

几点说明。

中国指南的版次。 上述三部防治指南均为中华医学会精神医学分会组织编写，第二版出版于 2015 年前后。版次、出版年份与具体推荐请以版权页和最新版本为准；如果你看到“2010 年版”或更早的版本，先确认有没有更新。

《精神卫生法》的要点。 它确立了几条与诊断直接相关的原则：精神障碍的住院治疗实行自愿原则；非自愿住院需要满足法定条件并经过规定的程序；诊断应当由具备资质的精神科执业医师作出；精神障碍患者的隐私受法律保护；不得歧视、侮辱、虐待患者。具体条文以全国人大法律库公布的文本为准。

12356 热线。 国家卫生健康委设置的全国统一心理援助热线，2025 年起在全国推行。各地接通时间、坐席规模、服务时段以当地卫生健康委公布为准。它提供心理支持与危机转介，不做诊断。

WHO 与 NIMH 的定位。 WHO 的实况报道和 NIMH 的科普页面适合了解疾病概况、治疗方向和求助途径，但它们不是诊断标准，也不能替代本地指南。

什么时候需要联系医生或去急诊

- 自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

- 命令性幻听、坚信被迫害并准备行动、明显激越或有伤人风险：拨打 120，必要时 110。
- 意识时清时浊、注意力飘忽、伴发热或感染：警惕谵妄，立即急诊。
- 木僵、缄默、拒食、长时间维持一个姿势：急诊精神科评估。
- 高热、肌肉僵硬、大汗、意识改变：立即急诊。
- 长期大量饮酒或镇静药突然停用后抽搐、幻觉、意识混乱：立即急诊。

怎么判断一条标准或指南过时了

下面这份清单可以用来核对任何一篇“诊断科普”或指南摘要。

- ☐ **看年份**：诊断标准是否标了版本（DSM-5-TR、ICD-11）？指南是否标了发布与更新日期？
- ☐ **看是否被取代**：DSM-5 已被 DSM-5-TR 取代；ICD-10 正逐步被 ICD-11 取代；旧版 NICE 指南可能已被新编号替代。
- ☐ **看机构**：来源是专业学会、国家卫生部门、WHO，还是自媒体、商业机构、论坛帖子？
- ☐ **看有没有原文链接**：能追到原始文件、摘要或官方页面的，可信度通常更高。
- ☐ **看有没有“诊断标准全文”**：真正合规的科普会做要点转述，不会大段复制条文，也不会教你“中几条就是”。
- ☐ **看时间门槛与功能损害**：只列症状、不提病程和功能的，基本可以判定为删节版。
- ☐ **看适用范围**：成人指南是否被套用到儿童？中国指南是否被套用到其他医疗系统？
- ☐ **看有没有利益声明**：指南和共识通常会披露编写者与资助方。
- ☐ **看是否与面诊医生说法冲突**：冲突时不要自行判断谁对，把差异带给医生讨论。
- ☐ **看更新记录**：一份好的资料会写“最后更新”和“下一版计划”。

常见误区

“年份越新越可靠。” 新不一定是权威。要看发布机构、方法透明度和是否被专业共同体接受。反过来，一份 2015 年的指南如果仍在被引用且没有被替代，也不等于过时。

“ICD-11 生效了，ICD-10 就没用了。” 各国切换编码需要数年，旧病历、旧研究、旧系统里仍会看到 ICD-10。看到旧编码不必惊慌，只要知道它对应哪个概念。

“指南写了，就一定适合我。” 指南针对群体，个体化判断需要医生结合年龄、躯体病、用药、孕期、个人偏好来调整。

“法律规定了住院，医生就能随便收人。” 《精神卫生法》对非自愿住院设定了条件和程序。对程序有疑问时，可以要求说明依据，也可以寻求法律咨询。

版本记录与免责声明

本页版本：V1.0，2026-10。 与《精神疾病确诊资料库》整体版本一致。

复核周期。 建议每 12 个月核对一次，重点是：DSM-5-TR 是否有新版、ICD-11 本地化进展、NICE 相关指南是否更新或替换、中国指南是否有新版、12356 各地接通情况。

修订原则。 发现错误时，先在篇目顶部标注“待核”，再集中修订；不把未核实的改动扩散到多个文件。涉及诊断标准条目的改动，必须有原文或官方摘要支撑。

免责声明。 本页是版本索引与阅读指引，不是诊断标准全文，也不构成医疗、法律或保险建议。诊断必须由具备资质的精神科执业医师，在面诊、必要的躯体检查和随访之后作出。任何人不应依据本页内容给自己或家人“确诊”，也不应据此自行开始、调整或停止任何治疗。出现自杀风险、意识障碍、木僵拒食、高热僵硬、严重皮疹或戒断反应时，请立即呼叫 120（必要时 110）或前往最近医院急诊。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines（ICD-11 临床描述与诊断指南）.
- National Institute for Health and Care Excellence. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022; Bipolar disorder (CG185), 2014（2020 更新）; Psychosis and schizophrenia in adults (CG178), 2014（2020 更新）.
- 全国人民代表大会常务委员会. 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化诊断建议；具体诊断以面诊医生为准。